

# Не просто накормить

---

*Как организовать безопасное, достойное и вариативное  
питание людей с психическими нарушениями в домах  
социального обслуживания*

От единого меню к поддерживаемому выбору: здоровье, безопасность, права жителей,  
пищевые блок, деньги и ответственность руководителя

Санкт-Петербург · 25–27 августа 2026 года

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

---

Для руководителей стационарных организаций социального обслуживания из 51 субъекта Российской Федерации

Чистяков Е. В., директор СПб ГАСУСОН «ДСО „Серафимовский“»

# Содержание

## Часть I. Основной текст

2. Обращение к участникам семинара
3. Аннотация
4. Резюме для руководителя
5. Собирательная ситуация: «Один обед — пять конфликтов»
6. Кто находится за столом
7. Что значит «накормить»
8. От мономеню к вариативности: лестница моделей
9. Пищевое поведение при психических расстройствах
10. Дисфагия и аспирационный риск: часто нераспознанная проблема стационарного ухода
11. Лекарства и еда: пять правил, которые обязана знать кухня
12. Отказ от еды: от первого пропуска до врачебного решения
13. Переедание, гиперфагия и ночное едение
14. Пикажизм, заглатывание и другие поведенческие риски за столом
15. Невербальный выбор: как услышать того, кто не говорит
16. Дееспособность, опека и выбор еды: карта решений
17. Право Российской Федерации: что разрешено, что требуется, что опасно
18. Санитария и пищевая безопасность при вариативности
19. Два варианта блюда: технология без второй кухни
20. Точка раздачи: дизайн линии, очередь и помощь
21. Когда выбор изменился: журнал, пересчёт и «фиктивная вариативность»
22. Как проверить реальность питания: аудит и замеры
23. Кто участвует: география семинара и система ПНИ-2026
24. Как устроены нормы в регионах
25. Российские практики: четыре подтверждённых кейса и одна региональная модель
26. Международный опыт: проверяемые нормы девяти систем
27. Что говорят исследования: доказательные вмешательства и их границы
28. Люди за линией: персонал стола
29. Финансовые модели: сколько стоит питание и сколько стоит выбор
30. Закупки продуктов: 44-ФЗ без кошмаров
31. Документальный комплект: как практика становится системой
32. Как отвечать проверяющему: сценарий диалога без страха

33. Ответственность директора: честная карта рисков без запугивания
34. Права жителей и совет жителей: от объекта заботы к соавтору меню
35. Пилот на 90 дней: минимальный безопасный старт
36. Дорожная карта на 12 месяцев: от пилота к системе
37. Четырнадцать возражений и честные ответы на них
38. Десять вопросов учредителю: повестка для разговора наверх
39. Предложения отрасли: что должно измениться выше уровня учреждения
40. Организационные предложения семинару
41. Заявление о достоверности: что в этом докладе на чём стоит
42. Аутсорсинг питания: контракт как место вариативности
43. Заключение: что остаётся после последней страницы
44. Библиография и источники

## Часть II. Учебные кейсы (22 разбора)

- Учебные кейсы 1–4
- Учебные кейсы 5–8
- Учебные кейсы 9–12
- Учебные кейсы 13–16
- Учебные кейсы 17–20
- Учебные кейсы 21–22

## Часть III. Приложения: проекты локальных форм (45 шаблонов)

- Приложения 1–6
- Приложения 7–12
- Приложения 13–18
- Приложения 19–24
- Приложения 25–30
- Приложения 31–36
- Приложения 37–38
- Приложения 39–42
- Приложения 43–44
- Приложение 45. План Б: питание при закрытии столовой

## Часть IV. Одностраничные инфографики (для печати)

## Часть I. Основной текст

Сорок четыре раздела: от границы «кухня не назначает клинику» до пилота на девяносто дней, папки проверяющему и честного заявления о том, на чём стоит каждая цифра.

### БЛОК I.1. ВСТУПЛЕНИЕ И РЕЗЮМЕ (РАЗДЕЛЫ 1–4)

#### Как организовать безопасное, достойное и вариативное питание людей с психическими нарушениями в домах социального обслуживания

**Методическое руководство** к межрегиональному методическому семинару-совещанию «Пространство Новых Идей 2.0»

**Автор:** Чистяков Евгений Владимирович, директор Санкт-Петербургского государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения «Дом социального обслуживания „Серафимовский“»

Со-модератор дискуссии 26.08.2026: Нурбаев Тимур Аликович, директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания населения «Дом социального обслуживания „Тесовый берег“»

Тема семинара: «Права, свободы, интересы жителей и персонала социальных стационаров»

**Дискуссионная сессия 26 августа 2026, 14:00–15:30 — «Организация питания: опыт реализации проектов»** (площадка № 2)

Санкт-Петербург, 25–27 августа 2026 года

Организаторы: Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

Аудитория: руководители стационарных организаций социального обслуживания — психоневрологических интернатов и домов социального обслуживания — из 51 субъекта Российской Федерации

*Это справочник для внедрения, а не конспект девяноста минут. На стол в зал — презентация v6 и памятка на две страницы; полный текст — в сумку. Документ не является нормативным правовым актом, клиническим руководством или индивидуальной юридической консультацией. Все локальные формы в приложениях — проекты и требуют адаптации. Заявление о достоверности — в разделе 41.*

## 2. Обращение к участникам семинара

Коллеги, начну не с витрины.

Один обед — пять конфликтов: очередь против помощи, отказ без журнала, кофе на клозапине, «добавка» без врача, журналы «к комиссии». Голодный житель и оплаченное сырьё в баке — одна система. Национальной доли отходов нет. Её даёт семидневный замер в пилоте, не лозунг. Дисфагия в изученных клинических группах — 21,9–69,5 %; на все российские ДСО это не переносится<sup>1</sup>.

Кто в вашем доме сегодня решает, что лежит на тарелке: он сам, сиделка, врач, кухня, контракт или региональная норма? Чаще всего отвечают «кухня» и «норма». Реже всего — «он сам». Для человека в вашем доме еда — три-четыре события в день. Тема семинара — права жителей. Здесь они либо доходят до тарелки, либо остаются в статье закона.

**Что унести, если закрыть этот том после двух страниц.** Ответ проверке — комплект, не формула «запрета нет». Закон не требует шведский стол и не запрещает замену. Проверяющему нужна папка: положение, меню с вариантами, журнал заказа, журнал замен, пищевые карты, согласование с учредителем; пищевые предпочтения — в ИППСУ, где это уместно (442-ФЗ). Без комплекта та же практика выглядит как отступление от раскладки. Шаблоны — в приложениях; порядок сборки — разделы 31–32. Гуманное отношение — ст. 5 ч. 2 Закона № 3185-1.

Клинику кухня не назначает. Таблица «лекарство × еда», текстуры, «диабетический стол», отказ от еды — только с врачом. Иначе осторожный директор правильно услышит: «мне предлагают медицинскую реформу руками повара». Граница — разделы 4.0 и 4.3.

Практика уже есть. Два дома в Новосибирской области, Усть-Илимск, Серафимовский — публично. Иркутская область масштабирует выбор на регион<sup>2, 3, 4, 5, 6</sup>.

Про 74 %. По данным за 2024 год, обработанным проектом «Если быть точным», порядка трёх из четырёх жителей ПНИ признаны судом недееспособными<sup>7</sup>. В вашем доме цифра будет другой. Логика та же: повседневное пищевое предпочтение обычно не сделка; опекун учитывает мнение (ст. 29 ГК).

Последнее слово этого текста — не «внедряйте», а «измеряйте». Семь дней замера отделяют убеждение от знания. Если получилось в Успенском — жители «с лёгкостью освоили новую систему»<sup>3</sup> — это методика, не чудо.

Как пользоваться пакетом. Сессия 26.08 — презентация v6, основной показ слайды 1–18. Со стола — памятка на две страницы. Этот файл — справочник: маршруты в разделе 4.6, достоверность — в разделе 41. GitHub директорам ПНИ не канал доставки; ссылку и PDF отдаёт организатор или флешка.

Это методическое руководство, а не стенограмма. В зале звучит восемнадцать слайдов и памятка. Здесь — 44 раздела, 22 учебных кейса, 45 шаблонов, 126 источников (34 правовых и практических, 48 клинических, 44 международных). На семинаре покрывается около десяти процентов материала. Остальное — на случай, если понадобится в работе, и не для того, чтобы читать подряд. Пятнадцать минут — раздел 4. Вечер — раздел 4.6. Неделя внедрения — главы 31 и 35. Разговор с учредителем без лужи — 31, 32, 33, 37. Полный реестр — раздел 44.

### 3. Аннотация

Методическое руководство по организации питания в стационарных организациях социального обслуживания, где живут люди с психическими расстройствами, — психоневрологических интернатах и домах социального обслуживания. Подготовлено к семинару «Пространство Новых Идей 2.0» (Санкт-Петербург, 25–27 августа 2026 года). Автор — Чистяков Е. В., директор СПб ГАСУСОН «ДСО „Серафимовский“». Адресат — руководители таких организаций из 51 субъекта Российской Федерации.

Три вопроса. **Клинический:** чем кормление людей с психическими расстройствами отличается от «обычного» стационарного питания и какие риски — лекарственно-пищевые взаимодействия, метаболические эффекты антипсихотиков, дисфагия и аспирация, расстройства пищевого поведения — стол обязан учитывать через врача, не через самостоятельность кухни. **Правовой:** что российское законодательство разрешает и чего не требует в части выбора блюд; как оформить вариативное питание документами, которые можно положить проверяющему. **Управленческий:** пилот на 90 дней, замер вместо лозунга, разговор с учредителем.

Доказательная база: 34 позиции российского правового и практического реестра (часть — внутренние или вторичные; ограничения — в разделе 41), 48 клинических публикаций, 44 международных источника. Подтверждены четыре российские публичные практики (Новосибирская и Иркутская области, Санкт-Петербург, 2024–2025); Иркутская область масштабирует выбор на регион.

Объём: 44 раздела, 22 учебных кейса, 45 шаблонов. Справочник для внедрения после сессии. На 26.08 — презентация v6 и памятка на две страницы; полный текст — в сумку.

Ограничения: не заменяет клинических руководств, нормативных актов и индивидуальных юридических заключений; шаблоны — проекты локальных форм; редакции актов — по датам проверки (июль–август 2026 года).

### 4. Резюме для руководителя

Пятнадцать минут. Если меньше — боль стола (один обед — пять конфликтов), затем раздел 4.0, выводы 2, 5, 7, 10 и модель 4.4. Не начинайте с витрины «как хорошо у нас получается». Сначала несъеденное и голод, потом броня документов и пилот на одно отделение.

Это руководство. Перед сессией его не читают подряд. На 26.08 в зале три предмета: презентация v6, памятка на две страницы, этот том в сумке.

#### 4.0. Сначала граница: что кухня не назначает

Это произносят раньше списка взаимодействий. Иначе зал услышит медицинскую реформу руками повара.

**Без врача:** любые ограничения рациона (включая «диабетический стол»), изменение текстур (протёртое, загущённое), правила при дисфагии и протокол свободной воды, действия при длительном отказе от еды, режим питания при седации, решения об энтеральном и зондовом питании и о комфортном кормлении в конце жизни, сдвиг времени еды у жителей на инсулине, слабительные и реакция на запор, назначение анализов и добавок микронутриентов, интерпретация MUST и витаминизация при ОРИ.

**Без учредителя:** изменение финансирования продуктовой строки, изменение штатного расписания (норма помощи за столом), аутсорсинг питания, официальный статус пилота и его публичность.

**Без правовой проверки:** формулировки о «согласии недееспособного» в локальных актах, обработка пищевых карт как персональных данных, ответы на запросы прокуратуры, любые конструкции, где учреждение одновременно является опекуном жителя.

Таблица «лекарство × еда» на посту законна только с подписью врача. Кухня исполняет назначение, не ставит диагноз.

## 4.0а. Методология за один экран (как читать цифры)

Четыре класса утверждений. Цифры, акты и цитаты снабжены сносками: российские правовые и практические источники, клинические и международные — в PDF это нумерованные сноски, полный список в разделе 44.

**Класс 1 — норма.** Цитата закона с реквизитами, первоисточником и датой проверки. Этим спорят с юристом и проверяющим.

**Класс 2 — толкование.** Системное прочтение нормы в ситуации, которой сама норма не регулирует. В разделе 41.2 помечено, что это толкование, не норма.

**Класс 3 — рекомендация.** «Делайте так, потому что так делает Успенский ПНИ» — опыт конкретного дома с публикацией, не императив.

**Класс 4 — проект локальной практики.** Шаблоны приказов, положений, журналов — черновики. Каждый требует локальной правовой проверки. В шапке: «проект локальной формы, не норматив».

Слово «проверено» без даты и URL — реклама. «Общий опыт» — анекдот. «Как известно» — либо тривиальность, либо ложь. Утверждение без маркера — ошибка автора, не недоразумение читателя.

Источники проверены 23.07.2026; правовая сверка — 19–21.08.2026. После этой даты акт мог измениться. СанПиН 2.3/2.4.4282-26 вступает в силу 01.09.2026; в тексте обе редакции — 3590-20 и 4282-26 — помечены, какая действует сейчас и какая с 1 сентября. Полный разбор — раздел 41.

### 4.1. Одиннадцать главных выводов

**Вывод 1. Ошибки за столом проверяют как юридически значимые.** Проживающие в ПНИ и ДСО для лиц с психическими расстройствами пользуются правами пациентов психиатрических стационаров (ст. 43 Закона № 3185-1). Питание нормировано СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (не менее трёх приёмов в день, диетическое по показаниям); с 01.09.2026 ту же норму закрепляет СанПиН 2.3/2.4.4282-26, п. 56 подп. 11<sup>8,9</sup>. Дела по ст. 6.6 КоАП — про качество и достаточность, не про «два вторых»<sup>10</sup>. Разделы 17, 32, 33.

**Вывод 2. Ответ проверяющему — комплект документов, не формула «запрета нет».** Федеральное право не запрещает вариативность и не обязывает давать выбор каждого блюда. Таблицы замены в раскладках — законный механизм<sup>11,12</sup>. Директору этого мало: нужна бумага, которая *разрешает у вас*. Минимальный комплект: положение, меню с вариантами, журнал заказа, журнал замен, пищевые карты, согласование с учредителем. Без комплекта та же практика выглядит как отступление от раскладки. Разделы 31, 32.

Практика уже есть. Два ПНИ Новосибирской области, Усть-Илимск, Серафимовский — публично; Иркутская область масштабирует на регион<sup>2,3,4,5,6</sup>. Разделы 8, 23, 25.

**Вывод 3. Главные риски стола — клинические, и они измеримы.** Антипсихотики различаются по прибавке веса в разы (мета-анализ 100 РКИ: от -0,23 кг до +3,01 кг за 6 недель)<sup>13</sup>. В отдельных изученных клинических группах распространённость дисфагии — от 21,9 до 69,5 %; переносить этот диапазон на все российские ДСО нельзя<sup>4</sup>. Смертность от пневмонии при тяжёлых психических расстройствах в семь раз выше популяционной<sup>14</sup>. Организация стола входит в профилактику преждевременной смертности. Разделы 9–14.

**Вывод 4. Четыре лекарственно-пищевых правила кухня исполняет по таблице врача.** Клозапин — кофеин, литий — соль и вода, ИМАО — тирамин, карбамазепин — грейпфрут<sup>15, 16, 17, 18</sup>. Одна подписанная таблица на посту. Кухня не «убирает кофе сама». Раздел 11 и граница 4.0.

**Вывод 5. По агрегированным данным о российских ПНИ за 2024 год порядка трёх из четырёх признаны судом недееспособными; в вашем доме цифра будет другой.** 74 % — данные за 2024 год, проект «Если быть точным» (публикация 09.04.2026), не текущая статотчётность Минтруда<sup>7</sup>. Сделки совершает опекун (ст. 29 ГК РФ). Повседневное предпочтение обычно не сделка — а мнение недееспособного обязаны выяснять и учитывать. Опекун учитывает мнение подопечного (ст. 29 ГК, 48-ФЗ). Статья 43 Закона № 3185-1 задаёт статус проживающих, не эту обязанность. 442-ФЗ — права получателя и ИППСУ. Кто не говорит — показ двух порций, наблюдение, пищевая биография. Разделы 15, 16.

**Вывод 6. «Диабетический стол» и другие жёсткие ограничения — зона врача, а не шаблона.** Лечебное питание назначается поимённо, с целью и сроком пересмотра; приказы Минздрава о лечебном питании адресованы медицинским организациям и не распространяются на СОСО автоматически<sup>19,20</sup>. Разделы 17, 19.

**Вывод 7. Вариативность без журналов — имитация для проверяющего.** См. комплект в выводе 2. Разделы 31, 32.

**Вывод 8. Честная финансовая модель начинается с замера.** Мы не утверждаем, что вариативность «почти бесплатна». Семидневный замер отходов и трудозатрат до старта — первый шаг; иллюстративные расчёты в докладе помечены. Разделы 29, 35. «Средний житель» здесь опасен: одного перекормили, другого недокормили, среднее по отделению выглядит нормой (раздел 6.5).



**Вывод 9. Директор отвечает за систему контроля.** Ответственность наступает не за каждое событие, а за неработающий контроль<sup>10, 21</sup>. Письмо учредителю о дефиците ресурсов не индульгенция, но доказательство своевременного реагирования. Раздел 33.

**Вывод 10. Пилот за 90 дней реалистичен на одном отделении без новой сметы.** Месяц измерений, месяц документов и обучения, месяц пилота: два варианта на завтрак и обед (модель Новосибирской области)<sup>2, 3</sup>. «Без новой сметы» не значит «без затрат»: полный переход дома может потребовать оборудования и ставок<sup>5</sup>. Раздел 35.

**Вывод 11. Шесть вопросов дискуссии 26.08 — развилка зала.** Модераторы: Чистяков Е. В. и Нурбаев Т. А.; площадка № 2 — ДСО «Тесовый берег». Лечебное питание и вариативное меню совместимы, если диета задаёт множество, не одно блюдо. Серафимовский — 223-ФЗ; Тесовый берег — 44-ФЗ. Раздел 17.12 не читать вслух, пока зал не спросил. Разделы 17.12–17.13, 8, 17, 29, 35.

## 4.2. Что сказать повару в понедельник

1. Семь дней считаем отходы и смотрим, что реально остаётся на тарелках (приложение 25).
2. Замеряем интервал ужин → завтрак одной строкой в журнале.
3. На пост — таблица врача «лекарство × еда», не самостоятельность кухни (приложение 21).
4. Три отказа подряд — звонок врачу в тот же день (приложение 9).
5. Если кухня чужая — открыть спецификацию: есть ли строка выбора (разделы 42 и 35.9).

Остальное — опрос, письмо учредителю, рабочая группа, поднос для постельных — после этих пяти. Чек-листы — приложения 18–20.

## 4.3. Чего нельзя делать без врача, учредителя или правовой проверки

См. границу раздела 4.0. Повтор, чтобы её не пропустили те, кто листает выводы и сразу ищет «что можно».

## 4.4. Минимальная безопасная модель

Два варианта блюда, журнал и карта. Без второй кухни.

1. **Документы:** положение об организации питания и журналы (пробы, бракераж, отказов, заказа) ведутся в ритме смены.
2. **Клиника:** таблица врача на посту; список риска дисфагии у сиделки; три отказа — врач в тот же день.
3. **Люди:** на каждого кормимого — конкретный помощник; еда не подаётся, пока помощь не готова.
4. **Голос жителя:** остатки на тарелках разбирают; есть хотя бы один канал пожеланий.
5. **Замер:** ночной интервал и отходы известны числом.
6. **Ночной интервал:** операционная цель дома — не больше 13 часов (рабочий ориентир авторов внутри международного диапазона 11–14 ч, не нормативное требование). 14 часов — верхняя граница CMS (США), не целевой показатель российского чек-листа. Если больше 13 — сдвиг расписания (ужин позже или завтрак раньше) либо вечерний перекус по согласованию с врачом (раздел 13.9).

Если хотя бы один из шести пунктов не выполняется — начните с него.

**Одна просьба к 26.08.** Не меняйте всё меню. Один обед, одно отделение, одна неделя замера — затем пилот на 90 дней с двумя безопасными вариантами и журналом фактического выбора.

## 4.5. Что сделать в понедельник до обеда

Пять действий. Новой сметы не нужно, меню не трогают. Врач входит в рабочую группу: он ставит границу, а не «назначает диету руками кухни».

1. **Посчитать сырьевую строку** (1 час). Расходы на продукты за последний полный месяц разделить на число жителей и на число дней. Записать своё число. Если за пять минут его никто не называет — это первая находка аудита. Методика — раздел 29.3, приложение 25.
2. **Запустить семидневный замер отходов и времени раздачи** (10 минут на запуск). Ответственный — завпроизводства или старшая смена. Замерять: тарелочные остатки по трём основным приёмам, граммы на порцию; кухонные остатки; время от начала раздачи до последней тарелки. Журнал — приложение 25. Без замера через 90 дней сравнивать нечего.
3. **Приказ о рабочей группе** (30 минут). Директор или зам по АХЧ, врач или фельдшер, диетсестра или завпроизводства, старшая медсестра одного отделения, представитель учредителя — если получится. Пункт: «в срок до [дата + 30 дней] подготовить предложение по пилоту на одном отделении на 90 дней».
4. **Письмо-уведомление учредителю** (30 минут). Одна страница: обоснование (Новосибирская и Иркутская области, Санкт-Петербург), ссылка на СанПиН 3590-20 п. 7.1.11 / 4282-26 п. 56(11), сроки, просьба о согласовании или уведомительном порядке. Шаблон — приложение 32; разделы 31, 38. Уведомление потом закрывает претензию «самоуправство».

**5. Точка пилота** (1 час с заведением). Одно отделение 20–35 жителей; лучше «сложное» (группа помощи, неговорящие), не самое удобное; одна смена; один приём пищи — обед. В протокол рабочей группы. Почему «сложное» — раздел 35.7.

**В первый понедельник не делать.** Не выбирать модель М1–М5 — это решение группы после замера. Не менять меню. Не выпускать пресс-релиз. Совет жителей подключается на этапе пар эквивалентов.

**Через семь дней на руках:** сырьевая строка, замер отходов запущен, приказ с пятью фамилиями, письмо учредителю, выбранное отделение.

#### 4.6. Три предмета на 26.08 и три маршрута после

**На сессию:** презентация v6, слайды 1–18. **На стол:** памятка «что унести в регион». **В сумку:** этот том.

После семинара. **Маршрут директора (два часа):** разделы 4, 5, 8, 22, 35, 37, 42. **Маршрут внедрения (неделя):** 6–8, 17–19, 31, 35–36 и приложения. **Маршрут спорщика (вечер):** 23–27, 37, 39–40. Раздел 41 не пропускать: по клинике и международным нормам база плотная, по эффекту вариативности в психиатрии — почти пустая. Поэтому последнее слово — «измеряйте».

## 5. Собирательная ситуация: «Один обед — пять конфликтов»

### БЛОК 1.2. СЦЕНА, ТЕРМИНОЛОГИЯ, ЛЕСТНИЦА МОДЕЛЕЙ (5–8)

*Учебный кейс, составленный для анализа. Все персонажи и совпадения вымышлены; ситуация собрана из типичных элементов, описанных в проверенных источниках и практиках учреждений.*

#### 5.1. Обед, как он есть

Средний российский психоневрологический интернат — 289 коек<sup>7</sup>. Обеденный зал на 120 мест, поточная раздача в три захода<sup>22</sup>. На линии — один вариант каждого блюда: борщ, гречка с котлетой, компот. Двенадцать жителей первого захода едят только с помощью. На смене четыре сиделки, из них одна развозит лекарства. До конца смены — пять часов.

**Первый конфликт: очередь против помощи.** Тех, кто ест сам, раздали первыми — так быстрее, — и они уже сидят перед остывающими тарелками. Четыре сиделки на двенадцать кормимых: не менее трёх циклов по 15–20 минут; последних кормят холодным. Международная норма, которую мы приводим в разделе 26, требует не больше двух полностью кормимых на работника и подачи только под готовую помощь<sup>23</sup>. У нас это нигде не закреплено и нарушением не считается. Именно здесь рождаются недоедание и аспирация «на скорость».

**Второй конфликт: «он опять не ест кашу».** Житель С. третий день отодвигает тарелку. Журнала отказов нет: запись в тетради или нет, врач узнает в четверг. Депрессивный эпизод и, возможно, начинающаяся дисфагия — проверить некому, логопеда в штате нет. Покашливание за столом, «влажный» голос после еды с отказами никто не связывает<sup>24</sup>. «Каприз» или «симптом» — кто дежурит.

**Третий конфликт: лекарства и кофе.** Житель К. на клозапине с утра выпил две большие кружки крепкого кофе от родственников. Семью и К. не предупредили: кофеин взаимодействует с клозапином; резкий рост потребления даёт клинически значимый рост концентрации<sup>15, 25</sup>. Вечером седация сильнее. Дежурная: «плохой день».

**Четвёртый конфликт: добавка.** Житель П. на оланзапине за год набрал 14 килограммов; мета-анализы: один из самых выраженных весогенных профилей<sup>13</sup>. Просит вторую котлету. Сиделка: «вам нельзя, вы полнеете» — по своему представлению о пользе, без врачебного назначения. Вечером забирает хлеб у соседа. Разбирают дисциплину, не самовольное ограничение рациона.

**Пятый конфликт: проверка на следующей неделе.** Четверг — комиссия учредителя. Завхоз: журналы «в порядок», суточные пробы за двое суток подпишут сегодня. Самое опасное из пяти — документальная имитация контроля. Прокуратуры: нет суточных проб и недоброкачественные продукты — типовой состав дел по ст. 6.6 КоАП для социальных учреждений<sup>10</sup>.

#### 5.2. Почему все пять конфликтов — одна система

У каждого свой «виноватый»: медленная сиделка, капризный С., неведущая семья К., несдержанный П., нерадивый завхоз. На деле — отказ системы.

| Конфликт              | Отказ системы                                           | Где в докладе решение    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| Очередь против помощи | Нет нормы помощи за столом и порядка подачи             | Разделы 20, 28           |
| «Не ест кашу»         | Нет журнала отказов, триггеров и маршрута дисфагии      | Разделы 10, 12           |
| Лекарства и кофе      | Нет лекарственно-пищевой таблицы и информирования семьи | Раздел 11, приложение 32 |

| Конфликт            | Отказ системы                                            | Где в докладе решение |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Добавка             | Ограничение рациона принято не врачом и не зафиксировано | Разделы 13, 17, 19    |
| Журналы «в порядок» | Контроль имитируется                                     | Разделы 31, 33        |

Ни один из пяти не требует денег для начала — решение директора и документы. Три упираются в кадровую нагрузку. Вариативное питание добавит шестой конфликт: «кто выбирает блюдо». Пять базовых не закрыты — шестой добьёт систему. Дорожная карта (разделы 35–36) начинается с измерения и фундамента.

### 5.3. Сцена спустя год

Та же столовая, тот же час — год работы по этому докладу. Женщина, которой нужно молчание, ест за тихим столом у окна. Мужчина на клозапине пьёт кофе, согласованный с врачом. Житель с дисфагией ест свою текстуру; тарелка не выглядит «детской». Неговорящий показал на карточку и получил то, на что показал. Смена работает по журналам. Пять конфликтов не исчезли — они получили процедуры.

## 6. Кто находится за столом

### 6.1. Неоднородность как единственная норма

Первая ошибка — «средний житель ПНИ». Его нет. Даже в агрегате: 65 % старше 45 лет, 74 % признаны недееспособными, 11 % — постельные или маломобильные<sup>7</sup>. В одной столовой сидят сразу: пожилой человек с шизофренией и старческой дисфагией; молодой мужчина с расстройством аутистического спектра и сенсорной невосприимчивостью текстур; женщина средних лет с аффективным расстройством и выраженным набором веса на препаратах; человек с умеренной умственной отсталостью, который не читает меню; житель в стойкой ремиссии, готовящийся к переводу в сопровождаемое проживание, — ему навыки «свой стол» нужнее, чем кому-либо.

Задача не «накормить контингент» — маршрут каждой группы к достаточной, безопасной и выбранной им еде. Разделы 9–14 — по механизмам; здесь — карта.

### 6.2. Пять измерений неоднородности

**Психическое состояние.** Депрессия — безразличие к еде; мания и возбуждение не оставляют времени на стол; психоз добавляет «отравлено»; тревога делает шумную очередь местом избегания. Состояние волнообразно: один житель в разные недели требует разной организации. «Особые состояния» — штатный режим, не авария (раздел 12).

**Когнитивные функции.** От сохранного интеллекта до глубокой умственной отсталости и деменции — не юридическая «компетентность», а способ выбора: слово по меню, указание на порцию, жест, устойчивый паттерн потребления (раздел 15). Статус задаёт инструмент, не наличие выбора.

**Коммуникация.** Неговорящие и малоговорящие — значимая доля. «Что будете?» для них худший инструмент. Выбор фиксируется иначе. Международное право (Замечание общего порядка № 1 к ст. 12 КПИ) требует поддержанного, а не подменяющего принятия решений<sup>26</sup>.

**Соматика.** Дисфагия (раздел 10), диабет и метаболический синдром (разделы 11, 13), запоры — в том числе опасные клозапиновые<sup>27</sup>, сердечно-сосудистая патология, эпилепсия с риском аспирации при припадке за столом. Соматическая карта — рамка выбора.

**Жизненный опыт и культура.** «Всю жизнь ужинал в девять», религиозные правила, детские и праздничные блюда как якоря идентичности. Немецкий стандарт собирает «биографию питания» при поступлении: позже это может стать единственным доступом к воле<sup>28</sup>. Форма — приложение 3.

### 6.3. Классификация для практики

Карта должна работать, а не украшать стенд.

| Группа                        | Как распознать                          | Главный риск за столом                      | Маршрут питания                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Самостоятельные, стабильные   | Едят сами, выражают предпочтения словом | Однообразие, «столовская» еда               | Полный выбор, участие в совете жителей          |
| Самостоятельные, нестабильные | Волнообразное состояние                 | Пропуски приёмов при обострении             | Выбор + «особые состояния» в пищевой карте      |
| Маломобильные                 | Едят в жилой зоне                       | Холодная еда, очередь «в последнюю очередь» | Подача под готовую помощь, контроль температуры |
| Нуждающиеся в кормлении       | Не могут есть сами                      | Недоедание, аспирация «на скорость»         | Норма помощи 1:2 (ориентир), медленный темп     |



| Группа                              | Как распознать                                | Главный риск за столом             | Маршрут питания                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Неговорящие / малоговорящие         | Не отвечают на вопрос о выборе                | Подмена выбора удобством персонала | Показ порций, наблюдение, пищевая биография                       |
| С дисфагией                         | Покашливание, «влажный» голос, долгий приём   | Аспирация, пневмония               | Назначенная текстура, поза, темп (раздел 10)                      |
| С выраженным набором веса           | +5 % и более за 3 месяца на препаратах        | Метаболический синдром             | Мониторинг, пищевая среда, без самостоятельных «диет» (раздел 13) |
| С расстройствами пищевого поведения | Переедание, ночное едение, пика, заглатывание | Соматические и бытовые риски       | Индивидуальные протоколы (разделы 13, 14)                         |

Таблица — проект рабочей классификации для локального использования, не нормативная документация.

## 6.4. Что сказать повару в понедельник

Пять действий раздела 4.2 остаются. Здесь — пять других чисел: сколько едят сами, сколько с помощью, сколько неговорящих, сколько в группе дисфагического риска, сколько на весогенных препаратах. Форма — приложение 35. Без них планируете для абстракции.

## 6.5. Почему «средний житель» — опасная конструкция

«Средняя порция» промахивается в обе стороны, и промахи складываются. Гиперфагия получает «среднее» и ищет еду ночью и в чужих тарелках (раздел 13). Депрессивная фаза оставляет две трети: отходы растут, вес падает, учёт видит «норму» — среднее по отделению прежнее. Одного перекормили, другого недокормили. Защита — распределение: сколько оставляют больше трети порции. Форма замера (приложение 25) — построчно.

## 6.6. Контингент меняется — карта стареет

Пять чисел не константа. Контингент стареет, доля постельных и помощных растёт, назначения меняются. Числа год назад — питание для людей, которых уже нет. Квартальное обновление — калибровка прицела. Самый дорогой вид старения карты — рост группы помощи без роста ставок: сначала темп кормления, потом вес жителей, потом, если повезёт, документы.

## 6.7. Как собрать пять чисел за один обход

Ни статистик, ни неделя. Обход с заведующими, полтора часа: из головы, сверка с листом жителей. Точность «из головы» — смысл метода: не называет число кормимых своего отделения — находка важнее числа. Второй проход — врач: весогенные препараты (таблица раздела 11) и назначенные текстуры. Третий — старшие смены: кто оставляет еду, кто ест ночью, кто «не ест в зале». Три прохода — живая карта для разделов 19–20. Обновление — раз в квартал, строка в панели (приложение 35).

# 7. Что значит «накормить»

## 7.1. Шесть измерений одной тарелки

«Накормить» в управленческой речи обычно одно: порция по норме и съедена. Этого мало — не из гуманизма: одномерное «накормить» само производит недоедание, конфликты и нарушения. Шесть измерений — у каждого свои нормы, провалы, измерители.

**1. Достаточность.** Вес и состав покрывают рекомендуемые нормы Минтруда (приказ № 520н) и региональные нормы на их основе<sup>29, 11, 12</sup>. Измеритель — фактическое потребление: выданная и не съеденная порция достаточностью не является. Замер остатков (приложение 25) — сколько доходит.

**2. Безопасность.** Три слоя. Санитарный: пробы, температуры, отдельные потоки, питьевой режим — СанПиН 2.3/2.4.3590-20 к организациям соцобслуживания (до 31.08.2026; с 01.09.2026 — СанПиН 2.3/2.4.4282-26, п. 56 подп. 11–13, п. 62)<sup>9</sup>. Клинический: назначенные текстуры при дисфагии (раздел 10), лекарственно-пищевые ограничения (раздел 11). Поведенческий: защита от заглатывания, пика, отбирания еды (раздел 14). Провал любого слоя — не «недовольство качеством», а ответственность (раздел 33)<sup>10</sup>.

**3. Удовольствие.** Вкус, температура, вид, разнообразие. Еда здесь — главный ежедневный опыт: удовольствие не роскошь, а фактор потребления. Невкусное съедается хуже — недоедание при формально достаточных нормах. Международные нормы связывают качество и привлекательность блюд с нутритивными исходами<sup>30, 31</sup>. Измеритель: остатки и жалобы.

**4. Социальность.** Разговор, общий ритм, участие персонала. Финская национальная рекомендация закрепляет совместные трапезы персонала и проживающих как элемент качества<sup>32</sup>. Голландское рандомизированное исследование семейной подачи: рост качества жизни и потребления энергии за счёт социальной организации

стола<sup>33</sup>. У нас это ещё бесплатный мониторинг: работник за общим столом замечает «он сегодня не жуёт» раньше журнала.

**5. Самостоятельность.** Пройти линию, выбрать, поесть приборами, убрать за собой. Для части жителей — реабилитация к сопровождаемому проживанию; в России такие программы действуют и расширяются<sup>7</sup>. Стол, который делает всё за человека, закрепляет зависимость. Поточная линия с самообслуживанием, как отмечает одно из российских учреждений, «развивает навыки самообслуживания»<sup>22</sup>.

**6. Выбор.** Что, когда, где и как есть — формула австралийского стандарта «Еда и питание»<sup>34</sup>. Единственное измерение, которое нельзя делегировать: систему можно построить за человека, решение — нет. Здесь право (разделы 16–17), технология (разделы 19–22) и тема семинара.

## 7.2. Матрица провалов

Типовой провал каждого измерения виден без обследований:

| Измерение         | Типовой провал                            | Быстрый измеритель                                    |
|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Достаточность     | Норма на бумаге, недоедание на тарелке    | Доля несъеденных порций (7-дневный замер)             |
| Безопасность      | Журналы есть, контроль имитируется        | Сверка фактических проб с графиком без предупреждения |
| Удовольствие      | «Столовая» еда, однообразие               | Блюда-аутсайдеры по остаткам; жалобы                  |
| Социальность      | Столовая как конвейер, тишина или команды | Наблюдение за одним обедом: есть ли разговор          |
| Самостоятельность | Всё делают за жителя                      | Доля жителей, проходящих линию сами                   |
| Выбор             | Решает кухня                              | Ответ жителя на вопрос «что ты сегодня выбрал?»       |

«Накормить» — шесть задач. «Питание в порядке» — по которому из шести? Деньги закрывают в основном первые три; последние три — организацию и документы. Вариативное питание работает, когда первые пять не провалены.

## 7.4. Проверка каждого измерения на вашей линии

Шесть проверок по десять минут за день — не директору, а тому, кто будет честен. **Безопасность:** сколько из списка риска едят вне поля зрения смены. **Физиология:** ужин и завтрак против шведского ориентира ночного интервала (не более 11 часов<sup>30</sup>; пример — ужин 17:30 → завтрак 8:30 = 15 часов без еды; без замера в своём доме это нельзя называть типовым распорядком РФ). **Психология:** вечером спросить у трёх жителей, что было на обед; не помнят или «как обычно» — еда фон. **Социальность:** персонал ест с жителями или «потом, на кухне» — второй ответ описывает культуру стола. **Право:** реальность выбора (приложение 24). **Экономика:** сырьевая строка за минуту деления (приложение 25). Ни рубля. Карта первого провала. Начинать с него, не с красивого проекта.

## 7.5. Граница измерений: что не входит

Два понятия за рамкой. **Кулинарное качество** (вкус как искусство) важно, но не предмет системы: свежесть, температура, рецептура — да; субъективный вкус — совет жителей и дегустации (раздел 34), не нормативы. **Медицинская нутрициология** в полном объёме (нутриентный расчёт под заболевания) — врач и, где есть, диетолог. Доклад организует исполнение назначений, не подменяет содержание. Границы — от кулинарного эстетства и псевдомедицины.

## 7.6. Минимальная планка каждого измерения

Одно действие на измерение. **Безопасность:** список риска на посту. **Физиология:** ночной интервал ≤13 часов (диапазон 11–14 часов, раздел 26). **Психология:** показ меню каждому ежедневно. **Социальность:** один «тихий стол» в зале. **Право:** журнал замен. **Экономика:** посчитанная сырьевая строка. Не идеал — вывод из зоны отказа. Так собирается минимальная безопасная модель раздела 4: не совершенство в одном и провал в пяти, а планка в шести.

# 8. От мономеню к вариативности: лестница моделей

## 8.1. Термины, чтобы не путаться

Смешивают четыре вещи. **Цикличное меню** — повторяющийся цикл (14 дней по российским раскладкам, 21 день в Онтарио, 4 недели по немецкому стандарту)<sup>22, 23, 31</sup>: разнообразие во времени, не выбор. **Вариативное меню** — в одной точке приёма больше одного варианта, из которых житель выбирает. **Замена по таблице** — эквивалентная замена продуктов в раскладке, в нормах десятилетиями<sup>11, 12</sup>: делает вариативность законной, выбором жителя не является. **Персонализация** — индивидуальные назначения (текстуры, ограничения, усиленное питание) вне общего выбора.

Типовая ошибка: назвать «вариативным» цикличное меню («14 дней без повторов») или таблицу замен («гречку на рис по остаткам»). Выбора жителя нет. В докладе «вариативность» строгая: в момент еды житель реально может получить не менее двух вариантов и влияет на то, какой получит.

## 8.2. Лестница моделей

Между мономеню и «полным выбором» — лестница. Каждая модель (M0–M5) — рабочая конфигурация с известной ценой и рисками. M1–M2 подтверждены российской практикой (Болотнинский, Успенский, Иркутск)<sup>2, 3, 4, 6</sup>.

**Модель M0. Мономеню с учётом отказов.** Выбора нет, но отказ влечёт замену по таблице — житель не остаётся голодным, — а остатки влияют на цикл. Не вариативность, а фундамент: американская федеральная норма требует альтернативу при отказе как базовый минимум<sup>35</sup>.

**Модель M1. Выбор из двух вариантов в одной позиции.** Один второй вариант ключевого блюда (каша А/каша Б, второе А/второе Б) на части приёмов и дней. Российский старт: Болотнинский ПНИ — «несколько раз в неделю», завтрак и обед, перечень определяет диетсестра<sup>2</sup>. Цена: вторая гастрорёмкость, журнал заказа; при парных эквивалентах новых денег почти нет (раздел 29).

**Модель M2. Выбор по всем основным позициям ежедневно.** Два варианта первых, вторых, гарниров, напитков. Успенский ПНИ (все отделения)<sup>3</sup> и региональная модель Иркутской области<sup>6</sup>. Нужны журнал заказа и пересчёт объёмов по статистике выбора (раздел 21).

**Модель M3. Выбор на линии раздачи («шведский стол»).** Житель комплектует тарелку из выставленного ассортимента. Больше выбора — площадь раздачи, скорость потока, санитарный контроль открытых блюд<sup>8</sup>. Для ПНИ — выборочно. Публично такая линия — у ДДСОЛ<sup>2</sup>. Успенский ПНИ — M2 (два вторых, два салата, два напитка), не M3<sup>3</sup>.

**Модель M4. Семейная подача за столом.** Общие блюда, жители накладывают сами. Доказанный эффект у пожилых с деменцией: качество жизни, вес, потребление энергии<sup>33</sup>. Точно, где рассадка и поведение позволяют. Персонал — от раздачи к сопровождению.

**Модель M5. «Своя кухня».** Жители готовят сами при поддержке: британский self-catering на реабилитационных отделениях<sup>36</sup> и американские малые дома Green House<sup>37</sup>. Горизонт квартир тренинга жизненных навыков и подготовки к сопровождаемому проживанию, не массовая модель.

## 8.3. Критерии реального выбора

Любая модель — пять критериев. Формальная «вариативность» отсеивается (раздел 22 и приложение 24).

1. **Доступность:** вариант Б существует, когда подходит житель, а не «закончился к первому отделению».
2. **Равноценность:** эквивалентны по питательной ценности — замена по таблице, не «гречка или ничего»<sup>11</sup>.
3. **Информированность:** знает о выборе и понимает доступным способом (слово, показ, визуальное меню).
4. **Уважение:** выбранное подаётся; переубеждать «для вашей пользы» — не норма.
5. **Учёт:** выбор фиксируется и влияет на завтрашние объёмы и будущие циклы.

## 8.4. Что сказать повару в понедельник

Понедельник раздела 4.2 — замер и журналы. Здесь задача недели: где вы стоите — M0, M1 или M2. Российские подтверждённые практики — M1–M2<sup>2, 3, 4, 6</sup>. Хаотичные журналы — с M0; порядок в документах — с M1 на одном отделении.

## 8.5. Движение вниз по лестнице: тихий регресс

Лестница работает в обе стороны. Вниз — чаще. Уходит инициатор (заведующая, диетсестра) → показ меню «временно» упрощают → через квартал журнал «для проверки», выбор снова делает кухня. Снаружи организация «внедрила»: положение действует. Регресс читается в панели раньше жалоб: падает доля выбирающих, растёт доля «стандартных», журнал срывов пустеет — не потому что срывов нет, а потому что записывать перестали. Противоядие: документ и ритм, не человек — приказ, ротация ответственных, квартальная панель (раздел 31). Практика, пережившая смену двух заведующих, устоялась. До этого рубежа — проект энтузиаста.

## 8.6. Лестница участия жителя: критерий измерения

*Примечание: нумерация ступеней участия (0–5) не совпадает с моделями организации (M0–M5, раздел 8.2). Это разные оси: модели — технология раздачи, ступени участия — мера контроля над едой, возвращённого жителю.*

Степень измеряется одним вопросом: что изменилось в тарелке конкретного жителя сегодня? Проверка через жителя, не через документ. Нулевая: еду определили регион — кухня — смена. Первая: спросили, тарелка та же. Вторая: выбор дошёл до тарелки сегодня. Третья: дошли ещё время и место. Четвёртая: влияет на меню через совет. Пятая: еда снова часть жизни, не процедуры. «На какой мы ступени» звучит абстрактно, пока вопрос не про одного жителя по имени — дальше это план.

## 8.7. Как определить свою ступень за 15 минут

Самооценка почти всегда завышает: «у нас выбор» оказывается «спрашиваем, готовим одно». Три вопроса к фактам. **Покажите вчерашний журнал** — нет записи вчера, ступень не выше первой, что бы ни говорило положение. **Был ли второй вариант физически на линии вчера** — спросить смену, сверить с журналом срывов. **Кто вчера выбрал не то, что принесли бы по умолчанию** — «таких нет» третью неделю: выбор декоративен. Ответы ставят ступень без субъективности. Полная форма — в семинарском пакете (форма ступени). Правило: ступень — вчерашний день, не положение.

## 8.8. Еда как навык сопровождаемого проживания

Сопровождаемое проживание уже не гипотеза: порядка семи тысяч человек вышли из ПНИ в такие программы<sup>7</sup>. Кто десятилетиями не выбирал даже кашу, на выходе встречает магазин и плитку как чужой язык. Ступени 3–5 (время и место, совет, своя кухня) — не «ресторан для интерната», а тренировка: назвать, показать, отказаться, убрать за собой. Вариативное меню внутри дома и менее институциональные формы жизни не конкурируют: первое готовит навык, без которого второе — лозунг. Ближайший год для большинства — ступени 1–2; ступень 5 — горизонт квартир тренинга, не массовая модель (раздел 8.2).

# 9. Пищевое поведение при психических расстройствах

## БЛОК 1.3. КЛИНИКА: ПОВЕДЕНИЕ, ДИСФАГИЯ, ЛЕКАРСТВА, ОТКАЗ, ГИПЕРФАГИЯ, ПИКАЦИЗМ (9–14)

### 9.1. Почему обычные правила здесь работают иначе

Стационарный стол рассчитан на «среднего едока»: пришёл вовремя, сел на 20–30 минут, съел что дали, сказал, если не так. Психические расстройства ломают каждое из этих допущений — системно. Здесь — паттерны, которые стол обязан предвидеть.

Паттерн — симптом, лекарственный эффект или оба. Не характер. На симптом — врач; на лекарственный эффект — врач с кухней; на сбой стола — администрация. «Дисциплиной» не отвечает никто.

### 9.2. Паттерны и их механизмы

**Снижение интереса к еде (депрессия).** Не «отказывается» — еда перестаёт значить, тарелка уходит без слов. Тихое недоедание видно по весу через месяцы. Журнал и триггеры — раздел 12; при долгом снижении — врач. *Wunschkost*: мотивация есть важнее нутритивной строгости<sup>28, 38</sup>.

**Подозрительность к пище (психоз).** «Отравлено», «не то», «с запахом». Убеждать бесполезно. Работают запечатанная упаковка, блюдо из общего котла на глазах, выбор из двух порций, доверенный человек, иногда еда вне зала. Каждый эпизод — врачу: это симптом плана лечения.

**Возбуждение и мания.** Два укуса на ходу — и ушёл. «Мало и часто», *finger food* (BDA — меню без приборов именно для этого)<sup>36</sup>, отдельная комната, отложенная порция. «Обед с 13:00 до 13:30» не работает. Отложенный доступ — британские и австралийские стандарты<sup>39, 34</sup>.

**Седация.** Утренние препараты — человек спит в часы завтрака. Гибкое окно и отложенная порция — прямая рекомендация BDA<sup>36</sup>; австралийский стандарт держит еду и перекусы круглосуточно<sup>34</sup>. «Опоздал — остался голодным» — не дисциплина, а нарушение доступности.

**Ригидность и сенсорные особенности (РАС, умственная отсталость).** Узкий круг «безопасных» блюд; смешанные текстуры не идут; вид, запах, температура, посуда, соседи. Расширять постепенно, без насилия; в каждом приёме — «безопасный» вариант; сенсорика — в карте. Два незнакомых блюда «в лоб» не работают: выбор внутри привычного ряда.

**Быстрое заглатывание.** Почти без жевания, за минуты. Риски: аспирация, удушье, рвота, отбирание еды «по инерции». Малые порции с добавкой, питьё между глотками, посадка рядом с работником, без сухих крупных кусков. Наблюдение — раздел 10: механика риска та же.

**Переедание и гиперфагия.** Раздел 13: препараты и метаболика.

**Прятание и «хомячение».** В тумбочку, под матрас. Причины: опыт голода, тревога, симптоматика, ночное едение (раздел 13). Не изымать — легализовать: перекус на посту снимает мотив прятать. Санитарные правила — заменой запасов, не конфискацией.

**Избирательность «всё или ничего».** Съедает только любимое. Учёт в карте, «опорные» блюда в цикле регулярно, расширение через парные предложения.

### 9.3. Что это меняет в организации стола

Три следствия. Журнал потребления — диагностика: паттерны видны только в записи, врач читает его еженедельно. «Особые состояния» — штатный режим (три строки — 9.6, приложение 3). Гибкость по времени и месту — часть

безопасности: отложенные порции, отдельные столы, приём в жилой зоне стоят в положении о питании, иначе это «нарушение распорядка».

#### 9.4. Границы раздела

Доклад не ставит диагнозов и не описывает лечения. Клиника здесь — стол и наблюдение: что видят сиделка и повар, что фиксирует журнал, когда эскалация к врачу. Кухня клинику не назначает: видит, фиксирует, передаёт врачу.

#### 9.5. Ограничение: паттерн ≠ диагноз

Обратная ошибка — психологизация: «ест быстро, потому что в детстве голодал». Наблюдаемое пишется как наблюдаемое («съедает за 3–4 минуты, не прожёвывает»). «Почему» — врачу и психологу. В журнале и карте — факты; гипотезы — в беседе с врачом. Бережёт жителя от ярлыков и смену от выхода за компетенцию (раздел 28).

#### 9.6. Питание при обострениях: заготовленный режим

Волнообразное течение — норма. Режим на обострение готовится до него. Три строки в карте: что с едой у этого жителя при ухудшении (отказывает / объедается / не выходит в зал / всё отравлено); что помогало (форматы, продукты, люди); кто переводит на режим и обратно (врач). Есть три строки — смена исполняет план. Нет — каждый эпизод заново. Проверка: три заведующих показывают эти строки у трёх жителей. Нечего показать — первая задача на месяц, важнее нового блюда.

#### 9.7. Паттерны по сменам: что видит пост и что с этим делать

Обзоры дают диапазоны, пост начинает со сцены. Переедание при тяжёлых психических расстройствах — 4,4–45 % в зависимости от диагноза и инструмента, тяга к еде — 16,1–64 %, ночное едение — 4–30 %<sup>40</sup>. «Средней частоты» нет. Есть частота вашего контингента. Мерить — самим.

Четыре сцены. Съел всё за минуты и просит ещё — не жадность, возможная гиперфагия терапии (раздел 13) → врач и структурированная доступность. Прячет в тумбочку — часто опыт дефицита (биография, приложение 3) → не отбирать, легальный «запас» из допустимого. Ест только белое / только мягкое — сенсорная селективность → пары эквивалентов внутри спектра, не ломка. Ест только в комнате — перегрузка зала → право на место, не принуждение к залу. Сцена — информация о механизме. Пост, который так читает, — первый диагност системы.

## 10. Дисфагия и аспирационный риск: часто нераспознанная проблема стационарного ухода

#### 10.1. Масштаб, о котором не говорят

Расстройство глотания (дисфагия) при психических расстройствах в отдельных изученных клинических группах встречалось, по разным исследованиям, у 21,9–69,5 % пациентов. Разброс — популяции и методы скрининга. Диапазон **нельзя переносить на все российские ДСО и ПНИ** как единую распространённость<sup>1, 24</sup>. Даже нижняя граница: проблема не редка. В типовом ПНИ часто нет ни логопеда, ни скрининга, ни назначенных текстур. Дисфагия невидима до первой тяжёлой пневмонии.

Цена измерена. Смертность от пневмонии у людей с тяжёлыми психическими расстройствами в семь раз выше популяционной (RR 7,00 по национальным когортным данным); аспирация — ключевой механизм<sup>14</sup>. Разрыв продолжительности жизни — 15–20 лет, и значимая его часть связана с причинами, на которые влияет стол<sup>14</sup>. Дисфагия — вопрос смертности.

#### 10.2. Откуда берётся дисфагия при психических расстройствах

Механизмов шесть, в наших домах они идут сразу:

- 1. Лекарственные:** антипсихотики дают экстрапирамидные нарушения мускулатуры глотания и сухость рта (ксеростомия); седация замедляет глотательный рефлекс<sup>24</sup>.
- 2. Болезненные:** течение расстройства ломает координацию «жевание — глоток — дыхание».
- 3. Поведенческие:** быстрое заглатывание без жевания (раздел 9) перегружает глотание.
- 4. Возрастные:** 65 % жителей старше 45 лет<sup>7</sup>; саркопения и старческая дисфагия накладываются сверху.
- 5. Сопутствующие:** последствия инсультов, болезнь Паркинсона, деменция, эпилепсия.
- 6. Стоматологические:** нет зубов, плохие протезы — «жевательная» задача становится «глотательной».

Дисфагия в ПНИ статистически ожидаема. Система обязана её искать.



### 10.3. Признаки, которые видит сиделка без логопеда

Скрининг не требует специалиста — обученный глаз и правило записи. Тревожные признаки: покашливание или поперхивание во время еды или после; «влажный», булькающий голос после глотка; многократное проглатывание одного куса; еда «за щекой»; необычно долгий приём; отказ от твёрдого или сухого при сохранном аппетите; повторные пневмонии в анамнезе<sup>24, 41</sup>. Любой — повод для врача и теста с водой. Несколько — немедленная коррекция подачи до выяснения.

### 10.4. Текстуры: система IDDSI и её измеримый эффект

Международный стандарт **описания** текстур — IDDSI (восемь уровней: напитки — 0–4, пища — 3–7). «Протёртое» становится проверяемым: вилка, ложка, наклон<sup>42</sup>. Это терминология и проверка консистенции, не диагностика и не лечение. Текстуру назначает уполномоченный медицинский специалист по индивидуальной оценке. Кухня клинику не назначает.

Исследование в пяти учреждениях: соответствие поданных текстур назначенным с 44 % до 90 %, загущённых жидкостей — с 31 % до 100 %; эффект держался 6 месяцев. Барьер — осведомлённость персонала, не техника<sup>43</sup>. Меряется долей правильных текстур на тарелках (чек-лист пищеблока, приложение 19).

### 10.5. Организационный пакет без логопеда

Дом без реабилитолога — почти каждый — делает пять вещей:

1. **Список риска** по 10.3. Живёт на посту и в кухне, не в истории болезни.
2. **Назначенные текстуры**: врач назначает поимённо (мягкая, протёртая, загущённые жидкости) с датой пересмотра; кухня маркирует порции.
3. **Правила стола**: вертикальная поза, медленный темп, малые глотки, без спешки «на бегу», питьё весь приём, работник до конца еды.
4. **Достоинство текстур**: протёртое не выглядит наказанием. Австралийская практика — подача в формах, имитирующих обычные блюда<sup>44</sup>.
5. **«Осознанный риск»**: настаивает на обычной пище — информированное решение с врачом, не самодеятельность сиделки и не насилие<sup>44</sup>.

### 10.6. Связка с вариативностью

Дисфагия не отменяет выбор — переносит его внутрь текстуры: два варианта протёртого второго вместо одного (пара эквивалентов, раздел 19). Иначе группа теряет и здоровье, и голос. В карте (приложение 3) текстура и основание — отдельный раздел с датой пересмотра.

### 10.7. Жидкости: забытая половина дисфагии

Загущение жидкостей — свой контур IDDSI. В исследовании внедрения здесь был самый низкий старт (31 %) и самый большой эффект обучения (до 100 %)<sup>45</sup>. Минимум: загуститель по назначениям, тест стекания с вилки/ложки перед выдачей, кружки с клапанами по показаниям. «Просто меньше пить» ведёт к обезвоживанию; у пожилого оно само провоцирует пневмонии и делирий.

Загущённые напитки снижают потребление жидкости и создают нагрузку лечения; убедительных данных о снижении респираторных осложнений при рутинном применении нет<sup>45, 46</sup>. «Загустить и забыть» — худшая стратегия. Текстура напитка — решение врача с пересмотром.

Дом без врача мониторит: объём выпитого за сутки («стакан» как единица); предложения жидкости между приёмами (чайная пауза — лежачим и при жаре); у жителей на загущённых — тёмная моча, сухость языка, сонливость вне режима. Панель 22: «выпито за сутки, мл (или стаканов), среднее по группе риска».

**Протокол свободной воды** (Frazier), если врач считает риск аспирации чистой воды приемлемым: неограниченная чистая вода между приёмами после гигиены полости рта; иначе — назначенная текстура<sup>45</sup>. Не российская норма. Допуск, группу, исключения назначает врач. Дом: гигиена рта до воды и журнал объёма. Без гигиены рта протокол противопоказан: вода смывает бактериальную нагрузку в лёгкие.

### 10.8. Пакет «без логопеда»: что организация делает своими силами

Специалистов глотания у большинства СОСО нет. Это ограничение, не повод стоять. К пакету 10.5 — четыре элемента.

**Распознавание.** К 10.3 добавляются длительное пережёвывание без глотка и подтекание изо рта. Один инструктаж. Любой признак → запись → врач.

**Поза и темп.** 90°, подбородок чуть вниз, малые глотки, паузы, 30 минут после еды без укладывания<sup>41</sup>.

**Текстура.** IDDSI с вилкой и наклоном<sup>42</sup> — одно занятие повару. 44 → 90 % поднимали обучением, не оборудованием<sup>43</sup> (см. 10.4).

**Инцидент.** Алгоритм приложения 12; два обученных человека на посту в часы еды.

Пакет не лечит, не заменяет инструментальную оценку, не отменяет врача. Переводит дом из «не знаем, кто в риске» в «знаем, наблюдаем, исполняем назначения» — уровень проверки и уровень, который спасает жизни.

### 10.9. Структурированный скрининг: шкала вместо «опытного глаза»

Признаки 10.3 зависят от наблюдателя. Там, где дисфагия вероятна (тяжёлые нарушения, повторные пневмонии, кашель при еде), нужен валидированный инструмент. **GUSS** (Gugging Swallowing Screen) — четыре шага: непрямая проба, полужидкое, жидкость, твёрдое; валидирован против эндоскопии; выполняет подготовленная медсестра<sup>47</sup>. **EAT-10** — 10 вопросов о симптомах, с жителем или интервью<sup>48</sup>. Число в карту, сравнение через полгода.

Созданы не для психиатрического контингента; инструкцию адаптируют. Текстуру назначает врач. GUSS/EAT-10 — по показаниям; шесть признаков — ежедневно всем.

### 10.10. Гигиена полости рта: самая дешёвая профилактика аспирационной пневмонии

Аспирационная пневмония — главный смертельный риск (10.1). Бактериальная нагрузка формируется во рту. РКИ на 366 проживающих домов ухода: уход после каждого приёма (щётка; в части случаев — повидон-йод) плюс еженедельный осмотр стоматолога снизил пневмонии с 19 % до 11 %<sup>49</sup>. Обзор van der Maarel-Wierink et al. (пять публикаций): улучшение ухода **может снижать** частоту пневмонии и связанную смертность у немощных пожилых<sup>50</sup>. «Примерно каждая десятая смерть» — узкая выборка, не доказанный эффект для российских ПНИ: дома ухода, не психиатрия.

Не «две минуты на всех 951 место», а **группа зависимости**: кто не чистит зубы сам (постельные, тяжёлая умственная отсталость, выраженная седация). Формула: зависимые × 2–3 минуты × приёмы. На 80 зависимых и три приёма — около 8 человеко-часов в сутки: ставка, не жест. Минимум: щётка/губка и паста не «по запросу»; строка обхода («рот осмотрен, обработан»); обучение смены. Панель 22: «осмотр полости рта выполнен, % группы риска». Протезы: плохо сидящие и сухость во рту — две главные жалобы домов ухода<sup>51</sup>. Протез, мешающий жевать, маскирует «плохой аппетит» (раздел 12).

### 10.11. Зондовое и энтеральное питание: отдельный контур, не «без выбора»

Для зонда и гастростомы вариативность — не два вторых на линии, а **время, объём, положение, вкус разрешённых пастообразных добавок** (если врач допускает пероральные пробы) и ритуал стола: сидеть со всеми, не есть в палате как исключённый. Прямых исследований вариативного меню при энтеральном питании в ПНИ нет. Смесь, скорость, положение — только врач. График вне пика седации; «нельзя в столовую» — не дисциплина. Пероральная проба при зонде — информированное решение врача, не инициатива смены.

## 11. Лекарства и еда: пять правил, которые обязана знать кухня

### 11.1. Принцип раздела

Взаимодействий «препарат — пища» — десятки. Стол держит не справочник, а перечень с действием для кухни, поста и меню. **(установлено)** — исследования и официальные инструкции/справочники. **(мониторинг)** — стабильность и наблюдение, не запрет. **(рекомендация)** — предосторожность руководств.

### 11.2. Правило 1. Клозапин – кофеин: считать чашки (установлено)

Кофеин ингибирует метаболизм клозапина: в контролируемом исследовании добавление кофеина повышало AUC в среднем на 19 %<sup>15</sup>; резкий рост потребления доводил концентрацию до токсических значений (случай 1796 нг/мл)<sup>25</sup>. Резкая отмена привычного кофеина: падение на 37–47 % с риском потери эффекта<sup>52</sup>. Курение индуцирует метаболизм клозапина и оланзапина, снижая концентрации примерно вдвое; резкое прекращение без коррекции опасно<sup>15</sup>.

**Действия:** в карте — привычное потребление кофе/чая/энергетиков; запрет на резкие изменения (семья письменно, приложение 32); кофе не «награда» и не «наказание»; изменение привычки — врачу. Правило входит в британскую таблицу в меню<sup>36</sup>.

### 11.3. Правило 2. Литий – соль и вода: стабильность, а не запрет (мониторинг)

Литий чувствителен к водно-солевому балансу. Резкое уменьшение соли или обезвоживание повышают концентрацию до токсической (дрожь, спутанность, рвота); резкое увеличение снижают эффект<sup>16, 53</sup>. Опасные сцены: «малосольный стол» по инициативе кухни; жара без воды; рвота/диарея; отказ от питья при обострении. Кухня не назначает солевой режим.

**Действия:** без врача солевой режим не меняют; вода видна, не «по просьбе»; рвота/диарея или жара — врачу в тот же день; отказ от еды и питья — эскалация раздела 12 сокращается.

#### 11.4. Правило 3. ИМАО – тирамин: тираминовая разметка меню (установлено)

Неселективные ингибиторы МАО (редко, но назначают) с тирамином дают гипертонический криз: выдержанные и плесневые сыры, копчёности, соленья, брынза, пиво, квас домашний, соевый соус<sup>47, 54</sup>. Описано: давление со 160/90 до 220/115 и выше<sup>55</sup>.

**Действия:** отдельная строка в меню-потребности; кухня получает тираминовую разметку от врача; выбор — внутри безопасного множества. Вариативность полная.

#### 11.5. Правило 4. Грейпфрут – ряд психотропных: исключить по списку (установлено)

Грейпфрут и его сок ингибируют CYP3A4 и повышают концентрации. Для карбамазепина — рост AUC порядка 40 %<sup>18</sup>. В зоне внимания — некоторые бензодиазепины и часть антипсихотиков.

**Действия:** грейпфрут и сок не входят в закупку и в меню вовсе; «подарочные» фрукты проверяет дежурный. Одна строка в положении закрывает вопрос.

#### 11.6. Правило 5. Алкоголь и энергетики: нулевая терпимость + серые зоны (рекомендация)

Алкоголь при психотропных непредсказуемо усиливает седацию и риски. В стационаре исключён полностью — в правилах передач. Серая зона — энергетики (кофеин + стимуляторы): для клозапина это правило 1, для тревожных и биполярных — провокация. Энергетики в буфете закрывает ассортиментный перечень.

#### 11.7. Лекарственно-пищевая таблица: форма

Пять правил — таблица (приложение 21): препарат — недопустимо/контролируется — кухня — пост — врачу. Заполняет врач по назначениям, пересматривает при смене терапии. Копии: пост, кухня, комната передач. BDA встраивает такую таблицу в меню и в информирование пациентов<sup>36</sup>. Наша форма — тем же российским документооборотом.

#### 11.8. Чего в разделе нет

Перечень не исчерпывающий: полный список ведёт врач. Кухня не трактует инструкции: исполняет таблицу. Правила задают границы, внутри которых выбор полный.

#### 11.9. Передачи как фармакологический канал

Без управления комната передач — неконтролируемая аптека. Кофе, крепкий чай, энергетики, грейпфруты, копчёности, алкоголь приходят оттуда — с любовью и без рецепта. Порядок: перечень на стенде (санитарный и лекарственный блоки отдельно), регистрация, маркировка, выдача по режиму для позиций таблицы. Памятка (приложение 32): «проверяем передачи, потому что у вашего близкого лекарства конфликтуют с продуктами».

#### 11.10. Границы таблицы

Таблица (приложение 21) — минимум дома, не справочник. Полный справочник — у врача и в аптечных системах. Полная фармакология на посту не читается. Классы уверенности учат смену: «установлено» (клозапин – кофеин, литий – соль) и «осторожность по классу» (отдельные комбинации ИМАО) — разная жёсткость при разной доказательности.

#### 11.11. Три сценария из практики поста

**«Добрый кофе».** Житель на клозапине — термос от близких. Кофеин ингибирует CYP1A2; случай 1796 нг/мл с тяжёлой клиникой<sup>25</sup>; популяционно AUC +19 % уже при обычном потреблении<sup>15</sup>. Не конфискация со скандалом — врачу и согласованный режим. Резкая отмена: –37–47 %<sup>52</sup>.

**«Солёные огурцы к выходным».** Солёная передача раз в неделю на литии. Натрий конкурирует с литием за выведение<sup>16, 53</sup>. Не запрет огурцов — стабильность и врач.

**«Сок вместо воды».** Грейпфрутовый сок «для витаминов» на карбамазепине: +40 %<sup>18</sup>. Исключение на уровне кухни, не памяти смены.

Ловятся конструкцией: таблица, правило передач, «увидел → врачу сегодня».

## 12. Отказ от еды: от первого пропуска до врачебного решения

### 12.1. Почему отказ — самая опасная бытовая ситуация

Отказ в ПНИ случается ежедневно и обрабатывается «глазами»: заметил, сказал, решил. За ним — «невкусно», депрессия, психоз, дисфагия, соматика, предсмертный период. Пропущенный «каприз» стоит тарелки; пропущенная дисфагия или депрессия — жизни<sup>14, 24</sup>. Нужен алгоритм, не интуиция дежурного.

### 12.2. Классификация причин

Шесть корзин, у каждой — владелец решения:

| Причина                                           | Признаки                                           | Владелец решения           |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| Организационная («невкусно», «не то», «холодное») | Избирательно, на конкретные блюда; остальное ест   | Кухня + администрация      |
| Состояние (депрессия, тревога, психоз)            | Изменение поведения, сна, контакта                 | Врач                       |
| Лекарственная (тошнота, седация, сухость)         | Совпадает с назначением/сменой терапии             | Врач                       |
| Дисфагия/соматика                                 | Покашливание, долгий приём, боль, запор            | Врач (срочно)              |
| Осознанный отказ конкретного человека             | Аргументированный, стабильный, при ясном состоянии | Житель (фиксируется)       |
| Предсмертный период                               | Общее угасание, паллиативный статус                | Врач + паллиативная служба |

Смешение корзин — главная ошибка: «осознанный отказ» лечат как симптом, симптом списывают на «характер».

Строки «болит жевать» в таблице нет — частая маска. Плохо сидящие протезы и сухость во рту — две главные проблемы полости рта у проживающих домов ухода; их сообщают более половины опрошенных<sup>51</sup>. Выглядит как «плохо ест твёрдое, просит мягкое» и уходит в «организационную», хотя место — в стоматологическом маршруте. Вопрос «болит ли жевать, мешает ли что-то во рту» разделяет пути за десять секунд. Рот и протезы — в пищевом паспорте при поступлении (приложение 37).

### 12.3. Алгоритм эскалации

Канадское регулирование: отказ от трёх приёмов подряд и оставление ≥25 % порции за двумя из трёх приёмов за неделю — триггеры врачебной оценки<sup>23, 56</sup>. Проект российского правила (не российская норма — маркировка обязательна):

1. **Каждый отказ фиксируется** в журнале (приложение 9): кто, приём, что отвергнуто, сколько съедено, поведение.
2. **Отказ → альтернатива** в тот же приём по таблице. Житель не остаётся голодным — норма американского федерального правила<sup>35</sup>.
3. **Три отказа подряд → врач в тот же день**. Не «на обходе в четверг», не «завтра утром».
4. **≥25 % порций несъедено системно за неделю → врач + пересмотр карты** (два дня).
5. **Отказ от воды или от еды и воды → немедленно**. Обезвоживание при литии и ряде препаратов — прямая угроза<sup>53</sup>.
6. **Эпизод закрывается записью**: что установлено, что назначено, когда пересмотр.

### 12.4. Насилие недопустимо — и что это значит юридически

«Кормить силой» недопустимо безоговорочно. Это насилие, противоречащее праву на уважительное и гуманное отношение, исключаяющее унижение достоинства (ст. 5 ч. 2 Закона № 3185-1). Статья 43 распространяет на проживающих в стационарных организациях социального обслуживания права ст. 37; ч. 2 ст. 37 — перечень прав пациентов психиатрического стационара, не норма о гуманном обращении<sup>8</sup>. Иное — медицинское искусственное питание: решает врач по законодательству об охране здоровья и правилам психиатрической помощи. Доклад в эту плоскость не входит. Граница: предлагают, заменяют, адаптируют, фиксируют, эскалируют — силой не вводят.

### 12.5. Дееспособность и осознанный отказ

Британская модель: дееспособность — по конкретному решению в конкретный момент. Человек с психическим расстройством может быть способен отказаться от конкретного приёма — решение фиксируется и уважается<sup>39</sup>. Российская рамка иная (раздел 16): недееспособность не отменяет учёта мнения; отношение к бытовому вопросу оценивается по существу<sup>8</sup>. Форма: слова жителя в журнале («отказался от ужина, поел в 21:00 по просьбе») — данные, не «нарушение».

## 12.6. Предемертный период

В паллиативной фазе нутритивные цели уступают комфорту. Wunschkost: то, что человек хочет и может, важнее полноты<sup>28, 38</sup>. Для ПНИ со стареющим контингентом<sup>7</sup> маршрут питания существует письменно: кто определяет статус, как меняется меню, как информируется семья. Оформление — комплект раздела 31.

## 12.7. Что сказать смене в понедельник

Журнал отказов. «Три подряд → врач сегодня». Альтернатива при каждом отказе. Список дисфагического риска на посту. Стоимость — тетрадь и инструктаж.

## 12.8. Что говорить жителю: фразы смены

Слова в момент отказа рождаются плохие: «ну что ты, давай ложечку». Готовые формулы. От блюда: «Хорошо, это уберу. Есть ещё \_\_, принести?» — без «почему» и без оценки. От еды: «Не будете сейчас — оставляю, скажете, когда захотите» — контроль жителю, еда сохраняется. «Отравлено»: «Я вас услышала. Скажу врачу, он придёт сегодня. Хотите, принесу в упаковке?» — без спора с содержанием. Запрещены: «а кто будет доедать», «врач сказал надо», «в последний раз предлагаю».

## 12.9. Насилие: почему формулировка жёсткая

Запрет 12.4 без оговорок сознателен. «Принуждение в исключительных случаях» в стационаре расширяется усталостью смен и дефицитом рук. Удержание, вливание, шантаж, лишение «пока не съешь» недопустимы всегда. Истощение решает врач (назначения, энтеральная поддержка по показаниям, госпитализация), не сила смены. Эпизод принудительного кормления — готовый сюжет для прокуратуры<sup>8</sup>.

## 12.10. Разбор эскалации по часам

Правило работает с часами и фамилиями. Завтрак 8:30 — отказ в журнале к 9:00, замена предложена. Обед 13:00 — второй отказ; старшая смены выясняет контекст до 14:00 (болен? конфликт? «отравлено?»). Ужин 17:30 — третий; 18:00 — дежурному врачу или по телефону; решение письменно тем же вечером.

Три провала. «Подожждём утреннего обхода» — обход через сутки; для бреда поздно. «Передадим устно» — второй отказ теряется, счёт с нуля. «Наблюдайте» без записи — не решение; в записи: что, как часто, когда пересмотр. Три-четыре сообщения в месяц — рабочий поток. Никогда — вопрос, ведётся ли журнал.

## 12.11. Паллиативное питание: comfort feeding и границы искусственного питания

В периоде 12.6 отказ — часть процесса. Вопрос не «как накормить», а «что еда делает для человека». **Comfort feeding** (комфортное кормление): еда и питьё, пока приносят комфорт — любимые блюда, малые порции, помощь и время — без принуждения и без искусственного питания против воли<sup>57</sup>.

Исходы читать точно. Ретроспективное госпитальное исследование после рекомендаций comfort feeding — без группы сравнения: среди глубоко паллиативных госпитализированных с деменцией медиана выживаемости — 13 дней<sup>58</sup>. Описывает популяцию, не сравнивает режимы; вывода «не меняет выживаемость» не содержит. Обзор перорального питания при деменции фиксирует прибавку веса при высококалорийных добавках, нет доказанных эффектов на другие исходы, сильна роль предпочтений и культуры ухода<sup>57</sup>. Рамка меняет качество процесса, не доказанно длительность.

Локальный акт — три строки: (1) формат в конце жизни определяет врач с семьёй и, где возможно, с жителем; (2) любимые блюда и доступные текстуры — элемент паллиативного контура, не «поблажка»; (3) отказ документируется по 12.4–12.5. *Маркировка: comfort feeding — международный ориентир, не российская норма; зондовое и парентеральное питание — исключительно врачебное решение (раздел 18 семинарского пакета: «не без врача»).*

## 13. Переедание, гиперфагия и ночное едение

### 13.1. Метаболическая цена антипсихотиков: что доказано

Прибавка веса на антипсихотиках — измеренный классовый эффект с большим разбросом, не «особенность». Мета-анализ 100 рандомизированных исследований (Pillinger и соавт., 2020): от −0,23 кг до +3,01 кг за шесть недель<sup>13</sup>. Клинически значимая прибавка (≥7 % массы тела) при длительном применении (около 38 недель, Campforts и соавт., 2023, BJPsych Open, DOI bjo.2022.619): клозапин — 76,3 %, оланзапин — 36,9 %, рисперидон — 23,0 %<sup>9</sup>. Первый эпизод психоза: долгосрочно +9,34 кг (оланзапин) и +7,19 кг (клозапин)<sup>60</sup>. Мониторинг предписан: вес, глюкоза, липиды по расписанию<sup>61</sup>.

Переедание на весогенном препарате — гиперфагия, не «прожорливость»; дисциплина здесь ошибка. Кухня не лечит голоданием: самостоятельные ограничения без врача незаконны (раздел 17) и опасны. Клинику кухни не назначает.



### 13.2. Пищевое поведение: что показывают исследования

RESOLVE при тяжёлых психических расстройствах: переедание 4,4–45 %, тяга к еде (food craving) 16,1–64 %, ночное едение 4–30 %<sup>40</sup>. Широта — методы и популяции; даже нижние границы — заметный контингент в каждом доме.

Вмешательства по весу скромны. Мета-анализ образа жизни: порядка –1,4 кг<sup>62</sup>; программа с диетологом (Teasdale) лучше именно при специалисте<sup>63</sup>. Марафон с малыми цифрами. Ядро — среда, мониторинг, врач, не ограничения.

### 13.3. Что может организация питания (без подмены врача)

**Мониторинг веса.** Старт терапии, 4-я, 8-я, 12-я неделя и далее. Триггеры +5 % за 3 месяца и онтарианские пороги 5/7,5/10 % — сигналы врачу<sup>61, 23</sup>. Весы, журнал, ответственный — стоимость нулевая.

**Среда вместо запретов.** Доступное между приёмами важнее запрещённого: фрукты и кисломолочное вместо выпечки; нет энергетиков, лимит сладких напитков (раздел 11); приёмы без «дыр». Это не диета и не режет порций — законно без врача.

**Добавка по правилам.** «Дай вторую котлету» (кейс раздела 5) закрывает письменный порядок: кому, что, когда. Ограничение порций — только врач, только поимённо (раздел 17).

### 13.4. Ночное едение: не наказывать, а структурировать

Ночные набег (4–30 %<sup>40</sup>) имеют три корня: препаратная гиперфагия, сон-аппетит, тревога. Замок на кухне добавляет тревогу, конфликт, поиск еды вне дома. **Структурированная ночная доступность:** поздний перекус по расписанию; вода, чай, сухой перекус на посту.

Та же мера сокращает интервал «ужин — завтрак». Международные нормы: 11–14 ч<sup>30, 35</sup>. 14 ч — верх CMS (США), не российская норма и не цель. Рабочая цель дома — ≤13 ч. Одна бесплатная мера закрывает две задачи — поведенческую и нормативную.

### 13.5. Когда вопрос клинический

Врачу: +5 % и более за 3 месяца на препарате; гиперфагия, ломающая режим; ночное едение как синдром; любой запрос «посадить на диету». Только врач: смена препарата, ограничительный рацион, эндокринолог, метформин. Дом даёт вес, журнал, карту и исполняет назначения.

### 13.6. Что сказать повару в понедельник

Вес с триггерами, правила добавки, ночная доступность. «Посадить на диету» без врача нельзя. Выбор внутри среды снижает конфликт.

### 13.7. Разговор с жителем о весе: без стыда

«Воспитательные беседы» бесполезны и жестоки: весогенность не лечится стыдом<sup>13</sup>. Формула: «побочный эффект лечения, который мы вместе обходим», не «ваше переедание». Инструменты: объёмные низкокалорийные добавки, дробность, доступность по режиму, активность. Понимающий порцию сотрудничает. Без объяснений обходит — передачи, чужие тарелки, подполье, где калорий больше.

### 13.8. Метаболический мониторинг как часть питания

Вес и сахар — предмет кухни не меньше кабинета. Антипсихотики различаются на килограммы за недели<sup>13</sup>; при первом эпизоде +9,34 кг на оланзапине<sup>60</sup>; мониторинг на практике неполный<sup>61</sup>. Для СОСО: ежемесячно, одни весы, одно время; >5 % за квартал → врач и пересмотр плана.

Отдельно — недостаточность, не набор. MUST (Malnutrition Universal Screening Tool, BAPEN) — пять шагов: ИМТ, непреднамеренная потеря >5 % за 3–6 месяцев, острое заболевание; в домах ухода обычно ежемесячно<sup>64</sup>. Это не «+5 % на оланзапине»: набор и потеря — две строки панели 22. Заполняет медсестра или врач. Кухня даёт вес и факт поедания, категорию риска не ставит. Лежащий без кресла-весов: строка «вес» — фикция. Онтарио: ≥5 % / 30 дней, ≥7,5 % / 90, ≥10 % / 180<sup>23</sup> — врачу сегодня.

### 13.9. Ночная доступность: конструкция, а не «открытый холодильник»

Не свободный доступ к кухне и не «ночью ничего нет». Четыре элемента к 13.4. **Перечень** — два-три продукта с врачом (кефир, хлеб, фрукты по сезону; при метаболическом риске — низкокалорийные объёмные). **Место** — пост или буфет отделения, не кухня. **Режим** — окно (например, 21:00–22:00 и при ночном пробуждении), запись. **Границы** — гиперфагия порционно, не «возьми сам».

Клинически: едение перестаёт быть подпольным. Право: ночная еда — услуга, не «нарушение режима». 4–30 %<sup>40</sup> на 30 человек — от одного до девяти еженощно. Вопрос — «подпольно или организовано».

### 13.10. Запор: скрытый регулятор аппетита и поведения

Сниженный аппетит, «необъяснимое» беспокойство, отказы часто имеют причину — запор. На клозапине: 30–60 %; гипомотильность ЖКТ при объективных исследованиях — до 80 %; исход — илеус, перфорация, смерть. TGA (Австралия) ввёл предупреждение в инструкцию<sup>65</sup>. NHS называет запор при клозапине потенциально фатальным: мониторинг стула и профилактические слабительные по назначению врача<sup>66</sup>.

Стол: да/нет стула за сутки в постовом журнале, без деталей; вода и клетчатка в меню, не «по просьбе»; движение после еды. Трое суток без стула в группе антихолинергической нагрузки — врач сегодня. Журнал — сведения о здоровье: пост и врач, не кухня и не «все смены»; основание — соцслужбы / 152-ФЗ (раздел 17.6); диагноз не пишется. *Маркировка: питание — поддержка и мониторинг; слабительные, диагностика, подбор — только врач (раздел 18 семинарского пакета: «не без врача»).*

### 13.11. Микронутриенты: то, что не видно на весах

Мониторинг 13.8 не видит дефицитов настроения, когнитии, аппетита. **Витамин D:** дефицит в психиатрической популяции распространён, рутинный скрининг рекомендован<sup>67</sup>; карбамазепин — фермент-индуктор, мета-анализ связывает его со снижением 25(OH)D<sup>68</sup>; он уже в таблице раздела 11. **B12 и фолат:** с возрастом, связаны с депрессией и когнитивными нарушениями, недодиагностируются у пожилых<sup>69</sup>. **Железо:** редкое мясо плюс потери — анемия под маской «усталость и не ест». Дом спрашивает и подсвечивает: «профиль микронутриентов обсудить с врачом» в годовом маршруте антиконвульсантов и вегетарианцев. Анализы и добавки — врач<sup>67</sup>.

### 13.12. Инсулин и время еды: гибкий стол без гипогликемии

Диабет в стационаре обычен; вариативность ломает «все едят в одно время». Инъекция привязана к раздаче, житель выбрал отложенный приём или другой объём — клинический риск. Прямых российских норм «инсулин × вариативное меню» нет. Список на инсулине — у поста и кухни без диагноза в открытом доступе («время еды фиксировано / гибкое»). Сдвиг больше [локальный порог, согласовать с врачом] — только с отметкой врача. Отложенный обед — с переносом инъекции или не предлагается. Гибкость остальных не страдает. *Только врач меняет схему; организация не сдвигает инсулин «по договорённости смены».*

## 14. Пикацизм, заглатывание и другие поведенческие риски за столом

### 14.1. Круг рисков

Помимо паттернов 9–13, столовая ПНИ встречается с рисками, редкими по отдельности и неизбежными в сумме. Их не лечит организация — ими управляет. Цена — безопасность.

**Пикацизм (поедание несъедобного).** Бумага, земля, мел, вата, бытовая химия, чужие лекарства. Умственная отсталость, психозы, деменция. Среда без доступных опасных объектов (химия и медикаменты вне досягаемости — отдельный учёт); наблюдение за зафиксированным пикацизмом за едой и на прогулке; информирование всей смены, не только врача. Запись в карте обязательна: это пищевая безопасность не меньше аллергии.

**Быстрое заглатывание.** В разделе 9 — паттерн; здесь — риск. Как у дисфагии: непрожёванный кусок перекрывает дыхательные пути. Удушье пищей (choking) — документированная причина смерти в психиатрических учреждениях<sup>41</sup>. Малые порции с добавкой, без крупных сухих кусков, посадка рядом с работником, приём Геймлиха у смены. Это пищевая безопасность, не «первая помощь вообще».

**Отбирание еды и «грабёж» стола.** Гиперфагия на препаратах (раздел 13), недокорм прошлого опыта, поведение. Рассадка не рядом с медленными едоками группы риска; правила добавки; вес обоих. Жертву не делают виноватой: порция восполняется всегда.

**Опрокидывание, бросание, отказ от приборов.** Возбуждение или протест. Посуда без стекла; finger food как штатная опция (BDA включает его именно для этого)<sup>36</sup>; отдельный стол; приём после снижения возбуждения — отложенная порция вместо пропущенной (раздел 12).

**Ритуалы и пищевые «правила».** Цвет, своя тарелка, порядок блюд. Пока не опасен — учитывается, не «лечится»: самый дешёвый вид персонализации. Карта фиксирует как данность, кухня считается.

### 14.2. Общий протокол: среда, наблюдение, запись, эскалация

Четвёрка для локального акта:

- 1. Среда:** опасное вне досягаемости; посуда безопасная; рассадка продуманная.
- 2. Наблюдение:** работник за столом видит, не только подаёт. «Обеденный дежурный» — штатная роль.
- 3. Запись:** пика, заглатывание с поперхиванием, отбирание, опрокидывание — строка в журнале, не рассказ «на кухне».
- 4. Эскалация:** повтор — врач; угроза (поперхивание, несъедобное, чужое лекарство) — врач немедленно.

### 14.3. Граница с насилием — вторая сторона

Соблазн: связать, запереть, изолировать от еды, кормить отдельно «наказанием». Вне закона (ст. 37 Закона № 3185-1: гуманное отношение и уважение достоинства)<sup>8</sup> и вне доказательности: сила не меняет гиперфагию, пикацизм, заглатывание. Изоляция при возбуждении — клиническая процедура (питание по 12.4 и BDA<sup>36</sup>), не «дисциплина за столом». Локальный акт запрещает: лишение еды как меру, ограничение питья, «штрафные» порции. Строка положения защищает жителя и директора.

Здесь дешевле предвидение. Один инструктаж (среда — наблюдение — запись — эскалация), безопасная посуда, раскладка и добавка, запрет «едовых наказаний» — и эпизод кончается записью, не травмой.

### 14.5. Заглатывание предметов: граница с соматикой

Проглоченный предмет — соматика. Стул, температура, боль в животе в последующие дни — по назначению врача, с записью. «Проглотил — вышло — забыли» опасно: часть предметов травмирует не сразу. Каждый эпизод — протокол разбора (приложение 34). Вопрос не «кто недосмотрел», а «как предмет оказался доступен»: второй чинит систему, первый учит смену молчать.

### 14.6. Пикацизм и кухня: точка пересечения

Часть эпизодов — поиск еды несоциальными способами на фоне голода (реального или субъективного при гиперфагии). Два инструмента: структурированная доступность (перекусы снижают поисковое поведение) и безопасный буфет (нет ничего, что нельзя есть). Правильный стол здесь — профилактика инцидентов.

### 14.7. Протокол «среда — наблюдение — запись — эскалация» на практике

Четыре звена 14.2 — по людям и часам. **Среда:** еженедельный осмотр зоны старшей сменой (мелкие предметы, оторванная одежда и мебель, моющие, пуговицы и шнурки), строка с подписью; десять минут ловят риск до эпизода. **Наблюдение:** не «смотреть постоянно», а окна риска — скука и безструктурное время после еды; занятие, прогулка, присутствие сильнее надзора. **Запись:** что, когда, где, что предшествовало; серия за месяц даёт паттерн. **Эскалация:** врач при первом эпизоде (пикацизм — симптом, не «привычка»: дефициты, компульсии); скорая — при опасном проглатывании. Замещение: жевательные альтернативы и доступность еды с врачом. Как ночная доступность (раздел 13): нет легального выхода — поведение уходит в подполье.

## 15. Невербальный выбор: как услышать того, кто не говорит

### БЛОК I.4. ПРАВО И САНИТАРИЯ: НЕВЕРБАЛЬНЫЙ ВЫБОР, ДЕЕСПОСОБНОСТЬ, ПРАВО РФ, САНПИН (15–18)

#### 15.1. Масштаб вопроса

Три четверти жителей российских ПНИ признаны недееспособными<sup>7</sup>. Значимая часть остальных не скажет выбора словом: неговорящие и малоговорящие, глубокая умственная отсталость, деменция, острые состояния. Если вариативность стоит на вопросе «что будете?», она сама отсекает большинство. Технология выбора для тех, кто не говорит, — ядро системы, не пристройка.

#### 15.2. Правовая рамка: поддержанное, а не подменяющее решение

Международный стандарт — Замечание общего порядка № 1 к ст. 12 Конвенции о правах инвалидов: «мы знаем лучше» подлежит замене поддержкой. Человек получает помощь, чтобы выразить свою волю; воля и предпочтения не подменяются «лучшими интересами»<sup>26</sup>. Российское право этой логике не противоречит, но основания нельзя смешивать. Статья 43 Закона № 3185-1 задаёт статус и права проживающих в стационаре<sup>8</sup>. Обязанность опекуна учитывать мнение подопечного и сведения о его предпочтениях — из ст. 29 ГК РФ и 48-ФЗ. 442-ФЗ закрепляет права получателя и индивидуализацию услуг. Выбор еды — бытовое решение, не сделка: неспособность к сделкам не отменяет способности предпочитать.

*Маркировка: этот абзац — системное толкование норм, а не прямое правило закона; прямой нормы «выбор блюда не требует дееспособности» в российском законодательстве нет. Практические формы ниже — проект локальной практики.*

#### 15.3. Четыре канала воли

**Канал 1. Показ вместо вопроса.** Вербальный выбор требует удержать в памяти два слова и соотнести их с опытом — многим это непосильно. Две реальные порции снимают задачу: человек указывает, тянется, смотрит, отворачивается. Практика деменс-ухода рекомендует визуальный выбор вместо вербального<sup>70, 36</sup>. Вариант Б должен физически стоять на линии: без минимальной вариативности показ двух порций невозможен (ступень 1, раздел 8).

**Канал 2. Наблюдение за потреблением.** Тарелка — это голос. Систематически несъеденное — зафиксированное «нет», доеденное до конца — «да». Журнал потребления (раздел 9) становится документом предпочтений.

Скандинавские муниципальные стандарты прямо требуют документировать наблюдаемые предпочтения тех, кто не сообщает их словами<sup>71</sup>.

**Канал 3. Пищевая биография в «хороший день».** Пока состояние позволяет, с жителем — и с семьёй, с прежними работниками — заполняется пищевая биография: любимое, нелюбимое, ритуалы, «детские» блюда, распорядок<sup>28</sup>. Документ держит волю периода максимальной ясности, когда ясности меньше, — приоритет зафиксированной воли<sup>26</sup>. Форма — приложение 3.

**Канал 4. Те, кто знает человека.** Семья, опекун, давние работники — источники интерпретации воли, а не «решающие за него». Сведения входят в пищевую карту с указанием источника<sup>26</sup>.

#### 15.4. Иерархия источников при расхождении

Порядок фиксируется в локальном акте: (1) зафиксированная воля самого жителя (пищевая биография, устойчивые предпочтения); (2) текущая демонстрируемая воля (показ, жест); (3) сведения близких; (4) медицинские ограничения по назначению врача — сужают пункты 1–3 только при реальной клинической необходимости; (5) удобство кухни в иерархию не входит. Медицинское ограничение не отменяет выбор, а задаёт его множество: австрийский стандарт требует вовлекать проживающего в решение о диете<sup>38</sup>.

#### 15.5. Технология на линии: сценарий для смены

Сценарий показа, проверенный логикой российских внедрений<sup>2, 3</sup>:

1. На линии — два варианта в одинаковых гастрорёмкостях, на виду.
2. Работник показывает обе порции неговорящему жителю, называя их просто: «гречка — рис».
3. Реакция — один из четырёх значков журнала: указал / потянулся / отвернулся / без реакции.
4. Нет реакции — вариант по пищевой карте (зафиксированное предпочтение), не «первый по очереди».
5. Потребление фиксируется и корректирует карту.

На одного жителя — 15–20 секунд; на отделение — несколько добавочных минут на линии, которые окупаются снижением несъеденных порций.

«Наши не могут выбирать» — самое частое возражение (раздел 37) и самое проверяемое. Три дня: покажите трём неговорящим две порции и запишите реакцию. Обычно «не может» значит «никогда не спрашивали доступным способом». Где 74 % жителей недееспособны<sup>7</sup>, невербальный выбор и есть вариативность, а не её запасной ход для меньшинства.

#### 15.7. Обучение смены чтению воли: три упражнения

Навык считывания тренируется. Три упражнения инструктажа: «молчаливый заказ» — сотрудники заказывают друг у друга без слов и проверяют, как их поняли; «перестановка» — тест позиционного эффекта на себе; «неделя наблюдения» — мини-журнал одного жителя и защита вывода перед сменой. После этого форма приложения 6 — уже запись того, что смена умеет видеть, а не бумажка.

#### 15.8. Ошибка «профессионального чтения»

Риск — уверенность смены: «я его десять лет знаю». Опыт ценен и непроверяем: знание живёт в голове и уходит с ротацией. Любое «я знаю» переводится в запись — карта, форма наблюдения — в течение недели; непереверённое для системы не существует. Это звучит бюрократично до первой смены кадров. После неё это единственный способ не потерять человека вместе с ушедшей сиделкой.

#### 15.9. Иерархия источников воли: кто на каком месте

Каналы противоречат регулярно. Без заранее объявленной иерархии побеждает тот, кто говорит громче. Рабочий порядок из пяти уровней — иной, чем в 15.4; оба записываются в положение о питании. 1) **текущее выраженное предпочтение жителя** (жест, показ, отказ, съеденное) — сильнейший источник, пока не противоречит назначениям врача; 2) **зафиксированная биография** (приложение 3) — воля ясного периода сильнее текущих догадок окружающих; 3) **систематическое наблюдение** (форма приложения 6, серия записей) — сильнее единичного впечатления любого сотрудника; 4) **сведения близких** — данные биографии, но уступают наблюдению при расхождении («дома он любил» — здесь два месяца не ест); 5) **«усреднённое благо»** («всем полезно») — слабейший источник, только когда первые четыре пусты. Спор родственников, смены и администрации о том, «что он на самом деле хочет», уходит из плоскости мнений на этажи: этаж решает.

#### 15.10. Культурные и религиозные рамки стола

Каналы 15.3 работают и когда предпочтение задано не вкусом, а традицией: халяль или кашрут, пост (в том числе многодневный), вегетарианство, отказ от продуктов по убеждению. Для 51 региона с разным конфессиональным составом это обычная часть контингента — и вопрос достоинства в смысле ст. 37 через ст. 43 закона № 3185-1<sup>8</sup>. Нормы Онтарио требуют при поступлении нутритивной оценки культурных, духовных и религиозных



предпочтений и планирования меню с их учётом<sup>23</sup>. Российской рамки такого пункта нет, запрета тоже нет: «индивидуальные потребности» 442-ФЗ покрывают и его<sup>72</sup>. Минимум: два вопроса в пищевой биографии («есть ли пища, которую вы не едите по убеждению или вере?»; «соблюдаете ли посты?») и строка в заказе — «ограничения по убеждению». Если таких жителей больше двух-трёх, в цикле держат пару блюд под основные рамки (постное горячее как регулярная позиция): дешевле индивидуальной готовки, без новой строки сметы. Религиозное ограничение — волеизъявление того же достоинства, что «не люблю рыбу», не медицинская диета и не основание для худшего рациона. Форма — пищевой паспорт (приложение 37).

### 15.11. Постные и религиозные меню-циклы: маркировка «пост — не диета»

Минимум цикла: постное горячее 2–3 раза в неделю в периоды многодневных постов (Великий пост, Рамадан, Рождественский пост), постные гарниры ежедневно (крупы, овощи — они и так в раскладке), маркировка постных позиций в визуальном меню. Три правила. **Первое: пост — волеизъявление, не назначение.** При медицинских показаниях (сахарный диабет, белково-энергетическая недостаточность, анемия) постное меню согласуется с врачом; «постное» не должно стать «неполноценным». Ограничение по убеждению не отменяет нормы питания (приказ Минтруда 520н)<sup>29</sup>: постный суп на воде без белка обед не заменяет. **Второе: отказ от поста — право жителя в любой день.** Рамка 15.10 работает симметрично: давление в пользу поста так же недопустимо, как против него. **Третье: пост не меняет санитарного контура.** Суточные пробы, бракераж, температурный режим — те же (раздел 18). Формы: строка «ограничения по убеждению» в заказе (15.10) и пищевой паспорт (приложение 37).

## 16. Дееспособность, опека и выбор еды: карта решений

### 16.1. Постановка вопроса

Тема семинара — права, свободы и интересы жителей. В питании они упираются в вопрос, который редко ставят прямо: кто вправе решать, что ест недееспособный житель, — и вправе ли вообще кто-то, кроме него? Раздел даёт карту: двенадцать вопросов с ответами «прямая норма / системное толкование / открытый вопрос». Маркировку держим строго. Именно здесь директору опаснее всего опереться на красивую, но неподдержанную формулу.

### 16.2. Нормативная основа

Три федеральных столпа. **ГК РФ:** признание гражданина недееспособным (ст. 29) означает, что сделки от его имени совершает опекун (п. 2 ст. 29); опека оформляет отношения по ст. 31–32. Опекун учитывает мнение подопечного; если его невозможно установить — сведения о предпочтениях. Мелкие бытовые сделки без согласия попечителя допускаются **ограниченно дееспособным** (п. 1 ст. 30; при ограничении дееспособности вследствие психического расстройства — п. 2 ст. 30 со ссылкой на подп. 1 п. 2 ст. 26), а не недееспособным — режимы нельзя смешивать. Повседневное пищевое предпочтение (выбор блюда при раздаче) обычно не гражданско-правовая сделка: элемент ухода и права на достоинство. Недееспособность не снимает обязанности выяснять и учитывать мнение (ст. 29 ГК, 48-ФЗ). **48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»:** обязанности опекуна — забота о содержании и учёт мнения подопечного. **Закон № 3185-1:** ст. 37 — права пациентов психиатрических стационаров (гуманное отношение, достоинство, обращения, представительство); ст. 43 распространяет эти права на проживающих в стационарных организациях социального обслуживания для лиц с психическими расстройствами и требует ежегодного освидетельствования комиссией врачей с участием психиатра — в том числе для решения о переводе в организацию общего типа<sup>8</sup>. Статья 43 задаёт **статус** проживающих, не норму «опекун учитывает мнение»: последняя — из ст. 29 ГК и 48-ФЗ. **442-ФЗ:** права получателя (ст. 9), индивидуальная программа (ИППСУ, ст. 16) и учёт индивидуальных потребностей<sup>72</sup>.

### 16.3. Карта решений: двенадцать вопросов

| № | Вопрос                                                                           | Ответ                                                                  | Уровень                                                           |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1 | Отменяет ли недееспособность бытовые предпочтения?                               | Нет. Недееспособность касается сделок, не вкусов                       | Прямое следствие ст. 29 ГК; ст. 37/43 3185-1 — статус проживающих |
| 2 | Является ли выбор блюда «сделкой», требующей дееспособности?                     | Нет; бытовой акт                                                       | Системное толкование                                              |
| 3 | Обязано ли учреждение учитывать мнение жителя, признанного судом недееспособным? | Да, при решении вопросов, затрагивающих его интересы                   | Норма (ст. 29 ГК; 48-ФЗ); не ст. 43 3185-1                        |
| 4 | Может ли опекун «запретить» жителю конкретное блюдо?                             | Только в рамках медицинских назначений; вкусы — не компетенция опекуна | Системное толкование                                              |



| №  | Вопрос                                                      | Ответ                                                                                                            | Уровень                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 5  | Что делать, если учреждение само — опекун жителя?           | Конфликт интересов фиксируется; решения о питании принимаются по прозрачным правилам, а не «усмотрением опекуна» | Открытый вопрос + управленческая рекомендация               |
| 6  | Нужно ли согласие недееспособного на вариативное меню?      | Не требуется: вариативность не ограничивает прав, а расширяет возможность выбора                                 | Системное толкование                                        |
| 7  | Как быть с отказом недееспособного от еды?                  | Не насилие; наблюдение, альтернатива, эскалация врачу (раздел 12)                                                | Норма (ст. 37) + алгоритм                                   |
| 8  | Может ли семья диктовать меню?                              | Учитывается как источник сведений о воле; не заменяет её                                                         | Толкование (GC1 как ориентир <sup>26</sup> )                |
| 9  | Кто решает об ограничениях рациона (соль, сахар, порции)?   | Только врач, поимённо, с целью и сроком пересмотра                                                               | Системное толкование + международная практика <sup>38</sup> |
| 10 | Куда вписываются пищевые решения юридически?                | В ИППСУ (потребности) и локальные акты (порядок)                                                                 | Норма (442-ФЗ)                                              |
| 11 | Проверяет ли кто-то, учитывается ли мнение жителя?          | Ежегодное освидетельствование по ст. 43; контроль учредителя; прокуратура по жалобам                             | Норма (3185-1)                                              |
| 12 | Что если житель недееспособен, но его состояние улучшилось? | Вопрос о дееспособности решает суд; до решения — поддержанный выбор по максимуму                                 | Норма + практика                                            |

#### 16.4. Конфликт интересов «учреждение = опекун»: честный разбор

Ситуация массовая: значительная часть жителей ПНИ под опекой, и нередко опекун — само учреждение. Структурный конфликт: опекун обязан защищать интересы подопечного и одновременно является организацией, чьи ресурсы и удобство этими интересами ограничиваются. Прямого запрета закон не содержит — и прямого разрешения игнорировать конфликт тоже. Меры, снижающие риск (рекомендация, не норма):

1. Решения о питании — в **прозрачных правилах** (положение о питании, триггеры, правила добавки), одинаковых для всех: усмотрение заменяется процедурой.
2. **Совет жителей и независимый канал обращений** (раздел 34) — внешний глаз на решения «опекуна-учреждения».
3. **Ежегодное освидетельствование по ст. 43** — по назначению: не формальность, а внешняя оценка условий жизни<sup>8</sup>.
4. Спорные случаи — **учредителю письменно**. Молчаливое усмотрение хуже зафиксированного решения.

#### 16.5. Практическая формула для локального акта

Формулировка для положения о питании (проект): «При организации питания учитываются мнение и предпочтения получателей социальных услуг, в том числе признанных недееспособными, выявленные доступным способом (словом, показом, наблюдением за потреблением, пищевой биографией, сведениями близких). Ограничения рациона вводятся только по назначению врача поимённо с указанием цели и срока пересмотра. Лишение пищи или питья как мера воздействия не допускается». Каждая фраза опирается на разделы 16.2–16.4. Ни одна не выходит за пределы действующего права.

#### 16.6. Что сказать повару в понедельник

Выбор еды не требует дееспособности. Опекун учитывает мнение (ст. 29 ГК, 48-ФЗ). Риски — непрозрачные решения «по усмотрению», конфликт интересов опекуна-учреждения, отсутствие документов. Закрываются локальными актами.

#### 16.7. Разбор трёх коллизий из зала

«**Родственник против опекуна-учреждения**». Родственник настаивает на меню, учреждение — на своём, житель молчит. Иерархия 15.9 ставит биографию и наблюдение выше обеих сторон: спор решает не статус спорящих, а данные о жителе. «**Врач запретил, житель требует**». Назначение врача — рамка, выбор внутри рамки — право; конфликт возвращается врачу с конкретикой, не решается сменой (кейс 2). «**Раньше выбирал, теперь нет**». Снижение способности к выбору — клинический сигнал (депрессия, прогрессирование, седация после смены схемы): врачу сообщают. «Перестал — значит, не хочет» — диагностическая ошибка. Каждая коллизия возвращается к источникам воли и к врачу — никогда к авторитету должности.

## 16.8. Учреждение = опекун: три антидота в документах

К конфликту 16.4 (по вторичной аналитике, до 74 % жителей ПНИ недееспособны, опекуном нередко выступает само учреждение<sup>7</sup> — статус данных: вторичная аналитика) три документальных приёма. Первый: приоритет зафиксированных предпочтений над административным удобством — в положение (приложение 29); конфликт становится видимым. Второй: протокол разногласий — причина отклонения предпочтения пишется (санитария, назначение врача, ресурс). Третий: внешний элемент — совет жителей с независимыми представителями, близкими, общественными наблюдателями (раздел 34). Ни один приём конфликт не отменяет; все три делают его проверяемым. Большого локальный уровень не даёт — честная граница раздела.

## 16.9. Карта двенадцати вопросов: как ею пользоваться

Карта (способность выбрать ≠ дееспособность ≠ диагноз) применяется не к «жителю вообще», а к решению сегодня. Двенадцать вопросов сводятся к трём блокам: **информирован** ли человек о варианте (показали ли, в его ли формате, в его ли время); **понимает** ли последствия в доступной мере (переспрос, не допрос); **может ли сообщить** выбор хоть одним каналом (раздел 15). Ответы ставят жителя в одну из четырёх рабочих категорий на сегодня: выбирает сам / выбирает с поддержкой формата / выбор считается наблюдением / выбор недоступен — действует стандартный вариант с пересмотром. Категория не навсегда: пересмотр при смене состояния, терапии, для группы «недоступен» — не реже раза в квартал. Динамичность отличает поддерживаемое принятие решений от опеки<sup>26</sup>: опека фиксирует неспособность, поддержка ищет формат, при котором способность проявляется.

## 16.10. Ограничение дееспособности вследствие психического расстройства: недоиспользованный режим

С 02.03.2015 ГК РФ содержит отдельный режим — ограничение дееспособности гражданина, который «вследствие психического расстройства может понимать значение своих действий или руководить ими лишь при помощи других лиц» (п. 2 ст. 30)<sup>73</sup>. В отличие от полной недееспособности (ст. 29), такой гражданин самостоятельно совершает сделки подпунктов 1 и 4 пункта 2 статьи 26 (мелкие бытовые и распоряжение предоставленными средствами) и остальные — с письменного согласия попечителя (п. 2 ст. 30). Для ПНИ это развилка: значительная часть жителей, признанных недееспособными, по клинической картине подпадает под п. 2 ст. 30, и переход «ст. 29 → п. 2 ст. 30» (по заявлению, через суд и психиатрическую экспертизу — п. 3 ст. 29) расширяет бытовую автономию, включая выбор еды, без ущерба для защиты. Практика узкая: суды осторожны, литература отмечает невостребованность и размытость критериев<sup>73</sup>. Доклад не зовёт к кампании пересмотра — это суд и экспертиза. Вывод: в карте дееспособности жителя (приложение 37) фиксируется не только статус, но и основание (ст. 29 или п. 2 ст. 30): от него зависит объём бытовых решений, которые учреждение обязано уважать и обслуживать.

## 17. Право Российской Федерации: что разрешено, что требуется, что опасно

*Дата актуальности правового раздела: 19–21.08.2026. Раздел действителен на дату семинара 25–27.08.2026. С 01.09.2026 вступает в силу СанПиН 2.3/2.4.4282-26; для переходного периода 01–15.09.2026 проверяющий оценивает август по старым правилам, сентябрь — по новым (подробнее — раздел 18.10 и приложение 39). Обновления правовых норм после 21.08.2026 в этом разделе не отражены; при использовании после указанной даты сверяйтесь с разделом 41 и разделом 44.*

### 17.1. Логика раздела

Три зоны. Зелёная — разрешено или требуется прямо. Жёлтая — нужны документы, согласования или врач. Красная — нарушение независимо от намерений. У каждого элемента — уровень: норма, толкование, рекомендация.

**Навигатор (если времени мало).** 17.2 — зелёная (5 минут). 17.3 — жёлтая (10 минут). 17.4 — красная (5 минут). 17.5 и 17.10 — серая зона лечебного питания (10 минут, читать обе: две стороны одной конструкции). 17.6 — пищевые карты и 152-ФЗ. 17.7 и 17.9 — КПИ. 17.11 — три вопроса к любому акту (5 минут). 17.12 — указатель модераторского блока 26.08. 17.13 — смежные панели, чтобы не отвечать за чужой зал. 17.14 — ПНИ vs ДСО.

### 17.2. Зелёная зона: прямые разрешения и требования

- Питание ≥3 раз в день + диетическое по показаниям** — прямая санитарная норма для организаций соцобслуживания. На дату семинара (25–27.08.2026) действует СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 7.1.11–7.1.14; с 01.09.2026 его сменяет СанПиН 2.3/2.4.4282-26 (пост. Главного государственного санитарного врача РФ от 02.06.2026 № 18), п. 56 подп. 11–14: питание проживающих в стационарных организациях соцобслуживания организуется не менее 3 раз в день, в том числе диетическое (лечебное) по медицинским показаниям<sup>9</sup>. Ни одна редакция не ограничивает число вариантов блюд — только безопасность и периодичность.

2. **Права получателя и учёт индивидуальных потребностей** — ст. 9 442-ФЗ и ИППСУ (ст. 16)<sup>72</sup>. Пищевые предпочтения и доступный выбор можно включать в ИППСУ; прямого субъективного права на ежедневный выбор блюда из нескольких вариантов закон не устанавливает.
3. **Права проживающих:** гуманное отношение и достоинство — ст. 5 ч. 2 Закона № 3185-1; ст. 37 — перечень прав пациентов психиатрического стационара; ст. 43 распространяет ст. 37 на проживающих в стационарных СОСО<sup>8</sup>.
4. **Рекомендуемые нормы питания Минтруда (приказ № 520н)** и региональные нормы на их основе — базовая рамка рационов<sup>29,11,12</sup>. Слово ключевое: рекомендуемые; регион их конкретизирует.
5. **Таблицы замены продуктов** в раскладках — действующий механизм эквивалентной замены, легальная основа вариативности<sup>11,12</sup>.
6. **Выбор блюд жителями** не запрещён ни одной федеральной нормой; в 2024–2025 гг. реализован публично минимум в четырёх учреждениях трёх регионов<sup>2,3,4,5,6</sup>.
7. **Плата за стационарное соцобслуживание** ограничена 75 % среднедушевого дохода (ст. 32 ч. 4 442-ФЗ)<sup>72,74</sup> — рамка финансовых моделей раздела 29.

### 17.3. Жёлтая зона: делать можно — через процедуру

| Действие                                         | Процедура                                                | Основание                                         |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Ограничение рациона жителя (сахар, соль, порции) | Назначение врача поимённо, цель, срок пересмотра         | Толкование + международная практика <sup>38</sup> |
| Текстурные модификации (протёртое, загущенное)   | Назначение врача, маркировка порций                      | Клиническая необходимость (раздел 10)             |
| Изменение цикла меню                             | Увязка с региональной раскладкой и таблицами замен       | 11,12                                             |
| Пищевые карты жителей (персональные данные)      | Основание обработки, ограничение доступа                 | 152-ФЗ (раздел 17.6)                              |
| Отложенные приёмы, ночная доступность            | Пункт в положении о питании + санитарный контур хранения | 9                                                 |
| Совет жителей с полномочиями по меню             | Локальный акт о совете                                   | Практика + международные нормы <sup>23</sup>      |
| Вариативное меню                                 | Пакет документов (раздел 31) + уведомление учредителя    | Рекомендация на практике <sup>2,3</sup>           |

### 17.4. Красная зона: нарушения независимо от намерений

1. **Лишение еды или питья как мера воздействия** — прямое нарушение ст. 5 ч. 2 3185-1 (гуманное отношение); ст. 43 распространяет права ст. 37 на проживающих<sup>8</sup>.
2. **Насилие при кормлении** (принудительное бытовое кормление) недопустимо; искусственное питание — только клиническая процедура по медицинским правилам (раздел 12.4).
3. **Имитация санитарного контроля** (суточные пробы «задним числом») — типовой состав дел по ст. 6.6 КоАП<sup>10</sup>.
4. **Недоброкачественные продукты на столе** — ст. 6.6 КоАП для должностного лица<sup>10</sup>.
5. **Картельные и согласованные закупки** — антимонопольная ответственность вплоть до уголовной (ст. 178 УК; практика ФАС)<sup>75,76</sup>.
6. **Отказ в питании «за опоздание»** как системная практика — нарушение доступности питания (п. 7.1.11 СанПиН 3590-20; с 01.09.2026 — п. 56 подп. 11 СанПиН 4282-26)<sup>9</sup>.

### 17.5. «Серая зона» лечебного питания: честная маркировка

Приказы Минздрава о лечебном питании (395н, 1008н, 330н и картотека диет) адресованы **медицинским организациям**; на организации соцобслуживания автоматически не распространяются. Обходная легализация на практике: региональные распоряжения применяют эти приказы к стационарным СОСО (пример — распоряжение Минсоцразвития Московской области 19РВ-32, на которое опирается ДДСОЛ с советом по питанию)<sup>22</sup>. Если «мостик» в регионе есть — лечебное питание оформляется по медицинской картотеке; если нет — диетические назначения через врача и положение о питании, без прямых ссылок на неадресные приказы. *Уровень: системное толкование + практика; до проверки в конкретном регионе не использовать как готовое решение.*

### 17.6. Пищевые карты и 152-ФЗ

Пищевая карта/биография содержит персональные данные (сведения о здоровье — специальная категория). К той же категории — журнал стула (раздел 13.10) и список «время еды фиксировано» для инсулина (раздел 13.12). Правовой минимум: основание обработки (исполнение договора соцобслуживания/ИППСУ), круг доступа (пост и врач; кухня видит функциональные ограничения, не диагноз), исключение избыточных данных, сроки хранения. *Уровень: рекомендация по применению 152-ФЗ; форма карты в приложении 3 требует локальной правовой проверки.*

## 17.7. КПИ: статус и практическое значение

Россия подписала Конвенцию о правах инвалидов в 2008 году и ратифицировала в 2012-м; конвенция действует как международный договор РФ. Статья 28 (достойный уровень жизни, включая достаточное питание) и Замечание общего порядка № 1 к ст. 12 (поддержанное принятие решений) — стандарт, который российские суды и органы берут как ориентир толкования<sup>77, 26</sup>. *Уровень: международный договор + толковательная практика; в локальных актах ссылаться можно — как на обоснование, не как на обязанность формата «КПИ требует два варианта каши».*

## 17.8. Что сказать повару в понедельник

Положение о питании и журналы. Главный правовой риск — не внедрение выбора, а отсутствие документов при уже существующей практике (раздел 31). Красная зона — безопасность и насилие, не число блюд.

## 17.9. КПИ и правовая культура: дальний горизонт

КПИ с акцентом на поддерживаемое принятие решений<sup>26</sup> — не источник обязанностей кухни, а вектор: от «за него решат» к «ему помогут решить». Нормы о выборе, предпочтениях и участии будут ужесточаться — австралийский Стандарт 6<sup>34</sup> и онтарийские требования<sup>23</sup> это показывают. Дом с процедурами выбора встретит завтрашние требования готовым. Дом, ждущий обязательности, будет догонять под сроками — дороже и фиктивнее.

## 17.10. Серая зона лечебного питания: рабочая конструкция до «моста»

Пока регионального «моста» нет, нельзя ни игнорировать лечебное питание («мы не больница»), ни имитировать больницу («заводим диеты как в стационаре»). Три элемента: назначения по питанию — от лечащего врача (психиатра, терапевта) письменно, любой формат письменности лучше устного; кухня исполняет через текстуры и исключения, не через «номерные диеты» больничной инфраструктуры; учредителю ежегодно уходит предложение о региональном акте по образцу существующих<sup>12</sup>. Конструкция называется и документируется как временная — с датой запроса учредителю. Серая зона перестаёт быть безответственностью и становится пробелом региона с назначенным владельцем.

## 17.11. Как читать норму: три вопроса к любому акту

Директору не нужно становиться юристом. Три вопроса к акту, который «грозит» или «разрешает». **Первый: кому адресован?** Приказы Минздрава о лечебном питании — медицинским организациям; на СОСО автоматически не ложатся, стык — через региональный «мост» (раздел 24)<sup>12</sup>. **Второй: каков статус требования?** Рекомендованные нормы Минтруда (приказ 520н<sup>29</sup>) — ориентир, пока регион не сделал их императивными; СанПиН<sup>9</sup> обязательны всегда. **Третий: что доказывает бумага?** Право без процедуры («уважать достоинство») исполняется журналом, картой, протоколом. Две ошибки зала: «нам всё запрещено» (часто по акту не к вам) и «нам всё можно» (по акту рекомендательному, который у вас давно императивен). Зелёная, жёлтая и красная зоны — ответы на три вопроса, приложенные к вариативному питанию.

## 17.12. Указатель модератору: дискуссия 26.08

Шесть вопросов дискуссии 26.08 («Организация питания: опыт реализации проектов», 14:00–15:30, площадка № 2 — ДСО «Тесовый берег»; модераторы: Е. В. Чистяков, дир. ДСО «Серафимовский»; Т. А. Нурбаев, дир. ДСО «Тесовый берег»):

1. Кто выбирает форму питания — проживающий социального дома или его руководитель?
2. Как формировать меню в условиях жёстких нормативно-правовых и финансовых ограничений?
3. Должно ли быть питание в социальных домах «лечебным»?
4. Как совместить понятия «лечебное питание» и «вариативное меню», не ограничивая право проживающего на выбор?
5. Как соблюсти баланс между выбором недееспособного проживающего «что ему есть» и имеющимися у него медицинскими рекомендациями?
6. Как совместить качество продуктов питания и нормирование цен на них при планировании бюджета в условиях рыночной экономики?

Дословные ответы по схеме «правовая рамка / практика / алгоритм / что нельзя делать» для каждого из шести вопросов, сводная матрица и пакет документов на выступление — в отдельном спикерском файле модератора (не входит в раздатку). Действительно по состоянию на 19–21.08.2026 с учётом правок 14–16 к программе семинара.

## 17.13. Смежные площадки семинара: что пересекается с организацией питания

Питание — не отдельный «кухонный» трек. Вопросы других сессий, не закрытые здесь, вернутся 26.08: «а вчера нам говорили другое». Ниже — только пересечения, где есть норма или раздел этого доклада. Формулировки — по обновлённой программе; правки № 15–16 вошли в текст. Лекция Федермессер — 25.08, 16.15–17.45; мозговой штурм «Как наладить жизнь в доме?» — 26.08, 16.00–17.45, сразу после сессии о питании.



**17.13.1. 25.08, 12.00–13.30. «ПРАВО БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»**

Пересечения: вопрос 1 (выбор vs гарантированная безопасность, в т. ч. отказ от жизненно важных процедур) и вопрос 3 (проживающий регулярно выбирает то, что ухудшает состояние, **включая еду**).

**Ответ на вопросе питания, без отмены автономии.** Отказ от блюда ≠ отказ от еды: эквивалент внутри нормы и, при назначении, внутри диеты (разделы 12, 17.12 вопросы 1 и 5). Отказ от воды или еды более 24 часов — клинический контур комиссии, не «он сам выбрал, мы ни при чём» (вопрос 10 той же сессии — перекладывание ответственности). «Уважение» ≠ «дать вредное без фиксации»: диабетический стол без назначения — ограничение без основания; снятие диеты по просьбе при действующем назначении документируется, не прячется (17.12 вопросы 3–5). Безопасность — СанПиН, назначения, журналы, не отмена выбора.

**17.13.2. 25.08, 14.30–16.00. «ПРАВО НА ВЫБОР: ЕСТЬ ИЛИ НЕТ?»**

Чистяков Е. В. — **эксперт этой панели** (модератор Георгиев К. А.). Вопросы — внедрение, страх коллектива, «проигравшие». Для питания это **перевод** 17.12 на язык управления, не второй доклад:

- «Есть ли выбор, если решение принято?» — директор вводит пару на линии; житель выбирает внутри рамки («шеф решает, что готовить; житель решает, что взять»).
- Риск, который называют первым (проверка, СанПиН, «не по меню»), не подтверждён делами о вариативности. Публичные дела КоАП 6.6 — качество и достаточность, не второе блюдо (разделы 17, 18).
- Кто мог «проиграть»: смена на раздаче (труд), поставщик (если ТЗ ужесточили), привычка кухни к одной раскладке. Кто выиграл: житель с журналом выбора. Это ответ на вопрос 6 панели.

**17.13.3. 25.08, 12.00–13.30. «ПРАВО БЫТЬ НЕДЕЕСПОСОБНЫМ»**

Вопросы 1–4: интересы подопечного, кто их выявляет, алгоритмы. На столе — вопрос 5 дискуссии 26.08. Повседневное предпочтение обычно не сделка и не медицинское вмешательство (ст. 29 ГК, ст. 11 3185-1 применяется к диете, не к «котлета или рыба»). Иерархия источников воли — раздел 16.4. Опекун содействует, не подменяет. Назначение диеты — извещение опеки не позднее следующего дня (ч. 3 ст. 11 3185-1).

**17.13.4. 26.08, 16.00–17.45. «КАК НАЛАДИТЬ ЖИЗНЬ В ДОМЕ?» (МОЗГОВОЙ ШТУРМ)**

После сессии о питании: перерыв 15.30–16.00, тот же дом. Ночной интервал и индивидуальный режим — передача, не новая тема.

Цель: режим дня из индивидуальных потребностей, не из удобства смены. Для кухни — ночной интервал и часы приёмов (раздел 7, слайд дека о ночном голоде). Вариативное меню без сдвига ужина «всем удобно в 17:30» оставляет 14–15 часов без еды. Выбор блюда голод не лечит. Связка: индивидуальный режим + пара на линии + второй ужин по СанПиН, если интервал не проходит.

**17.13.5. 25.08, 14.30–16.00. «ЧЕЛОВЕК ИЛИ ФУНКЦИЯ»**

Делать за человека vs помогать сделать самому. Кто кладёт «как всегда», превращает жителя в функцию ration. Кто держит два варианта и ждёт жеста — сопровождение. Еда как навык сопровождаемого проживания — раздел 8.8.

**17.13.6. 26.08, 11.30–13.00. «ПРАВО НА ЧАСТНУЮ ЖИЗНЬ»**

Вопрос 2: может ли быть частная жизнь у недееспособных. Ежедневный выбор «что есть» — одна из немногих регулярных зон автономии. Журнал выбора и пищевая биография фиксируют частное предпочтение. «Нарушение есть во всех домах» (вопрос 7 программы) на кухне: общая раскладка без учёта отказа, еда в палате без согласия, камера на раздаче без рамки 152-ФЗ (раздел 42.3).

**17.13.7. 25.08, 16.15–17.45. ИНТЕРАКТИВНАЯ ЛЕКЦИЯ А. К. ФЕДЕРМЕССЕР «ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ — КАК ОБЕСПЕЧИТЬ СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВА НА ДОСТОИНСТВО»**

Тот же день, что «Право на выбор» (14.30–16.00, Чистяков — эксперт): после пятнадцатиминутного перерыва — достоинство и «не причинять добро». На следующий день это должно лежать на тарелке. *(В промежуточной свёрке слот ошибочно оставили на 26.08 16.15–17.45: в обновлённой программе на это время — мозговой шторм 17.13.4.)*

Акцент программы: уважать выбор, «не причинять добро». Навязанный «полезный» стол без назначения — причинение добра. Comfort feeding / паллиатив — раздел 12.11; Wunschkost — раздел 12.6.

Параллельно нашей сессии 26.08, 14.00–15.30 — «Право на достойный уход» (Олескина): предсмертный период. Если модератора питания там не будет, ответ всё равно в 17.12 вопрос 5, сценарий В, и в 12.11.

**17.13.8. ЧЕГО НЕ ПЕРЕНОСИТЬ В ДОКЛАД О ПИТАНИИ**

Трудоустройство недееспособных, контент от жителей, учебное проживание, киносессии — косвенные пересечения. Не раздуваем. «Еда как занятость» — раздел 8.8, коротко.

**Источники к 17.13:** обновлённая программа семинара 25–27.08.2026; правки к программе (позиции 14–16, вошли в текст); разделы 7, 8, 12, 12.11, 16, 17.12, 18, 42 настоящего доклада; Конституция ст. 21, 41; 3185-1 ст. 11; ГК ст. 29.



## 17.14. ПНИ и ДСО: различия в правовом статусе, которые важны для темы питания

В зале 26.08 будут оба типа учреждений; правовые режимы по теме питания **не совпадают**. Различие в регуляторике — первое, что проверяют на старте пилота. Таблица — рабочая памятка директора перед запуском вариативности.

| Параметр                                                            | ПНИ (психоневрологический интернат)                                                                            | ДСО (дом социального обслуживания), в т. ч. для пожилых и инвалидов                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип жителей (как правило)                                           | Лица с психическими расстройствами, преимущественно трудоспособного возраста, длительное пребывание            | Лица пожилого возраста и инвалиды (старше 18 лет), в т. ч. с психическими расстройствами, часто — паллиативный профиль                                                                              |
| Применимость ст. 37/43 3185-1                                       | Прямая (ст. 43 распространяет права пациентов психиатрических стационаров на ПНИ безусловно)                   | Косвенная через общее распространение ст. 37 на лиц с психическими расстройствами в стационарных учреждениях соцобслуживания; для жителей без психиатрического диагноза — только общие нормы 442-ФЗ |
| Региональный норматив (пример СПб)                                  | Постановление 1284 (отдельно нормы для ПНИ и для ДСО) — нормы по ПНИ обычно калорийнее и больше белка          | Постановление 1284 (отдельно нормы для ДСО) — калорийность может быть ниже, акцент на лёгкую усвояемость и текстуры                                                                                 |
| Диетические столы                                                   | Чаще: ОВД, ЩД, ВБД, реже НБД; значительная доля жителей с назначенной диетой                                   | Чаще: ОВД, щадящие, протёртые; выше доля дисфагии и потребности в IDDSI-текстурах                                                                                                                   |
| Вариативность: публично подтверждённая ступень                      | М1–М2 (Болотнинский, Успенский, Иркутск). М3 — при площади и санитарном контуре, не «типовая»                  | Старт чаще М1; М2–М3 упираются в текстуры                                                                                                                                                           |
| Учёт невербального выбора                                           | Нужен там, где выбор не выражен словом. Не путать с ~¼ недееспособных (раздел 16): недееспособность ≠ молчание | Нужен при дисфагии, деменции, отсутствии речи                                                                                                                                                       |
| Совет жителей (раздел 34)                                           | Работает, но суррогатно: недееспособные через опекунов; совещательный статус                                   | Работает лучше, особенно в учреждениях для пожилых без тяжёлой психиатрии                                                                                                                           |
| Региональные акты-«мостики» к приказам Минздрава о лечебном питании | Встречаются реже; чаще работает «конструкция до моста» (раздел 17.10)                                          | Встречаются чаще; пример ДДСОЛ — распоряжение Минсоцразвития МО 19РВ-32 (раздел 17.5)                                                                                                               |
| Типовая проверочная претензия по 6.6 КоАП                           | Качество/достаточность питания; соблюдение санитарного контура                                                 | Качество/достаточность + <b>текстуры</b> (особенно для жителей с дисфагией)                                                                                                                         |
| Цена тарифа (ориентир, 2025)                                        | Алтай 422 руб./день — ПНИ и ДСО единый тариф; СПб — 1366-р, разбивка по типам                                  | Те же 422 руб./день; СПб — отдельные позиции в 1366-р                                                                                                                                               |

**Что из этого следует для вариативности.** Стартовый пилот (раздел 35) устроен одинаково, но точка пилота в ДСО чаще требует проработки текстур (раздел 10), в ПНИ — невербального выбора (раздел 15). Документальный пакет (раздел 31) один; в ДСО чаще согласование текстур с учредителем, в ПНИ — процедура опеки (раздел 16). Четыре публичных кейса Новосибирской и Иркутской областей (раздел 25) — ПНИ; ДСО «Серафимовский» (СПб) и ДДСОЛ (МО) — ДСО. Опыт есть в обоих типах.

## 18. Санитария и пищевая безопасность при вариативности

### 18.1. Главный тезис: СанПиН — про безопасность, а не про однообразие

Санитарные правила для организаций социального обслуживания на дату семинара — СанПиН 2.3/2.4.3590-20: не менее трёх приёмов пищи в день, диетическое питание по показаниям, контроль на всех этапах — приёмка сырья, суточные пробы готовой продукции, бракераж, температурный режим, питьевой режим<sup>9</sup>. С 01.09.2026 3590-20 утрачивает силу; действует СанПиН 2.3/2.4.4282-26 (пост. № 18 от 02.06.2026). Каркас тот же: питание не менее 3 раз в день, в том числе диетическое (лечебное) по медицинским показаниям; суточные пробы — от каждой партии блюда (п. 56 подп. 11–14)<sup>9</sup>. Ни одна редакция не ограничивает число вариантов блюда. Вариативность входит в санитарный контур целиком: в этом сила (каждый вариант защищён как мономеню) и уязвимость (каждый вариант должен контур пройти). После 1 сентября локальные акты и чек-листы пищеблока перепривязывают к пунктам 4282-26, модель выбора не меняя.

### 18.2. Санитарный контур при двух вариантах

Что меняется при переходе от одного варианта к двум:

**Пробы.** Суточная проба — с каждого блюда, то есть с обоих вариантов. Трудозатраты: вторая пробная тарелка и вторая строка журнала. Ошибка: проба «с основного» при раздаче двух — для проверяющего это отсутствие пробы второго блюда.

**Температура.** На линии и на последнем столе; при двух гастрೋмкостях — на обеих. Меньший объём остывает быстрее: меньшие гастрೋмкости и пополнение, не «вариант Б комнатной температуры».

**Маркировка.** Чтобы раздающий не перепутал: цветные маркеры, наклейки, порядок на линии. При текстурных модификациях маркировка — клинический элемент (раздел 10): перепутанная протёртая и обычная порция — риск аспирации.

**Раздача и поток.** Два варианта удлинняют выдачу на 5–10 секунд на человека; для маломобильных порядок подачи прописывается отдельно (выбор заранее по журналу заказа — раздел 21).

**Хранение остатков.** Правила хранения и запрет повторного использования — на оба варианта одинаково<sup>9</sup>; журнал замен фиксирует, что ушло в переработку по правилам, а что — в списание.

### 18.3. Типовые нарушения и цена

Надзор по социальным учреждениям бьёт в один набор: отсутствие или имитация суточных проб, недоброкачественные продукты, нарушение температурных режимов, отсутствие бракеража<sup>10</sup>. Ответственность по ст. 6.6 КоАП для должностного лица — штраф (в разобранных делах — 5 тыс. руб.<sup>10</sup>; сумма мала, само дело — проверка, представление прокуратуры, репутационный след. Кейс Кашина (СПЦ, 2022): просроченные продукты и отсутствие проб — директор привлечён по 6.6<sup>10</sup>. *Маркировка: дела касаются учреждений соцобслуживания иных типов; для ПНИ это ограниченная аналогия с прямой переносимостью состава нарушений.*

### 18.4. Буфет, передачи и «серая еда»

Три канала вне общего меню — и все три требуют правил.

**Буфет/перекусы.** Круглосуточная доступность перекусов — международная норма<sup>34, 30</sup>. В российском контуре: ассортиментный перечень буфета утверждён (без энергетиков, с учётом раздела 11), продукты проходят тот же контур приёмки, сроки годности контролируются.

**Передачи от семьи.** Радость и риски: скоропорт, тираминовые продукты для жителей на ИМАО, крепкий кофе для клозапиновой группы, грейпфруты. Не запрет, а регламент: перечень приветствуемых и недопустимых (приложение 32), осмотр дежурным, информирование семей при поступлении и ежегодно.

**«Своя» еда жителей.** Запасы в тумбочках («хомячение», раздел 9) — сроки годности и гигиена. Решение: легальные зоны хранения перекусов и регулярная замена, не конфискации.

### 18.5. Ответственный за санитарный контур

При любой вариативности ответственный один: руководитель учреждения, делегирующий контроль приказом (завхоз/шеф/диетсестра — по штату). Делегирование исполнения не снимает ответственности за работающий контроль: «распределил функции» и «контролирует фактически» — центральное различие раздела 33. Минимум: еженедельный обход пищеблока руководителем или заместителем по чек-листу (приложение 19) с записью. Десять минут превращают «формально распределено» в «фактически контролируется».

### 18.6. Что сказать повару в понедельник

Второй вариант проходит тот же контур: пробы, температуры, маркировка, журналы. Если контур имитируется, вариативность удвоит имитацию. Сначала контур (модель М0), потом выбор.

### 18.7. Суточная проба при вариативности: частые ошибки

К пробам 18.2 три ошибки вариативной линии: «средняя по обеду» (не доказывает ни один вариант); только вариант А (Б беззащитен при инциденте); без маркировки варианта (через сутки не доказать, что в банке). Правило: каждый вариант каждой позиции — своя промаркированная проба в тех же журналах. Трудозатрата — минуты; доказательная цена — вся линия.

### 18.8. Буфет и передачи: два хронических очага

Буфет и комната передач — ежедневный стык санитарии и прав. Буфет: допустимые категории (напитки, хлеб, упакованное, фрукты с мытьём), режим пополнения, ответственный — письменно; «под присмотром» без регламента закрывается первой проверкой. Передачи: перечень запрещённого (скоропорт, открытые домашние заготовки, алкоголь и энергетики — также по лекарственной таблице<sup>45</sup>), регистрация, хранение с маркировкой. Нет регламента — две крайности: полный запрет (нарушение прав, подполье) и бесконтролье (отравления и взаимодействия). Регламент пишут как форму разрешения, не как форму запрета.

### 18.9. Вторая гастрೋмкость: санитарный паспорт новой позиции

Второй вариант на линии проверяется пятью пунктами, которые санврач спросит первыми. Отвечать — до старта, одной страницей. **Поточность:** новая позиция в том же потоке (раздача → столы → мойка), пересечений «сырого» и «готового» не создаёт. **Температура:** горячие — в мармите или на раздаче с контролем; вторая гастрೋмкость либо

имеет свой мармит, либо выдаётся первой по времени — решение фиксируется. **Маркировка:** бирка на каждой вариативной ёмкости (наименование, «вариант А/Б»); безымянные кастрюли — классическое замечание. **Суточная проба:** от каждого варианта, не «от обеда вообще» — иначе проба не доказывает безопасность Б. **Журналы:** температура и пробы в тех же санитарных журналах, без отдельной «вариативной» бухгалтерии. Страница-паспорт подписывается завпроизводством и идёт к приказу о пилоте. Первый вопрос проверяющего «как вы это организовали» отвечает документ, не экскурсия.

## 18.10. Переходный месяц: сентябрь 2026

Семинар — последняя неделя старых правил; первый месяц новых — самый нервный. Постановление № 18 не даёт поэтапного перехода или отсрочки: с 01.09.2026 все требования СанПиН 2.3/2.4.4.282-26 применяются в полном объёме<sup>9</sup>.

**Документы задним числом не переписываются:** журналы до 31.08 по формам 3590-20 законны такими, какими заполнены; с 01.09 ведутся по новым формам (приложения 4 и 5 — бракераж<sup>9</sup>). Сентябрьская проверка смотрит сентябрь по новым правилам и август по старым; «переоформить» августовские журналы под новые формы хуже, чем их возраст. **Программа производственного контроля актуализируется к 01.09** (инструкции, графики, формы журналов) — готовность, не «потом»<sup>9</sup>. Если внедрена ХАССП, её документы перепривязываются вместе с ППК; доклад не утверждает, что ХАССП обязателен для каждой СОСО сверх производственного контроля. Чек-лист перепривязки — приложение 39. Модель питания (выбор, пары, замены) не меняется: обе редакции её не ограничивают. Переходный месяц — крайний срок, не передышка. Что не перепривязано к 1 сентября, с 2 сентября — уязвимость.

## 18.11. Питание при карантине и ОРИ: выбор не отменяется

Вспышка ОРИ или карантин отделения — типовой кризис ПНИ; питание ломается первым: столовая закрыта, персонал перераспределён, доставки ограничены. Рамка есть: при COVID-19 Минтруд выпускал методические рекомендации по работе стационарных СОСО (совместно с санитарной логикой Роспотребнадзора) — усиленный питьевой режим, отдельная посуда, дезинфекционный контур при раздаче в жилые комнаты<sup>78</sup>; базовые рекомендации Минтруда по питанию требуют лечебно-профилактических продуктов, профилактики витаминной недостаточности и санитарно-эпидемиологической безопасности<sup>79</sup>. Принципы доклада в карантин переносятся: **выбор не отменяется — меняется форма.** В комнате — два варианта на подносе, не вторая линия в коридоре: житель видит обе порции (или картинки на двери), стандартный вариант всегда есть, журнал замен ведётся усиленно — снимает риск «в спешке забыли». Температура горячего — на последней выдаче в палате: путь «мармит → коридор → комната» ломает п. 50, если его не мерить<sup>9</sup>. Питьевой режим при ОРИ усиливается (тёплое питьё по графику — прил. 40), витаминизация — по назначению врача. «План Б» (приложение 45: холодный буфет, запас посуды, график по отделениям, кто кормит, если не вышла кухня или не приехал аутсорсер) окупается в первый день закрытия столовой. Нагрузка на раздачу растёт кратно — это видно в графике до вспышки, не в 8 утра. Тот же поднос — повседневный маршрут постельных и маломобильных: если выбор живёт только в столовой, одиннадцать процентов жителей в него не входят (раздел 20.11).

## 19. Два варианта блюда: технология без второй кухни

### БЛОК 1.5. МЕНЮ, РАЗДАЧА, ЗАМЕР: ПАРЫ ЭКВИВАЛЕНТОВ, РАЗДАЧА, ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ, АУДИТ (19–22)

#### 19.1. Идея в одном абзаце

Модели М1–М2 (раздел 8) не просят вторую кухню. Они просят второй вариант **ключевого блюда** в том же потоке: каши А и Б — в двух котлах сразу, вторые А и Б — из одной мясной заготовки двумя способами. Так уже варят в России: Болотнинский ПНИ — завтрак и обед несколько раз в неделю<sup>2</sup>; Успенский ПНИ — два вторых, два салата, два напитка каждый день<sup>3</sup>; Иркутская модель — два первых, два вторых, гарниры<sup>6</sup>.

#### 19.2. Пары эквивалентов

Вариант Б не берут «с полки». Три фильтра: та же норма белка и круп по таблице замен<sup>11, 12</sup>; тот же поток — печь, котёл, доска; спрос, уже видный по прошлым неделям. Рабочие пары:

- **Крупы:** гречка / рис / пшено / овсянка — взаимозаменяемы по таблицам.
- **Вторые:** котлета / тефтели; тушёное мясо / печёночный соус; рыба запечённая / рыбные биточки — одна заготовка, две формы.
- **Салаты:** свекольный / морковный; капустный / винегрет.
- **Напитки:** чай / какао / кофейный напиток, как в Болотнино<sup>2</sup>. Какао и кофейные напитки входят в кофеиновую строку пищевой карты — правило клозапина, раздел 11.
- **Первые:** борщ / щи; суп крупяной / суп овощной — если готовы держать два котла.

Чего в паре быть не должно: «настоящее / что осталось». Это ломает равноценность (раздел 8.3) и за неделю убивает доверие к выбору.

### 19.3. Точки выбора: с чего начинать

Практика начинается с завтрака и обеда<sup>2</sup> — и это верно по кухне: у каш и вторых есть естественные пары, варятся в одном потоке. Завтрак спокойнее: меньше позиций, персонал учится без давки. Сначала одна позиция — каша или второе. Потом вторая. Потом салаты и напитки. Конечная картина первого года у Успенского: два вторых, два салата, два напитка ежедневно<sup>3</sup>.

### 19.4. Объёмы: журнал заказа

Самый частый сбой — «вариант Б закончился». Механика живёт в тетради.

1. **Заказ накануне.** Вчерашний выбор (журнал, приложение 7) задаёт сегодняшнюю варку.
2. **Стартовая пропорция.** Пока статистики нет — 50/50 с резервом. Через 2–3 месяца предпочтения стабилизируются<sup>3,4</sup>.
3. **Пересчёт раз в две недели.** Доля выбравших Б правит закупку. Остатки вариантов пишут отдельно.
4. **Индикатор сбоя.** Доля тех, кто выбрал Б и не получил Б, стремится к нулю. Если растёт — виноваты объёмы, не «непредсказуемые жители».

Для тех, кто выбирает невербально (раздел 15), заказ собирают по пищевым картам и вчерашнему показу. Та же тетрадь, другой источник.

### 19.5. Кто это делает: роли

Подтверждённая схема: **диетсестра формирует перечень для выбора**<sup>2</sup>. Вариативность сидит внутри норм, не сбоку. Диетсестра — или завхоз, где её нет — пары и раскладка. Повар — два варианта в одном потоке. Раздающие и сиделки — предложение и журнал. Старшая смена — контроль «вариант Б существует» (чек-лист, приложение 24). Руководитель — положение о питании и ежемесячная статистика.

### 19.6. Сколько это стоит: честная рамка

Вариативность не «бесплатна». Честная структура (раздел 29): сырьё при парных эквивалентах не растёт — идёт перераспределение внутри строки. Растут секунды на линии (5–10 на человека) и канцелярия: две тетради. Единоновременно могут понадобиться вторые гастрорёмкости и маркировка. Иллюстрация: отделение на 30 человек, второй вариант каши — +3–4 кг крупы в сутки при том же суммарном расходе. Перераспределение, не добавка. *Расчёт иллюстративный: замер обязателен до выводов (приложение 25).* Два варианта — вторая гастрорёмкость и тетрадь, не вторая кухня. Поэтому подтверждённые кейсы стартовали в обычных домах без специальных бюджетов<sup>2,3,4</sup>. Возражение «нет денег» — раздел 37.

### 19.8. Журнал замен: недооценённый документ

Этот журнал держат «вторым» — зря. Он один доказывает: отказ обернулся альтернативой, а не голодом. Американская норма об обязательной альтернативе при отказе<sup>35</sup> по сути описывает эту тетрадь. Писать в день события: вечерние «по памяти» превращают журнал в художественный текст. Фиксируют не только «чем заменили», но и «принял ли». Серия замен одного блюда у разных жителей — сигнал кухне о блюде, не о жителях. Раз в месяц журнал замен читают вместе с журналом срывов: где система отказывает жителю — срывы; где житель — системе — замены. Это разные ремонты.

### 19.9. Что не является парой

Три антипримера. «Второй вариант — без всего»: отказ от компонента не есть выбор блюда. «Второй есть, но его надо просить за неделю у заведующей»: выбор с барьером — декорация. «Второй — то же самое, но холодное или вчерашнее»: санитарно и этически недопустимо. Все три встречаются чаще честного «у нас один вариант». Все три ловит проверка реальности выбора (приложение 24), вопрос № 3.

### 19.10. Пары эквивалентов: строительный набор на месяц

Эквивалентность — по основному нутриенту позиции, не по полному составу. Набор на месяц закрывают пары 19.2 плюс белковая линейка котлета мясная / рыбная / курица / биточек (фарш против куска — уже сервис для тех, кому трудно жевать) и напитки компот / морс / чай. Два правила сверх списка. Пара различима: гречка с котлетой и гречка с подливой — одно блюдо с двумя именами. Оба элемента одинаково «ранговые»: рыба и «остатки вчерашнего» — сортировка жителей по сортам. Ранговость жители считают сразу. Подтверждённая практика — две позиции второго, два салата, два напитка<sup>6</sup> — укладывается в этот набор без экзотики.

## 20. Точка раздачи: дизайн линии, очередь и помощь

### 20.1. Почему линия важнее меню

Вариативность живёт или умирает в трёх метрах линии. Здесь сходятся очередь, выбор, помощь кормимым, температура и «почему ему больше». Меню может быть идеальным. Если линия заточена под скорость, выбор станет давлением, а помощь — ожиданием холодной тарелки. Четыре элемента: поток, подача помощи, видимость порций, атмосфера.

### 20.2. Поток: как не создать пробку

Два варианта добавляют 5–10 секунд на человека. На отделении в 30 человек это 3–5 минут. Что работает.

**Предварительный заказ.** Выбор фиксируют накануне (журнал заказа). На линии — выдача по списку, решение ещё можно сменить. Время почти не растёт. Российские внедрения идут так<sup>2,3</sup>.

**Визуальное меню.** Фотографии или образцы двух вариантов до линии снимают паузу «что там?» и помогают невербальному выбору (раздел 15).

**Разнесение потоков.** Самостоятельные — на линию. Маломобильные получают выбор в жилой зоне по журналу. Кормимые — за столами, еда приходит к ним. Три потока в одной очереди — конструктивная ошибка большинства столовых.

**Две точки выдачи.** Хлеб и единое первое — отдельно от позиций с выбором. Выбор не тормозит всех.

### 20.3. подача помощи: еда — под готовые руки

Международный ориентир, не российское требование: один работник — не больше двух полностью кормимых; еду не ставят, пока помощь недоступна<sup>23</sup>. Тарелка перед человеком, который не может есть сам, остывает и унижает. Спешка — риск аспирации (раздел 10).

У нас нормы помощи не закреплены. На смене часто далеко от 1:2 — кейс раздела 5: четыре сиделки на двенадцать кормимых. Без новых штатов:

1. **Все руки на час еды.** На основные приёмы к столу выходит вся смена. Это приказ, не добрая воля.
2. **Рассадка по помощи.** Кормимые — по двое у каждого помощника. Подают по готовности рук, не по очереди тарелок.
3. **Волонтёры и соцработники дневных отделений** в часы еды — где возможно.
4. **Честный расчёт дефицита.** Если 1:2 недостижимо, число фиксируют и выносят учредителю письменно (раздел 38). Молчаливый дефицит — риск директора. Зафиксированный — предмет решения учредителя.

### 20.4. Видимость порций: «почему ему больше»

Выбор делает раздачу прозрачной — и впервые видимое неравенство порций становится конфликтом. Типовой сбой внедрения. Три ответа: **порционные ложки** — мерка на виду; **нормы граммов** у линии («котлета — 75 г, гарнир — 200 г»); **объявленные правила добавки** («после раздачи всем — добавка из остатка»). Конфликт рождает не выбор, а неравенство. Прозрачность его лечит.

### 20.5. Атмосфера: раздача как сервис, а не как раздача

Немецкий стандарт требует от кухни выходить к жителям и дегустировать<sup>28</sup>. Финский — персонал за общим столом<sup>32</sup>. Австралийский: «я выбираю, что, когда, где и как я ем»<sup>34</sup>. Раздача — сервис, не технологическая операция. Минимум без затрат: раздающий называет варианты вслух («гречка или рис?»), не молча черпает; жителю дают 3–5 секунд без давления очереди — это даёт предзаказ; жалобу принимают как данные и кладут в журнал.

### 20.6. Температура и время на еду

Два замера — один раз, потом ежеквартально (раздел 22). Температура на первом и последнем столе: падение больше 10–15 °С — перестраивать поток. Время на еду у самого медленного из группы помощи: меньше 15 минут — торопят, риск аспирации, раздел 10. Оба замера бесплатны. Оба превращают «у нас всё нормально» в числа.

Линия проверяет вариативность каждый день. Элементы 20.2–20.4 плюс два ежеквартальных замера и маршрут для тех, кто на линию не выходит (раздел 20.11), не требуют денег. Здесь жители впервые чувствуют разницу между «накормить» и «обслужить».

### 20.8. Стол для группы помощи: микроустройство

Устройство стола решает половину задачи кормления. Помогающий садится между двумя жителями, не напротив одного. Жителей с дисфагическим риском не сажают вместе — каждый требует полного внимания в момент глотка. Посуда: глубокие тарелки с бортиком, нескользкие подставки, ложки удобного захвата. Адаптивная посуда



возвращает частичную самостоятельность; каждый самостоятельный житель — минуты помощи другому. Порции среднего размера с добавкой: большая порция деморализует едока и торопит помогающего. Самый частый дефект — помогающий обсуждает свои дела через голову едока. Самый дешёвый ремонт: «с едоком говорят с едоком».

## 20.9. Атмосфера: бесплатные элементы, которые зал замечает первыми

Программы среды Pioneer, Eden, Green House<sup>80, 81, 37</sup> единодушны: обед читают по атмосфере раньше, чем по меню. Нулевая стоимость: скатерти и салфетки вместо голого пластика; еда на столах до рассадки; персонал не стоит полукругом «над» едящими; без бряцания тележек в часы еды; освещение рабочее, не казённо-верхнее. Вместе это «столовая против раздаточной». Проверка: фотография вашего зала в часы обеда рядом с домашней кухней. Разница на снимке — программа на квартал.

## 20.10. Поток: инженерия очереди за один обед

Очередь с выбором — задача потока, не терпения. Пять решений, от дешёвого к дорогому, сверх 20.2: **предзаказ**; **визуальное меню до линии** (очередь делает пауза «что брать», не сам выбор); **разведение точек** — салаты и напитки на отдельный столик; **очерёдность отделений** — группы помощи первыми, порядок в распорядке; **вторая точка выдачи**, если позволяет помещение. Замер до и после (время от первого до последнего выданного) даёт минуты. «Выбор добавил 4 минуты к обеду» — факт. «Выбор создал хаос» — обычно диагноз отсутствия этих пяти решений.

## 20.11. Выбор вне линии: постельные и поднос

11 % жителей — постельные или маломобильные<sup>7</sup>. Если вариативность живёт только на линии, она — привилегия ходячих. Для этой группы выбор — **два варианта на подносе**, не вторая очередь в коридоре. Житель видит обе порции или картинки на двери, показывает; стандартный вариант всегда есть; журнал — на посту. Температура доходит до комнаты по технологическим документам; замер — на последней выдаче, не только на линии. Та же логика, что при карантине: раздел 18.11 и приложение 45. Помощь приходит с едой, не после неё (раздел 20.3). Проверка та же, что для ходячего: вчера был ли реальный второй вариант — на подносе, не в положении.

# 21. Когда выбор изменился: журнал, пересчёт и «фиктивная вариативность»

## 21.1. Тема раздела

Выбор жителя — не константа. Он меняется с состоянием, сезоном, сменой препаратов и просто со временем. Система, которая записала предпочтения при поступлении и больше не спрашивала, через год кормит человека, которого больше нет. Раздел — как выбор отслеживают, пересчитывают и отличают от декорации.

## 21.2. Три регистра данных о выборе

**Журнал заказа (оперативный)**. Вчерашний выбор = сегодняшние объёмы (раздел 19.4). Горизонт — сутки. Владелец — раздача и кухня. Форма — приложение 7. Без этой тетради объёмы варианта Б гадают, и «закончился» становится нормой.

**Журнал потребления (клинический)**. Что съедено: полная порция, половина, не тронута — для группы риска и при внедрении (раздел 9.3). Горизонт — неделя. Владелец — сиделки и врач. Функция — увидеть отказы, дисфагию, «нелюбимые блюда» раньше, чем они станут весом и пневмонией.

**Статистика выбора (управленческая)**. Доли А/Б по позициям и неделям; блюда-лидеры остатков; доля «выбрал Б — не получил Б». Горизонт — месяц. Владелец — диетсестра и руководитель. Функция — править объёмы, цикл и закупки. Опыт Усть-Илимска описывает её как «группировку блюд по популярности»<sup>4</sup>.

## 21.3. Пересчёт объёмов и цикла

Каждые две недели доли выбора правят варку. Каждый цикл статистика правит сам цикл: блюдо-аутсайдер по остаткам меняют по таблице замен — законно и безболезненно<sup>11, 12</sup>. Международный ориентир: 21 день (Онтарио) и 4 недели (Германия) против наших типовых 14<sup>23, 31</sup>. Российский 14-дневный цикл — законный минимум, не эталон. Расширение цикла — самая дешёвая форма разнообразия.

Статистика стабилизируется за 2–3 месяца. Решения — на горизонте месяца, не по эпизоду. «Вчера все взяли гречку» — не основание менять пропорции. «За четыре недели рис берут втрое чаще» — основание.

## 21.4. Фиктивная вариативность: пять признаков

Чек-лист для себя и для чужих презентаций.

1. «Вариант Б заканчивается через десять минут» — объём занижен. Индикатор: доля нереализованного выбора Б.

2. «Все выбирают А» — Б непривлекателен (смотреть остатки) либо выбор формален: нет показа, нет времени.
3. «Выбор есть в положении, но не на линии» — документ без процедуры. Один визит в часы еды.
4. «Выбирает персонал за жителя» — журнал «по привычке», без вопроса; для невербальных — без показа (раздел 15).
5. «Статистика не влияет ни на что» — данные собирают, объёмы и цикл не меняют.

Каждый признак снимается действием из разделов 19–20. Фиктивность — диагноз, не приговор.

### 21.5. Обратная связь жителей: от статистики к разговору

Статистика говорит «что», не «почему». Четвёртый канал — прямой разговор: ящик пожеланий, разбор меню на совете жителей (совет резидентов смотрит каждый цикл<sup>23, 82</sup>), дегустации с голосованием<sup>28</sup>. Минимум — раз в цикл. Формат совета — раздел 34 и приложение 30.

Канал изменит меню — иначе умрёт за полгода. Каждое пожелание: принято или нет, с причиной, на следующем заседании. Немецкий стандарт требует документированной системы жалоб со сроками ответа<sup>31</sup> — одна строка в регламенте.

Четыре регистра 21.2 плюс совет — тетради, не софт. Директору есть что положить учредителю и проверяющему: доли, пересчёт, решения совета (раздел 32).

### 21.7. Данные для совета жителей: как показывать числа

Статистика — материал совета (раздел 34). Три правила подачи. Одна цифра — один вывод: «выбирает 6 из 10 — меню надо показывать ещё четверым». Никаких процентов без абсолютов: «двенадцать человек» понятнее. Каждая цифра кончается вопросом к залу: «почему рыбу выбирают чаще курицы?». Совет, обсуждающий свои данные, — соуправление. Такие протоколы убеждают проверяющего быстрее положений.

### 21.8. Пять признаков фиктивной вариативности: детализация

Читать в поле, за один визит — сверх списка 21.4. Журнал одним почерком и одной ручкой за неделю. Доля «стандартных» выше 90 % без объяснения. На вопрос «что выбирали вчера» — «не знаю». Второй вариант к вашему приходу «уже закончился» при пустом журнале срывов. Выбор только на завтрак и только по кашам, хотя положение обещает «полную вариативность». Один признак ещё может быть невинным. Два и больше — система фиктивна, разговор о перезапуске, не о «развитии» (кейс 12).

### 21.9. Пересчёт меню по статистике: рабочий цикл

Четырёхнедельный цикл. Неделя 4 месяца: итоги журнала заказа по позициям — фактическая пропорция, например 62/38 вместо заложенных 50/50. Объёмы следующего цикла — по факту с резервом 10 % на вариант Б. Позиции с устойчивой долей ниже 15 % — кандидаты на замену: не «плохие», не выбираемы этим контингентом. Замену выносят на дегустацию совета (раздел 34). Позиции, которые кончаются до третьего отделения дважды за цикл, — кандидаты на увеличение доли (журнал срывов, приложение 8). Два часа в месяц у диетсестры или завпроизводства. Честный эффект почти всегда: пропорции стабилизируются через 6–8 недель. Эффект новизны кончается. Начинается карта вкусов дома — впервые измеренная.

## 22. Как проверить реальность питания: аудит и замеры

### 22.1. Принцип: измеряй факт, а не документ

Пилот, финансы, ответственность дальше в докладе стоят на данных. Дом, который себя не измерил, не докажет эффект, не защитится на проверке и не поймёт, что чинить первым. Инструментарий: экспресс-аудит, семидневный замер, квартальная панель. Измеряют факт — температуру на последнем столе, остаток на тарелке, интервал в часах, — не запись о факте.

### 22.2. Экспресс-аудит «Стол за один день»

Чек-листы — приложения 18–21. Один случайный будний день. Замеряющий — не профильный: заместитель, бухгалтер, сестра-хозяйка другого отделения. Четыре блока.

**До еды.** Меню вывешено языком блюд и совпадает с раскладкой. Ночной интервал — вчерашний ужин → сегодняшний завтрак — в часах. Журналы проб ведутся в реальном времени: почерки, время. Лекарственно-пищевая таблица на посту.

**Во время еды.** Кормимых на одного работника. Тарелки, ждущие рук. Температура на первом и последнем столе. Текстуры — выборочно 3 тарелки группы риска. Время у самого медленного. Объявлена ли добавка. Ест ли персонал с жителями. Остатки — доля и блюда-лидеры. Атмосфера: разговор или звон посуды и команды.

**После еды.** Журнал отказов читает врач. Срабатывала ли эскалация «3 отказа → врач». Куда ушли остатки. Есть ли вечерний перекус и доходит ли до постельных. Что может съесть житель в 2 часа ночи — спросить дежурную сиделку, не положение.

**Документы и люди.** Комплект раздела 31: положение, меню, журналы, паспорта, согласование. Когда совет жителей обсуждал меню. Выходил ли повар к жителям за месяц. Может ли кто-то за 5 минут назвать расход на сырьё на жителя в день.

Итог — 24 строки «да / нет / число». Каждая сама становится строкой плана. Большинство находок бесплатны: расписание, порядок подачи, журналы. Меньшинство — организационны: рассадка, смена. Единицы требуют денег.

### 22.3. Семидневный замер отходов и потребления

Форма — приложение 25. Семь дней, три веса в день: выдано (кг по линии), возвращено с тарелок, остатки кухни. Результат — доля несъеденного по блюдам и дням. База для финансовой модели (раздел 29), корректировки цикла (раздел 21), разговора с учредителем (раздел 38). *Семь дней — короткий ряд; сезонность и «хорошие дни» искажают. Замер повторяют ежеквартально. Выводы — на повторяемости, не на одном замере.*

### 22.4. Квартальная панель директора

Двенадцать чисел раз в квартал на одном листе (приложение 35).

1. Ночной интервал (часы). 2. Доля несъеденных порций. 3. Блюда-аутсайдеры (топ-3). 4. Кормимых на одного работника (факт). 5. Температурная дельта «линия — последний стол». 6. Соответствие текстур назначенным (выборка). 7. Число отказов и доля с эскалацией в срок. 8. Весовые триггеры — две строки, не одна: (а) набор  $\geq 5\%$  за квартал (метаболический риск, раздел 13.8); (б) потеря по MUST / рамка Онтарио (недостаточность питания). Кухня не ставит категорию MUST. 9. Доля жителей с актуальной пищевой картой. 10. Доля выбравших Б, не получивших Б (при вариативности). 11. Сырьевая строка (руб./житель/день). 12. Число жалоб на питание и доля с ответом в срок.

Панель показывает динамику — главный аргумент учредителю; рано сигнализирует о сбоях; дисциплинирует систему: что измеряется — то существует.

### 22.5. Экспресс-оценка «за 10 минут» для гостя семинара

Минимальная версия «завтра по приезду».

1. Спросить у жителя: «Что ты сегодня выбрал?» Ответ или его отсутствие измеряет выбор точнее документов.
2. Мойка после обеда: остатки — голос всех, включая молчаливых.
3. Ночной интервал по расписанию и по факту. Расхождение — разрыв бумаги и жизни.
4. Спросить у сиделки: «Что ты делаешь, если он отказался от третьего приёма подряд?» Правильный ответ: «фиксирую и сообщаю врачу сегодня».
5. Спросить у завхоза: «Сколько стоит сырьё на жителя в день?» Пауза измеряет финансовую прозрачность.

Последовательность: экспресс-аудит (неделя 1 пилота), семидневный замер (недели 1–2), квартальная панель. Стоимость — время непрофильного сотрудника в квартал и две тетради.

### 22.7. Аудит чужими глазами: взаимные визиты домов

Формат почти бесплатный между двумя домами — лучше разных типов и регионов, находка через семинар. Обмен аудиторами на день. Аудитор проходит чек-листы приложений 18–21 и пишет только факты. Три эффекта самоаудита нет: видны «невидимые нормы»; аудитор уносит к себе три находки хозяина; появляется внешний факт для учредителя. Правило: сначала договорённость о некарательности. Находки не уходят вверх без согласия принимающей стороны. Иначе формат умрёт после первого визита.

### 22.8. Кто замеряет: почему не свой

Самоаудит завышает баллы не из лжи, а из адаптации: своя столовая «всегда такая». Замеряющий — не владелец процесса: заместитель по другому контуру, бухгалтер, сестра-хозяйка соседнего отделения, коллега из другого дома. Единственная компетенция — записывать факт, не впечатление. «Вариант Б закончился на втором отделении» — факт. «Кухня не справляется» — впечатление. Чек-листы 18–21 построены под факты.

### 22.9. Оценка за 10 минут: как пользоваться шкалой

Итог — не «хорошо / плохо», а зона, задающая первый шаг. **Зона А (18–24 из 24):** система работает; задача — удержание: панель, ротация, защита от регресса (раздел 8.5). **Зона Б (12–17):** практика есть, контур дыряв; задача — документы и журналы (раздел 31), линию не трогать. **Зона В (6–11):** элементы есть, системы нет; пилот по разделу 35, не «всё сразу». **Зона Г (0–5):** точка старта; замеры (приложения 25–26) и разговор с учредителем (раздел 38) до изменений на линии. Оценку ставит факт вчерашнего дня: «положение есть» = 0 баллов, если вчера

выбора не было. Повторный аудит тем же человеком через квартал важнее идеальной первой оценки. Динамика балла — главный показатель управляемости темы.

## 23. Кто участвует: география семинара и система ПНИ-2026

### БЛОК 1.6. КОНТЕКСТ: ГЕОГРАФИЯ, НОРМЫ РЕГИОНОВ, РОССИЙСКИЕ ПРАКТИКИ, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ, ИССЛЕДОВАНИЯ (23–27)

#### 23.1. Аудитория по документам

Семинар «Пространство Новых Идей 2.0» собирает в Санкт-Петербурге руководителей стационарных организаций социального обслуживания со всей страны<sup>83</sup>. Очищенный список участников — отдельный файл к докладу: **170 записей из 51 субъекта Российской Федерации**; с учётом четырёх явных дублей — расчётно 166 уникальных организаций. Состав неоднороден: классические ПНИ (Краснодарский край, Ростовская, Нижегородская, Новосибирская области), переименованные «дома социального обслуживания» (Красноярский край, Волгоградская, Вологодская, Тюменская области), центры реабилитации и социализации (Воронежская область), «добрые дома» (Московская, Ульяновская области), геронтологические центры с отделениями ПНО (Владимирская область), детские и смешанные учреждения.

Аудитория говорит на разных организационных диалектах. Пищевая задача одна. Поэтому я обращаюсь к директору стационарной организации, не к «директору ПНИ».

#### 23.2. Система в числах (с оговорками о статусе данных)

По данным за 2024 год, обработанным проектом «Если быть точным» (публикация 09.04.2026). Материал пересказывали СМИ; ТАСС автором исследования не является. «Ведомости» 10.04.2026: психоневрологических интернатов за три года стало на 13 % меньше. Цифры перепроверены по нескольким независимым изданиям<sup>7,84</sup>:

- **466 психоневрологических интернатов** в России (три года назад — 536: сокращение на 13 %);
- **139 500 жителей** ПНИ; всего в стационарных организациях соцобслуживания — **более 174 000 человек** (данные Минтруда в пересказе);
- **65 % жителей старше 45 лет** — контингент стареет;
- **74 % признаны недееспособными** — три четверти;
- **11 % — постельные или маломобильные**;
- средний размер — **289 коек**;
- **41 регион переименовал ПНИ** в «дома социального обслуживания» и подобные имена — это видно по списку участников;
- в сопровождаемом проживании — порядка **7 000 человек** из ПНИ (и 1 800 в программах распределённых квартир).

*Статус данных: вторичная аналитика на государственных массивах, не официальная отчётность Минтруда. Первичные ряды в машиночитаемом виде на дату подготовки доклада в открытом доступе не извлечены — зафиксировано в журнале верификации. Цифры — порядковые ориентиры, не точная статистика.*

#### 23.3. Что цифры значат для темы доклада

Четыре следствия. Первое: контингент стареет (65 % старше 45 лет) — растут дисфагия, соматика, помощь за столом (разделы 10, 20, 28). Второе: 74 % недееспособных — невербальный выбор (раздел 15) важнее вербального. В вашем доме цифра будет другой; логика та же. Третье: переименования в ДСО — не косметика. Новая вывеска задаёт ожидание «дома», и питание — первое место, где его проверяют. Четвёртое: сопровождаемое проживание растёт — навыки «своего стола» (ступени 3–5 лестницы, раздел 8) становятся реабилитационной задачей с измеримым выходом.

#### 23.4. Кто в зале уже внедрил вариативность

В списке — организации с **подтверждёнными публичными практиками**: Успенский ПНИ (№ 117)<sup>3</sup>, Усть-Илимский дом социального обслуживания (№ 94)<sup>4</sup>, ДСО «Серафимовский» — наш петербургский дом<sup>5</sup>, Болотнинский ПНИ из того же региона, что участник № 118 (Тогучинский ПНИ)<sup>2</sup>. Практика сидит в зале. Предложение модераторам — раздел 40.

#### 23.5. В зале сидят внедрившие: как использовать это обстоятельство

Три организации представлены лично — Успенский, Усть-Илимск, Серафимовский<sup>7, 4, 5</sup>. Болотнинский — из того же региона, что Успенский<sup>2</sup>. Вопросы «сколько стоило», «что сказала проверка», «где ломалось» — носителям опыта в зале, не только лектору (панель — раздел 40). Для остальных это сильнее презентации: коллега с таким же штатом, учредителем и СанПиНом уже сделал это.



### 23.6. Чего в списке нет — и что это значит

В списке нет общественных организаций жителей и семей, нет профсоюзов смен, нет экспертов по питанию. Состав управленческий. Это не упрёк организаторам. Решения будут принимать о людях, которых в зале нет. Первая проверка любого решения семинара — не отчёт учредителю, а столовая: житель и смена. Держать этих двух в поле зрения — задача модерации каждого обсуждения.

### 23.7. Что список участников говорит о системе

170 записей, 51 субъект, 4 дубля → 166 уникальных организаций — срез отрасли. Рядом сидят классические ПНИ, переименованные ДСО, дома-интернаты общего типа, СРЦ и детские организации. Советы, годные взрослому ПНИ, для детского учреждения требуют отдельной проверки: детский контур в докладе обозначен, но не раскрыт — честная граница. 51 регион — больше половины субъектов РФ; семинарская повестка способна стать отраслевой (раздел 40). Качество данных: 20 записей с пометками о неуверенном распознавании текста и 4 дубля. Даже официальный список федерального семинара требует чистки. Тот же принцип везде в докладе: сначала верификация, потом выводы.

## 24. Как устроены нормы в регионах

### 24.1. Двухуровневая система норм питания

Рамка двухуровневая. Федеральный уровень — **рекомендуемые нормы Минтруда** (приказ № 520н): суточные наборы для взрослых и детей<sup>29</sup>. Региональный — акты субъектов, которые принимают эти нормы как обязательные для подведомственных, конкретизируют и дополняют. Проверенные примеры: постановление Правительства Москвы № 1068-ПП, постановление администрации Псковской области № 206, постановление Правительства Красноярского края № 607-п, постановление Правительства Ленинградской области № 458, постановление Правительства ХМАО № 306-п<sup>85, 12, 11</sup>.

Для директора действует региональный акт: граммы, раскладка, таблицы замен. Первое действие — найти и перечитать свой региональный акт, не федеральные приказы. Путь — через учредителя.

### 24.2. Что общего у региональных норм

Проверенные акты держат одну конструкцию.

1. **Набор продуктов в граммах на человека в день** по группам — хлеб, крупы, мясо, рыба, молочные, овощи — прямо или со ссылкой на федеральные рекомендации.
2. **Раскладка блюд** (перспективная картотека) — перечень с выходом в граммах.
3. **Таблицы замены продуктов** — эквиваленты по питательной ценности. Ключевой механизм: легализует вариативность (разделы 8, 19).
4. **Отдельные нормы для категорий** — дети, лица с соматическими заболеваниями.
5. **Периодичность и режим** — число приёмов, интервалы — в связке с СанПиН<sup>9</sup>.

Различия — в граммах, категориях и свободе таблиц замен. Систематического сопоставления всех 89 субъектов нет: такого обзора мы не нашли. Обобщения о «российских нормах вообще» делать осторожно.

Приказ Минтруда 520н на федеральном уровне — «рекомендуемые нормы». В Минюсте не регистрировался: рекомендательный акт, не императив. В ряде субъектов региональные акты прямо ссылаются на 520н как на основу для подведомственных — и тогда нормы обязательны в данном регионе независимо от федерального статуса. Проверяя рамку (раздел 24.4, шаг 1), уточняйте не только наличие акта, но и его ссылочный аппарат. (Уточнение 19.08.2026.)

### 24.3. Региональные модели организации: четыре архетипа

Организации устроены по-разному. Это влияет на питание.

**Архетип 1. Классический ПНИ** (Краснодарский край, Ростовская, Нижегородская, Новосибирская области): специализированное учреждение для лиц с психическими расстройствами. Питание — профильная функция; диетсестра чаще в штате. Этот архетип дал все три подтверждённые практики вариативности<sup>2, 3, 4</sup>.

**Архетип 2. Дом социального обслуживания (ДСО)** (Красноярский край, Волгоградская, Вологодская, Тюменская области и др. — 41 регион переименований<sup>7</sup>): универсальное учреждение, жители с психическими расстройствами живут вместе с другими категориями. Питание — на общих нормах; психиатрическая специфика — в назначениях врача и локальных актах.

**Архетип 3. Центры реабилитации и «добрые дома»** (Воронежская, Московская, Ульяновская области): питание — элемент восстановления навыков; ближе к моделям М3–М5 (раздел 8).



**Архетип 4. Смешанные учреждения с отделениями ПНО** (Владимирская область и др.): психоневрологическое отделение внутри геронтологического центра или специального дома-интерната. Питание общего контура с отдельными назначениями для отделения.

Заимствуя опыт, смотрите на архетип источника. Модель классического ПНИ переносится на ДСО с адаптацией, не копируется.

#### 24.4. Пять шагов проверки своей региональной рамки

Алгоритм для директора (форма — в семинарском пакете).

1. Получить у учредителя действующий региональный акт о нормах питания и проверить редакцию: дата, изменения.
2. Сверить фактическую раскладку дома с актом: граммы, категории, таблицы замен.
3. Проверить таблицы замен: какие эквиваленты разрешены — пространство законной вариативности.
4. Найти нормы для особых категорий: где «диетическое питание» вашего контура.
5. Зафиксировать письменно: что решает учреждение, что — учредитель (матрица полномочий, приложение 17).

Таблицы замен — готовое законное пространство выбора, которым почти никто не пользуется по назначению. Без этих пяти шагов пилот строится вслепую.

#### 24.6. Разговор с регионом: как ставить вопрос

Чиновник отвечает на точный вопрос охотнее, чем на «разберитесь с нормами». Постановка: «Просим подтвердить статус приказа Минтруда № 520н в части норм питания для подведомственных организаций: рекомендованный или обязательный; просим указать акт, которым статус установлен». Один вопрос, одна просьба о документе. Такой же шаблон — для меню, «моста» и форм учёта. Четыре письма заменяют год коридорных пересудов.

#### 24.7. Проверка за пять шагов: сценарий недели

День 1 — письмо учредителю с вопросами 1–4 из раздела 38. День 2 — сбор внутри: какое меню висит на кухне, кто утвердил, когда пересматривалось. День 3 — сверка: предписано ≠ фактическое; разницу фиксируют письменно. День 4 — ответ учредителя или фиксация его отсутствия и решение о рамке пилота. День 5 — запись рамки в приказ о пилоте (приложение 28). Неделя без изменения на линии. После неё правовая геометрия кухни известна точнее, чем за предыдущие годы.

#### 24.8. Четыре архетипа региональной регуляции: детализация

Узнавать по одному документу каждого типа. **«Императивное меню»** — приложение к постановлению: двухнедельное меню с граммовками, отступления не предусмотрены. Вариативность начинается с изменения приложения; первый шаг — запрос процедуры (вопрос № 2 учредителю, раздел 38). **«Нормы без меню»**: нутриенты и кратность закреплены, меню — дело организации. Свобода максимальна, ответственность за пары — на организации. **«Типовая раскладка»**: наследие советской раскладки, формально рекомендованной, фактически священной. Лечится письменным вопросом о статусе. **«Мост»**: акт, связывающий СОСО с системой диет (распоряжение 19РВ-32 как образец<sup>12</sup>) — самый благоприятный для лечебного питания и самый редкий. Один регион может комбинировать: императивное меню плюс мост. Диагностика — не анекдот «у нас нельзя», а форма из пяти строк: статус норм, меню, мост, формы учёта, закупочная модель. Эту форму семинар собирает по 51 региону (раздел 40) — первый срез вместо фольклора.

## 25. Российские практики: четыре подтверждённых кейса и одна региональная модель

#### 25.1. Методологическая рамка: что считается подтверждением

Практикой считается только то, о чём организация или регион рассказали публично на официальном ресурсе. Новость подтверждает факт сообщения, не аудит практики. Перечень не полон: российская практика вариативности шире её публичной документации, поиск при подготовке доклада — срез, не перепись. Где деталей нет в источнике, прямо написано «данных нет».

#### 25.2. Кейс 1. Болотнинский ПНИ (Новосибирская область), с 2024 года

Сообщение учреждения от 16.08.2024<sup>2</sup>: вариативное питание действует **несколько раз в неделю**; на завтрак — выбор чая, какао или кофейного напитка, каши или супа; на обед — салаты, вторые и десерт; **перечень блюд для выбора определяет медсестра диетическая**.

Модель М1 (раздел 8) — точечный выбор на ключевых приёмах и днях. Вариативность внутри норм, ответственная — диетсестра, конфликт «выбор против раскладки» снят. Чего в источнике нет: охват, учёт невербального выбора, статистика, влияние на отходы, судьба после 2024 года. Данных нет — повод для контакта, не для домыслов.

### 25.3. Кейс 2. Успенский ПНИ (Новосибирская область), с 2024 года

Сообщение от 13.08.2024 <sup>3</sup>: вариативное меню **во всех отделениях**; ежедневно **два вторых, два салата, два напитка**; «страхи персонала не подтвердились», жители «с лёгкостью освоили новую систему»; обновлена посуда, проведены занятия по этикету.

Модель М2 — ежедневный выбор по основным позициям, полный охват. Не М3: шведской линии в источнике нет. Два факта для семинара. Главное сопротивление было внутренним и не материализовалось. Внедрение шло с бытовым апгрейдом и обучением жителей: программа, не приказ. Участник семинара — № 117.

### 25.4. Кейс 3. Усть-Илимский дом социального обслуживания (Иркутская область), с сентября 2024 года

Сообщение от 27.09.2024 <sup>4</sup>: вариативное питание вводится **поэтапно**; старт — для жителей, посещающих столовую; предварительно — **опрос предпочтений**; блюда **сгруппированы по популярности**.

Внедрение начали с измерения и сегментации (сначала мобильные), не с приказа. Это логика дорожной карты раздела 35. Участник семинара — № 94.

### 25.5. Кейс 4. ДСО «Серафимовский» (Санкт-Петербург), 2025 год

Сообщение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 22.07.2025 <sup>5</sup>. Я, директор дома Евгений Чистяков, представил на рабочей группе по реформированию ПНИ **первые результаты вариативного меню для части жителей**. Несколько месяцев проживающим предлагали **накануне выбрать рацион следующего дня**. Дом **закупил дополнительное оборудование и добавил сотрудников**. Жители восприняли эксперимент **с энтузиазмом**. Полный переход **крайне затруднителен**: нормы сбалансированности и особенности здоровья; жители склонны выбирать **популярные, но не самые полезные** продукты.

Модель М1 — заказ накануне для части жителей, близко к пилоту раздела 35. Два факта, которых нет в других публичных российских кейсах. Старт **не** был «без новых денег»: оборудование и ставки названы прямо. Учреждение само назвало пределы — нормы, здоровье, популярный нездоровый выбор. Это ценнее победной реляции. *Маркировка: официальная новость учредителя — факт публичного сообщения на дату, не аудит и не оценка устойчивости. Докладчик семинара — директор этого дома.*

**Развитие кейса: приказ № 124 от 10.03.2026 <sup>86</sup>**. Приказ утверждает **правила внутреннего распорядка жителей**. В них — **заказное питание (вариативное меню)**, в том числе для маломобильных: «для маломобильных граждан приём пищи осуществляется в жилых комнатах, оказывается помощь в кормлении (при необходимости)». Из «эксперимента по новости» вариативность стала **нормой внутреннего распорядка** — локальный акт для проверяющих. *Реквизиты — PDF приказа на [www.pni9.ru](http://www.pni9.ru); сайт прекратил работу, домен истёк, проверено 21.08.2026; архив: [web.archive.org/web/20260415001233/https://www.pni9.ru/правила-внутреннего-распорядка/](http://web.archive.org/web/20260415001233/https://www.pni9.ru/правила-внутреннего-распорядка/). Заказное питание — раздел правил, не отдельный приказ.*

**Масштаб и режим (обновление 21.08.2026, архивные копии сайта)**. Февраль 2026: **1 004 человека** — 949 за счёт бюджета Санкт-Петербурга (625 мужчин, 324 женщины; свободных мест нет) и 55 за счёт средств физических и юридических лиц (28 мужчин, 27 женщин); раздел «Свободные места», архив 07.03.2026. Режим: завтрак 8.00–10.00, обед 13.00–15.00, полдник 16.00–17.00, ужин 18.00–20.00, второй ужин 20.00–21.00; ночной интервал от второго ужина до завтрака — **11–12 часов**. Укладывается в правило «интервал не превышает 14 часов» раздела 4 и в критерий раздела 13.9. Материально-техническое обеспечение (архив 24.01.2026): «6-и разовое питание, наличие диет столов», протёртый стол и дополнительное питание при заболеваниях ЖКТ — факты для раздела 17.12.

### 25.6. Региональная модель: Иркутская область, с 2025 года

Пресс-релиз (пересказ отраслевым изданием, 14.02.2025)<sup>6</sup>: в стационарных учреждениях области — **ежедневный выбор из двух первых, двух вторых и гарниров**. Если подтвердится первоисточником (сайт минсоцразвития Иркутской области), это первый в России случай **масштабирования вариативности на уровень региона**. *Источник вторичный; сколько учреждений фактически — на дату подготовки доклада не установлено.*

### 25.7. Опорная практика: ДДСОЛ (Московская область)

ДДСОЛ публикует устройство питания<sup>22</sup>: зимнее и летнее **14-дневное меню**, 5–6-разовое питание, поточная линия самообслуживания, буфетная зона, **совет по питанию** (распоряжение Минсоцразвития Московской области 19РВ-32 от 13.04.2017 — медицинская рамка, применённая к соцучреждению), **замены по желанию жителей с согласованием с врачом**. Это не «вариативное меню» в нашем строгом смысле, но работающая персонализация внутри нормы — и легальный «мостик» к лечебному питанию (раздел 17.5).

## 25.8. Сравнительная таблица практик

| Учреждение        | Модель         | Точки выбора                | Частота                 | Охват            | Ответственный           | Особенности                                                                               |
|-------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Болотнинский ПНИ  | M1             | Завтрак, обед               | Неск. раз/нед           | Данных нет       | Диетсестра              | Перечень от медицинской структуры                                                         |
| Успенский ПНИ     | M2             | Все основные позиции        | Ежедневно               | Все отделения    | Данных нет              | Посуда, этикет, работа со страхами                                                        |
| Усть-Илимский ДСО | M1→M2          | Старт — столовая            | Позтапно                | Мобильные жители | Данных нет              | Опрос предпочтений, группировка по популярности                                           |
| Серафимовский ДСО | M1             | Рацион на следующий день    | Накануне, неск. месяцев | Часть жителей    | Данных нет              | Оборудование и доп. сотрудники; энтузиазм; полный переход затруднителен (нормы, здоровье) |
| Иркутская область | M2             | 2 первых, 2 вторых, гарниры | Ежедневно               | Регион           | Учредитель              | Масштабирование на субъект                                                                |
| ДДСОЛ             | персонализация | Замены по желанию           | Постоянно               | Все жители       | Совет по питанию + врач | 14-дневное меню, региональный «мостик» к 330н                                             |

## 25.9. Выводы для участников

- Вариативность в России — не эксперимент:** минимум четыре учреждения и один регион — публично, с 2024 года<sup>2, 3, 4, 5, 6</sup>.
- Три кейса Новосибирской и Иркутской областей начинались без новых денег** — второй вариант внутри существующих норм. **Серафимовский публично назвал оборудование и дополнительные ставки<sup>5</sup>** — универсального «бесплатного старта» нет.
- Три кейса сидят в зале** — Успенский, Усть-Илимский и дом докладчика (раздел 40).
- Документация отстаёт от практики:** учёта, статистики, документов в публичных сообщениях нет. Учреждение, рассказавшее о выборе с цифрами, сдвинет отрасль сильнее методического доклада (раздел 39).

## 25.10. Чего мы не знаем о практиках — и почему это важно сказать

По каждой из шести практик неизвестно больше, чем известно: экономика сырьевой строки, устойчивость на сегодня, охват неговорящих, вопросы проверок. Новость подтверждает факт сообщения на дату — и только. Поиск локальных актов и повторных публикаций выполнен там, где они нашлись (распоряжение ДДСОЛ<sup>22</sup>, региональное решение по Иркутску<sup>6</sup>), и честно не выполнен там, где их нет: повторных публикаций по Болотнинскому и Успенскому на момент проверки не обнаружено. По Серафимовскому известны факты новости Комитета<sup>5</sup> — не штатное расписание, не меню, не панель чисел. «Внедрено публично» ≠ «работает годами». Зал должен слышать обе половины фразы.

## 25.11. Что объединяет внедривших: четыре общих признака

Сравнение шести практик (Болотнинский<sup>2</sup>, Успенский<sup>3</sup>, Усть-Илимский<sup>4</sup>, Серафимовский<sup>5</sup>, Иркутская область<sup>6</sup>, ДДСОЛ<sup>22</sup>) даёт механику, не лозунги. **Точка входа — предпочтения:** опрос предшествует линии (явно — Усть-Илимск<sup>4</sup>). **Скромный старт:** два вторых, два салата, два напитка<sup>3</sup> или заказ накануне для части жителей<sup>5</sup>. **Публичность как защита:** рассказанное на официальных сайтах с датами труднее тихо отменить. **Страхи и пределы названы постфактум:** «страхи не подтвердились»<sup>3</sup> и «полный переход крайне затруднителен»<sup>5</sup>. Признак, который **не** общий: новосибирские и иркутский кейсы не сообщают о новых ставках; Серафимовский сообщает об оборудовании и сотрудниках. Это не доказывает ни «бесплатности», ни «дороговизны» (раздел 29): порог может быть организационным (модель НСО) или требовать ресурсов (модель СПб). Пилот на одном отделении без новых денег реалистичен. Обещать бесплатный полный переход — нельзя.

Следующий шаг блока «Контекст» — международный опыт (раздел 26): что делают в девяти зарубежных системах, где их регуляторика расходится с российской, и какие нормы там появляются раньше, чем у нас.

## 26. Международный опыт: проверяемые нормы девяти систем

Раздел 25 дал четыре российских кейса. Здесь — ориентиры и предупреждения из девяти зарубежных систем.

## 26.1. Правила заимствования

Три правила. Беру только **проверяемые нормы** — числа, процедуры, документы; не «ценности» и не «подходы». К каждой норме — статус дома (закон, руководство, стандарт, доплата) и **граница применимости**: большинство писано для гериатрии, не для психиатрии; перенос на ПНИ — наша адаптация, и она маркируется. Превосходные степени исключены: сравниваем механизмы, не страны.

## 26.2. Великобритания: психиатрическая специфика

Единственное найденное руководство **именно для психиатрических стационаров** — Британской диетической ассоциации (BDA)<sup>36, 87</sup>. Берём: гибкий завтрак для седатированных; меню без приборов (finger food) при риске; протокол питания в изоляции (посуда, текстура, фиксация потребления, эскалация); лекарственно-пищевая таблица в меню (раздел 11); self-catering на реабилитации. Базовый стандарт — Regulation 14 регулятора CQC: учёт предпочтений **по времени, месту и количеству еды**, не только по составу; отложенная еда для пропустивших<sup>39</sup>. «Защищённые приёмы пищи» — с оговоркой: систематический обзор признаёт доказательную базу недостаточной<sup>88, 89</sup>.

## 26.3. Австралия: еда как самостоятельный стандарт

С 1 ноября 2025 года действует Standard 6 «Food and Nutrition»: питание — отдельный стандарт качества ухода. Формула выбора **«что, когда, где и как я ем»**; перекусы 24/7; меню с участием проживающих; текстуры по IDDSI с достойной подачей и процедурой «осознанного риска»<sup>34, 44</sup>. Финансовая подпорка — следствие скандала: медиана расходов на сырьё \$8,00 AUD в день (Hugo)<sup>90</sup> → надбавка \$10 AUD **в обмен на обязательную ежеквартальную отчётность о расходах на питание**<sup>91</sup>. «Деньги в обмен на прозрачность» — самый переносимый финансовый элемент (раздел 29).

## 26.4. Онтарио: решётка измеримых норм

Подзаконный акт О. Reg. 246/22 — самая детальная из найденных конструкций<sup>23</sup>: цикл меню ≥21 день; выбор на всех приёмах; **совет резидентов рассматривает каждый цикл меню и согласует время приёмов**; еда по диете доступна 24 часа; триггеры веса −5 %/−7,5 %/−10 % за 1/3/6 месяцев с автоматической междисциплинарной оценкой; диетолог ≥30 минут на жителя в месяц; **кормление: один работник — не более двух кормимых, еда — только под готовую помощь**. Профессиональные формы добавляют триггеры потребления: ≥25 % порции за 2 из 3 приёмов в течение недели; отказ от трёх приёмов подряд<sup>56</sup>. Почти вся решётка переносима в российский локальный акт без изменения закона (разделы 12, 20, 21).

## 26.5. США: альтернатива при отказе и ночной интервал

Федеральное правило 42 CFR §483.60<sup>35</sup>: при отказе от блюда **обязательна альтернатива сходной питательной ценности**; между существенным ужином и завтраком — **не более 14 часов** (16 — при питательном перекусе на ночь). Нарушения фиксируются пронумерованными инспекционными F-тегами (F800–F807 — пищевой блок)<sup>92</sup>: механика пронумерованных пунктов переносима во внутренний аудит (приложения 18–24).

## 26.6. Скандинавия: 11 часов ночи и совместный стол

Шведское руководство Livsmedelsverket: ночной интервал ≤11 часов с обязательным вечерним перекусом; шесть пищевых событий в день; пищевой совет (matråd) из проживающих<sup>30, 82</sup>. Замеры Талльберга: норма интервала у 79 % проживающих — индикатор одной строкой расписания<sup>82</sup>. Финляндия: **персонал ест вместе с проживающими** как национальная рекомендация<sup>32, 93</sup> — бесплатный мониторинг. Ориентир дома — ≤13 ч (внутри 11–14 ч, не отдельная норма); ужин 17:30 → завтрак 8:30 = 15 часов; меняется сдвигом на час и вечерним перекусом без сметы (раздел 13.9). *Определения «приёма пищи» и учёт перекуса различаются — считайте фактический интервал своего дома.*

## 26.7. Германия и Австрия: биография, желание и конец «диабетического стола»

DGE-QST (сертификация с аудитом): «**биография питания**» (Essbiografie) при поступлении — прототип нашей пищевой карты; «**пища по желанию**» (Wunschkost) при критических состояниях и в терминальной фазе; цикл меню ≥4 недель; вегетарианское предложение ежедневно; замещающая еда для пропустивших; повара выходят к жителям с дегустациями<sup>31, 28</sup>. Австрийский стандарт 2022: **либерализация диет** — нет общего «диабетического стола», решение индивидуально и с участием проживающего<sup>38</sup>; исследование SUNRISE: **аппетитные названия блюд измеримо меняют выбор**<sup>94</sup> — самая дешёвая из всех норм раздела.

## 26.8. Япония: как стимул стал стандартом

Жизненный цикл за 16 лет: доплата за нутритивный менеджмент (2005) → охват 87–94 % учреждений (2020) → обязательный стандарт с **вычетом за неисполнение** и сдачей данных в национальную базу LIFE (2021)<sup>95, 96, 97</sup>. Доплата — с меньшим риском ухудшения уровня ухода (HR 0,90)<sup>98</sup>; больше диетологов в штате — ниже риск



потенциально предотвратимых госпитализаций (скорректированный HR 0,72; 95 % ДИ 0,54–0,97; ретроспективная когорта 2 909 жителей 235 домов; BMC Geriatrics, 2023)<sup>99</sup>. *Наблюдательное исследование, не РКИ; одна префектура; авторы призывают к осторожности в причинной интерпретации.* Структурированная поддержка питания в наблюдательных когортах ассоциировалась и со снижением смертности (HR 0,90)<sup>100</sup>. Урок — траектория: норма росла 16 лет и начиналась с денег за специалиста, не с призывов к качеству (ставки — раздел 38, вопрос 5).

## 26.9. Десять переносимых норм — сводка

| №  | Норма                                           | Источник           | Российская посадка                  |
|----|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 1  | Ночной интервал ≤11–14 ч                        | Швеция, США        | Расписание + перекус (раздел 13.4)  |
| 2  | Альтернатива при отказе — обязательна           | США                | Таблицы замен + правило в положении |
| 3  | Выбор «что/когда/где/как»                       | Австралия, Онтарио | Лестница моделей (раздел 8)         |
| 4  | Замещающая еда пропустившим; гибкий завтрак     | Германия, BDA      | Пункт положения о питании           |
| 5  | Аппетитные названия блюд                        | Австрия            | Доска меню (0 руб.)                 |
| 6  | Пищевая биография при поступлении               | Германия           | Приложение 3                        |
| 7  | Совет жителей о меню и времени приёмов          | Онтарио, Швеция    | Раздел 34, приложение 30            |
| 8  | Триггеры: вес 5/7,5/10 %; 25 % порций; 3 отказа | Онтарио            | Разделы 12, 21, приложение 9        |
| 9  | Кормление 1:2; еда под готовую помощь           | Онтарио            | Раздел 20 (ориентир)                |
| 10 | Отчётность о расходах на сырьё                  | Австралия, Япония  | Раздел 29, дашборд                  |

Во всех девяти системах выбор закреплён законом, стандартом или условием оплаты. Берём проверяемые нормы, маркируем происхождение, внедряем локальным актом, измеряем (раздел 22).

## 26.10. Как читать зарубежные нормы без романтизации

Три фильтра. **Ресурс:** нормы Онтарио (диетолог 30 минут на жителя в месяц<sup>23</sup>) — система с другим финансированием; переносится принцип «время специалиста нормируется», не минуты. **Правовая конструкция:** F-теги<sup>92</sup> работают благодаря инспекции с денежными санкциями; переносится механика пронумерованных пунктов во внутренний аудит, не штрафы. **Зрелость:** Стандарт 6 с 01.11.2025<sup>34</sup> — норма на старте; переносится формулировка («что, когда, где и как я ем») как ориентир, не как «проверенная модель». Романтизация и ксенофобия одинаково отменяют анализ. Вопрос — «какой механизм работает и есть ли он у нас». Из десяти норм восемь уже имеют российскую рамку: совет, журнал, альтернатива при отказе, триггеры веса, ночной интервал.

## 27. Что говорят исследования: доказательные вмешательства и их границы

### 27.1. Зачем раздел и как его читать

Доклад опирается на исследования, не на рекламу методик. Каждое вмешательство — с популяцией, дизайном и ограничениями. **Почти вся доказательная база организационных вмешательств в питании — гериатрия и деменс-уход, не психиатрия;** перенос на ПНИ требует адаптации и своего измерения (раздел 22).

### 27.2. Вмешательства с измеримым эффектом

**Семейная подача (family-style dining).** Nijs и соавт., 2006: кластерное РКИ в пяти голландских домах ухода, 178 жителей **без деменции** (не психиатрический контингент ПНИ/ДСО). Общие блюда на столе дали рост качества жизни (+6,1 балла), массы тела (+1,5 кг) и потребления энергии (+991 кДж/день) против контроля<sup>33</sup>. Перенос на российские ДСО и отделения с деменцией **не обоснован**; механизм (социальность + саморегуляция порций) обсуждается точно, не как норма. Для острых состояний — нет.

**IDDSI и текстуры.** Пять учреждений: соответствие текстур выросло с 44 % до 90 % (жидкости: 31 % → 100 %), эффект 6 месяцев; барьер — осведомлённость персонала<sup>43</sup>. Перенос прямой: дисфагия есть в любом ПНИ (раздел 10).

**Монтессори-подход к еде.** Обучение персонала деменс-ухода (Montessori-based activities) улучшает самостоятельность еды и снижает проблемное поведение за столом<sup>70</sup>. Для когнитивных нарушений; это навык, не меню.



**Доплаты за нутритивный менеджмент (Япония).** Доплата ассоциирована с меньшим риском ухудшения ухода (HR 0,90); диетологи — с меньшим риском потенциально предотвратимых госпитализаций (скорректированный HR 0,72; 95 % ДИ 0,54–0,97)<sup>98,99</sup>. *Ограничение: наблюдательные данные, возможен отбор; причинность не доказана.*

### 27.3. Вмешательства со слабой или отрицательной доказательностью

**Защищённые приёмы пищи (protected mealtimes).** Систематический обзор: доказательная база **недостаточна** — исследования малочисленны и неоднородны<sup>88, 89</sup>. Вердикт: разумно и бесплатно, но не «доказано»; внедряется как организационная гигиена без обещания эффекта.

**Образ жизни для снижения веса при ТПР.** Мета-анализ: средний эффект порядка –1,4 кг<sup>62</sup> — статистически реальный, клинически скромный. Программы с диетологом сильнее<sup>63</sup>. Метаболическая стратегия — среда и мониторинг (раздел 13), не ожидание больших цифр.

**Малые дома (Green House, Eden Alternative).** Оценки показывают улучшение качества жизни и питания<sup>37, 81</sup>; это системные реформы (штат, архитектура, финансирование), не «приёмы» — горизонт, не действие на следующей неделе.

### 27.4. Что доказано про вес и препараты (свод клинического ядра)

Клинические факты — в одной таблице; разбор — в разделах 11–13. **Campforts 2023 (BJPsych Open, CRWG) — исследование веса на антипсихотиках, не меню.**

| Факт                                                      | Число                | Источник                                     |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| Разброс прибавки веса между антипсихотиками (6 недель)    | от –0,23 до +3,01 кг | Мета-анализ 100 РКИ <sup>13</sup>            |
| Клинически значимая прибавка (≥7 %) при клозапине         | 76,3 % пациентов     | Campforts 2023, консенсус CRWG <sup>59</sup> |
| Прибавка при первом эпизоде психоза (оланзапин)           | до +9,34 кг          | FERWG <sup>60</sup>                          |
| Кофеин повышает АУС клозапина                             | в среднем +19 %      | Контролируемое исследование <sup>15</sup>    |
| Грейпфрут повышает концентрацию карбамазепина             | порядка +40 %        | Фармакокинетика <sup>18</sup>                |
| Распространённость дисфагии при психических расстройствах | 21,9–69,5 %          | Обзоры <sup>1, 24</sup>                      |
| Смертность от пневмонии при ТПР                           | RR 7,00              | Нац. когорты <sup>14</sup>                   |
| Разрыв продолжительности жизни при ТПР                    | 15–20 лет            | Нац. когорты <sup>14</sup>                   |

### 27.5. Что исследования не говорят (честные пробелы)

- Нет РКИ вариативного меню в психиатрических учреждениях** — внедрение выбора опирается на нормы, практики и здоровый механизм, не на рандомизированные исходы. Это не аргумент против внедрения, но аргумент за собственное измерение (раздел 22).
- Нет надёжной доказательности «вариативность снижает отходы»** — связь правдоподобна, документированных сравнений мало; позиция доклада — замерить до и после (приложение 25), не цитировать.
- Нет данных по российским ПНИ** — отечественной исследовательской базы по питанию в ПНИ мы не нашли; это находка для семинара (раздел 39: отраслевые данные — вклад учреждений).

Три опоры: измеримые (семейная подача, IDDSI, Монтессори, диетологи) — по показаниям; слабые (защищённые приёмы, lifestyle) — гигиена без обещаний; пробелы (вариативность, отходы, Россия) — мерить самим. Кто внедрил выбор и замерил отходы, вес и жалобы, через год владеет доказательством, которого сейчас нет ни у кого в стране.

### 27.7. Что доклад сделал бы с грантом на исследование

Одно исследование из пробелов раздела: многоцентровое (5–7 ПНИ разных регионов) прагматичное внедрение выбора из двух вариантов с измерением отходов, веса, отказов, трудозатрат и качества жизни за 6 месяцев, замер до/после по единой методике. Закрыло бы главный пробел («нет РКИ вариативности в психиатрии») дешевле одного федерального форума. Общий замер семинара (раздел 40) — его задел.

### 27.8. Как пользоваться базой, не становясь исследователем

Три вопроса к любой «научной» цифре: какая популяция (психиатрия? пожилые? дети?), какой дизайн (РКИ? наблюдение? новость?) и что измерено (вес и госпитализации — или «удовлетворённость» по самодельной анкете). Цифра, не выдержавшая трёх вопросов, в приказ не попадает — в лучшем случае в презентацию с оговоркой. Реестры доклада (раздел 44) размечены по этим трём осям.

## 27.9. Три исследования, которые стоит знать в лицо

**Первое** — RCT Нийса, 2006: семейный стиль подачи, не смена меню; цифры и оговорка «без деменции» — в 27.2<sup>33</sup>. **Второе** — IDDSI в пяти учреждениях: обучение подняло соответствие текстур с 44 до 90 %<sup>43</sup>; резерв — обучение, не оборудование. **Третье** — японская когорта **поддержанного жилья**: питание как сервис ассоциировалось со снижением госпитализаций и смертности<sup>100</sup>. В тройке нет ни российского исследования, ни исследования вариативного меню. Доказательства — о механизмах (стол, текстуры, сервис); «два варианта каши против одного» не доказаны нигде. Честный доклад обязан это сказать вслух. Campforts 2023 в тройку не входит: вес на антипсихотиках, не меню.

## 28. Люди за линией: персонал стола

### БЛОК 1.7. ЛЮДИ И ДЕНЬГИ: ПЕРСОНАЛ, ФИНАНСЫ, ЗАКУПКИ (28–30)

#### 28.1. Почему тема персонала — половина темы семинара

Формула семинара — «права, свободы, интересы жителей и персонала». Изменение исполняют руки: сиделка, повар, раздающий, диетсестра, завхоз. Доклад без их нагрузки и страхов не будет исполнен. В Успенском главным препятствием оказались не деньги и не нормы, а «страхи персонала»<sup>3</sup>.

#### 28.2. Роли и их реальная нагрузка

**Сиделка/санитар.** Кормит, наблюдает, фиксирует, предлагает выбор. Добавка вариативности — 5–10 секунд на жителя на линии и строки в журналах; клинический контур — признаки (дисфагия, отказы) и одна фраза эскалации. Минуты смены, не «энтузиазм».

**Повар.** При парных эквивалентах второй вариант — та же заготовка в другой форме (раздел 19): нагрузка на гастроремкости и маркировку, не на «второе производство». Обратная связь: повар видит, что блюдо выбирают. Немецкая практика — выход к жителям с дегустациями<sup>28</sup>; у нас — дегустация цикла с голосованием совета жителей.

**Диетсестра (или завхоз при её отсутствии).** Раскладка, таблицы замен, пары эквивалентов; перечень для выбора формирует именно диетсестра<sup>2</sup>. Единственная роль, где вариативность добавляет интеллектуальную работу: подбор пар, пересчёт объёмов (раздел 21).

**Врач.** Чаще приходящий; функции — письменно, иначе «висят»: текстуры и ограничения, лекарственно-пищевая таблица, еженедельное чтение журналов отказов и потребления, триггеры веса, освидетельствование по ст. 43<sup>8</sup>.

**Руководитель.** Положение о питании, приказы, обход по чек-листу (раздел 18.5), квартальная панель (раздел 22.4), разговор с учредителем (раздел 38).

#### 28.3. Норма помощи: самая болезненная цифра

Ориентир 1:2 (один работник — не более двух полностью кормимых)<sup>23</sup> для большинства российских учреждений недостижим текущими штатами — и доклад не делает вид, что это решается приказом. Три шага:

- 1. Замер:** сколько кормимых приходится на одного работника фактически на каждом приёме (форма учёта трудозатрат, приложение 26).
- 2. Реорганизация:** все руки на час еды, рассадка по помощи, порядок подачи под готовые руки (раздел 20) — без новых штатов.
- 3. Фиксация дефицита:** разрыв между фактом и ориентиром оформляется числом и выносится учредителю письменно (раздел 38). Молчаливый дефицит — зона риска директора (раздел 33); зафиксированный — предмет компетенции учредителя.

#### 28.4. Обучение: три уровня за три инструктажа

Три сорокаминутных инструктажа с проверкой «на линии»: клинический минимум (дисфагия — раздел 10.3; «3 отказа → врач сегодня»; лекарственно-пищевая таблица — раздел 11) — проверка: фраза на обходе; технология выбора (два варианта, показ неговорящему — раздел 15.5, журналы) — проверка: один обед; санитарный контур (пробы двух вариантов, температуры, маркировка — раздел 18) — проверка: сверка журналов без предупреждения. Содержание по аудиториям — 28.10. Барьер качества — осведомлённость персонала (IDDSI: от 5 до 79 % в разных домах)<sup>43</sup>. Обучение — самая дешёвая точка рычага доклада.

#### 28.5. Мотивация и выгорание

Три механизма. **Видимый смысл** — статистика пилота (раздел 35) до смены, не только до учредителя. **Участие** — повар на дегустации, сиделка в совете, раздающий в разборе жалоб; это лечит «тихий саботаж». **Защита от конфликтов** — письменные правила добавки, порций и замен: решение принимает правило, не человек на линии (раздел 20.4). Мифы — в 28.9.

## 28.6. Типовые ошибки управления

1. **«Приказал — значит внедрил»:** без инструктажа и проверки усвоения приказ производит имитацию.
2. **Нагрузка «в подарок»:** новые процедуры без пересмотра смены — перегруз и откат.
3. **Наказание за данные:** сиделка, оштрафованная за честную запись об отказах, перестанет записывать — система ослепнет.
4. **Изменение без объяснения «зачем»:** персонал, не понимающий смысла выбора, видит в нём только лишнюю работу — и оказывается прав по-своему.

## 28.7. Что сказать старшей смене в понедельник

Письменные роли, включая врача. Замер нормы помощи. Три инструктажа с проверкой на линии. Статистика пилота — до смены, не только до учредителя. В Успенском «страхи персонала не подтвердились»<sup>3</sup> после того, как их озвучили.

## 28.8. Беречь тех, кто кормит

Помощь за столом сталкивается с отказами, агрессией, смертью подопечных — и почти не получает обратной связи. Три жеста: разбор трудных ситуаций без виноватых (кейсы 1–22); конкретная благодарность («ты накормила его вчера, когда он неделю не ел»); фильтр новых форм — «какое решение она меняет» (раздел 31.7). Текучесть смены — налог на качество: новая сиделка не знает карт и темпов; дом с кадровой каруселью кормит хуже при любом меню.

## 28.9. Мотивация без мифов

Два мифа. Денежный: «пока не доплатят, ничего не будет» — опыт внедривших прошёл без доплат<sup>6, 22</sup>; валюта смены — выполнимость: процедура, которая укладывается в смену, выполняется; процедура, добавляющая час на «бумагу», саботируется молча и справедливо. Идеологический: «главное — объяснить про права» — права убеждают руководителей; смену убеждает другое: меньше скандалов за столом, меньше недоеденных тарелок, ясные ответы на «а что мне делать, если...». Ядро инструктажа — не ценности, а кейсы 1–22. Ценности — обязательный фон, но фон не заменяет маршрут.

## 28.10. Три инструктажа: содержание по уровням

Единый «общий инструктаж» не работает. **Кухня (45 минут):** пары эквивалентов и ранговость; маркировка и пробы двух вариантов; IDDSI с тестом вилкой; лекарственно-пищевая таблица на закладке, не в памяти; журнал срывов. **Пост (45 минут):** меню в форматах жителей; журнал заказа при жителе; алгоритмы отказов (приложения 10–11); признаки дисфагии; запрет еды как рычага; помощь в темпе едока. **Администрация (30 минут):** правовая рамка зон (раздел 17); ответ проверяющему (раздел 32); панель чисел. При найме — до первой смены; далее раз в год. Проверка — три вопроса у линии: «если выбранное кончилось?», «кому — о трёх отказах?», «запись вчерашнего заказа».

## 28.11. Трудоёмкость выбора: человеко-минуты, которые нужно знать директору

Страх смены — «это добавит час на каждую раздачу». Цифра другая. **Иллюстративная раскладка** для обеда на отделении 30 жителей в модели М1 (выбор одного приёма 2–3 дня в неделю, раздел 8). Оценки экспертные и аналоги канадского аудита полной стоимости питания (раздел 29.2)<sup>56</sup> — не замеры в российских учреждениях; **собственный замер обязателен** (приложение 25, раздел 22.3).

| Действие                                            | Без выбора (мин) | С выбором М1 (мин) | Доп. нагрузка | Кто делает                 |
|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------|----------------------------|
| Показ меню жителям (визуальное, устное)             | 0                | 3                  | +3            | Сиделка/санитар            |
| Сбор заказа (накануне / в начале смены)             | 0                | 5                  | +5            | Старшая смена              |
| Пересчёт объёмов (по статистике выбора)             | 0                | 4                  | +4            | Диетсестра/завпроизводства |
| Маркировка второй гастроёмкости (загрузка на линию) | 0                | 2                  | +2            | Повар                      |
| Раздача с предложением выбора                       | 30 (60 сек × 30) | 35 (70 сек × 30)   | +5            | Сиделка/раздающий          |
| Запись в журнал заказа (3–5 строк)                  | 0                | 3                  | +3            | Старшая смены              |
| Запись в журнал замен (если были)                   | 0                | 2                  | +2            | Раздающий                  |

| Действие                                                          | Без выбора (мин) | С выбором М1 (мин) | Доп. нагрузка        | Кто делает |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|------------|
| Итого на 30 жителей за обед                                       | 30               | 52                 | +22 минуты           | —          |
| В пересчёте на 1 жителя                                           | 1,0 мин          | 1,7 мин            | +0,7 мин/житель      | —          |
| В пересчёте на 3 приёма пищи (завтрак, обед, ужин) для 30 жителей | 90               | 130–140            | +40–50 минут в сутки | —          |

Доп. нагрузка М1 — около 40 минут в сутки на отделение 30 жителей ( $\approx 80$  человеко-минут в неделю); укладывается в пересменку, если минуты видны. М2–М3: +60–90 минут в сутки; М4 и М5 перестраивают роль персонала. Группа помощи — 2–3 мин/житель. Возражение «нас не хватит» чаще закрывается потоком (раздел 20): предзаказ, визуальное меню, маркировка «вариант А / вариант Б».

Канадский аудит (раздел 29.2): до 45 минут на жителя группы помощи в сутки — **значительно больше** наших 1,7 мин/жителя (там выбор встроен в широкую модель помощи). Прямое сравнение не работает; ориентир: **помощь за столом — самая дорогая строка**.

В таблице нет: (а) повар на второй вариант — 10–20 минут на партию при эквивалентных парах («гречка/рис» одновременно); (б) врач на диетические столы (раздел 19); (в) диетсестра на пары и раскладку (раздел 19.2, раз в квартал — 4–8 часов). Эти позиции — в разделе 29.4; здесь — только линия раздачи.

Цифра для учредителя: **+22 минуты** на обед для 30 жителей в М1. Укладываем в пересменку или заявка на ставку. «Не справимся, потому что страшно» без цифры — не управление.

## 29. Финансовые модели: сколько стоит питание и сколько стоит выбор

### 29.1. Честная рамка: что мы не утверждаем

В прежних версиях стояла формула «вариативность почти бесплатна». Она удалена. Стоимость зависит от модели и измеряется замером: утверждать экономию без данных нельзя, утверждать невозможность — тоже. Раздел даёт инструментарий: три стоимости, пять моделей с их ценой, порядок замера. Все числовые примеры — иллюстративные.

### 29.2. Три стоимости, которые путают

**Сырьевая строка** — продукты на жителя в день. Ориентиры (год и валюта, не нормативы для РФ): медиана \$8,00 AUD (Австралия, Hugo)<sup>90</sup>; Онтарио: \$8,33 CAD, выросшие до \$13,71 CAD после кампании<sup>101, 102</sup>; США: более четверти домов в 2025 году ниже \$10 (ассоциация ANFP, не госорган)<sup>103, 104</sup>. Урок — механизм: во всех трёх странах изменения начались с публикации сырьевой строки<sup>91, 102</sup>.

**Полная стоимость приёма пищи** — сырьё + труд кухни + энергия + амортизация. Канадский аудит: \$27,91–54,85 за жителя в день — в 3–6 раз выше сырьевой строки<sup>56</sup>. Экономия на сырьё при огромной полной стоимости — самая неэффективная экономия системы.

**Стоимость кормления** — время помощников за столом. Те же канадские данные — до 45 минут в день на жителя группы помощи<sup>56</sup>. Самая дорогая и самая скрытая строка: живёт в штатном расписании, не в продуктовом бюджете.

### 29.3. Сырьевая строка: как посчитать свою за час

Формула (приложение 25): расходы на продукты за месяц ÷ число жителей ÷ число дней = руб./житель/день. Три правила: считать только продукты (без труда и коммуналки); сравнивать с собой в динамике и с региональными коллегами, не с зарубежными долларами; публиковать — учредителю и совету жителей: прозрачность строки во всех изученных странах работала на её рост<sup>91, 101</sup>. Если никто в доме не может назвать эту цифру за пять минут — это первая находка аудита (раздел 22).

### 29.4. Пять моделей вариативности и их честная цена

| Модель                                        | Что меняется                        | Цена сырья                     | Цена труда             | Разовые затраты        |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|
| М1. Выбор из двух (завтрак+обед, 2–3 дня/нед) | Вторая гастроёмкость, журнал заказа | ~0 (перераспределение пар)     | +минуты на линии       | Гастроёмкости, маркеры |
| М2. Выбор ежедневно по позициям               | Тот же принцип в полном объёме      | ~0 при пересчёте по статистике | +время раздачи и учёта | Визуальное меню        |

| Модель                             | Что меняется            | Цена сырья                  | Цена труда              | Разовые затраты  |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|
| М3. Буфетная зона (салаты/напитки) | Самообслуживание в зоне | Рост потребления → пересчёт | Контроль зоны           | Стеллажи, посуда |
| М4. Семейная подача (точечно)      | Подача общими блюдами   | ~0                          | Меняется роль персонала | Столовая посуда  |
| М5. «Своя кухня» (реабилитация)    | Программа навыков       | Как у группы                | Персонал-сопровождающий | Кухонная зона    |

*Модельные оценки, не замеры: фактическая цена — семидневный замер до старта и через 90 дней (приложение 25).*

Механизм М1–М2: сырьё не добавляется — **перераспределяется внутри той же строки** через пары эквивалентов (раздел 19.2). Пример: отделение 30 человек, каша гречка/рис — суммарный расход круп тот же, меняется пропорция. *Расчёт иллюстративный; пропорции — статистика выбора.*

### 29.5. Отходы: единственная честная «экономия»

Несъеденная порция — оплаченное сырьё в баке. Выбор снижает долю несъеденного: нелюбимые блюда перестают попадать на тарелку. Но (1) доказательной базы эффекта в наших условиях нет (раздел 27.5); (2) формула доклада — **замер до и после**. Семь дней до пилота и через 90 дней дают собственную цифру. Международные аналоги (снижение остатков при улучшении качества и выбора) существуют<sup>105</sup> и переносятся только как гипотеза. Граммы в рубли — в 29.11.

### 29.6. Каналы денег и разговор с учредителем

Источники изменения продуктовой строки: региональные нормы (пересмотр — компетенция учредителя/региона), экономия отходов (по замеру), пожертвования и целевые программы, буфетная выручка (если предусмотрена уставной деятельностью). Инструмент разговора — пакет из раздела 38: сырьевая строка в динамике, замер отходов, международная механика прозрачности<sup>91</sup>. Австралийский урок: надбавка \$10 AUD дана **в обмен на ежеквартальную отчётность**<sup>91</sup> — такую конструкцию может предложить и российский директор. Скелет презентации — в 29.9.

### 29.7. Ловушка экономии

Питание — худшее место для экономии. Сырьевая строка сжимается → качество падает → растут отходы и недоедание → растут соматические расходы и жалобы → система платит втрое в других строках<sup>56, 90</sup>. Аргумент директору, которому «режут продукты»: стоимость недоедания (пневмонии, госпитализации) против копеек сырьевой строки. Три действия: строка за час, отходы за неделю, дефицит числом учредителю письменно. М1–М2 не требуют новых денег и не обещают экономии до замера. Пропорция «сырьё — меньшая доля» — в 29.10.

### 29.9. Разговор о деньгах с учредителем: скелет презентации

Десять слайдов мысленной презентации (не путать с семинарской): 1) сырьевая строка — руб./житель/день; 2) динамика за год; 3) доля сырья в полной стоимости (методика<sup>56</sup>); 4) отходы в рублях — факт замера; 5) что сделано без денег; 6) эффект — числа до/после; 7) что стоит денег — три позиции с расчётом; 8) цена бездействия (отходы, жалобы, проверки<sup>75</sup>); 9) просимое решение — одно, с датой; 10) что отчётность покажет через квартал. Каждый слайд — число или документ; эмоция в разговоре о деньгах проигрывает счёту всегда.

### 29.10. Ловушка экономии: когда «сократить сырьё» дороже всего

Канадский аудит полной стоимости<sup>56</sup>: сырьё — меньшая часть полной стоимости, труд и инфраструктура — большая. Сокращение сырьевой строки — самая заметная и самая вредная экономия: бьёт по жителям, экономит меньшую долю, производит скрытые издержки (вес, здоровье, жалобы, проверки). Обратная стратегия — эффективность большой доли (поток, трудозатраты, отходы) при стабильной сырьевой строке. Поэтому публикация строки (раздел 29.3) — защита жителей: видимая строка сопротивляется сокращению лучше невидимой<sup>91, 101</sup>.

### 29.11. Отходы: как замер превращается в рубли

Замер (приложение 25) даёт граммы на порцию; топ-3 блюд по остаткам сверяются с циклом: уходят, уменьшаются или заменяются парой. Перевод: масса недельных отходов × цена килограмма по фактуре. Три правила: отходы не равны нулю нигде; тарелочные остатки — вкус, размер порции, состояние жителей, кухонные — планирование объёмов; снижение после выбора — гипотеза, которую подтверждает только повторный замер через 90 дней. Иллюстрация (не замер): дом на 150 жителей, 80 г на порцию, 3 приёма — 36 кг в день; при условных 250 руб./кг — порядка 9 000 руб. в день потенциала. Дом-тысячник (Серафимовский — 1 004 проживающих на февраль 2026, кейс 25.5) при тех же 80 г и трёх приёмах — **240 кг в день, порядка 60 000 руб./день условного потенциала**. Цифры условные — порядок действий настоящий.



Если учреждение готовит на своей кухне — модели М1–М5 выше. Если питание на аутсорсинге — контрактные риски, восемь строк ТЗ и приёмка: раздел 42.

## 30. Закупки продуктов: 44-ФЗ без кошмаров

### 30.1. Рамка раздела

Закупка продуктов для казённого и бюджетного стационара, как правило, идёт по 44-ФЗ. Для автономного учреждения режим зависит от положения о закупке: часть операций — по 223-ФЗ, субсидия на госзадание нередко остаётся в контуре 44-ФЗ — зона юриста, не формула «всем 44-ФЗ». Два риска: формальный (процедура) и антимонопольный (картель поставщиков или обвинение в ограничении конкуренции). Доклад не заменяет контрактного управляющего; раздел — стык закупки с питанием и то, где директор обязан быть грамотным лично.

### 30.2. Продуктовая рамка: что нужно знать директору

Три принципа. Первый: **объект закупки — продукты по спецификации**; качество спецификации определяет стол сильнее, чем качество повара. «Крупа гречневая, ГОСТ, ядрица, не ниже первого сорта» и «крупа» — две разные столовые. Второй: **пропорции внутри спецификации — инструмент вариативности**: пары эквивалентов (гречка/рис, курица/рыба) закладываются в закупку заранее, по статистике выбора (раздел 21); вариативность, не заложенная в план, умрёт на складе. Третий: **сроки и партии** важнее экономии на цене — срыв одной позиции ломает раскладку и таблицы замен.

### 30.3. Антимонопольная зона: практика ФАС

ФАС раскрыла картель на торгах по поставке социально значимых продуктов — 543 торга на 4,7 млрд рублей (Москва, Московская область, Владимирская область, Дагестан; 2024)<sup>75</sup>; в Челябинске — картель на 27 тендерах школьного питания 2022–2024, штраф 5,1 млн и уголовное дело по ст. 178 УК (2025)<sup>76</sup>. Три вывода для директора-заказчика:

1. **Картель бьёт по качеству и цене стола** — заказчик, замечающий признаки согласованности (одни и те же компании с «подставными» заявками, цены «с потолка»), обязан сообщать в УФАС: это защита жителей, не доносительство.
2. **Заказчик тоже в зоне риска**: избыточные требования («поставщик с опытом работы именно с нашим учреждением», товарные знаки без «или эквивалент») — состав ограничения конкуренции.
3. **Документируйте качество поставок**: акты приёмки, брак, возвраты — санитарный контур (раздел 18) и база для претензий поставщику и для УФАС.

Практика ФАС — по публичным сообщениям; для конкретных решений нужно заключение контрактной службы/юриста. Признаки в своих торгах — в 30.7.

### 30.4. Закупка и вариативность: стыковка

1. Статистика выбора за 2–3 месяца (раздел 21) → пропорции пар в спецификации.
2. Сезонность и праздничное меню → корректировка квартальных объёмов (совет жителей, раздел 34).
3. Таблицы замен → «запасные эквиваленты» в спецификации на случай срыва поставки.
4. Малые партии скоропорта → график поставок, не склад.
5. Раз в год — пересмотр спецификации по замеру отходов (приложение 25): что стабильно не съедается, уходит из закупки законно, через таблицы замен<sup>11, 12</sup>.

### 30.5. Аутсорсинг питания: за и против честно

Аргументы «за»: профессиональное производство, санитарная дисциплина, снятие нагрузки. «Против» — знать до контракта: потеря гибкости, зависимость от контракта, разрыв «житель — кухня». Вариативность закладывается в ТЗ (два варианта, текстурные линии, журналы выбора, дегустации) — не вписанная, от аутсорсера не дожидаться. *Рекомендация, не норма.*

Директор не обязан быть закупщиком. Обязан: спецификация определяет стол; вариативность в плане закупок по статистике; признаки картеля и канал в УФАС; приёмка; при аутсорсинге — выбор в ТЗ. Пять пунктов, не погружение в 44-ФЗ.

### 30.7. Картели: что директор обязан знать, не будучи юристом

Цифры масштаба — в 30.3 (543 торга / 4,7 млрд; Челябинск: 27 тендеров, штраф 5,1 млн)<sup>75, 76</sup>. Директор — не следователь. Три признака в своих закупках: одни и те же два-три поставщика поочерёдно «выигрывают» с близкими ценами годами; снижение от начальной цены ритуально мало (доли процента); «проигравший» в этом торге побеждает в соседнем с тем же раскладом. Один признак — не доказательство; устойчивая картина —

основание информировать учредителя и, при его согласии, обратиться в ФАС (анонимность заявителя законом предусмотрена). Карфельная закупка — скрытый налог на сырьевую строку; разговор «дорого варить два варианта» иногда стоит начинать не с кухни, а с цен закупки.

### 30.8. Спецификация под вариативность: пять строк, которые всё решают

Новых законов не нужно — нужны пять строк. **Перечень:** позиции как группы взаимозаменяемых («крупы гарнирные: гречка, рис, пшено»), не монопозиция — пары легальны на уровне контракта. **Пропорции:** объёмы внутри группы по статистике выбора с правом корректировки раз в квартал без изменения сути контракта (в пределах допустимых 44-ФЗ изменений). **Замены:** при недопоставке — эквивалент из той же группы по согласованию, с актом. **Качество:** характеристики, значимые для текстур (помол, консистенция полуфабрикатов), — иначе дисфагический контур заложник «самого дешёвого фарша». **Приёмка:** ответственный и форма акта — без этой строки претензии превращаются в обиды. Каждая строка согласуется с контрактной службой заранее; конфликт «меню против контракта» — симптом того, что меню меняли, а спецификацию нет.

*Аутсорсинг (223-ФЗ или 44-ФЗ на услугу питания) — другая механика: восемь строк ТЗ, контроль приёмки, привязка к меню. Раздел 42, особенно 42.3 и 42.7.*

## 31. Документальный комплект: как практика становится системой

**БЛОК 1.8. ДОКУМЕНТЫ, РИСКИ, СТРАТЕГИЯ: ДОКУМЕНТЫ, ПРОВЕРЯЮЩИЙ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, СОВЕТ, ПИЛОТ, КАРТА, ВОЗРАЖЕНИЯ, УЧРЕДИТЕЛЮ, ОТРАСЛИ, СЕМИНАР, ДОСТОВЕРНОСТЬ, АУТСОРСИНГ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, БИБЛИОГРАФИЯ (31–44)**

### 31.1. Зачем документы, если практика уже работает

Устная договорённость «у нас два варианта» живёт до первого проверяющего, конфликта с родственником или ротации. Комплект закрепляет границы, распределяет ответственность по фамилии и делает практику воспроизводимой. Собрано из разделов 17–30; шаблоны — приложения 1–36, все — **проекты локальных форм.**

### 31.2. Шесть базовых документов

**1. Положение об организации питания** (локальный акт). Нормативная база (3185-1 ст. 43, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и с 01.09.2026 — СанПиН 2.3/2.4.4282-26, приказ Минтруда 520н — нормы рекомендованные, если регион не императивен)<sup>8, 9, 29</sup>; структура питания; роли; учёт индивидуальных потребностей. Утверждается директором, согласовывается с учредителем по регламенту региона.

**2. Раздел о вариативности** в положении или отдельный порядок. Перечень позиций с выбором; механизм заказа (журнал, визуальное меню); гарантия стандартного варианта («никто не остаётся без полноценного приёма пищи»); правило замен; связь с лечебным питанием через «мост» (раздел 24).

**3. Меню с вариантами.** Двухнедельное или четырёхнедельное (международный ориентир цикличности — 21–28 дней<sup>23, 31</sup>; в РФ императива цикла для СОСО нет — региональные требования собирайте локально). Каждая вариативная позиция — пара эквивалентов с нутриентным обоснованием (раздел 19).

**4. Журналы заказа и замен.** Два журнала или один совмещённый. Второй важнее: доказательство нормы об альтернативе при отказе — в США прямо<sup>35</sup>, в РФ выводится из ст. 37 3185-1 в связке со ст. 43<sup>8</sup> (толкование — раздел 17).

**5. Пищевые карты жителей.** Не медицинская карта: предпочтения, запреты, текстура (IDDSI при показаниях)<sup>42</sup>, помощь, лекарственные ограничения (раздел 11). Формат — приложение 7; источники — наблюдение, житель, близкие, врач по иерархии раздела 15.

**6. Согласование с учредителем.** Письмо-отчёт о пилоте с панелью 12 чисел (раздел 22) до и после. Изменения через учредителя переживают проверки; изменения «тихо» — не всегда<sup>3, 4</sup>.

### 31.3. Три клинических документа

**7. Лекарственно-пищевая таблица** (раздел 11, приложение 21): пять правил взаимодействий с классами уверенности. Подпись врача; кухня и постовая; обновление при смене назначений.

**8. Список дисфагического риска** (раздел 10, приложение 21): жители с признаками, уровень текстуры, приём «два обученных человека на посту»<sup>1</sup>. Врачебный документ — ведение делегируется старшей сиделке.

**9. Журнал отказов** (раздел 12, приложение 9): дата, приём пищи, обстоятельства, действия. Три отказа подряд — врач в тот же день.

### 31.4. Три управленческих документа

**10. Приказ об ответственных:** за питание в целом, за вариативную линию, за журналы, за связь с врачом. Без фамилий комплект не работает.

**11. Регламент совета жителей по питанию** (раздел 34, приложение 30): состав, периодичность, полномочия (меню, дегустации, пожелания), форма доведения решений до администрации.

**12. Квартальная панель** (раздел 22, приложение 35): 12 чисел на одном листе — от отходов до доли выбирающих. Не отчётность наверх, а самопроверка.

### 31.5. Учётная форма: что сказать честно

Учёт продуктов в СОСО — формы по приказу Минфина 52н; переход на электронные формы поэтапно через приказы 61н, 142н, 100н, 157н, 174н<sup>106</sup>. Не называйте конкретную форму «обязательной для вас», пока это не подтвердил учредитель или региональный орган: статус форм менялся не раз. Журнал заказа живёт рядом с любой учётной формой, не вместо неё.

Двенадцать документов — один пакет, не библиотека. Соберите за неделю из приложений 1–36, подпишите приказ, покажите учредителю — практика перестанет зависеть от того, кто сегодня стоит у раздачи.

### 31.6. Порядок сборки комплекта за неделю

Пять дней, если приложения 1–38 — заготовки. День 1: приказ об ответственных и приказ о пилоте (приложения 17, 28). День 2: положение о питании с разделом о вариативности (приложение 29); 60 % текста — из заготовки. День 3: клинический блок с врачом — таблица, список риска, журнал отказов (приложения 21, 9); без подписи врача день не заканчивать. День 4: журналы заказа/замен/срывов, меню с парами, карты первой очереди (группа риска и неговорящие — первыми). День 5: регламент совета (приложение 30), панель (приложение 35), письмо учредителю. Проверка: новый сотрудник понимает действия за час? папка отвечает на три вопроса раздела 32? Два «да» — комплект работает.

### 31.7. Когда документов слишком много

Антипаттерн — раздувание: положение на сорока страницах, журналы на двенадцати графах, карты на шести листах. Признак: форма не заполняется в ритме смены. Каждая графа обязана отвечать «какое решение принимается по этой графе»; графа без решения удаляется. Лучший комплект — самый короткий из полностью работающих: проверяющему нужна доказуемость, смене — выполнимость; общий знаменатель — краткость.

### 31.8. Жизненный цикл документа: пересмотр

Документ без даты пересмотра стареет молча. Меню и пары — по циклу пересчёта (раздел 21.9); лекарственно-пищевая таблица — при каждой смене назначений и не реже раза в квартал; список риска — ежемесячно; положение — раз в год (учётные формы меняются этапами<sup>106</sup>); панель — ежеквартально. Ответственный за актуальность — в приказе об ответственных, одной строкой на документ. Вопрос на обходе: «когда это менялось последний раз»; документ, не менявшийся год в живой системе, либо мёртв, либо система неживая.

## 32. Как отвечать проверяющему: сценарий диалога без страха

### 32.1. Почему этот раздел отдельно

Главный барьер — фраза «придут и спросят». Страх реальный, но размытый. Раздел даёт сценарий. Основа — административные дела<sup>75,76</sup> и надзорные документы<sup>10</sup>; не консультация юриста по делу.

### 32.2. Кто приходит и что проверяет

**Роспотребнадзор** — санитария: на дату семинара СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 7.1.11–7.1.14; с 01.09.2026 — СанПиН 2.3/2.4.4282-26, п. 56 подп. 11–14 (питание проживающих не менее 3 раз в день, в том числе диетическое по показаниям; суточные пробы)<sup>9</sup>. Вопросов «почему два варианта» нет — есть вопросы о температуре, маркировке, суточных пробах, поточности. Вариативность входит как дополнительная линия, не как новый объект (раздел 18).

**Соцзащита / учредитель** — стандарты и нормативы региона, расходование средств, жалобы. Защита — документы: согласование, меню с эквивалентами, журнал замен, панель чисел (раздел 31).

**Прокуратура** — по жалобам, чаще о правах жителей. Опора — ст. 37 и 43 закона 3185-1<sup>8</sup>. Вопрос «были ли нарушены права»; журнал отказов и документированный выбор — ответ, не уязвимость.

### 32.3. Три вопроса и три ответа

«Почему не по утверждённому меню?» Варианты — часть меню; пары эквивалентов нутриентно равноценны; перечень согласован. Если региональное меню императивно — сначала меняется региональный документ, потом

практика (раздел 24). Красная линия: при императивном меню «два варианта» без изменения документа — нарушение, и доклад этого не советует.

«Где гарантия, что житель получил норму?» Журнал заказа и журнал замен: каждый получил выбранное, либо стандартное, либо зафиксированную замену. В США альтернатива при отказе закреплена федерально<sup>35</sup>; в РФ выводится из права на уважение человеческого достоинства (ст. 37 в связке со ст. 43)<sup>9</sup> — журнал превращает толкование в доказательство.

«Кто разрешил?» Приказ директора и отчёт учредителю. Внедрившие шли этим путём<sup>6, 22</sup>.

#### 32.4. Чего не говорить проверяющему

Не говорите «так теперь везде» (неправда и не аргумент). Не говорите «нам диетолог разрешил» (должности может не быть в штате — уязвимость, не защита). Не говорите «жители сами захотели» без документа (устная воля не проверяема; пищевая карта и протокол совета — проверяемы). Каждая устная фраза — с бумажным двойником из комплекта раздела 31.

#### 32.5. Если замечание всё же выписано

Зафиксировать формулировку точно. Запросить норму, на которую ссылаются (немотивированные отсылки к «нарушению порядка» разваливаются при запросе конкретики)<sup>75</sup>. Подключить учредителя на стадии возражения, не после постановления. При штрафе — перспектива обжалования с юристом. Данных о процентах отменённых замечаний по вариативному питанию нет — тема в судебной практике не выделена; статистику не выдумывать.

Комплект — до старта пилота (раздел 35), не после первого звонка из надзора.

#### 32.6. Досье проверки: папка, которая отвечает за вас

Папка «Питание: проверки» — заранее, у заместителя, не в сейфе. Состав: приказы (питание, пилот, ответственные); положение с разделом о вариативности; меню с парами и обоснованием эквивалентности; журналы за квартал (заказ, замены, отказы, срывы); санитарный блок (пробы, температуры, паспорт второй гастрорёмкости — раздел 18.9); клинический блок (таблица, список риска — подписи врача); панель чисел; переписка с учредителем; протоколы совета. Десять разделов — на десять вопросов; ответ за минуту меняет проверку из допроса в сверку. Актуальность — квартал; прошлогодние журналы хуже отсутствия папки.

#### 32.7. Поведение при проверке: пять правил

Отвечать на заданный вопрос, без экскурсии — лишнее порождает новые вопросы. Факты — документом, не словом; «у нас ведётся журнал» без журнала — антиответ. Не спорить в коридоре: несогласие письменно после; коридорный спор проигрывается всегда, письменное возражение — иногда выигрывается. Фиксировать ход своей записью (кто, что спросил, что показано) — основа возражений. Не подписывать акт с формулировками, которых не понимаете: оговорка «с формулировкой не согласен, возражения будут представлены» сохраняет позицию; молчаливая подпись её хоронит.

### 33. Ответственность директора: честная карта рисков без запугивания

#### 33.1. Принцип раздела

Ответственность подают запугиванием («посадят за всё») или успокоением («ничего не будет»). Оба мешают решениям. Карта: какие составы применялись по «пищевым» сюжетам, какие существуют на бумаге, как вариативность меняет риск-профиль. Обзор практики, не юридическое заключение.

#### 33.2. Что реально применялось: КоАП ст. 6.6

Статья 6.6 КоАП — нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах. Публичные дела: штраф СРЦ «Кашинский» (2022, качество питания)<sup>10</sup> и Зеленогорский ДИПИ (2021, ТАСС)<sup>10</sup>. Оба — о качестве и достаточности, не о вариативности. Дел о «двух вариантах» в публичном поле нет — «данных нет», не доказательство безопасности.

Постановление ВС РФ от 21.02.2019 № 11-АД19-4<sup>21</sup>: дом-интернат не организация общепита — питание проживающих как социальная услуга, не реализация населению. Квалификация защищает от чужих норм об общепите, не отменяет СанПиН. Защита — след: меню, акты, журналы.

#### 33.3. Уголовные составы: где граница реальности

УК ст. 238 (услуги, не отвечающие требованиям безопасности), 285/286 (злоупотребление и превышение полномочий), 293 (халатность) формально применимы к руководителям. Публичных дел против директоров ПНИ именно по организации питания в проверке не обнаружено. Градиент: жалобы и прокурорские представления

(часто) → административные дела по 6.6 (реже, но есть) → уголовные составы (по пищевым сюжетам — не выявлено в публичной практике). Запугивание уголовными статьями — недостоверная риторика; игнорирование административного контура — легкомыслие.

### 33.3а. Качественная шкала риска (без выдуманных вероятностей)

«Дел о двух вариантах не найдено» — **не «низкий риск»**, а **непроверенная зона**: нет публичных дел ≠ нет дел. Состав 6.6 карает за **качество и достаточность**, не за число блюд; вариативность не создаёт нового состава и не защищает от старых. Риск — по документальному следу. Числовых вероятностей **нет**. Карта ниже: частота в **публичной** практике (не прогноз для дома), тяжесть, что двигает риск.

| Вектор                              | Частота (публичная практика)                        | Тяжесть                                | Повышает                                    | Снижает                                            |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Жалоба жителя/родственника          | высокая (массовый повод — «невкусно, не ем»)        | низкая сама по себе                    | молчаливая раздача без записи               | журнал выбора и замен, совет жителей (разд. 34)    |
| Прокурорское представление          | средняя                                             | низкая–средняя (устранение + контроль) | жалоба, проигнорированная неделями          | регламентный разбор в дни (прил. 34)               |
| Административное дело 6.6 КоАП      | низкая, но реальная — о качестве/достаточности      | средняя (штраф должностному лицу)      | недоброкачественные продукты, имитация проб | пробы, бракераж, температурный контур, меню и акты |
| Уголовные составы (238/285/286/293) | по пищевым сюжетам в публичной практике не выявлено | высокая, но крайне редкая              | системное бездействие при известном вреде   | работающий контроль и своевременная реакция        |

**Вариативность не добавляет ни одной строки в этой таблице.** Она перераспределяет жалобу из «невкусно» в «я выбрал сам» — если выбор задокументирован. Без документов **утяжеляет** вектор 6.6: «два варианта без записи» читается как «отступление от меню».

### 33.4. Как вариативность влияет на риск: два направления

**Снижает.** Жалобы — невкусно, однообразно, «не ем это». Документированный выбор снимает массовый повод; журнал замен закрывает «оставили голодным»; совет жителей (раздел 34) делает жалобщиков соавторами меню. Нормы о выборе в США, Онтарио, Австралии — защита прав; проверяющие оценивают дома по их исполнению<sup>35, 23, 34</sup>.

**Создаёт риск при плохом исполнении.** Два варианта без документов = «отступление от меню»; замена без записи = «не докормили»; выбор без связи с лечебным питанием = риск для диет. Риск-профиль — в документальном контуре (разделы 31–32). Шкала — в 33.3а.

### 33.5. Личная ответственность: три правила сна директора

Первое: решения о вариативности — коллегиальные и документированные (приказ, протокол совета, согласование с учредителем). Единоличное устное распоряжение — самый уязвимый формат. Второе: клинические границы определяет врач; директор отвечает за исполнение назначений, не за их содержание (дисфагия, взаимодействия, диеты — разделы 10–11). Третье: жалоба — сигнал системы, не личная атака; регламент разбора (приложение 34) снимает роль «бьющегося за каждый эпизод» и возвращает роль управляющего системой. Директор отвечает за систему контроля, не за каждое событие за столом.

Риск вариативности с документами ниже риска бездокументной монотонности. Считайте риск по документам, не по страшилкам.

### 33.6. Страховка вместо страха: что реально снижает личный риск

Четыре элемента значимее намерений<sup>75, 76</sup>. **Коллегиальность**: приказ + протокол совета + уведомление учредителя. **Клиническая делегация**: каждый клинический документ подписан врачом; подписавший таблицу взаимодействий сам принял чужой риск даром. **Скорость**: разбор жалобы в дни (приложение 34) — «прокурорские» сюжеты растут из жалоб, проигнорированных месяцев. **Честность статусов**: документ-проект не даёт претензии «самоуправство»; документ, изображающий нормативность, которой нет, — даёт. Риск определяется качеством следа, не смелостью изменений.

### 33.7. Психологическая цена вопроса — и её управление

Страх ответственности — главный тормоз; документами он снимается не полностью. Три приёма: разделить риск; ограничить первый шаг (пилот отделения, не дома); дата пересмотра (эксперимент, не «навсегда»). Задача раздела не «не бояться», а сделать так, чтобы бояться было нечего конкретно.



## 34. Права жителей и совет жителей: от объекта заботы к соавтору меню

### 34.1. Правовая рамка без натяжек

Права жителей СОСО закреплены: ст. 37 закона 3185-1 (уважение человеческого достоинства, гуманное обращение) распространяется на проживающих через ст. 43<sup>8</sup>. Конвенция о правах инвалидов — ст. 28 (достаточный жизненный уровень и питание) и Замечание общего порядка № 1: поддержка правоспособности требует узнавать волю и предпочтения человека, а не решать «за него»<sup>77, 26</sup>. Конструкции «права на выбор блюда» в российском законе нет — честная серая зона (раздел 17): выбор внедряется как способ реализации уже существующих прав, не как новое право из ниоткуда.

### 34.2. Три модели участия жителей

**Информационная:** извещение о меню (доска, раздатка, визуальное меню). Минимум за неделю; участие без влияния.

**Консультативная:** опросы предпочтений, дегустации, «ящик пожеланий». С опроса начинала Усть-Илимская организация<sup>4</sup>. Влияние есть, ритм задаёт администрация.

**Институциональная:** совет жителей (по образцу ДДСОЛ: совет по питанию — постоянная структура с распорядительным документом от 13.04.2017)<sup>22</sup>. Совет обсуждает меню до утверждения, проводит дегустации, собирает и ранжирует пожелания, получает отчёт о судьбе пожеланий. Единственная модель, где участие переживает смену заведующих отделениями.

### 34.3. Совет жителей: как собрать работающий, а не декоративный

**Состав.** 5–9 человек: жители (включая недееспособных — интересы представляют выбранные ими лица или члены совета по регламенту), сиделка, повар, врач (совещательный голос). Квоты по отделениям, иначе совет — клуб самого активного корпуса.

**Полномочия.** Четыре: обсуждать меню до утверждения; проводить дегустации; собирать пожелания и доводить до администрации; получать ответ в установленный срок. Не включайте то, что администрация не готова исполнять, — декоративный совет хуже отсутствующего: он производит цинизм.

**Ритм.** Ежемесячное заседание с коротким протоколом (приложение 30). Протокол — доказательство для раздела 32: «жители сами захотели» со ссылкой на протокол — проверяемое утверждение.

### 34.4. Недееспособные жители в совете: не исключение, а особый формат

74 % жителей ПНИ по вторичной аналитике — недееспособные<sup>7</sup> (статус данных — раздел 23). Исключить их — исключить большинство. Форматы: представительство через доверенных лиц (не обязательно опекуна-учреждение — конфликт интересов, раздел 16); наблюдательные методы (показ, выбор, реакция — раздел 15) в пищевой карте; ротация «пробных обедов», где реакция — данные для совета. Международные нормы требуют учитывать предпочтения независимо от когнитивного статуса: Австралия, Стандарт 6 с 01.11.2025<sup>34</sup>; Онтарио — обязательный учёт preferences в плане питания<sup>23</sup>.

### 34.5. Конфликт интересов «учреждение = опекун» в совете

Если опекун — учреждение, в совете оно потенциально голосует за жителя. Антидоты из раздела 16: приоритет пищевой биографии над «усреднённым благом»; независимые представители, где они есть; фиксация разногласий в протоколе. Формула для локального акта: «при расхождении позиции администрации с зафиксированными предпочтениями жителя приоритет имеют предпочтения, если они не противоречат назначениям врача».

Совет бесплатен, снимает жалобы до их рождения и превращает «права жителей» в ежемесячную процедуру. Начните с опроса предпочтений — как в Усть-Илимске<sup>4</sup> — и дайте опросу статус протокола.

### 34.6. Первое заседание: сценарий по минутам

Первый совет решает, будет ли второй. Сценарий на 40 минут: **5 минут** — «меню обсуждают те, кто ест»; **10 минут** — четыре полномочия и чего совет не может (врач и СанПиН); **15 минут** — дегустация двух кандидатов с голосованием; **5 минут** — три пожелания; **5 минут** — дата следующего и ответ. Ошибки: чтение положения вслух; обещания вне полномочий; состав «для фотографии». Протокол — три строки: кто был, что решили, кому поручено.

### 34.7. Совет и семьи: граница ролей

Пускать ли родственников. Совет — структура жителей; семьи — отдельный канал (дни открытых дверей, дегустации по приглашению совета, памятка приложения 32). Смешение ролей: говорящие родственники представляют говорящих жителей, молчащее большинство остаётся без голоса. Если житель сам просит

представлять его близкого — это его выбор представителя, не «место для родни». Иерархия источников воли (раздел 15.9): близкие — четвёртый уровень; совет не переписывает иерархию по громкости голоса.

## 35. Пилот на 90 дней: минимальный безопасный старт

### 35.1. Почему 90 дней и почему пилот

«Меняйте всё с понедельника» ломает две вещи. Кухня — поток с жёстким ритмом. Жители ПНИ — люди, для которых предсказуемость среды — часть благополучия (раздел 9). Пилот бережёт обе: меняется одна точка — отделение или приём пищи, — остальное идёт как вчера.

Девяносто дней проявляют статистику выбора (первые две недели — эффект новизны), трудовые издержки и первые конфликты. Усть-Илимск шёл поэтапно: от опроса предпочтений к расширению<sup>4</sup>. Успенский зафиксировал: «страхи персонала не подтвердились» — после пробного периода, не до него<sup>3</sup>.

### 35.2. Дни 1–14: подготовка (без изменений на линии)

**Неделя 1.** Приказ о пилоте (приложение 28): точка, сроки, ответственные, критерии успеха и остановки. Замер «до»: семь дней отходов, времени раздачи, отказов (приложение 25). Без него через 90 дней сравнивать будет нечего.

**Неделя 2.** Опрос предпочтений в точке (приложение 36): житель или представитель отвечает коротко; ответы — в пищевые карты. Параллельно — инструктаж смены раздачи (раздел 28) и письмо учредителю.

### 35.3. Дни 15–75: работа пилота

Минимальный пилот — модель М1 из раздела 29: два варианта второго на обед, 2–3 дня в неделю, заказ вечером накануне или на линии. Стандартный вариант гарантирован всегда. Журнал заказа и журнал замен — с первого дня, не «когда наладится».

Еженедельно — пятнадцатиминутная планёрка: что выбирали, где очередь, какие замены, что говорят жители. Три корзины: смена (очередь, маркировка), кухня (пары, объёмы), администрация (документы, закупка). Третья не должна пустовать больше двух недель: иначе пилот выдыхается.

Если в точке есть ночное едение (раздел 13) — структурированный ночной перекус по согласованию с врачом: самая быстрая субъективная победа.

### 35.4. Дни 76–90: оценка и решение

Двенадцать показателей (приложение 24) «после» против «до»: доля выбирающих, отходы, время раздачи, отказы, замены, жалобы. Число без фразы «что это значит» никому не показывайте (раздел 22).

Совет жителей заслушивает итоги: расширять / оставить точку / свернуть. Протокол — в отчёт учредителю.

Решение директора — одно из трёх, на бумаге: расширение, закрепление точки, свёртывание с причинами. Свёрнутый пилот с причинами — результат, не провал: защищает от следующего «а давайте».

#### 35.4а. Что пилот доказывает, а что нет: дизайн и его границы

Честный дизайн важнее красивого отчёта. Пилот 90 дней проверяет исполнимость и безопасность — не эффект вариативности (раздел 27.5).

«До/после» на одном отделении (20–35 человек, без контроля) показывает: держатся ли два варианта в ритме смены и журналы; не выросли ли отказы и аспирации (на малой выборке важно любое ухудшение); цену сырья, труда и отходов. Не показывает, что именно выбор улучшил отходы, вес, настроение или здоровье: нет ни контрольной группы, ни мощности. Такого исследования в психиатрии не опубликовано (раздел 27.5).

Смещения — вслух. **Хоторн:** ≈2 недели завышены экспериментом; база — до старта, выводы — дни 30–90.

**Сезонность:** летние отходы не переносить на зиму. **Смены:** одна смена-единомышленник, иначе меряете смену.

**Возврат к среднему:** плохой «замер до» улучшится сам; база — семь дней, не один «показательный».

Решение — по осуществимости и безопасности. **Успех:** журналы без срывов, выбор на большинстве приёмов, отказы и риск не выросли, труд в смете — «умеем безопасно», не «выбор доказал пользу». **Свернуть:** рост отказов или аспираций либо неподъёмные трудозатраты (35.5). **Неоднозначно:** ещё 60 дней, чинить пары и поток.

Пилот отвечает: безопасно ли и за какую цену. Не «работает ли вариативность».

### 35.5. Критерии остановки: где линия

Стоп немедленно при трёх сигналах: рост отказов от еды в точке (недоедание важнее любой вариативности — раздел 12); санитарные нарушения новой линии (раздел 18); клинические противопоказания врача. Остальное —

рабочие проблемы: очереди — поток (раздел 20), страхи персонала — инструктаж (раздел 28), «не то выбирают» — пересмотр пар (раздел 19).

Девяносто дней, одна точка, три журнала, двенадцать чисел. Пилот М1 на одном отделении обычно укладывается в текущую смету; полный переход дома может потребовать оборудования и ставок<sup>5</sup>.

### 35.6. Пилот, который «не пошёл»: разбор четырёх исходов

Не каждый пилот заканчивается расширением.

**Тихая смерть:** журналы умерли к 60-му дню. Нет владельца ритма: планёрка отменялась «на недельку» четыре раза. Ритм — в приказе с датами.

**Бунт кухни:** второй вариант невыполним — загрузка плит. Пилот без завпроизводства. Кухня проектирует пары, администрация — рамку.

**Фиктивное оживление:** журналы полны, жители молчат — предзаполнение (кейс 4). Проверка реальности (приложение 24) с 15-го дня.

**Честное свёртывание:** рост отказов или неподъёмные трудозатраты; приказ с причинами. Из четырёх — единственный успех управления: система узнала себя без цены здоровьем. Документ защитит от того же эксперимента через два года.

### 35.7. Масштаб первого пилота: почему меньше — значит быстрее

«Сразу на весь дом» понятно и губительно. Сбой масштаба дома на 300 жителей — сбой системы; в доме-тысячнике тем более. Серафимовский: 1 004 проживающих на февраль 2026, раздел 25.5.

Точка: одно отделение 20–35 жителей, одна смена-единомышленник, один приём пищи. Меньше — проба. Больше — реформа без подстраховки. «Сложный» контингент (группа помощи, неговорящие) предпочтительнее «удобного»: прошедший на сложном масштабируется почти сам; прошедший на удобном ломается о первое сложное отделение — и хоронит тему.

### 35.8. Первая неделя пилота по дням

Главный риск — импровизация.

**День 1:** меню вечером, заказ; утром сверка объёмов до варки; на линии — старшая смена; вечером 10 минут. **День 2–3:** очередь у варианта Б, забытые бирки, «стандартные» без спроса — чинить вечером. **День 4–5:** срывы и замены; проверка реальности (приложение 24) — пять вопросов. **Выходные:** линия молчит, журнал нет. **День 7:** планёрка по трём корзинам.

До семи дней данных ничего не отменять и не «улучшать». Первая неделя — базовая линия, не эффект.

### 35.9. Своя кухня и аутсорсинг: один пилот, две точки входа

Глава 35 — под свою плиту; глава 42 — под спецификацию. Директору с комбинатом нужна таблица, иначе пилот «на линии» начинается в пустоте.

|                            | Своя кухня                                                 | Аутсорсинг                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Дни 1–14                   | Приказ, замер «до», опрос, инструктаж, письмо учредителю   | То же плюс сверка контракта: строки выбора, замен, проб, отчётности (раздел 42.3) |
| Что меняется               | Вторая гастрорёмкость и журнал на линии                    | Поставка двух вариантов и журнал замен поставщика; линия принимает, не готовит    |
| Если контракта ещё нет     | Старт с понедельника                                       | Сначала восемь строк в ТЗ (календарь — раздел 42.7); пилот без строк — декорация  |
| Если контракт уже идёт     | —                                                          | Допсоглашение или претензия по приёмке; не «попросить поваров комбината»          |
| Стоп-сигналы               | Рост отказов, санитарные нарушения, противопоказание врача | Плюс срыв поставки варианта Б и отсутствие суточных проб у учреждения             |
| Понедельник без разрешения | Замер и журнал отказов                                     | Замер, журнал и фото линии без лиц; ТЗ — в график закупки, не в пожелания         |

Публичных кейсов вариативности на аутсорсинге нет. Таблица переносит инструменты доклада, не чужой измеренный опыт. Критерии остановки те же (раздел 35.5): здоровье жителей важнее любой модели кухни.

## 36. Дорожная карта на 12 месяцев: от пилота к системе

### 36.1. Логика карты

Каждый квартал — самостоятельная ценность: остановились — остаётся работающий результат, не недостроенная схема. Сроки — ориентир для дома среднего размера. На 289 мест (средняя расчётная вместимость ПНИ по вторичной аналитике<sup>7</sup>) темп реалистичен; малым — быстрее, многокорпусным — медленнее. Карта — рекомендация, не норматив.

### 36.2. Квартал 1 (месяцы 1–3): безопасный фундамент

Параллельно с пилотом (раздел 35): аудит по 24 точкам (раздел 22, чек-листы приложений 18–21); документальный комплект (раздел 31); инструктажи трёх уровней (раздел 28); лекарственно-пищевая таблица и список дисфагического риска — подписаны врачом. **Результат:** пилот работает, замеры есть, клинические риски под документами. Можно остановиться — уже лучше исходной точки.

### 36.3. Квартал 2 (месяцы 4–6): расширение по горизонтали

Выбор идёт на все приёмы в точке или на соседнее отделение — по готовности смен, не по желанию администрации. Меню пересчитывается по статистике выбора (раздел 21); пары правятся. Запуск совета жителей (раздел 34), если не запущен раньше. **Результат:** вариативность — ежедневная практика в одном-двух отделениях, совет с протоколами.

### 36.4. Квартал 3 (месяцы 7–9): структурные элементы

Буфетная зона (модель М3) там, где позволяют контингент и санитарный контур; семейная подача (М4) точно в группах помощи; закупки — спецификации под парные позиции (раздел 30). Первый квартальный отчёт учредителю с панелью чисел. **Результат:** система затронула закупки и пространство, не только линию. Точка невозврата пройдена.

### 36.5. Квартал 4 (месяцы 10–12): масштабирование и закрепление

Решение о масштабе на всю организацию — по данным трёх кварталов. Положение о питании обновляется целиком; годовой отчёт учредителю; обмен опытом — региональная площадка, семинар, публикация по образцу тех, кто уже рассказал открыто<sup>3, 4, 6</sup>. **Результат года:** вариативность — норма дома: документированная, измеренная, защищённая перед проверкой.

### 36.6. Три типовых сбоя и их профилактика

«Пилот застрял». Точка работает год без расширения: нет решения по итогам 90 дней. Дата решения — в приказе, в день подписания.

«Ключевой человек ушёл». Практика на одном заведующем. Комплект и ротация: практика переживает людей (раздел 31).

«Учредитель молчит». Просите конкретику: перечень, форму отчёта, дату заслушивания. Молчание — риск раздела 32; снимать до масштабирования.

Каждый квартал — документ и число. Бумага переживает энтузиазм.

### 36.7. Карта при нехватке: три ветки обеднённого сценария

Базовая карта — дефолтные ресурсы. Честность требует веток.

**Нет второй гастрорёмкости** (кейс 22): год — предзаказ и буфет. Лестница — «максимум для этой инфраструктуры», не маска полной вариативности. Реконструкция — отдельной повесткой ежегодно.

**Нет ставок на помощь** (кейс 21): самостоятельность и приоритет риска; трудозатраты — в запросы ежеквартально; вариативность — позиции без дополнительной помощи.

**Учредитель против:** замеры и документы без смены линии; база — на следующий цикл; региональная группа семинара — внешний аргумент (раздел 40).

Обеднённый сценарий — другой маршрут, не урезанный базовый. Отличие — темп.

### 36.8. Как карта умирает: предупреждение по датам

Смерть карты по расписанию. Квартал 1 — молча: пилот «не дошёл». Квартал 2 — громко: конфликт с учредителем, тема «до лучших времён». Кварталы 3–4 — тихо: «и так сойдёт».

Предохранители. Первый — публичный старт: приказ с датами читает коллектив. Второй — ответы раздела 38 и региональная группа. Третий — победа квартала вслух: совету — число, коллективу — результат. Без предохранителей карта — пожелание.

## 37. Четырнадцать возражений и честные ответы на них

### 37.1. Как устроен раздел

Возражение — в редакции, близкой к тому, как его произносят. Издёвки нет: в большинстве есть рациональное ядро. Где данных нет — сказано прямо.

**1. «Наши жители не способны выбирать».** Часть жителей не выбирает вербально. Выбор — каналы, не анкета: показ, наблюдение, биография, близкие (раздел 15). Австралийский Стандарт 6 с 01.11.2025 требует учитывать предпочтения независимо от когнитивного статуса<sup>34</sup>. Где и наблюдение молчит — стандартный вариант: выбирать, чтобы поесть, не обязательно.

**2. «Будут очереди и хаос на раздаче».** Время выбора реально. Поток решается конструкцией: заказ накануне, визуальное меню до линии, маркировка (раздел 20). Успенский опыт: «страхи не подтвердились»<sup>3</sup>. Замер времени «до/после» покажет вашу правду.

**3. «Это дорого».** Неизвестно, пока не замерено. Сырьевая строка при парных эквивалентах близка к нулю (раздел 29), труд растёт на минуты, отходы могут падать. «Вариативность бесплатна» — недоказанное утверждение, и я его не повторяю. Семь дней замера отвечают точнее дискуссии.

**4. «Санэпид не разрешит».** СанПиН 3590-20 (с 01.09.2026 — 4282-26) регулирует поточность, температуру, пробы — не число вариантов<sup>9</sup>. Вторая гастроёмкость — тот же контур, одна точка маркировки (раздел 18). Замечание санврача — конкретика, не фольклор.

**5. «У нас нет диетолога».** Правда для большинства домов — и не препятствие. Пары строятся по нутриентной логике меню-раскладки (раздел 19), клинику решает врач. Диетолог ускоряет; его отсутствие не отменяет ни нормы, ни практику внедривших<sup>3,4</sup>.

**6. «Жители будут выбирать нездоровое».** Пара эквивалентов — выбор внутри нормы, не между нормой и вредом (раздел 19). «Гречка или рис» не создаёт свободы «гречка или конфеты». Пределы задаёт меню.

**7. «А если выбрал, а потом отказался?»** Журнал, альтернатива, фиксация (разделы 12, 19). Норма об альтернативе при отказе — федеральная в США<sup>35</sup>; у нас — выводимая из ст. 37/43 с документированием<sup>8</sup>. Эпизоды неизбежны; неизбежность — предмет журнала.

**8. «Лечебное питание несовместимо с выбором».** Совместимо через «мост»: региональные акты связывают СОСО с системой диет (распоряжение 19РВ-32 в ДДСОЛ)<sup>22</sup>, внутри диеты тоже есть пары. Диета ограничивает множество, не сжимает его до одного элемента.

**9. «Персонал против».** Против обычно не выбор, а непонятная надбавка к работе. Инструктаж по трём уровням, роли в приказе, ритм планёрок. Персонал проектирует линию, а не узнаёт о ней из приказа (раздел 28).

**10. «Проверка спросит — что ответим?»** Документом. Раздел 32 — три типовых вопроса и три документальных ответа. Страх проверки лечится комплектом, не отказом от практики.

**11. «Это всё для маленьких прогрессивных домов, у нас 400 мест».** Практики внедрены в ПНИ стандартной вместимости<sup>3,4</sup>; Иркутская область масштабировала модель регионально<sup>6</sup>. Масштаб меняет логику (поточность, заказ накануне), не принцип.

**12. «Зачем, если и так нормально?»** «Нормально» чьими мерками? Семидневный замер отходов и журнал отказов за неделю покажут. Если после замера всё подтвердится — доклад дал инструмент проверки, не только изменений.

**13. «Кухня не своя — нам не из чего выбирать».** Без своей плиты директор меняет спецификацию, не «добавляет кастрюлю». Вариативность на аутсорсинге — восемь строк контракта (раздел 42). Контракт идёт без строк — пилот с допсоглашения и приёмки. Контракт впереди — осенний календарь (раздел 42.7). Публичных кейсов на аутсорсинге нет — пробел, не невозможность.

**14. «Через четыре дня новый СанПиН — не время экспериментировать».** 01.09.2026 4282-26 вступает целиком, перехода нет<sup>9</sup>. Меняются формы бракеража и привязка ППК, не запрет числа вариантов. Журналы августа не переписывать; с 1 сентября — новые формы (раздел 18.10, приложение 39). Обе редакции выбор допускают. Проверка в сентябре смотрит сентябрь по новым правилам, август — по старым.

Двенадцать возражений снимаются документами, замерами, линией. 13-е — спецификацией. 14-е — чек-листом 1 сентября. «Зачем» — только своими данными. Начните с замера.

### 37.2. Риторика спора: как не проиграть правое дело

Три приёма губят аргумент в зале.



**Моральное превосходство:** «достоинство» в ответ на вопрос о деньгах. Зал слышит: «денег нет». Сначала механика (замер, пары, поток), потом смысл.

**Зарубежный аргумент без фильтра:** «в Онтарио диетолог 30 минут на жителя». Зал слышит чужие деньги. Подача: «время специалиста нормируется; минуты считаем сами».

**Обещание результата:** «отходы упадут на треть». Не упадут у слушателя — тема мертва. Замена: «замер покажет вашу цифру; вот дома, где после выбора замеряли»<sup>3</sup>.

Принцип + метод проверки + чужой измеренный факт. Веры не требует.

### 37.3. Возражение–лакмус: «а сами бы вы так ели?»

Самое короткое — тест на честность. Оправдания («для жителей нормально») — признание двух сортов. Процедура: руководство пробует еду с линии (тарелка, не папка), совет дегустирует, дегустации в протоколе. Кто не ел свою еду в этом месяце, спорить о качестве не вправе — обязан пойти и поесть. Ноль рублей. Чек-лист директора (приложение 18) — одна строка.

## 38. Десять вопросов учредителю: повестка для разговора наверх

### 38.1. Зачем этот список

Большинство решений в СОСО упираются не в закон, а в региональный контур: статус норм, меню, формы учёта, финансирование (раздел 24). Директор спрашивает «можно ли нам» и получает «не надо». Десять вопросов превращают разговор из просьбы в инженерную задачу. На каждый можно ответить документом.

### 38.2. Вопросы о нормах и документах

1. **Каков статус рекомендованных норм Минтруда (приказ 520н) в нашем регионе** — рекомендация или основа императивного регионального норматива?<sup>29</sup> От ответа — свобода манёвра по парам эквивалентов (раздел 19).
2. **Утверждено ли в регионе собственное перспективное меню для СОСО — и какова процедура внесения изменений?** При императивном меню вариативность начинается с документа, не с линии (раздел 24).
3. **Есть ли акт, связывающий СОСО с системой лечебного питания** (образец — распоряжение 19РВ-32)<sup>22</sup>? Если нет — готов ли учредитель инициировать его или санкционировать локальный «мост»?
4. **Какая форма учёта продуктов признаётся актуальной** — с учётом перехода на электронные формы по приказам Минфина<sup>106</sup> — и допускает ли она журналы заказа и замен как приложения?

### 38.3. Вопросы о финансах и закупках

5. **Как устроена сырьевая строка нашего финансирования** — и можем ли публиковать её внутри системы (учредителю и совету жителей) по итогам квартала? Прозрачность строки работает на её адекватность<sup>91, 101</sup>.
6. **Допускает ли действующий контракт (или типовая документация) парные позиции и закупку по статистике выбора** — или спецификации придётся менять при следующей закупке (разделы 30 и 42.7)?
7. **Как в регионе относятся к аутсорсингу питания — и если он у нас, включает ли контракт вариативность, текстуру и документирование замен?** Без этих строк подрядчику уходят не только кухня, но и права жителей (разделы 30 и 42).

### 38.4. Вопросы о полномочиях и развитии

8. **Согласен ли учредитель на пилот по модели раздела 35** — одна точка, 90 дней, панель чисел — с заранее оговорённой датой заслушивания? Просьба с датой — просьба о решении, не о благословении; на неё легче ответить «да».
9. **Готов ли регион к обмену практиками** — и поддержит ли публичный рассказ о нашем опыте по образцу уже опубликовавших<sup>3, 4, 6</sup>? Рассказанное труднее тихо отменить.
10. **Что учредитель считает показателями качества питания** — и готов ли включить долю выбирающих и уровень отходов? Вопрос переводит вариативность из «инициативы директора» в «показатель системы».

### 38.5. Как вести сам разговор

Три правила. Вопросу — одностраничная справка (приложение 33). Первая повестка — 1, 2 и 8. Ответы письменно, хотя бы служебной запиской: позиция учредителя — половина защиты (раздел 32).

У учредителя есть то, чего нет у директора: право менять региональные документы. Десять вопросов — дать ему эту работу.

### 38.6. Если ответ «нет»: три уровня отказа и работа с каждым

Отказ — диагностика.

**Ресурс** («нет денег»): список нулевой стоимости и замеры; деньги — под цифры.

**Риск** («накажут»): документы раздела 32; старт без смены линии — замеры, карты, совет.

**Статус** («не положено»): ссылка на норму. Часто нормы нет — и это уже «не принято», разговор о решении.

Отказ — письменно. Через год рамка сменится; устный растворится. Одно «нет» не закрывает остальные девять.

### 38.7. Когда учредитель — союзник: как не потерять его

Союзник — ресурс со сроком годности: ротации, приоритеты. Отчёт — числами, не активностью. Роль — публично, по образцу внедривших<sup>3,4</sup>. Риск — с защитой, не голый. Числа, роль, безопасность держат дольше ротации.

## 39. Предложения отрасли: что должно измениться выше уровня учреждения

### 39.1. Граница раздела

Предыдущее — что организация может сделать сама, в действующем поле. Этот раздел — что ей мешает и что решается только на региональном и федеральном уровнях. Предложения — повестка для обсуждения, в том числе на семинаре, не готовые законопроекты. Нормотворческое конструирование — за пределами доклада.

### 39.2. Пять федеральных предложений

**1. Закрепить минимальный стандарт выбора в рекомендованных нормах.** Приказ 520н<sup>29</sup> задаёт нутриентные рамки. Международные системы закрепляют ещё и структуру выбора: два и более вариантов основных блюд — Онтарио<sup>23</sup>, альтернатива при отказе — США<sup>35</sup>, «что, когда, где и как я ем» — Австралия<sup>34</sup>. Формула: в нормы — не меню, а принцип «не менее двух вариантов основной позиции там, где технологически возможно».

**2. Урегулировать стык СОСО и лечебного питания.** Приказы Минздрава адресованы медицинским организациям; СОСО — в серой зоне (раздел 17). Варианты — совместный акт Минтруда и Минздрава или типовой региональный «мост»<sup>22</sup>. Пока стык не урегулирован, каждая организация решает клинику на свой страх и риск.

**3. Два показателя в отраслевую отчётность:** доля жителей, участвующих в выборе, и уровень пищевых отходов. Оба измеримы дёшево (приложения 24–25). Что измеряется наверху, то организуется внизу.

**4. Снять неопределённость с формами учёта.** Переход на электронные формы (приказы 61н, 142н, 100н, 157н, 174н)<sup>106</sup> порождает на местах: «всё меняется, лучше не начинать». Нужна справка: какие формы у СОСО сейчас и какие — после каждого этапа.

**5. Поддержать публикацию практик.** Внедрившие существуют<sup>3,4,6</sup>, но опыт идёт через новостные ленты, не через методические каналы. Сборники с документальными приложениями сократили бы цикл с лет до месяцев.

### 39.3. Пять региональных предложений

**6. Установить статус рекомендованных норм** — одним абзацем: рекомендация или императив. Неопределённость — главный тормоз (раздел 24).

**7. При императивном меню — процедуру его изменения** с участием организаций: кто инициирует, какие обоснования, какие сроки.

**8. Региональный «мост» к лечебному питанию** там, где его нет, — по готовому образцу<sup>22</sup>.

**9. Требования к вариативности и документированию** — в типовые документы закупок и аутсорсинговых контрактов (разделы 30 и 42). Без этих строк права жителей — добрая воля подрядчика.

**10. Региональная площадка обмена** — ежегодный семинар или рабочая группа с публикацией. Иркутский опыт: региональное решение масштабирует быстрее усилий отдельных домов<sup>6</sup>.

### 39.4. Чего доклад не предлагает

Три умолчания. Новый закон о питании в СОСО не нужен: рамка (3185-1, СанПиН, 520н)<sup>8,9,29</sup> уже позволяет главное; проблема — статусы и стыки. Обязательная вариативность без перехода не предлагается: нет кухни или смены — получится фикция (раздел 21). Числовых нормативов стоимости нет: публичных данных о сырьевой строке российских СОСО нет, норматив на пустоте — выдумка.

Десять предложений директора формулируют вместе. Семинар — место согласования; раздел 40 — как организовать.

### 39.5. Как предложения становятся нормами: японский таймлайн как учебный

Япония<sup>95, 97</sup>: три фазы. 1 — надбавка за добровольность, авангард. 2 — национальная база, язык цифр. 3 — обязательность, когда отрасль умеет.

Мы между 1 и 2: авангард есть<sup>2, 3, 4</sup>, данных нет. Запрос вверх — «считайте», не «разрешите» и не «обязайте». Два показателя (предложение 3) запускают фазу 2 без рубля и риска.

### 39.6. Роль профессионального сообщества

Предложения 6–10 делают регионы, иницируют директора: они знают, где стык болит. Минимум: рабочая группа при ассоциации, ежегодный сбор практик, банк форм (приложения — первый взнос). Стоимость организационная. Методический дефицит закрывается так.

## 40. Организационные предложения семинару

Семинар — не глава внедрения. Сценарий трёх дней, малые группы, вопросы залу и предложения площадке — в семинарском пакете: уникальность состава, пять предложений по формату, чего не делать, инфраструктура после, конструкция трёх дней, подписка об общем замере.

Кто собирает зал — открывает пакет. Кто внедряет — разделы 35–39 и 41–43.

## 41. Заявление о достоверности: что в этом докладе на чём стоит

### 41.1. Зачем этот раздел

Предыдущие версии содержали утверждения без источников, заимствованные цифры и оценки, выдававшиеся за факты. Этот раздел — публичная отчётность: какие классы утверждений есть, как каждый подтверждён, где читатель может поймать автора.

### 41.2. Классы утверждений и их подтверждение

**Нормы права.** Каждая ссылка на акт — с реквизитами и привязкой к реестру (раздел 44: **34 записи**, маркеры S001–S035 без S026). Дата актуальности реестров — **23.07.2026**; правовая сверка — **19–21.08.2026**. Для каждого акта указано, что он подтверждает. Не все позиции — публичный первоисточник: часть — внутренние документы, вторичные пересказы или требует повторной проверки редакции. Приказ 940н из ранних материалов не подтверждён — исключён, не оставлен «на всякий случай».

**Клинические данные.** Числа о лекарственных взаимодействиях, дисфагии, метаболических эффектах и реабилитации — к реестру (раздел 44, **48 записей**: систематические обзоры, мета-анализы, руководства IDDSI и обществ, клинические случаи). Где доказательства сильны (клозапин — кофеин<sup>15</sup>, литий — соль<sup>16</sup>), где ограничены (частота отдельных паттернов пищевого поведения), где отсутствуют: рандомизированных исследований вариативного меню в психиатрии не найдено — раздел 27.

**Международные нормы.** Девять зарубежных систем — реестр (раздел 44, **44 записи**) с актом, пунктом и датой вступления там, где она значима (австралийский Стандарт 6 — с 01.11.2025<sup>34</sup>). Перенос на российскую почву — рекомендация или ориентир, не обязанность.

**Российская статистика.** Числа о системе ПНИ — вторичная аналитика «Если быть точным»: данные за **2024 год**, публикация 09.04.2026<sup>7</sup>. Не статотчётность Минтруда и не исследование ТАСС; информагентства пересказывали. Где независимого подтверждения нет — сказано прямо.

**Российские практики.** Каждая — публичный первоисточник с датой<sup>2, 3, 4, 6, 22, 5</sup>. «Мало», «растёт» — интерпретация открытого поиска, не репрезентативного обследования: такого обследования не существует.

**Числовые примеры и расчёты.** Модельные вычисления помечены как иллюстративные, с допущениями. Формула «вариативность почти бесплатна» удалена как недоказанная; вместо неё — порядок замера.

Четыре категории доступности нельзя смешивать под словом «верифицировано»: **публичный первоисточник, внутренний документ, вторичная публикация, требует перепроверки.**

### 41.3. Что доклад не знает (честный список пробелов)

Репрезентативной статистики вариативного питания в российских СОСО нет. Рандомизированных исследований эффекта вариативности в психиатрических стационарах не найдено. Судебной практики о вариативном меню не обнаружено. Данных о сырьевой строке российских СОСО в публичном поле нет. Статус норм в каждом из 51 региона не проверен индивидуально: методика — раздел 24, проверка — работа региональных групп (раздел 40). Пробелы — карта того, где читатель обязан включать собственную проверку.

#### 41.4. Как проверить авторов

Два способа. Первый: раздел 44 — каждое утверждение имеет маркер, каждый маркер — строку списка. Второй: утверждение без маркера или маркер без строки — ошибка автора, не недоразумение читателя. Достоверность — не обещание «мы не ошибались», а конструкция «вы можете нас поймать».

#### 41.5. Известные уязвимости этой версии

**Датировка.** Реестры — 23.07.2026; сверка — 19–21.08.2026. Нормы, особенно региональные и формы учёта<sup>106</sup>, меняются: перед приказом проверять заново. СанПиН 2.3/2.4.4282-26 утверждён 02.06.2026, вступает 01.09.2026 — через несколько дней после семинара. Переход от 3590-20 зафиксирован; локальные акты перепривязывать самим.

**Языковая асимметрия.** Международные тексты читались по-английски; немецкие и шведские нюансы могли сгладиться переводом.

**Отбор практик.** Шесть российских — открытый поиск; одна — дом докладчика (кейс 25.5, конфликт интересов раскрыт). Без публикаций в доклад не попали.

**Собирательные кейсы.** Кейсы 1–22 — типовые механизмы: правдивы по логике, условны по фактуре.

**Авторская позиция.** Где доказательств нет, доклад занимает сторону (приоритет зафиксированной воли, «учреждение = опекун»). Аргументировано, но позиция; границы — раздел 16.

Пять уязвимостей правит не редакция, а новые данные — те, что соберёт зал (раздел 40).

## 42. Аутсорсинг питания: контракт как место вариативности

### 42.1. Почему это раздел доклада

Питание всё чаще даёт не свой пищеблок, а комбинат, фабрика-кухня, готовые блюда и чужие повара<sup>107</sup>. Для директора это смена модели: контракт решает, что едят жители. Санитарная рамка не зависит от того, кто у плиты<sup>107</sup>.

Кейсов вариативного меню на аутсорсинге в открытых источниках нет — пробел. Раздел переносит инструменты глав 19–22 и 30 в контракт. Задача — вписать выбор и проверять аутсорсера, не превращая дом в «приёмный пункт тарелок».

### 42.2. Правовая рамка: кто за что отвечает

Закупка услуг питания для казённых и бюджетных — как правило, 44-ФЗ (ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ)<sup>108</sup>. Для автономных режим может быть 223-ФЗ при наличии положения о закупке: оговорка раздела 30.1, не формула «всем 44-ФЗ».

Я веду Серафимовский по 223-ФЗ. Тимур Нурбаев ведёт «Тесовый берег» по 44-ФЗ. Кухни и законы не путать. Свежий пример его контура — извещение № 0372200070825000244, открытый конкурс «Поставка продуктов питания» СПб ГБУСОН «ДСО „Тесовый берег“» (ИНН 7827661874), обеспечение заявки по ст. 45 44-ФЗ, опубликовано 24.11.2025, площадка АГЗ РТ<sup>109</sup>.

Санитарная рамка не «уезжает» с кухней. СанПиН 2.3/2.4.4282-26 прямо регулирует привлечённые предприятия. П. 56 подп. 12: при готовых блюдах из общепита в стационаре СОСО выделяется помещение для приёма продукции и отбора суточных проб; пробы отбирает работник пищеблока учреждения по подп. 4 п. 56 (каждое блюдо отдельно; холодные закуски / первые / гарниры / напитки — не менее 100 г; хранение не менее 48 часов при +2...+6 °С)<sup>9</sup>. П. 56 подп. 14: требования пункта — на предприятия, привлекаемые для питания стационара<sup>9</sup>. Раздел VI (кейтеринг): внутренний порядок прослеживаемости изготовления, перевозки, хранения и реализации и разграничения ответственности; вскрытие упаковок и порционирование — в выделенной зоне в месте услуги<sup>9</sup>. До 01.09.2026 — аналогичная рамка СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (п. 7.1.11–7.1.14, раздел VI)<sup>9</sup>.

Суточные пробы, бракераж и температура можно делегировать исполнением, не ответственностью. Перед жителями и проверяющими отвечает учреждение.

### 42.3. Восемь строк контракта, которые делают вариативность реальной

Развитие раздела 30 для аутсорсинга.

**1. Перечень как группы взаимозаменяемых** («крупы гарнирные: гречка, рис, пшено»), не монопозиция — пары на уровне контракта.

**2. Пропорции по статистике выбора** с правом корректировки раз в квартал без изменения сути контракта.

**3. Строка выбора:** где заявлена вариативность — не менее двух вариантов основных позиций; срыв фиксируется в журнале замен и не считается исполнением.

**4. Строка замен:** при недопоставке — эквивалент из той же группы по согласованию, с актом.

**5. Строка качества:** характеристики для текстур (помол, консистенция полуфабрикатов) — иначе дисфагический контур становится заложником «самого дешёвого фарша» (раздел 10).

**6. Строка приёмки:** ответственный от учреждения, форма акта, место и процедура суточных проб по п. 56 подп. 12<sup>9</sup>.

**7. Строка состава:** меню-цикл с раскладкой и массой порций — приложение к контракту; сверка с нормами 520н<sup>29</sup>.

**8. Строка отчётности:** доля выбора и остатки по блюдам — ежемесячно; данные для панели раздела 22.

Каждая строка — с контрактной службой заранее. Конфликт «меню против контракта» — симптом: меню меняли, спецификацию нет.

**Чего нельзя отдать строкой ТЗ.** Исполнение — да, ответственность — нет. Пробы отбирает работник учреждения (п. 56 подп. 12 и 4)<sup>9</sup>; бракераж приёмки — акт учреждения; дисфагия и текстуры — у врача и поста; эскалация отказа (раздел 12) — маршрут дома. Поставщик готовит и везёт. Учреждение решает, что безопасно сегодня.

#### 42.4. Как проверять аутсорсера без «кухонной войны»

**Замер остатков** (приложение 25). **Внезапный контроль линии:** температура по п. 50 СанПиН 4282-26<sup>9</sup>, соответствие заказанного выданному, стандартный вариант (раздел 21). **Суточные пробы:** наличие, маркировка, объём, срок. **Фото линии** без лиц жителей; здоровье — 152-ФЗ (раздел 17.6). **Раз в квартал — панель** с поставщиком: отходы, жалобы, доля выбора.

Кейсы 14 и 22 переносятся один в один. Ст. 6.6 КоАП<sup>10</sup> и практика ФАС<sup>75</sup> никуда не делась.

Учредитель уже написал, как держать поставщика. Письмо Комитета (председатель Е. Н. Фидрикова): ст. 34, 94, 95 44-ФЗ; ежедневный мониторинг, акты, претензии, одностороннее расторжение, РНП<sup>10</sup>. Позиция учредителя в контуре 44-ФЗ, не пожелание директора.

#### 42.5. Экономика: почему «дешевле отдать на сторону» — не всегда правда

Полная стоимость приёма в 3–6 раз выше сырьевой строки (раздел 29, канадский аудит)<sup>56</sup>. Аутсорсер режет сырьё — видимую и малую часть. Контракт фиксирует состав: меню-цикл, массу порций, соответствие 520н<sup>29</sup>. Британские стандарты обязательны и для контрактников<sup>111</sup>; нормы Онтарио — независимо от способа обеспечения<sup>23</sup>. Экономия — постройками, не «общей цифрой».

Аутсорсинг — новое место вариативности: спецификация, приёмка, отчётность. Пары, замер, журналы, пробы — в контракт, раздел 42.3. Контроль качества — исполнением, не ответственностью. Нет строк выбора и проб — вариативность невозможна.

#### 42.7. Осенний календарь: когда править ТЗ

Выбор вне ближайшей закупки откладывается на весь срок контракта. Даты свои, логика одна.

**Сентябрь.** Новый СанПиН не стоп выбора (раздел 18.10). Замер и журнал — числа для спецификации.

**Октябрь.** Восемь строк 42.3 — с контрактной службой; пробы, бракераж, дисфагия, эскалация отказа остаются у учреждения.

**Ноябрь–декабрь.** Контракт кончается в первом полугодии — строки в документации сейчас. Длинный контракт без строк — допсоглашение, не «переторжка».

**Январь.** Пилот по таблице 35.9: своя линия или два варианта от поставщика. Без осеннего окна замер можно — обещать выбор в договоре нельзя.

Деньги — раздел 29, процедура — 30, контракт — этот.

### 43. Заключение: что остаётся после последней страницы

#### 43.1. Суть доклада в пяти предложениях

Питание в стационаре — не услуга рядом с заботой. Это ежедневный тест на уважение: система сдаёт его или проваливает три-четыре раза в день. Правовое поле позволяет организовать выбор уже сегодня: нормы есть, серые зоны обозначимы, процедуры описаны. Практика работает — в Успенском, Усть-Илимске, Серафимовском<sup>7, 4, 5</sup> и в регионе, масштабировавшем её решением области<sup>6</sup>. Если кухня не своя, то же самое начинается со спецификации (раздел 42). Доказательная база разной плотности: по клинике и международным нормам сильна, по эффекту вариативности в психиатрии — почти пуста. Последнее слово — не «внедряйте», а «измеряйте»: семь дней замера отделяют убеждение от знания.



### 43.2. Три образа, с которых начинался разговор

В разделе 5 обед собрал пять конфликтов за одним столом: женщина, которой нужно молчание вместо зала; мужчина, чей кофеин и клозапин конфликтуют без ведома кухни<sup>15</sup>; житель, чья дисфагия пока видна только внимательной сиделке<sup>1</sup>; человек без слов, чьё «не хочу» система не умеет услышать; смена, которая делает «как всегда», потому что это единственный доступный сценарий. Теперь у каждого — процедура: тихая зона (раздел 20), лекарственно-пищевая таблица (раздел 11), список риска и текстуры (раздел 10), четыре канала воли (раздел 15), комплект документов и роли (разделы 28, 31). Конфликты не исчезнут. Они перестанут быть безымянными.

### 43.3. Что изменится для четырёх людей

**Для жителя** — еда перестаёт быть тем, что с ним происходит, и становится тем, в чём он участвует: называет, показывает, выбирает, отказывается. Отказ не превращается в голод: есть задокументированная альтернатива.

**Для сиделки** — «покормить» сменяется работой с опорами: карта жителя, таблица текстур, правило трёх отказов.

**Для директора** — питание выходит из тумана («придут — спросят») в управляемую систему: приказ, журналы, панель чисел, дата заслушивания у учредителя.

**Для учредителя** — работа, которую только он может сделать: статусы норм, «мост» к лечебному питанию, показатели отрасли (раздел 39).

### 43.4. Первый шаг

Доклад можно закрыть и начать. Первый шаг — неделя без разрешений: замер отходов, отказов, времени раздачи (приложение 25). Кто уезжает 27 августа: 1 сентября журналы не переписываются, новые формы бракеража — с утра (приложение 39). Дальше — знание о доме, не мнение. Из него растут пилот, совет, разговор с учредителем — и через год рассказ, которому зал поверит: за ним ваши числа.

Человек за столом ждёт обеда, в котором есть его выбор. Теперь вы знаете, как такой обед организовать.

### 43.5. Письмо директору через год

Прошёл год. Два сценария.

**А.** Доклад на полке. Изменилось одно: вы знаете, что у коллег работает, и жалоба на еду читается иначе.

**Б.** Неделя замера, совет, пилот в одном отделении; панель у учредителя; два варианта второго — как водопровод.

Разница — не деньги (пилот М1 дешевле ремонтного дня), не разрешения, не люди. Разница — первая неделя. Она дешевле года сомнений. Дальше — ваши числа и жители, которые скажут, какая каша — их. Разговор начался в зале. Продолжение — за линией раздачи, в понедельник, 8:30.

## 44. Библиография и источники

Сто двадцать шесть источников. Тридцать четыре российских правовых и практических (S001–S035 без S026), сорок восемь клинических, сорок четыре международных. Дата актуальности реестров — **23.07.2026**; правовая сверка — **19–21.08.2026**. Как читать классы утверждений — раздел 41.

В тексте доклада источник стоит маркером в месте первого упоминания; повтор указывает на тот же номер. Ниже — полный раскрытый список: **номер строки не равен номеру сноски**, в первой колонке — ID реестра. Пробелы списка названы прямо: часть позиций — внутренние документы или вторичные пересказы; практики S015–S019 и S030 — публикации учреждений, не аудит; S022 — единственное публично доступное судебное толкование по пищевым делам в СОСО; S013 и S014 — закупочная дисциплина, не обоснование выбора; S012 — качество и достаточность питания, не «дело о вариативности».

### 44.1. Российские правовые и практические источники (S) — 34

| ID   | Что                                                                                        | Где / URL                                                                                                                     | Проверено                   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| S001 | ФЗ № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ», ст. 9, 16, 17, 31, 32      | <a href="https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/">https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/</a> | Госдума — 23.07.2026        |
| S002 | Приказ Минтруда России от 13.09.2022 № 520н «Об утверждении рекомендуемых норм питания...» | <a href="https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405607433/">https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405607433/</a> | Минтруд России — 23.07.2026 |

| ID   | Что                                                                                                                                                                                                                                                                              | Где / URL                                                                                                                                                                                                                             | Проверено                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| S003 | СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (пост. ГГСВ РФ от 27.10.2020 № 32), п. 7.1.11–7.1.14 — до 01.09.2026; СанПиН 2.3/2.4.4282-26 (пост. ГГСВ РФ от 02.06.2026 № 18, зарег. в Минюсте 02.06.2026 № 86854), п. 56 подп. 11–14 (СОСО, раздел VII), п. 62 (питьевой режим), раздел VI (кейтеринг) | <a href="https://rovenkiadm.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/SanPiN_2.4.4282-26.pdf">https://rovenkiadm.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/SanPiN_2.4.4282-26.pdf</a>                                                             | Роспотребнадзор — 17.08.2026                         |
| S004 | Исследование «Если быть точным»: «Как устроены ПНИ в России» (09.04.2026)                                                                                                                                                                                                        | <a href="https://tochno.st/materials/kak-ustroeny-pni-v-rossii-issledovanie-esli-byt-tocnym">https://tochno.st/materials/kak-ustroeny-pni-v-rossii-issledovanie-esli-byt-tocnym</a>                                                   | проект «Если быть точным» — 23.07.2026               |
| S005 | Ведомости: «Психоневрологических интернатов за три года стало на 13% меньше» (10.04.2026)                                                                                                                                                                                        | <a href="https://www.vedomosti.ru/society/articles/2026/04/10/1189295-psihonevrologicheskikh-internatov-stalo-menshe">https://www.vedomosti.ru/society/articles/2026/04/10/1189295-psihonevrologicheskikh-internatov-stalo-menshe</a> | Ведомости — 23.07.2026                               |
| S006 | Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н: статус на 2026 г.                                                                                                                                                                                                                     | <a href="https://base.garant.ru/58070703/">https://base.garant.ru/58070703/</a>                                                                                                                                                       | Минфин России — 23.07.2026                           |
| S007 | Страница семинара на сайте Минтруда: <a href="http://mintrud.gov.ru/events/1481">mintrud.gov.ru/events/1481</a>                                                                                                                                                                  | <a href="https://mintrud.gov.ru/events/1481">https://mintrud.gov.ru/events/1481</a>                                                                                                                                                   | Минтруд России — 23.07.2026                          |
| S008 | Постановление Правительства Красноярского края от 17.12.2014 № 607-п (нормы питания), актуальная ред.                                                                                                                                                                            | <a href="https://ctonus.ru/f/normy_pitaniya.docx">https://ctonus.ru/f/normy_pitaniya.docx</a>                                                                                                                                         | Правительство Красноярского края — 23.07.2026        |
| S009 | Ст. 31 442-ФЗ + ПП РФ № 1075 (расчёт среднедушевого дохода)                                                                                                                                                                                                                      | <a href="https://www.consultant.ru/law/podborki/plata_za_stacionarnoe_socialnoe_obslyuzhivanie/">https://www.consultant.ru/law/podborki/plata_za_stacionarnoe_socialnoe_obslyuzhivanie/</a>                                           | Правительство РФ — 23.07.2026                        |
| S010 | Письмо Минтруда о семинаре + список участников (приложения пользователя)                                                                                                                                                                                                         | —                                                                                                                                                                                                                                     | Минтруд России — 23.07.2026                          |
| S011 | Закон РФ № 3185-1 «О психиатрической помощи...», ст. 37, 39, 43, 44                                                                                                                                                                                                              | <a href="https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4205/">https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4205/</a>                                                                                                             | ВС РФ — 23.07.2026                                   |
| S012 | Прокуратура: проверки питания в соцучреждениях, дела по ст. 6.6 КоАП (Кашин СРЦ 2022; Зеленогорск 2021; представление 19.03.2024 soc13.ru)                                                                                                                                       | <a href="https://www.kashin.info/prokuratura-informiruet/novosti-prokuratury/9121">https://www.kashin.info/prokuratura-informiruet/novosti-prokuratury/9121</a>                                                                       | прокуратуры районов — 23.07.2026                     |
| S013 | ФАС: картель на торгах поставки соц. значимых продуктов, 543 торга, 4,7 млрд руб. (25.07.2024, РГ)                                                                                                                                                                               | <a href="https://rg.ru/2024/07/25/fas-raskryla-kartel-na-torgah-na-postavku-socialno-znachimyh-produktov.html">https://rg.ru/2024/07/25/fas-raskryla-kartel-na-torgah-na-postavku-socialno-znachimyh-produktov.html</a>               | ФАС России — 23.07.2026                              |
| S014 | ФАС/ФСБ: картель на школьном питании Челябинск, 27 тендеров 2022–2024, штраф 5,1 млн (01.08.2025)                                                                                                                                                                                | <a href="https://www.pro-goszakaz.ru/news/116068">https://www.pro-goszakaz.ru/news/116068</a>                                                                                                                                         | УФАС Челябинской обл. — 23.07.2026                   |
| S015 | ГАУССО НСО «Болотнинский ПНИ»: «Вариативное питание» (16.08.2024)                                                                                                                                                                                                                | <a href="https://bpni.nso.ru/news/2312">https://bpni.nso.ru/news/2312</a>                                                                                                                                                             | Болотнинский ПНИ — 23.07.2026                        |
| S016 | ГАУССО НСО «Успенский ПНИ»: вариативное меню во всех отделениях (13.08.2024)                                                                                                                                                                                                     | <a href="https://upni.nso.ru/news/1916">https://upni.nso.ru/news/1916</a>                                                                                                                                                             | Успенский ПНИ — 23.07.2026                           |
| S017 | ОГБУСО «Усть-Илимский дом социального обслуживания»: «Что за зверь такой? Вариативное питание» (27.09.2024)                                                                                                                                                                      | <a href="https://ui-ogbuso.ru/novosti/">https://ui-ogbuso.ru/novosti/</a>                                                                                                                                                             | Усть-Илимский ДСО — 23.07.2026                       |
| S018 | Иркутская область: вариативное питание в стационарных учреждениях — выбор из двух первых, вторых и гарниров (14.02.2025)                                                                                                                                                         | <a href="https://irkutsk.bezformata.com/listnews/variativnoe/142531226/">https://irkutsk.bezformata.com/listnews/variativnoe/142531226/</a>                                                                                           | минсоцразвития ИО (пересказ bezformata) — 23.07.2026 |
| S019 | ДДСОЛ (Московская обл.): 14-дневное вариативное меню, совет по питанию, замены по желанию жителей с врачом                                                                                                                                                                       | <a href="https://ddsol.ru/about/pitanie/">https://ddsol.ru/about/pitanie/</a>                                                                                                                                                         | ДДСОЛ — 23.07.2026                                   |

| ID   | Что                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Где / URL                                                                                                                                               | Проверено                                                                           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| S020 | Постановление Правительства Москвы № 1068-ПП (нормы питания в стационарных организациях)                                                                                                                                                                                                                                     | —                                                                                                                                                       | Правительство Москвы — 23.07.2026                                                   |
| S021 | Постановление адм. Псковской обл. № 206; постановление Правительства Красноярского края № 607-п; пост. Правительства Ленобласти № 458; пост. Правительства ХМАО № 306-п                                                                                                                                                      | —                                                                                                                                                       | органы субъектов — 23.07.2026                                                       |
| S022 | Постановление ВС РФ от 21.02.2019 № 11-АД19-4 (переквалификация 6.6→6.7 КоАП)                                                                                                                                                                                                                                                | <a href="https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72095418/">https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72095418/</a>                             | Верховный Суд РФ — 23.07.2026                                                       |
| S023 | ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»                                                                                                                                                                                  | <a href="https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/">https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/</a>                           | Госдума — 23.07.2026                                                                |
| S024 | Лозовская С.О. «Правосубъектность лиц, признанных недееспособными и ограниченно дееспособными вследствие психического расстройства»                                                                                                                                                                                          | <a href="https://vestnik.msa.ru/jour/article/view/2058">https://vestnik.msa.ru/jour/article/view/2058</a>                                               | Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023, № 5, с. 139–146 — 23.07.2026 |
| S025 | «Кейтеринг в организациях социального обслуживания» (отраслевое издание, 2022)                                                                                                                                                                                                                                               | <a href="https://www.profiz.ru/sec/4_2022/Kejtinger/">https://www.profiz.ru/sec/4_2022/Kejtinger/</a>                                                   | Профиздат — 23.07.2026                                                              |
| S027 | СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (пост. ГГСВ РФ от 28.09.2020 № 28, зарег. в Минюсте 18.12.2020 № 61573)                                                                                                                | <a href="https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/">https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/</a>                           | Роспотребнадзор — 23.07.2026                                                        |
| S028 | Письмо Минтруда России от 21.04.2020 № 26-4/10/В-3076: методические рекомендации по организации работы стационарных организаций социального обслуживания в условиях COVID-19 (усиленный питьевой режим, раздача в жилые комнаты, дезинфекционный контур)                                                                     | <a href="https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=8&amp;documentId=361442">https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=8&amp;documentId=361442</a> | Минтруд России — проверено 18.08.2026 по тексту письма                              |
| S029 | Методические рекомендации по организации питания в учреждениях (отделениях) социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (пост. Минтруда России от 15.02.2002 № 12, ред. приказа от 04.06.2007 № 397): лечебно-профилактические продукты, профилактика витаминной недостаточности, санитарная безопасность | <a href="https://docs.cntd.ru/document/901816611">https://docs.cntd.ru/document/901816611</a>                                                           | Минтруд России — проверено 18.08.2026 по тексту                                     |
| S030 | Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга: «Работа по развитию психоневрологических интернатов продолжается» (22.07.2025) — первые результаты вариативного меню в ДСО «Серафимовский»                                                                                                                                  | <a href="https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/trud/news/302216/">https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/trud/news/302216/</a>                                   | Комитет по социальной политике СПб / ДСО «Серафимовский» — 17.08.2026               |

| ID   | Что                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Где / URL                                                                                                                     | Проверено                                                                                                                                                  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S031 | Письмо Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга руководителям государственных учреждений об усилении контроля за исполнением поставщиками питания своих обязательств (ст. 34, 94, 95 44-ФЗ; ежедневный мониторинг, акты, претензии, одностороннее расторжение, РНП)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | внутренний документ Комитета (оригинал у автора)                                                                              | Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга (председатель Е.Н. Фидрикова) — 19.08.2026                                                                 |
| S032 | Приказ Минздрава России от 05.08.2003 № 330н «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях РФ» (Инструкция по организации лечебного питания, диеты по Певзнеру; действующая редакция — с изм., внесёнными приказом Минздрава России от 19.02.2024 № 70н)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <a href="https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44323/">https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44323/</a>   | Минздрав России (рег. Минюст 12.09.2003 № 5073) — 19.08.2026                                                                                               |
| S033 | Приказ Минздрава России от 21.06.2013 № 395н «Об утверждении норм лечебного питания» (действующая редакция — с изм., внесёнными приказом Минздрава России от 19.02.2024 № 70н)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <a href="https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149196/">https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149196/</a> | Минздрав России (рег. Минюст 05.07.2013 № 28995) — 19.08.2026                                                                                              |
| S034 | Извещение № 0372200070825000244: открытый конкурс в электронной форме «Поставка продуктов питания» СПб ГБУСОН «ДСО «Тесовый берег» (ИНН 7827661874); обеспечение заявки по ст. 45 44-ФЗ; опубликовано 24.11.2025, площадка АГЗ РТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <a href="https://www.tenderguru.ru/tender/90473908">https://www.tenderguru.ru/tender/90473908</a>                             | СПб ГБУСОН «ДСО «Тесовый берег» — 19.08.2026                                                                                                               |
| S035 | Приказ директора СПб ГАСУСОН «ДСО «Серафимовский» от 10.03.2026 № 124 «Об утверждении правил внутреннего распорядка жителей СПб ГАСУСОН «ДСО «Серафимовский»» (в правилах закреплено заказное питание — вариативное меню, в т.ч. для маломобильных граждан; PDF опубликован на <a href="http://www.pni9.ru">www.pni9.ru</a> — сайт прекратил работу, домен истёк, проверено 21.08.2026; текст правил в архивной копии: <a href="http://web.archive.org/web/20260415001233/https://www.pni9.ru/правила-внутреннего-распорядка/">web.archive.org/web/20260415001233/https://www.pni9.ru/правила-внутреннего-распорядка/</a> ) | <a href="https://www.pni9.ru/правила-внутреннего-распорядка/">https://www.pni9.ru/правила-внутреннего-распорядка/</a>         | СПб ГАСУСОН «ДСО «Серафимовский» (архив сайта: <a href="http://web.archive.org/web/20260415001233/">web.archive.org/web/20260415001233/</a> ) — 21.08.2026 |

## 44.2. Клинические источники (М) — 48

| ID          | Что                                                                                                                                   | Где / URL                                                                                                                         | Проверено         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| M-cloz_hagg | Hägg S. et al. Кофеин 400–1000 мг/день: +19% AUC клозапина, –14% клиренс                                                              | <a href="https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2014893/">https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2014893/</a>                 | 2000              |
| M-cloz_case | Yartsev P. et al. Тяжёлая токсичность клозапина при приёме энергетиков (600 мг кофеина/день; уровень 1796 нг/мл) — клинический случай | <a href="https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8043221/">https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8043221/</a>                 | 2021              |
| M-cloz_wd   | Отмена кофеина: снижение уровня клозапина на 37–47% (Carrillo 1998; обзор)                                                            | <a href="https://www.pharmacytimes.com/view/caffeine-and-clozapine">https://www.pharmacytimes.com/view/caffeine-and-clozapine</a> | клинический обзор |

| ID           | Что                                                                                                                                                                                                         | Где / URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Проверено                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| M-lithium    | Литий и диета: почки обрабатывают литий и натрий сходно; дефицит натрия/ обезвоживание → рост уровня лития                                                                                                  | <a href="https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/25207-lithium-toxicity">https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/25207-lithium-toxicity</a>                                                                                                                                                                                                                                                 | Cleveland Clinic         |
| M-lithium_sp | StatPearls. Lithium Toxicity: риски — дегидратация, диуретики, лихорадка, потери ЖКТ                                                                                                                        | <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK499992/">https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK499992/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | StatPearls               |
| M-carb_gf    | Garg S.K. et al. Грейпфрутовый сок: пик карбамазепина 6,55→9,20 мкг/мл (+40%), AUC +41%                                                                                                                     | <a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9757152/">https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9757152/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1998                     |
| M-maoi_nhs   | NHS. MAOI — диетические ограничения (тирамин): пациентский листок                                                                                                                                           | <a href="https://www.torbayandsouthdevon.nhs.uk/uploads/25672.pdf?last-updated=20201119">https://www.torbayandsouthdevon.nhs.uk/uploads/25672.pdf?last-updated=20201119</a>                                                                                                                                                                                                                               | NHS                      |
| M-maoi_hist  | «Сырная реакция» на ИМАО: история открытия (Blackwell; АД 160/90→220/115)                                                                                                                                   | <a href="https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2738414/">https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2738414/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | исторический обзор       |
| M-maoi_guide | MAOI diet and tyramine: руководство для назначающих (обновление 2022)                                                                                                                                       | <a href="https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9172554/">https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9172554/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | prescriber's guide       |
| M-pillinger  | Pillinger T. et al. Мета-анализ 100 РКИ (25 952 пациента): прибавка веса на антипсихотиках от −0,23 кг (галоперидол) до +3,01 кг (клозапин) за медиану 6 нед (Lancet Psychiatry, 2020)                      | <a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31860457/">https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31860457/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2020                     |
| M-crwg       | Мета-анализ CRWG (прибавка ≥7% за 38 нед): клозапин 76,3%, оланзапин 36,9%, рисперидон 23,0% (BJPsych Open, January 2023, DOI 10.1192/bjo.2022.619). Campforts 2026 — другая статья (семаглутид/метформин). | <a href="https://www.cambridge.org/core/journals/bjpsych-open/article/association-between-antipsychotic-medication-and-clinically-relevant-weight-change-metaanalysis/C2DC78D062978D7C805E0E9B99B7911F">https://www.cambridge.org/core/journals/bjpsych-open/article/association-between-antipsychotic-medication-and-clinically-relevant-weight-change-metaanalysis/C2DC78D062978D7C805E0E9B99B7911F</a> | 2023                     |
| M-fepwg      | Мета-анализ при первом эпизоде психоза: долгосрочно оланзапин +9,34 кг, клозапин +7,19 кг                                                                                                                   | <a href="https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5589463/">https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5589463/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | мета-анализ              |
| M-metmon     | Мониторинг метаболического риска на антипсихотиках: график (вес/ИМТ: исходно, 4/8/12 нед, 6 мес, ежегодно; глюкоза/липиды/ АД: исходно, 12 нед, ежегодно)                                                   | <a href="https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8582768/">https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8582768/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | клинические рекомендации |
| M-lifestyle  | Lifestyle interventions in mental health conditions: systematic review (57 исследований; −1,42 кг)                                                                                                          | <a href="https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9462072/">https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9462072/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022                     |
| M-teasdale   | Teasdale S. et al. Nutrition/dietary interventions for SMI (MJA, 2023)                                                                                                                                      | <a href="https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9828433/">https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9828433/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2023                     |
| M-resolve    | RESOLVE: реалистский синтез антипсихотической прибавки веса (2025)                                                                                                                                          | <a href="https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12531729/">https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12531729/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2025                     |
| M-dysph_prev | Font L. et al. Дисфагия на фоне антипсихотиков: распространённость 21,9–69,5% (систематический обзор)                                                                                                       | <a href="https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10455044/">https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10455044/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | систематический обзор    |
| M-dysph_rev  | Дисфагия при шизофрении: механизмы (паркинсонизм, сухость, гиперсаливация, седация, нарушения еды) — обзор                                                                                                  | <a href="https://www.frontiersin.org/journals/psychiatry/articles/10.3389/fpsy.2024.1448623/full">https://www.frontiersin.org/journals/psychiatry/articles/10.3389/fpsy.2024.1448623/full</a>                                                                                                                                                                                                             | обзор                    |
| M-dysph_dd   | Дисфагия, аспирационная пневмония и кишечная непроходимость на антипсихотиках у лиц с нарушениями развития; предупреждение FDA о запорах на клозапине (2020)                                                | <a href="https://www.jscimedcentral.com/public/assets/articles/psychiatry-11-1183.pdf">https://www.jscimedcentral.com/public/assets/articles/psychiatry-11-1183.pdf</a>                                                                                                                                                                                                                                   | обзор                    |



| ID              | Что                                                                                                                                                                                        | Где / URL                                                                                                                                                                                                                                                           | Проверено                         |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| M-mortality     | Correll C. et al. Мета-анализ смертности при шизофрении: смерть на 15–20 лет раньше; пневмония RR 7,00 — высшая из естественных причин (World Psychiatry, 2022)                            | <a href="https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9077617/">https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9077617/</a>                                                                                                                                                   | 2022                              |
| M-mortality2    | Шведский регистр: ССЗ — ведущая причина избыточной смертности при шизофрении (MRR 2,80; смерть от ССЗ на 10 лет моложе)                                                                    | <a href="https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6137375/">https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6137375/</a>                                                                                                                                                   | регистровое исследование          |
| M-iddsi2017     | Cichero J.A.Y. et al. The IDDSI Framework (Dysphagia, 2017;32(2): 293–314)                                                                                                                 | <a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27913916/">https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27913916/</a>                                                                                                                                                                   | IDDSI, 2017                       |
| M-iddsi_wu      | Wu X.S. et al. IDDSI implementation: соответствие текстур 44%→90%                                                                                                                          | <a href="https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8994209/">https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8994209/</a>                                                                                                                                                   | 2022                              |
| M-nijs          | Nijs K. et al. Family-style mealtimes: cluster RCT (BMJ, 2006)                                                                                                                             | <a href="https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1463975/">https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1463975/</a>                                                                                                                                                   | 2006                              |
| M-montessori    | Montessori-based interventions for dementia: systematic review (15 исследований)                                                                                                           | <a href="https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10336713/">https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10336713/</a>                                                                                                                                                 | 2023                              |
| M-pm_rev        | Porter J. et al. Protected mealtimes: systematic review & meta-analysis (Int J Nurs Stud, 2017)                                                                                            | <a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27866011/">https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27866011/</a>                                                                                                                                                                   | 2017                              |
| M-pm_rct        | Porter J. et al. Protected Mealtimes: stepped-wedge cluster trial (2019)                                                                                                                   | <a href="https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5295189/">https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5295189/</a>                                                                                                                                                   | 2019                              |
| M-sup_hous      | Supported housing for people with SMI: systematic review & meta-analysis (2022)                                                                                                            | <a href="https://www.frontiersin.org/journals/psychiatry/articles/10.3389/fpsy.2022.966029/full">https://www.frontiersin.org/journals/psychiatry/articles/10.3389/fpsy.2022.966029/full</a>                                                                         | Frontiers in Psychiatry           |
| M-ebt           | Исследование «Если быть точным»: ПНИ России в цифрах — 466 интернатов (2024), 139 500 жителей, 74% недееспособных, 65% старше 45 лет (апрель 2026)                                         | <a href="https://www.forbes.ru/forbeslife/558987-s-2022-po-2024-god-cislo-psihonevrologicheskikh-internatov-v-rossii-snizilos-na-13">https://www.forbes.ru/forbeslife/558987-s-2022-po-2024-god-cislo-psihonevrologicheskikh-internatov-v-rossii-snizilos-na-13</a> | 2026                              |
| M-ebt2          | Исследование «Если быть точным»: сопровождаемое проживание — 7 000 чел.; переименование ПНИ в «дома социального обслуживания» в 41 регионе (2026)                                          | <a href="https://tochno.st/materials/kak-ustroeny-pni-v-rossii-issledovanie-esli-byt-tocnym">https://tochno.st/materials/kak-ustroeny-pni-v-rossii-issledovanie-esli-byt-tocnym</a>                                                                                 | 2026                              |
| M-oral_yoneyama | Yoneyama T. et al. Ежедневный уход за полостью рта в домах ухода: частота пневмоний 11 % против 19 % в контроле (РКИ, 366 проживающих)                                                     | <a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11874491/">https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11874491/</a>                                                                                                                                                                   | J Am Geriatr Soc, 2002            |
| M-oral_muller   | Müller F. Обзор 4 РКИ: улучшение гигиены полости рта может предотвращать ~1 из 10 смертей от аспирационной пневмонии у немощных пожилых                                                    | <a href="https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4541086/">https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4541086/</a>                                                                                                                                                   | Gerodontology, 2015               |
| M-dehydr_steele | Steele C.M. Нагрузка лечения загущёнными жидкостями: нет убедительных данных о снижении осложнений при доказанном снижении потребления жидкости                                            | <a href="https://publications.ersnet.org/content/breathe/17/1/210003">https://publications.ersnet.org/content/breathe/17/1/210003</a>                                                                                                                               | Breathe (ERS), 2021               |
| M-dehydr_li     | Li W.Q. et al. Систематический обзор и мета-анализ применения загущённых жидкостей при дисфагии                                                                                            | <a href="https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12516007/">https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12516007/</a>                                                                                                                                                 | 2025                              |
| M-constip_ep    | Every-Palmer S. et al. Клозапин-индуцированная гипомотильность ЖКТ: запоры у 30–60 % пациентов, при объективных методах — до 80 %; тяжёлый запор может быть фатальным (иблиус, перфорация) | <a href="https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5533872/">https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5533872/</a>                                                                                                                                                   | Aust N Z J Psychiatry / PMC, 2017 |

| ID              | Что                                                                                                                                                                                                       | Где / URL                                                                                                                                                                                 | Проверено                                                                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| M-constip_nhs   | NHS Specialist Pharmacy Service. Ведение запоров у принимающих клозапин: может быть фатальным; мониторинг стула, профилактические слабительные                                                            | <a href="https://sps.nhs.uk/articles/managing-constipation-in-people-taking-clozapine/">https://sps.nhs.uk/articles/managing-constipation-in-people-taking-clozapine/</a>                 | NHS, Великобритания                                                        |
| M-micro_vitd    | LoPinto-Khoury C. et al. Мета-анализ: карбамазепин ассоциирован со снижением 25(OH)D                                                                                                                      | <a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34847425/">https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34847425/</a>                                                                                         | Epilepsy Research, 2021                                                    |
| M-micro_psyс    | Cuomo A. et al. Дефицит витамина D распространён в психиатрической популяции; рекомендован рутинный скрининг                                                                                              | <a href="https://www.frontiersin.org/journals/psychiatry/articles/10.3389/fpsy.2019.00167/full">https://www.frontiersin.org/journals/psychiatry/articles/10.3389/fpsy.2019.00167/full</a> | Frontiers in Psychiatry, 2019                                              |
| M-micro_b12     | Hanna S. Дефицит B12 и фолата у пожилых: связь с депрессией и когнитивными нарушениями, недодиагностика                                                                                                   | <a href="https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2781043/">https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2781043/</a>                                                                         | Primary Care Companion / PMC, 2009                                         |
| M-dental_porter | Porter J. et al. Более половины проживающих домов ухода сообщают о проблемах полости рта — преимущественно сухость во рту и плохо сидящие протезы                                                         | <a href="https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4501060/">https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4501060/</a>                                                                         | Int J Dent Hyg / PMC, 2015                                                 |
| M-guss_trapl    | Trapl M. et al. GUSS (Gugging Swallowing Screen): прикроватный скрининг дисфагии, валидирован против FEES, выполняется подготовленной медсестрой                                                          | <a href="https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.107.483933">https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.107.483933</a>                                                                                   | Stroke, 2007                                                               |
| M-eat10         | Belafsky P.C. et al. EAT-10: 10-пунктный опросник симптомов дисфагии (само- и интервью-версии)                                                                                                            | <a href="https://doi.org/10.1177/000348940811701210">https://doi.org/10.1177/000348940811701210</a>                                                                                       | Ann Otol Rhinol Laryngol, 2008                                             |
| M-comf_oralfeed | Oral feeding options for people with dementia: a systematic review                                                                                                                                        | <a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21391936/">https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21391936/</a>                                                                                         | систематический обзор (2011); PMID 21391936                                |
| M-comf_jnha     | Comfort feeding in hospitalised people with dementia: a retrospective study of survival following comfort feeding recommendations                                                                         | <a href="https://doi.org/10.1016/j.jnha.2024.100362">https://doi.org/10.1016/j.jnha.2024.100362</a>                                                                                       | J Nutr Health Aging, 2024; DOI 10.1016/j.jnha.2024.100362                  |
| M-hydr_esp      | Volkert D. et al. ESPEN guideline on clinical nutrition and hydration in geriatrics (Clin Nutr, 2019, 38(1): 10–47)                                                                                       | <a href="https://doi.org/10.1016/j.clnu.2018.05.029">https://doi.org/10.1016/j.clnu.2018.05.029</a>                                                                                       | ESPEN (Европейское общество клинического питания и метаболизма); Clin Nutr |
| M-hydr_palt     | Dehydration and Fluid Maintenance in the Long-Term Care Setting — клиническое руководство                                                                                                                 | <a href="https://paltmed.org/sites/default/files/2024-10/Dehydration%20CPG%2008092024.pdf">https://paltmed.org/sites/default/files/2024-10/Dehydration%20CPG%2008092024.pdf</a>           | PALTmed (Общество паллиативной медицины), 2024                             |
| M-hydr_low      | Narrative Review of Low-Intake Dehydration in Older Adults                                                                                                                                                | <a href="https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8470893/">https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8470893/</a>                                                                         | обзор (2021); PMC8470893                                                   |
| M-must_bapen    | BAPEN. MUST — Malnutrition Universal Screening Tool: 5-шаговый скрининг (ИМТ, непреднамеренная потеря >5 % за 3–6 мес, острое заболевание); для домов ухода — регулярное (обычно ежемесячное) взвешивание | <a href="https://www.bapen.org.uk/pdfs/must/must_explan.pdf">https://www.bapen.org.uk/pdfs/must/must_explan.pdf</a>                                                                       | BAPEN, Великобритания, 2003/2018                                           |

#### 44.3. Международные нормы и практики (I) — 44

| ID      | Что                                                                                       | Где / URL                                                                                                                                                                                                                                                                               | Проверено           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| I-cqc14 | CQC. Regulation 14: Meeting nutritional and hydration needs — руководство для поставщиков | <a href="https://www.cqc.org.uk/guidance-regulation/providers/regulations-service-providers-and-managers/health-social-care-act/regulation-14">https://www.cqc.org.uk/guidance-regulation/providers/regulations-service-providers-and-managers/health-social-care-act/regulation-14</a> | CQC, Великобритания |

| ID          | Что                                                                                                      | Где / URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Проверено                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| I-bda       | BDA. Nutrition and Hydration Digest / руководство по питанию в психиатрических стационарах               | <a href="https://www.bda.uk.com/asset/A18E6711-0DCF-4191-851AB06AC59B4C90/">https://www.bda.uk.com/asset/A18E6711-0DCF-4191-851AB06AC59B4C90/</a>                                                                                                                                                                                                 | British Dietetic Association |
| I-bda_res   | BDA. Практические ресурсы по питанию в психиатрии (лекарственно-пищевые взаимодействия)                  | <a href="https://www.bda.uk.com/practice-and-education/resources-for-practice/mental-health-learning-disability-inpatients.html">https://www.bda.uk.com/practice-and-education/resources-for-practice/mental-health-learning-disability-inpatients.html</a>                                                                                       | BDA                          |
| I-nhs2016   | Hospital Food Standards Panel. Standards for food and drink in NHS hospitals                             | <a href="https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5a806e1eed915d74e33fa61a/Hospital_Food_Panel_May_2016.pdf">https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5a806e1eed915d74e33fa61a/Hospital_Food_Panel_May_2016.pdf</a>                                                                                                                   | ДН, Великобритания, 2016     |
| I-aus6      | Strengthened Aged Care Quality Standards, Standard 6 – Food and Nutrition                                | <a href="https://www.agedcarequality.gov.au/providers/quality-standards/strengthened-aged-care-quality-standards">https://www.agedcarequality.gov.au/providers/quality-standards/strengthened-aged-care-quality-standards</a>                                                                                                                     | ACQSC, Австралия, 2025       |
| I-aus_iddsi | ACQSC. Texture-modified food and fluids (IDDSI, EDAR) – provider fact sheet                              | <a href="https://www.agedcarequality.gov.au/sites/default/files/media/fnd_providers_texturemodified.pdf">https://www.agedcarequality.gov.au/sites/default/files/media/fnd_providers_texturemodified.pdf</a>                                                                                                                                       | ACQSC, Австралия             |
| I-hugo      | Hugo C. et al. What does it cost to feed aged care residents in Australia? (Nutrition & Dietetics, 2018) | <a href="https://pure.bond.edu.au/ws/files/25958488/What_does_it_cost_to_feed_aged_care_residents_in_Australia.pdf">https://pure.bond.edu.au/ws/files/25958488/What_does_it_cost_to_feed_aged_care_residents_in_Australia.pdf</a>                                                                                                                 | Австралия, 2018              |
| I-fct       | Milte R. et al. Foodservice Costing Tool study (2022): полная стоимость пищевой службы; надбавка \$10    | <a href="https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9321358/">https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9321358/</a>                                                                                                                                                                                                                                 | Ун-т Квинсленд, 2022         |
| I-ontario   | O. Reg. 246/22 (General) под Fixing Long-Term Care Act 2021, ст. 75–80                                   | <a href="https://www.ontario.ca/laws/regulation/220246">https://www.ontario.ca/laws/regulation/220246</a>                                                                                                                                                                                                                                         | Онтарио, Канада, 2022        |
| I-dcbp      | Dietitians of Canada. Best Practices for Nutrition, Food Service and Dining in LTC Homes                 | <a href="https://www.dietitians.ca/DietitiansOfCanada/media/Documents/Resources/2019-Best-Practices-for-Nutrition,-Food-Service-and-Dining-in-Long-Term-Care-LTC-Homes.pdf">https://www.dietitians.ca/DietitiansOfCanada/media/Documents/Resources/2019-Best-Practices-for-Nutrition,-Food-Service-and-Dining-in-Long-Term-Care-LTC-Homes.pdf</a> | Онтарио, 2019                |
| I-m3mmar    | M3 (Making the Most of Mealtimes): адекватность меню и потребление (mMAR)                                | <a href="https://www.jnursinghomeresearch.com/1592-food-services-in-long-term-care-homes-are-associated-with-residents-food-intake.html">https://www.jnursinghomeresearch.com/1592-food-services-in-long-term-care-homes-are-associated-with-residents-food-intake.html</a>                                                                       | Канада                       |
| I-m3rel     | M3: реляционные практики за столом и качество приёма пищи                                                | <a href="https://uwspace.uwaterloo.ca/bitstreams/5dc2e5f7-d1dc-4580-8ece-4444695c8753/download">https://uwspace.uwaterloo.ca/bitstreams/5dc2e5f7-d1dc-4580-8ece-4444695c8753/download</a>                                                                                                                                                         | Канада                       |
| I-ont_fao   | FAO Ontario: финансирование LTC, конверт raw food                                                        | <a href="https://fao-on.org/wp-content/uploads/2024/08/Long-term-care-homes-program.pdf">https://fao-on.org/wp-content/uploads/2024/08/Long-term-care-homes-program.pdf</a>                                                                                                                                                                       | Онтарио, 2019                |
| I-osnac     | OSNAC: конверт nutritional support \$13,71 CAD/рез./день                                                 | <a href="https://www.osnac-fnat.com/mltc">https://www.osnac-fnat.com/mltc</a>                                                                                                                                                                                                                                                                     | Онтарио, 2020-е              |
| I-torstar   | Toronto Star: конверт сырья \$8,33 CAD (2017)                                                            | <a href="https://www.thestar.com/news/canada/ontario-nursing-homes-feed-seniors-on-8-33-a-day/article_6b7fab43-437c-5ba6-bbfb-0f1d6426062b.html">https://www.thestar.com/news/canada/ontario-nursing-homes-feed-seniors-on-8-33-a-day/article_6b7fab43-437c-5ba6-bbfb-0f1d6426062b.html</a>                                                       | Онтарио, 2017                |
| I-cfr       | 42 CFR § 483.60 Food and Nutrition Services (CMS)                                                        | <a href="https://www.law.cornell.edu/cfr/text/42/483.60">https://www.law.cornell.edu/cfr/text/42/483.60</a>                                                                                                                                                                                                                                       | США, 2016                    |
| I-ftag      | The Consumer Voice. Food Appendix (F-теги пищевого блока)                                                | <a href="https://theconsumervoice.org/wp-content/uploads/2026/06/Food-Appendix.pdf">https://theconsumervoice.org/wp-content/uploads/2026/06/Food-Appendix.pdf</a>                                                                                                                                                                                 | США                          |
| I-ftag2     | LTCSS. Fact Sheet: F-теги и достоинство                                                                  | <a href="https://nursinghome411.org/wp-content/uploads/2023/01/Fact-Sheet-Food-and-Dietary-Services.pdf">https://nursinghome411.org/wp-content/uploads/2023/01/Fact-Sheet-Food-and-Dietary-Services.pdf</a>                                                                                                                                       | США                          |
| I-pioneer   | Pioneer Network. Home-Style Dining Interventions                                                         | <a href="http://www.pioneernetwork.org/wp-content/uploads/2016/10/Home-Style-Dining-Interventions.pdf">http://www.pioneernetwork.org/wp-content/uploads/2016/10/Home-Style-Dining-Interventions.pdf</a>                                                                                                                                           | США                          |

| ID          | Что                                                                                                    | Где / URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Проверено                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| I-ghouse    | Green House Project: модель и независимая оценка (качество жизни, нейтральная стоимость)               | <a href="https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5338211/">https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5338211/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | США                       |
| I-eden      | Eden Alternative: философия и десять принципов                                                         | <a href="https://edenalt.org/">https://edenalt.org/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | США                       |
| I-anfp      | ANFP Benchmarking Program: расходы на сырьё в nursing homes                                            | <a href="https://www.anfponline.org/docs/default-source/legacy-docs/docs/benchmarking-program/anfpbenchmarkingprogramarticle-marchapril2018.pdf">https://www.anfponline.org/docs/default-source/legacy-docs/docs/benchmarking-program/anfpbenchmarkingprogramarticle-marchapril2018.pdf</a>                                                                                                                           | США                       |
| I-snn       | Skilled Nursing News: >25% домов снизили расходы на питание ниже \$10 (2025)                           | <a href="https://skillednursingnews.com/2025/04/more-than-25-of-nursing-homes-slash-food-spending-below-10-a-day/">https://skillednursingnews.com/2025/04/more-than-25-of-nursing-homes-slash-food-spending-below-10-a-day/</a>                                                                                                                                                                                       | США, 2025                 |
| I-lvnat     | Livsmedelverket. Nationella riktlinjer för måltider i äldreomsorgen (ночной интервал ≤11 ч; 6 приёмов) | <a href="https://www.livsmedelverket.se/49bd7f/globalassets/publikationsdatabas/broschyrrer-foldrar/riktlinjer_for_maltider_aldreomsorgen.pdf">https://www.livsmedelverket.se/49bd7f/globalassets/publikationsdatabas/broschyrrer-foldrar/riktlinjer_for_maltider_aldreomsorgen.pdf</a>                                                                                                                               | Швеция, 2021              |
| I-orebro    | Örebro kommun. Riktlinjer för mat, måltid och nutrition (IDDSI, процесс нутритивной помощи)            | <a href="https://www.orebro.se/download/18.5779588418bcc1d3d2313d8/1700215055156/Riktlinjer%20f%C3%B6r%20mat,%20m%C3%A5ltider%20och%20nutrition%20version%206,%2023-11-16.pdf">https://www.orebro.se/download/18.5779588418bcc1d3d2313d8/1700215055156/Riktlinjer%20f%C3%B6r%20mat,%20m%C3%A5ltider%20och%20nutrition%20version%206,%2023-11-16.pdf</a>                                                               | Швеция, 2023              |
| I-norrk     | Norrköpings kommun. Riktlinje för mat och måltider (охват SoL и LSS)                                   | <a href="https://norrkoping.se/download/18.5ff942e1184b3f255e22fdc2/1664797385777/Fastst%C3%A4lld%20riktlinje%20f%C3%B6r%20mat%20och%20m%C3%A5ltider%20september%202022.pdf">https://norrkoping.se/download/18.5ff942e1184b3f255e22fdc2/1664797385777/Fastst%C3%A4lld%20riktlinje%20f%C3%B6r%20mat%20och%20m%C3%A5ltider%20september%202022.pdf</a>                                                                   | Швеция, 2022              |
| I-tallg     | Region Jämtland: кейс Tallgläntan — замеры ночного голодания 2×/год                                    | <a href="https://www.regionjh.se/download/18.7b79416a31d3449611c4/1557149809111/2016-2-Skoglund-%C3%96hman.pdf">https://www.regionjh.se/download/18.7b79416a31d3449611c4/1557149809111/2016-2-Skoglund-%C3%96hman.pdf</a>                                                                                                                                                                                             | Швеция, 2016              |
| I-fin_nnc   | Suominen M. et al. Nutritional guidelines for older people (семейные трапезы, персонал ест вместе)     | <a href="https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12877505/">https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12877505/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Финляндия, 2022           |
| I-fin2020   | Ruokavirasto. New food recommendation for elderly care (2020)                                          | <a href="https://www.ruokavirasto.fi/en/foodstuffs/healthy-diet/uutiset/new-food-recommendation-for-elderly/">https://www.ruokavirasto.fi/en/foodstuffs/healthy-diet/uutiset/new-food-recommendation-for-elderly/</a>                                                                                                                                                                                                 | Финляндия, 2020           |
| I-dge       | DGE-QST для стационарных учреждений (Essbiografie, Wunschkost, Fingerfood, аудит)                      | <a href="https://www.bmleh.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Ernaehrung/GesundeErnaehrung/DGE-Standard_Seniorenverpflegung.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=4">https://www.bmleh.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Ernaehrung/GesundeErnaehrung/DGE-Standard_Seniorenverpflegung.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=4</a>                                                                                                           | Германия                  |
| I-dge_bettr | DGE-QST Betriebe/ Kliniken: цикл ≥4 недели, вегетарианское ежедневно, перекусы в любое время           | <a href="https://www.jobundfit.de/fileadmin/user_upload/medien/DGE-QST/DGE-Qualitaetsstandard_Betriebe_Behoerden_Hochschulen.pdf">https://www.jobundfit.de/fileadmin/user_upload/medien/DGE-QST/DGE-Qualitaetsstandard_Betriebe_Behoerden_Hochschulen.pdf</a>                                                                                                                                                         | Германия                  |
| I-at_qs     | Qualitätsstandard Ernährung в домах престарелых (Австрия, актуализация 2022)                           | <a href="https://www.sozialministerium.gv.at/dam/jcr:4f9ff5dc-a44c-4dee-b8d9-a22e6cd3c300/AKTUALISIERT_QS_f%C3%BCr_die_Ern%C3%A4hrung_in_Wohn-_und_Pflegeeinrichtungen_f%C3%BCr_Seniorinnen_und_Senioren.pdf">https://www.sozialministerium.gv.at/dam/jcr:4f9ff5dc-a44c-4dee-b8d9-a22e6cd3c300/AKTUALISIERT_QS_f%C3%BCr_die_Ern%C3%A4hrung_in_Wohn-_und_Pflegeeinrichtungen_f%C3%BCr_Seniorinnen_und_Senioren.pdf</a> | Sozialministerium Австрия |
| I-noe       | Niederösterreich «Tut gut». Leitlinie Gemeinschaftsverpflegung (цикл ≥4 недели, частоты)               | <a href="https://www.noetutgut.at/fileadmin/user_upload/noetutgutmedia/Downloads/Vitalkueche/Gemeinschaftsverpflegung_Leitlinie_Senioren.pdf">https://www.noetutgut.at/fileadmin/user_upload/noetutgutmedia/Downloads/Vitalkueche/Gemeinschaftsverpflegung_Leitlinie_Senioren.pdf</a>                                                                                                                                 | Австрия, 2021             |
| I-sunrise   | MedUni Graz (SUNRISE): аппетитные описания блюд меняют выбор                                           | <a href="https://www.medunigraz.at/frontend/user_upload/OEs/institute/pflegewissenschaft/pdf/Leitfaden_Interessierte.pdf">https://www.medunigraz.at/frontend/user_upload/OEs/institute/pflegewissenschaft/pdf/Leitfaden_Interessierte.pdf</a>                                                                                                                                                                         | Австрия, 2021             |
| I-jp2005    | NIPH Journal: реформа LTCI 2005 и пищевые доплаты                                                      | <a href="https://www.niph.go.jp/journal/data/55-1/200655010006.pdf">https://www.niph.go.jp/journal/data/55-1/200655010006.pdf</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Япония, 2006              |
| I-jpcov     | Доплата за нутритивный менеджмент: охват 87–94% учреждений (2020)                                      | <a href="https://comimi.jp/archives/column/kasan3">https://comimi.jp/archives/column/kasan3</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Япония, 2021              |

| ID         | Что                                                                                                                                                                                                              | Где / URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Проверено                             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| I-jp2021   | Ревизия тарифов 2021: усиленная доплата, обязательный стандарт, вычет, LIFE                                                                                                                                      | <a href="https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/2021housyuukaitei/documents/eiyoucaremanezimentonozyuuzitu.pdf">https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/2021housyuukaitei/documents/eiyoucaremanezimentonozyuuzitu.pdf</a>                                                                                                             | MHLW, Япония                          |
| I-jperia   | ERIA. Outcomes of Long-term Care in Japan (доплаты и исходы, HR 0,90)                                                                                                                                            | <a href="https://www.eria.org/uploads/media/Research-Project-Report/2020-13-Outcomes-of-Long-term-Care-Japan/Outcome-of-Long-term-Care-Insurance-Service-in-Japan-new.pdf">https://www.eria.org/uploads/media/Research-Project-Report/2020-13-Outcomes-of-Long-term-Care-Japan/Outcome-of-Long-term-Care-Insurance-Service-in-Japan-new.pdf</a> | Япония, 2020                          |
| I-jpdiet   | Больше диетологов → ниже потенциально предотвратимые госпитализации: HR 0,72 (95% ДИ 0,54–0,97), когорта 2909 жителей 235 домов                                                                                  | <a href="https://doi.org/10.1186/s12877-023-04278-2">https://doi.org/10.1186/s12877-023-04278-2</a>                                                                                                                                                                                                                                             | BMC Geriatrics, Япония, 2023          |
| I-crpd28   | КПИ, ст. 28 «Адекватный жизненный уровень и социальная защита»                                                                                                                                                   | <a href="https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities">https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities</a>                                                                                                                             | ООН                                   |
| I-gc1      | Замечание общего порядка № 1 (2014) Комитета ООН по правам инвалидов о ст. 12 КПИ (CRPD/C/GC/1)                                                                                                                  | <a href="https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/general-comment-no-1-article-12-equal-reco">https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/general-comment-no-1-article-12-equal-reco</a>                                                                                             | Комитет ООН по правам инвалидов, 2014 |
| I-qr_wafr  | Moro M.F. et al. Quality of care in mental health services, 4 страны Зап. Африки (BJPsych Open, 2022)                                                                                                            | <a href="https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8811781/">https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8811781/</a>                                                                                                                                                                                                                               | WHO QualityRights                     |
| I-qr_ghana | Moro M.F. et al. Nationwide QualityRights evaluation, Ghana (BMC Public Health, 2022)                                                                                                                            | <a href="https://link.springer.com/article/10.1186/s12889-022-13102-2">https://link.springer.com/article/10.1186/s12889-022-13102-2</a>                                                                                                                                                                                                         | 2022                                  |
| I-easyread | Великобритания: Accessible Information Standard — информация для пациентов с нарушениями предоставляется в доступных форматах (включая easy read: короткие фразы + изображения); Mencap — методические материалы | <a href="https://www.mencap.org.uk/help-and-advice/health/accessible-information-standard">https://www.mencap.org.uk/help-and-advice/health/accessible-information-standard</a>                                                                                                                                                                 | NHS England / Mencap, Великобритания  |

Итого: 34 + 48 + 44 = 126. Маркер без строки в этом списке — ошибка автора.

## Часть II. Учебные кейсы (22 разбора)

Двадцать два ситуационных разбора переводят главы в ежедневные решения: что нельзя, что сделать сразу, кто решает, какие документы нужны, каково долгосрочное решение и где граница вывода. Все кейсы учебные; они не описывают конкретные дома и людей.

### Учебные кейсы 1–4

Все кейсы в этом блоке — учебные ситуации, составленные для анализа. Они не описывают конкретные организации и конкретных людей. Правовые и медицинские основания — ориентиры для разбора, не заключение по реальному делу.

#### Кейс 1. Один вариант закончился до подхода последнего отделения

**Ситуация.** На обед два варианта второго: гречка с котлетой и рис с рыбой. Рыба кончилась на третьем из пяти отделений. Последние два получают только гречку; часть жителей выбирала рыбу утром по визуальному меню.

**Проблема.** Выбор реален для первых и фиктивен для последних. Срыв система обязана фиксировать, а не списывать на «неудачный день».

**Что нельзя делать.** Выдавать гречку молча, без объяснения. Переписывать лист заказа задним числом. По одному эпизоду решать, что «вариативность не работает».



**Немедленно.** Предложить замену из остатков линии — альтернативный гарнир, если есть. Записать в журнал срывов выбора: дата, позиция, сколько порций не хватило, кому предложена замена.

**Кто принимает решение.** Старшая смены раздачи — о замене на месте. Заведующий производством — о причине: неверный расчёт заказа или кривая статистика выбора.

**Документы.** Журнал срывов выбора (приложение 8), журнал заказа (приложение 7).

**Долгосрочное решение.** Пересчёт объёмов по статистике выбора за 2–4 недели (раздел 21). Живое распределение редко бывает «пятьдесят на пятьдесят». Стандартный вариант — с резервом, вариативный — по статистике.

**Основания.** Замена при недоступности выбранного — 42 CFR §483.60 (международный ориентир)<sup>35</sup>. В российской рамке — обязанность обеспечить питание по СанПиН 2.3/2.4.3590-20<sup>9</sup> и уважение достоинства (ст. 37, 43 закона 3185-1)<sup>8</sup>.

**Ограничение вывода.** Один эпизод — не статистика. Объёмы меняют по серии записей журнала.

## Кейс 2. Человек выбирает блюдо, противопоказанное по назначению врача

**Ситуация.** Житель с диетой с ограничением соли просит солёную рыбу соседа. Дееспособен, настроение решительное.

**Проблема.** Столкнулись две законные нормы: право на выбор и врачебное назначение. Серая зона: персонал чаще запрещает «вообще всё» или пускает на самотёк.

**Что нельзя делать.** Решать силой на линии раздачи. Давать запрещённое «чтобы не скандалил». Выяснять диагноз при других жителях.

**Немедленно.** Предложить разрешённый эквивалент из меню. Сказать: вопрос солёного — к врачу сегодня же. Зафиксировать запрос.

**Кто принимает решение.** Врач — единолично: скорректировать назначение, подтвердить ограничение и разъяснить его жителю либо оформить исключение с фиксацией риска. Персонал и директор назначения не меняют.

**Документы.** Пищевая карта с назначением, запись врача; при изменении — обновлённая карта.

**Долгосрочное решение.** Конфликт «выбор против назначения» в тот же день уходит врачу — правило положения о питании. У диетических столов тоже пары эквивалентов (раздел 19).

**Основания.** Врачебное назначение персонал СОСО не имеет права пересматривать. Стык соцобслуживания и лечебного питания — региональный «мост» (раздел 24, пример — распоряжение 19РВ-32)<sup>22</sup>. Выбор — внутри назначенных рамок (ст. 37, 43 закона 3185-1)<sup>8</sup>.

**Ограничение вывода.** Кейс задаёт маршрут, не судит, «кто прав». Ответ даёт врач.

## Кейс 3. Недееспособный житель показывает на фотографию блюда

**Ситуация.** На визуальном меню житель с выраженным когнитивным снижением тычет в борщ. Сиделка: «Он всегда на первую картинку показывает, это не выбор».

**Проблема.** Как отличить выбор от рефлекса — и кто вправе объявить жест «не выбором».

**Что нельзя делать.** Игнорировать жест: «всё равно не выбор». Исполнять без проверки, если человек показывает на любую первую картинку. Исключать из процедуры навсегда по одному наблюдению.

**Немедленно.** Поменять порядок фотографий. Показывает на борщ независимо от места — выбор. Всегда на первую картинку — позиция, не содержание. Результат — в форму наблюдения.

**Кто принимает решение.** Смена фиксирует. Вывод о предпочтениях — в пищевую карту по нескольким наблюдениям: знающий жителя персонал, при возможности — близкие (раздел 15).

**Документы.** Форма наблюдения за невербальным выбором (приложение 6), пищевая карта.

**Долгосрочное решение.** Индивидуальный протокол: две карточки, не пять; время показа; проверка позиционного эффекта раз в месяц. Предпочтения и способности меняются.

**Основания.** Предпочтения учитывают независимо от когнитивного статуса: австралийский Стандарт 6 с 01.11.2025<sup>34</sup>; Онтарио — preferences в плане питания<sup>23</sup>. В российской рамке — ст. 37 через процедуру<sup>8</sup>.

**Ограничение вывода.** Перестановка — скрининг, не психологическая диагностика. Она не подменяет знание человека.

## Кейс 4. Персонал заполняет лист выбора заранее

**Ситуация.** Заведующая отделением обнаруживает: лист заказа на завтра заполнен сегодня днём — до показа меню. Сиделка: «Так быстрее, я и так знаю, кто что ест».

**Проблема.** Процедура есть, выбора нет. Документы при проверке «докажут» то, чего не было (раздел 21).

**Что нельзя делать.** Устраивать показательный разбор при смене. Списывать на «лень» — почти всегда не хватает времени на процедуру. Отменять журнал как «бесполезный»: проблема в наполнении, не в журнале.

**Немедленно.** Аннулировать предзаполненный лист. Провести выбор с жителями заново в тот же вечер. Спросить сиделку, сколько времени реально занимает показ меню.

**Кто принимает решение.** Заведующая отделением — о процедуре. Директор — если причина в дефиците времени смены (нормы нагрузки, раздел 28).

**Документы.** Журнал заказа, служебная записка о нарушении процедуры; при повторении — материалы внутренней проверки.

**Долгосрочное решение.** Меню висит заранее, показ — минуты на человека, выбор фиксируется при жителе. Проверка реальности (приложение 24): раз в неделю случайный опрос пяти жителей — «что вы вчера заказывали».

**Основания.** Документ, не соответствующий фактам, — худшая позиция перед проверкой (раздел 32). Нормы о выборе требуют реальной, не бумажной альтернативы<sup>35, 23</sup>.

**Ограничение вывода.** Злого умысла эпизод не доказывает. «я знаю, кто что ест» часто правда по содержанию. Беда — подмена процедуры знанием.

## Учебные кейсы 5–8

*Все кейсы — учебные ситуации, составленные для анализа.*

### Кейс 5. Житель отказывается от еды из-за подозрения в отравлении

**Ситуация.** Житель с психотическим расстройством второй день не ест: «Здесь отравлено». Убеждение бредовое. Вес пока стабилен.

**Проблема.** Отказ встроен в клинику: обычные приёмы не работают, бездействие опасно.

**Что нельзя делать.** Доказывать, что еда не отравлена: логика против бреда усиливает недоверие. Кормить принудительно — насилие недопустимо ни в какой форме (раздел 12). Ждать «пока проголодается» без мониторинга.

**Немедленно.** Врач — в тот же день. Правило трёх отказов срабатывает раньше: бредовая мотивировка сама по себе клинический сигнал. Приёмы смены, не нарушающие доверия: запечатанная упаковка, еда из общего котла при жителе, выбор тарелки из нескольких, участие человека, которому он доверяет.

**Кто принимает решение.** Врач — о клинической тактике, включая коррекцию терапии. Смена — о формате подачи. Директор — об условиях: выбор тарелки, упакованные продукты.

**Документы.** Журнал отказов (приложение 9), запись врача, динамика веса.

**Долгосрочное решение.** План питания на обострение: упаковка, «магазинные» продукты, приготовление на глазах, где возможно. Структурированная доступность еды (раздел 13) здесь держит нутритивный статус.

**Основания.** Принудительное кормление недопустимо — ст. 37 закона 3185-1 (гуманное обращение)<sup>8</sup>. Недоедание при отказах имеет летальную значимость (пневмония, истощение)<sup>1, 14</sup>.

**Ограничение вывода.** Приёмы «обхода» бреда — тактика на обострение, не постоянная модель. По выходе формат пересматривает врач.

### Кейс 6. Житель спит во время завтрака из-за седативного эффекта

**Ситуация.** Вечерний приём препаратов перенесён на 22:00. Утром пятеро спят через завтрак; к 11:00 голодны и раздражительны, кухня завтрак уже убрала.

**Проблема.** Фармакология столкнулась с расписанием: режим питания не подстроен под ритм жителей.

**Что нельзя делать.** Будить насильно «потому что завтрак». Оставлять без завтрака — «виноваты сами». Менять время препаратов самостоятельно: компетенция врача.

**Немедленно.** Сохранить завтрак для спящих: отложенные порции — с температурным режимом и сроками (раздел 18). Сообщить врачу картину утра.

**Кто принимает решение.** Врач — о времени приёма: перенос на более ранний вечер часто закрывает проблему. Заведующий производством — о формате отложенного завтрака. Директор — о расписании.

**Документы.** Расписание, запись врача о времени приёма, журнал выдачи отложенных порций.

**Долгосрочное решение.** Гибкое окно завтрака — например, 8:00–9:30 — вместо точки 8:30. Согласование расписания с назначением — постоянная процедура при каждой смене схем терапии.

**Основания.** Режим питания СОСО по СанПиН — не реже трёхразового, с учётом заключения врача для нуждающихся (п. 7.1.11–7.1.14 3590-20; с 01.09.2026 — п. 56 подп. 11 4282-26)<sup>9</sup>. Седация как побочный эффект — реальность антипсихотической терапии<sup>61</sup>. Ориентир гибкости: «что, когда, где и как я ем» (Стандарт 6)<sup>34</sup>.

**Ограничение вывода.** Гибкое окно — диапазон режима, не его отмена. Температура и сроки выдачи сохраняются полностью.

## Кейс 7. Два жителя отбирают еду друг у друга

**Ситуация.** За столом на шестерых один систематически забирает котлету у соседа. Тот не сопротивляется, потом доедает хлеб с чаем. Смена «не замечает»: вмешательство провоцирует агрессию.

**Проблема.** Скрытое недоедание одного плюс пищевая агрессия другого. Молчание смены подписывает обоих в риск.

**Что нельзя делать.** Наказывать отбирающего лишением еды — еда не инструмент вознаграждения и наказания (раздел 20). Сажать «обидчика» в одиночку навсегда без наблюдения. Считать, что «они сами разберутся».

**Немедленно.** Развести по разным столам сегодня же. Потерпевшему — полная порция под наблюдением. Зафиксировать эпизод.

**Кто принимает решение.** Старшая смены — о рассадке. Врач — об оценке пищевого поведения: гиперфагия, импульсивность, когнитивное снижение — разные механизмы (раздел 13). Заведующая отделением — о постоянной схеме столов.

**Документы.** Запись об инциденте, пищевые карты обоих; при повторении — протокол разбора (приложение 34).

**Долгосрочное решение.** Схема рассадки как документ отделения: кто с кем сидит и почему. Для жителя с гиперфагией — структурированный режим доступности еды, снижающий «охоту» за чужими порциями (раздел 13). Для потерпевшего — контроль веса.

**Основания.** Пищевая агрессия и гиперфагия — описанные паттерны при психических расстройствах<sup>40, 112</sup>. Защищать жителя от вредного воздействия других — из логики ст. 37<sup>8</sup>.

**Ограничение вывода.** Рассадка — рабочий инструмент, не наказание. Схему пересматривают, не закрепляют пожизненно.

## Кейс 8. Человек быстро заглатывает куски

**Ситуация.** Житель ест очень быстро, не прожёвывая, большими кусками. Дважды за месяц — поперхивание с кашлем. Врач в отпуске, замещающий придёт через неделю.

**Проблема.** Быстрое заглатывание — фактор риска аспирации. Ждать врача неделю без промежуточных мер — неоправданный риск.

**Что нельзя делать.** Ждать без изменений. Переводить на полностью протёртое «на всякий случай» без назначения: излишняя модификация бьёт по качеству жизни и питательности. Команда «есть медленно!» не работает.

**Немедленно.** Меньшие порции с добавкой, не большая сразу. Куски меньшего размера по просьбе повара — сервировка, не диета. Напиток под рукой. Место в поле зрения смены. Его стол обслуживается первым — снять мотив «надо успеть».

**Кто принимает решение.** Смена — о сервировке и наблюдении. Замещающий врач — о скрининге дисфагии по прибытии. При повторном поперхивании — врач вне очереди: признак из списка дисфагического риска (раздел 10).

**Документы.** Форма наблюдения, запись о поперхиваниях; после врача, при подтверждении риска — назначение текстуры по IDDSI<sup>42</sup>.

**Долгосрочное решение.** Скрининг дисфагии; при подтверждении — текстура, темповые техники, позиция за столом. Обучение смены приёмам безопасного кормления (раздел 10).

**Основания.** Поперхивание при еде — маркер риска аспирационной пневмонии, самого летального осложнения дисфагии<sup>24, 41</sup>. Связь текстуры с исходами — во внедрениях IDDSI<sup>43</sup>.

**Ограничение вывода.** Организационные меры — мост до врача, не замена скрининга. «Ест дважды поперхнулся» — основание для внеочередной оценки.

## Учебные кейсы 9–12

Все кейсы — учебные ситуации, составленные для анализа.

## Кейс 9. Кухня приготовила протёртое блюдо, не соответствующее назначенной текстуре

**Ситуация.** Жителю назначена текстура IDDSI 6 — мягкая, кусочками. Кухня дала «как обычно протёртое»: однородное пюре, это IDDSI 4. Разница видна невооружённым глазом — но не тому, кто не обучен.

**Проблема.** Ошибка в обе стороны опасна. Слишком грубая текстура — риск аспирации. Слишком гладкая — избыточная модификация: меньше питательной плотности, хуже сытость, унижающий «детский» вид тарелки.

**Что нельзя делать.** Выдать как есть — «протёртое же». Разбавлять пюре водой или бульоном «до нужной консистенции»: текстура и питательность меняются непредсказуемо. Считать, что «пюре безопаснее, пусть будет пюре»: избыточная модификация тоже вред.

**Немедленно.** Не выдавать. Дать порцию назначенной текстуры из доступных компонентов: мягкие кусочки — котлета, тушёные овощи — есть в стандартном меню. Зафиксировать несоответствие.

**Кто принимает решение.** Заведующий производством — о порции сегодня. Врач — если несоответствие повторяется: возможно, назначение не доведено до кухни. Директор — если кухня не обучена шкале IDDSI.

**Документы.** Назначение текстуры в пищевой карте и на кухонной карточке, запись о несоответствии.

**Долгосрочное решение.** Карточка текстур на стене кухни: вилка IDDSI с фотографиями из собственного меню. Обучение поваров тесту вилок и тесту наклона — минута на блюдо (раздел 10). Проверка текстур старшей сменой при выходе линии.

**Основания.** IDDSI — международный стандарт описания текстур<sup>42</sup>. Внедрение улучшает соответствие назначенной текстуры фактической<sup>43</sup>. Исполнение назначения — п. 7.1.12 СанПиН 3590-20 (с 01.09.2026 — п. 56 подп. 11 4282-26: питание по медицинским показаниям)<sup>9</sup>.

**Ограничение вывода.** Самопроверка кухни — организационная мера. Назначение и его пересмотр остаются на враче.

## Кейс 10. Родственник требует запретить продукт без врачебного назначения

**Ситуация.** Дочь требует: «Уберите отцу сахар совсем — у него преддиабет, я читала». Назначения по сахару нет. Отец сахар любит, споров не хочет, на вопросы отмалчивается.

**Проблема.** Третья сторона требует ограничить права жителя без клинического основания. Конфликт заботы, контроля и автономии.

**Что нельзя делать.** Исполнить молча — «родственникам виднее». Отмахнуться — «вы нам не указ»: родственник важен и может знать факты. Втягивать жителя в спор, «кто главнее».

**Немедленно.** Зафиксировать запрос письменно — заявление родственника. Маршрутизировать врачу: есть основания — назначит; нет — разъяснит родственнице. Позицию жителя выяснить отдельно и спокойно.

**Кто принимает решение.** Врач — о клинической стороне. Житель (дееспособный) — о питании в пределах назначений. Директор — о регламенте приёма заявлений.

**Документы.** Заявление родственника, запись врача, пищевая карта (позиция жителя).

**Долгосрочное решение.** Регламент «третьих сторон»: запрос на ограничение — только через врача и с учётом позиции жителя. Памятка родственникам (приложение 32): заранее объявленное правило снимает большинство конфликтов.

**Основания.** Права жителя не ограничивают по требованию третьих лиц без оснований (ст. 37, 43 закона 3185-1)<sup>8</sup>. Близкие — источник информации, не источник запретов (раздел 15).

**Ограничение вывода.** Если житель недееспособен и опекун — учреждение, конфликт интересов — по процедуре раздела 16: зафиксированные предпочтения имеют приоритет над «усреднённым благом».

## Кейс 11. Житель требует добавку при медицинском ограничении

**Ситуация.** Житель с ожирением на фоне терапии — набор веса известный эффект его препаратов — требует вторую порцию каждый обед. Врач рекомендовал контроль калорийности. Житель кричит: «Вы меня морите голодом».

**Проблема.** Гиперфагия лекарственного генеза против назначенного ограничения. Публичный конфликт за столом дестабилизирует отделение.

**Что нельзя делать.** Давать добавку «чтобы замолчал»: назначение обесценивается ежедневным исключением. Читать нотации о весе при всех. Оставлять конфликт на уровне «сиделка решает каждый день по настроению».

**Немедленно.** Выдать запланированную порцию спокойно, без лекции. Эскалация врачу — не «жалоба на жителя», а запрос на пересмотр тактики: низкокалорийные объёмные добавки (овощи), дробность, пересмотр препарата.

**Кто принимает решение.** Врач — о назначении и его коррекции. Смена исполняет назначение одинаково каждый день. Директор обеспечивает кухне низкокалорийные объёмные добавки.

**Документы.** Назначение врача, пищевая карта, динамика веса, записи о конфликтах.

**Долгосрочное решение.** Структурированный ответ на гиперфагию (раздел 13): объёмные низкокалорийные компоненты, дробный режим, ночная доступность там, где ночное едение — часть картины. Метаболический мониторинг веса, глюкозы, липидов — по стандартам для его терапии<sup>61, 59</sup>.

**Основания.** Набор веса на антипсихотиках — документированный дозозависимый эффект<sup>13, 60</sup>. Гиперфагия и ночное едение — специфические синдромы<sup>40</sup>. Исполнять назначение — п. 7.1.12 СанПиН 3590-20 (с 01.09.2026 — п. 56 подп. 11 4282-26)<sup>9</sup>.

**Ограничение вывода.** «Добавка или нет» — вопрос назначения, не дисциплины. Смягчение и ужесточение — только через врача.

## Кейс 12. Выбор есть только на бумаге

**Ситуация.** Положение о вариативном питании утверждено полгода назад. Меню с двумя колонками висит, кухня готовит один вариант — «второй никто никогда не заказывал». Журнал заказов пуст.

**Проблема.** Фиктивная вариативность организационного масштаба — не операционного, как в кейсе 4. Система самообмана, которая при проверке становится обманом документальным.

**Что нельзя делать.** Считать: «положение есть — практика есть». Наказывать кухню: она рационально адаптировалась к нулевому спросу. Тихо снять колонку меню и забыть.

**Немедленно.** Диагностика по пяти признакам фиктивной вариативности (раздел 21): знают ли жители о выборе; показывает ли кто-то меню; реально ли приготовить второй вариант; что с журналом; спросить пятерых: «вы знали, что можно выбрать?».

**Кто принимает решение.** Директор. Это провал внедрения, не исполнителей: процедура не была встроена в ритм отделений.

**Документы.** Положение, меню, журнал, результаты диагностики, служебная записка.

**Долгосрочное решение.** Перезапуск как пилот (раздел 35): одна точка, показ меню как обязанность смены, журнал, замер через 90 дней. Положение без процедуры — предмет для переписывания, не для полки.

**Основания.** Различие «документ — практика» — ядро международных проверок: рейтинги CQC оценивают фактический опыт жителей, а не положения<sup>39</sup>. Соответствие документов практике — ответственность управленческая (раздел 33).

**Ограничение вывода.** Нулевой спрос в первые недели — норма: эффект новизны работает в обе стороны. Вывод о фиктивности — по данным месяцев, не дней.

## Учебные кейсы 13–16

*Все кейсы — учебные ситуации, составленные для анализа.*

### Кейс 13. Бухгалтерия не может связать выбор со списанием

**Ситуация.** Вариативная линия работает месяц. Бухгалтерия: «Журнал заказа живёт в отделении, списание продуктов идёт по укрупнённым нормам — как нам свести, сколько гречки и сколько риса списать?»

**Проблема.** Два потока данных — заказы и склад — не соединены. Риск — необоснованное списание при первой финансовой проверке.

**Что нельзя делать.** Списывать «как раньше, пополам»: фиктивная точность хуже честного метода. Требовать от бухгалтерии «разобраться самим» — им не хватает данных отделений. Сворачивать вариативность из-за учёта: задача решаемая (раздел 29).

**Немедленно.** Назначить ответственного за сведение. Ежедневные итоги журнала заказа — сколько порций какого варианта выдано — уходят в бухгалтерию: одна строка на позицию.

**Кто принимает решение.** Главный бухгалтер совместно с заведующим производством — о методике списания по фактической выдаче. Директор приказом закрепляет форму и ответственных.

**Документы.** Форма сведения (приложение 7 + учётная форма), приказ о порядке учёта вариативных позиций, действующие учётные формы по 52н с учётом переходного статуса<sup>106</sup>.

**Долгосрочное решение.** Списание по факту выдачи: статистика выбора за месяц даёт пропорцию списания парных продуктов. Уточнить у учредителя признаваемую форму — статусы форм меняются поэтапно<sup>106</sup>.

**Основания.** Принцип достоверности учёта. Методика «выдано по заказам = списано по пропорции» — стандарт поточных кухонь, не изобретение.



**Ограничение вывода.** Методика согласуется с учредителем и учётной политикой. Приложение — проект локальной формы, не норматив.

#### Кейс 14. Поставщик не привёз один из вариантов

**Ситуация.** По контракту на завтра — рыба для вариативной позиции. Поставщик вечером: рыбы нет, будет курица. Заказы собраны, треть выбрала рыбу.

**Проблема.** Разрыв цепочки «закупка — меню — заказ»: выбор сделан под продукт, которого не будет.

**Что нельзя делать.** Молча заменить рыбу курицей во всех порциях. Объявить «завтра без выбора» как новую норму. Скандал поставщику без бумаги: претензионная работа живёт в документах (раздел 30).

**Немедленно.** Повторный показ вечером: «рыбы завтра не будет, есть курица и второй вариант — перезаказ». При честном перезаказе почти весь спрос перераспределяется без конфликтов.

**Кто принимает решение.** Заведующий производством — о замене позиции. Старшая смены отделений — о перезаказе. Ответственный за контракт — о претензии поставщику.

**Документы.** Акт о недопоставке, претензия по контракту, запись о перезаказе в журнале заказа.

**Долгосрочное решение.** В спецификации закупки — правило взаимозаменяемости с нутриентными эквивалентами (раздел 30). Резервная пара из долгохранящихся продуктов на случай срыва. Статистика срывов — аргумент при следующей закупке.

**Основания.** Исполнение контракта и претензионная работа — 44-ФЗ и условия контракта. Полноценный приём пищи при срыве — из обязанности обеспечить питание<sup>9</sup>.

**Ограничение вывода.** Единичный срыв — рабочая ситуация. Систематические — повод пересмотреть отношения с поставщиком по документам, не по раздражению.

#### Кейс 15. Персонал использует десерт как поощрение

**Ситуация.** В отделении укоренилось: «Кто убрал за собой — получает компот с булочкой, кто нет — просто компот». Сиделки считают это педагогикой.

**Проблема.** Еда стала рычагом поведения. Нарушение принципа «питание — право, а не награда» (раздел 20) и нормы о гуманном обращении.

**Что нельзя делать.** Закрывать глаза — «мелочь же»: из мелочей собирается культура столовой. Наказывать сиделок без объяснения: практика укоренилась — вина системная. Запрещать булочки «чтобы не было соблазна».

**Немедленно.** Прекратить дифференциальную выдачу сегодня же: десерт получают все по норме. Разговор со сменой — не о «плохих людях», а о правиле и его основаниях.

**Кто принимает решение.** Заведующая отделением — о прекращении практики. Директор — о фиксации правила в документах. Врач — если у кого-то ограничения по сладкому: альтернатива, не лишение.

**Документы.** Правило в положении о питании: «пища не используется как поощрение или наказание». Памятка персоналу (приложение 31), запись об инструктаже.

**Долгосрочное решение.** Инструктаж первого уровня (раздел 28) с правилом в явном виде. Правило — в контрольные вопросы обходов. Для сиделок — легальные инструменты поощрения: словесные, режимные, привилегии вне еды.

**Основания.** Гуманное обращение и недопустимость лишения питания — ст. 37 закона 3185-1<sup>8</sup>. Еда как рычаг — маркер институциональной культуры; СЭС трактует это как дефект ухода<sup>39</sup>.

**Ограничение вывода.** Правило касается еды как рычага. Оно не запрещает праздничные столы и совместную готовку как деятельность. Граница — в условности: «получишь, если».

#### Кейс 16. Житель не говорит, но систематически оставляет одну кашу

**Ситуация.** Немой житель два месяца подряд не трогает манную кашу — ест всё остальное. Смена: «не ест манную». Диетолога нет. Врач: «раз ест остальное — порядок».

**Проблема.** Невербальное сообщение система уже расшифровала, но не закрепила. Предпочтение живёт в голове смены и умрёт с её ротацией.

**Что нельзя делать.** Выдавать манную «по меню» и выбрасывать: отходы плюс ежедневное игнорирование сказанного. Делать из одного наблюдения теорию — «у него аверсия к текстуре»: возможно, но это гипотеза для наблюдения (раздел 15). Оставлять знание неформальным.

**Немедленно.** В пищевую карту: «манную не ест (наблюдение, 2 мес.) — замена: любая другая каша». Проверить: при выдаче другой каши — ест.

**Кто принимает решение.** Смена фиксирует. Заведующая отделением утверждает запись в карте. Врач — если появятся признаки, что дело не во вкусе, а в текстуре или глотании (раздел 10).

**Документы.** Пищевая карта, форма наблюдения (приложение 6).

**Долгосрочное решение.** Пересмотр пищевых карт раз в квартал: предпочтения меняются, карта — живой документ. Замены из карты — в статистику планирования закупок (раздел 21).

**Основания.** Наблюдение — легитимный канал воли невербального жителя (раздел 15). Учёт предпочтений независимо от способности их высказать — международная норма<sup>34, 23</sup>.

**Ограничение вывода.** «Не ест манную» — фиксация наблюдаемого, не диагноз. При признаках дисфагии маршрут становится клиническим.

## Учебные кейсы 17–20

*Все кейсы — учебные ситуации, составленные для анализа.*

### Кейс 17. Житель хочет есть позже установленного времени

**Ситуация.** Ужин в 17:30. Житель годами ужинал дома в 20:00: в 17:30 не голоден, к 20:00 — голоден и зол. Просит «просто оставить мне тарелку».

**Проблема.** Режим против биографии. Одна из самых частых и самых решаемых точек трения (раздел 9).

**Что нельзя делать.** Отвечать «режим для всех один»: режим — инструмент, не ценность. Оставлять тарелку на столе на 2,5 часа — санитарно недопустимо: температура, сроки. Делать вид, что просьбы не было.

**Немедленно.** Отложенная порция по правилам: снимается с линии, хранится по температурному режиму, выдаётся в 20:00. Либо поздний перекус — чай, выпечка, кефир — из буфетной зоны, если она есть.

**Кто принимает решение.** Старшая смены — о ежедневной отложенной порции. Заведующий производством — о санитарно корректной схеме. Директор — если таких жителей много: сдвиг режима или второе окно ужина.

**Документы.** Пищевая карта (привычное время), распорядок с правилом отложенных порций, журнал выдачи.

**Долгосрочное решение.** Гибкие окна приёмов пищи (раздел 20) и ночная доступность там, где она показана (раздел 13). При массовом запросе — пересмотр распорядка. Международный опыт идёт к «когда я ем» как элементу прав<sup>34</sup>. Шведская норма ночного интервала — не более 11 часов: режимы проектируют от физиологии, не от удобства кухни<sup>30</sup>.

**Основания.** СанПиН задаёт кратность — не реже трёхразового — и учёт заключения врача, а не астрономическое время ужина<sup>9</sup>. Привычный ритм — элемент уважения биографии (ст. 37)<sup>8</sup>.

**Ограничение вывода.** Отложенная порция — сервис для отдельных жителей. Когда исключение становится массовым, менять надо режим, а не плодить исключения.

### Кейс 18. В отделении не хватает работников для помощи за столом

**Ситуация.** 12 жителей нуждаются в помощи при еде. В смену — две сиделки. Норма помощи под «готовые руки» (1:2)<sup>23</sup> выполняется формально: кормят всех одновременно, темп конвейерный, двое регулярно не доедают.

**Проблема.** Дефицит рук — самая дорогая и самая честная проблема питания (раздел 28). Её не закрывают ни журналы, ни меню.

**Что нельзя делать.** Ускорять кормление — «по ложке в минуту»: риск аспирации и ежедневное унижение. Переводить всех на пюре «чтобы быстрее елось» без назначения. Писать, что помощь оказывается «в полном объёме».

**Немедленно.** Помощь по приоритету риска: сначала жители с дисфагическим риском (список из раздела 10). Для остальных — порционная сервировка, адаптивная посуда, рассадка «помогающий между двумя нуждающимися». Дефицит — служебной запиской директору, документ для раздела 38.

**Кто принимает решение.** Директор — о перераспределении смен между отделениями и о запросе учредителю (форма сообщения о дефиците — приложение 33). Старшая смены — о приоритете внутри смены.

**Документы.** Список дисфагического риска, служебная записка о дефиците, форма учёта трудозатрат (приложение 26) — замер реальных минут помощи.

**Долгосрочное решение.** Замер трудозатрат: минуты на жителя × число нуждающихся × приёмы пищи. Честный аргумент в разговоре о ставках (раздел 29: стоимость кормления — самая скрытая строка)<sup>56</sup>. Параллельно — форматы самостоятельности: адаптивная посуда, «семейная» подача части блюд.

**Основания.** Норма 1:2 под «готовые руки» — онтарийский стандарт, ориентир, не российский норматив<sup>23</sup>. Обеспечить потребление назначенного питания — из ст. 37/43 и СанПиН<sup>8, 9</sup>.

**Ограничение вывода.** Перераспределение и форматы — купирование, не решение. Решение — штатное, путь к нему — документированный замер дефицита.

### Кейс 19. Директор получает жалобу от родственника

**Ситуация.** Письмо: «Моего брата кормят одной перловкой, на фото из отделения — серая масса. Требую разобраться, копия — в прокуратуру». Факты: перловка была вчера, фото месяц назад при неудачном свете, брат ест нормально, меню действительно монотонно.

**Проблема.** Жалоба неточна по фактам и точна по существу — монотонность. Формальная отписка здесь проигрывает.

**Что нельзя делать.** Отвечать одним опровержением — «перловка была один раз»: родственник читает это как «нам всё равно». Искать виноватого до выяснения. Обещать «разобраться и наказать»: жалоба не о наказании.

**Немедленно.** Запросить факты: меню за месяц, журнал замен, вес жителя. Пригласить родственника на обед — личный визит снимает 80% конфликта. Письменный ответ по существу: что проверено, что подтвердилось, что меняется.

**Кто принимает решение.** Директор лично. Жалоба с копией в прокуратуру не делегируется.

**Документы.** Жалоба, материалы проверки, ответ заявителю; при системном выводе — пилот вариативности (раздел 35) или совет жителей с участием родственников (раздел 34).

**Долгосрочное решение.** Регламент разбора жалоб и инцидентов (приложение 34): сроки, обязательный личный контакт, системные выводы. Родственники — неоплаченные аудиторы качества. Дни открытых дверей и дегустации совета дешевле любой PR-службы.

**Основания.** Прокурорский контур по жалобам — реальный риск-градиент (раздел 33)<sup>75, 76</sup>. Ответ по существу — и правовая, и управленческая норма.

**Ограничение вывода.** Не каждая жалоба справедлива. Регламент защищает обе стороны: жителя — от плохой еды, организацию — от капризных конфликтов.

### Кейс 20. Прокуратура просит показать, как учитывается мнение недееспособных жителей

**Ситуация.** Запрос по итогам плановой проверки: «Представить документы, подтверждающие учёт мнения и предпочтений жителей, признанных недееспособными, при организации питания». В организации 70% жителей недееспособны.

**Проблема.** Нет документированных процедур учёта невербальной воли — ответить нечем.

**Что нельзя делать.** Отвечать «их интересы представляет опекун»: опекун здесь само учреждение, конфликт интересов очевиден (раздел 16). Изготавливать документы задним числом: это выясняется и усугубляет. Отделываться фразами о «заботе».

**Немедленно.** Собрать то, что есть честно: пищевые карты с наблюдениями, протоколы совета жителей — если есть представители интересов, — журнал замен. Документов мало — честный ответ о текущем состоянии плюс план с датами: формы наблюдения (приложение 6), опрос, совет.

**Кто принимает решение.** Директор — об ответе. Заведующие отделениями — о сборе существующих записей. Юрист / учредитель — о форме ответа.

**Документы.** Ответ на запрос, план мероприятий с датами и ответственными, приказ о внедрении процедур.

**Долгосрочное решение.** Полный контур раздела 15: четыре канала воли, формы наблюдения, пищевые карты, протоколы совета. После внедрения такой запрос закрывается папкой за час.

**Основания.** Ст. 37/43 закона 3185-1 — права не зависят от дееспособности<sup>8</sup>. КПИ и общие замечания ККИ — о поддерживаемом принятии решений<sup>77, 26</sup>. Международные нормы прямо требуют учёта предпочтений при когнитивных ограничениях<sup>34, 23</sup>.

**Ограничение вывода.** Запрос прокуратуры — не обвинение. Честный ответ с планом почти всегда завершает сюжет. Вымученная «идеальная папка» — начинает его.

## Учебные кейсы 21–22

*Все кейсы — учебные ситуации, составленные для анализа.*

### Кейс 21. Учредитель не выделяет средства на дополнительный персонал

**Ситуация.** Замер трудозатрат: для нормальной помощи за столом не хватает трёх ставок сиделок. Учредитель: «Денег нет, решайте в рамках имеющихся ресурсов». Директор в отчаянии: без рук всё остальное — декорация.

**Проблема.** Предел компетенции директора — и проверка: не стал ли отказ удобным объяснением бездействия.

**Что нельзя делать.** Ссылаться на отказ как на индульгенцию — «денег нет — ничего не можем»: часть изменений стоит минуты, не ставки. Требовать «или дайте людей, или не мешайте»: конфронтация без данных проигрывает. Скрывать дефицит дальше: молчание фиксирует статус-кво как норму.

**Немедленно.** Два списка. «Нулевая стоимость» — рассадка, приоритет риска, отложенные порции, адаптивная посуда из имеющейся, форматы самостоятельности — внедряется сразу. «Требует ресурсов» — ставки, обучение, оборудование — в повторный запрос с данными замера.

**Кто принимает решение.** Директор — о списке нулевой стоимости. Учредитель — о ставках. Повторный запрос директор обязан сделать документированным: числа, сценарии, последствия бездействия.

**Документы.** Форма учёта трудозатрат (приложение 26), форма сообщения учредителю о дефиците (приложение 33), план нулевой стоимости с датами.

**Долгосрочное решение.** Повторные запросы раз в квартал с обновлёнными данными. Решения о ставках принимают на третий-четвёртый документированный запрос, не на первый. Параллельно — показатель помощи в отчётность (раздел 39, предложение 3).

**Основания.** Стоимость кормления как скрытая строка — раздел 29<sup>56</sup>. Организация обязана обеспечить потребление питания имеющимися ресурсами с максимальным качеством и одновременно документировать дефицит (ст. 37/43)<sup>8</sup>.

**Ограничение вывода.** «Нулевая стоимость» — честная категория организационных мер, не обещание, что проблема рук решается без рук. Пределы списка называют учредителю прямо.

## Кейс 22. Пищеблок физически не позволяет готовить две горячие линии

**Ситуация.** Здание 1970-х: одна плита на четыре конфорки, узкая раздача, две гастроремкости на вторых блюда физически не встают на линию. Реконструкция — «в планах региона».

**Проблема.** Инфраструктурное ограничение — последнее возражение, когда сняты все остальные. Оно реально, но не абсолютно.

**Что нельзя делать.** Объявлять «вариативность нам не светит»: выбор не сводится к двум горячим линиям. Готовить второй вариант заранее и держать часами на водяной бане: санитарно хуже, чем один свежий. Ждать реконструкции как единственного решения.

**Немедленно.** Форматы без второй горячей линии. Заказ накануне: кухня готовит два варианта последовательно по статистике заказа, не параллельно. Вариативность холодных позиций — салаты, напитки, десерты, буфетная зона. Вариативность по дням: «вторник — рыбный с двумя гарнирами». Отложенные порции и ночная доступность.

**Кто принимает решение.** Заведующий производством — о технологически возможном формате. Директор — о модели (М1 в режиме предзаказа, М3 буфет — раздел 29). Учредитель — о реконструкции как отдельной повестке.

**Документы.** Обоснование формата — одна страница: ограничение → формат → гарантии санитарии. Журнал заказа. План реконструкции в переписке с учредителем.

**Долгосрочное решение.** Капитальная повестка — отдельным документом: стоимость второй линии против эффекта. Нет реконструкции — максимум выбора в имеющемся контуре как постоянная модель, не «временная ущербность».

**Основания.** СанПиН регулирует безопасность и кратность, не число линий<sup>9</sup>. Заказное питание в госпиталях (room service модели) строится на предзаказе и организации, не только на площадях<sup>111</sup>.

**Ограничение вывода.** Предзаказ переносит выбор с линии на канун. Это другой ритм для смен, и он требует своего инструктажа (раздел 28), а не только решения кухни.

## Как пользоваться кейсами на семинаре и в обучении

Каждый кейс — 15 минут по одной схеме: ситуация зачитывается без раздела «решение»; группа отвечает по восьми пунктам; сверка с текстом. Ценность — в расхождениях: если группа предлагает то, чего в кейсе нет, это повод дополнить локальный комплект, а не «исправить ошибку». Кейсы допускается адаптировать под организацию (детское / взрослое учреждение, размер, регион), сохранив структуру из восьми пунктов.

## Часть III. Приложения: проекты локальных форм (45 шаблонов)

Сорок пять шаблонов — рабочий инструментарий: чек-листы, журналы, алгоритмы, проекты приказов и положений. Каждый — проект локальной формы, не нормативно установленный документ. Адаптация под регион,

учётную политику, структуру дома, медицинскую лицензию и требования учредителя обязательна. Порядок внедрения — раздел 36.

## Приложения 1–6

*Единый дисклеймер для всех приложений 1–36 (на каждом шаблоне): «Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требует адаптации под региональное законодательство, учётную политику, структуру учреждения, медицинскую лицензию и требования учредителя».*

### ПОРЯДОК ВНЕДРЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ: ПРИОРИТЕТЫ ПО СРОКАМ

| Срок                  | Приложения                                                                                                    | Назначение                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Первая неделя         | 25 (замер отходов), 9 (журнал отказов), 21 (лекарственно-пищевая таблица)                                     | Базовые измерения и безопасность |
| Первый месяц          | 7 (журнал заказа), 8 (журнал срывов), 2 (карта предпочтений), 28 (приказ о пилоте), 29 (положение)            | Документальный каркас пилота     |
| Первый квартал        | 3 (пищевая биография), 6 (наблюдение невербальных), 17 (матрица ролей), 30 (совет жителей), 35 (панель чисел) | Системное закрепление            |
| По мере необходимости | Остальные 32 приложения                                                                                       | Специфические ситуации           |

Формы — проекты. Под регион и учредителя — обязательно.

### Приложение 1. Чек-лист готовности учреждения

*Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требует адаптации.*

Директор, зав. производством и врач — до старта пилота. «Нет» — не запрет, а строка плана.

**Право и документы** 1. Статус норм питания в регионе выяснен (рекомендация / императив) — ☐ да ☐ нет 2. Региональное меню изучено; процедура его изменения известна — ☐ да ☐ нет 3. Согласование учредителя на пилот получено письменно — ☐ да ☐ нет 4. Приказ о пилоте подписан, ответственные названы по фамилиям — ☐ да ☐ нет

**Клиника** 5. Лекарственно-пищевая таблица подписана врачом и висит на кухне и посту — ☐ да ☐ нет 6. Список жителей с риском дисфагии актуален; смена знает признаки — ☐ да ☐ нет 7. Правило «три отказа — врач в тот же день» доведено до всех смен — ☐ да ☐ нет

**Кухня и линия** 8. Пары эквивалентов на первую неделю рассчитаны и согласованы — ☐ да ☐ нет 9. Санитарный контур второй позиции проверен (маркировка, температура, пробы) — ☐ да ☐ нет 10. Журналы заказа, замен, срывов выбора заведены — ☐ да ☐ нет

**Люди** 11. Инструктаж смены раздачи проведён (показ меню, роли, замены) — ☐ да ☐ нет 12. Жители и близкие информированы; сбор предпочтений начат — ☐ да ☐ нет

Дата: \_\_\_\_\_ Подписи: директор \_\_\_\_\_ зав. производством \_\_\_\_\_ врач \_\_\_\_\_

### Приложение 2. Карта пищевых предпочтений жителя

*Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требует адаптации.*

На каждого жителя. Пересмотр — раз в квартал. Источник каждой записи: сам житель / наблюдение / близкие / врач.

| Поле                                        | Содержание | Источник   |
|---------------------------------------------|------------|------------|
| Любимые блюда                               |            |            |
| Не ест (наблюдаемое)                        |            |            |
| Не ест (заявляет сам)                       |            |            |
| Текстура (по IDDSI, если назначена)         |            | врач       |
| Назначенная диета / ограничения             |            | врач       |
| Лекарственные ограничения (из таблицы)      |            | врач       |
| Помощь за столом (нет / частичная / полная) |            | наблюдение |
| Привычное время еды, ритуалы                |            |            |
| Напитки: что пьёт, что нет                  |            |            |
| Аллергии, непереносимости                   |            | врач       |
| Канал выбора (речь / показ / наблюдение)    |            |            |



Дата заполнения: \_\_\_\_\_ Заполнил: \_\_\_\_\_ Дата пересмотра: \_\_\_\_\_

### Приложение 3. Пищевая биография

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптация.

При поступлении — или при заведении карты на того, кто уже живёт. Со слов жителя и близких. Не анкета: разговор по темам.

1. Где и как ел всю жизнь: дома, в семье, один, в учреждениях?
2. Что готовил сам? Что готовили для него?
3. Еда праздника и еда будня — что это было?
4. Что никогда не ел и почему (если помнит/говорит)?
5. Кто в его жизни «знает, как он ест» — имя, контакт?
6. Что из еды связано с тяжёлыми периодами (голод, стационары, ограничения)?
7. Три блюда, без которых «всё не то».

Свободная запись, 5–15 предложений. Выдержки — в карту предпочтений (приложение 2). Хранить в отделении, смена читает.

### Приложение 4. Простая форма выбора

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптация.

Одна строка на жителя. Заполняется при показе меню — вечером накануне или утром. Бумажный лист отделения.

Дата: \_\_\_\_\_ Приём пищи: обед / ужин

| № | Житель (фамилия или код) | Вариант А                | Вариант Б                | Стандартный              | Подпись/отметка смены |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1 |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                       |
| 2 |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                       |

Выбор — при жителе. «Стандартный» — если не выбрал: это нормальный итог, не сбой. Лист на кухню до \_\_\_\_ часов.

### Приложение 5. Визуальное меню

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптация.

Не бланк — спецификация изготовления:

- формат: лист А4 или А3 на день, вешается в столовой и на посту;
- каждая позиция — фотография реальной порции из собственной кухни (не стоковые картинки: жители должны узнавать свою еду);
- подписи крупным шрифтом, от 24 пт; без кулинарных терминов («биточек», а не «биточек паровой по-дунайски»);
- варианты выбора расположены рядом, визуально сопоставимы;
- фотографии обновляются при смене меню-цикла; ламинация — для санитарной обработки;
- для жителей со слабым зрением — устное дублирование при показе обязательно.

Ответственный за изготовление и обновление: \_\_\_\_\_ (фамилия в приказе).

### Приложение 6. Форма наблюдения за невербальным выбором

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптация.

Для тех, кто не говорит выбор. Смена, 2–3 минуты на запись.

Дата: \_\_\_\_\_ Житель (код): \_\_\_\_\_ Приём пищи: \_\_\_\_\_

1. Что было предъявлено (карточки / блюда / меню): \_\_\_\_\_
2. Реакция: показал рукой ☐ взгляд задержался ☐ потянулся ☐ отвернулся ☐ без реакции ☐
3. Проверка позиции (предметы поменяны местами): реакция повторилась на тот же предмет ☐ на ту же позицию ☐
4. Ел предъявленное: полностью ☐ частично ☐ не ел ☐
5. Вывод для карты предпочтений: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_ Подтверждающее наблюдение (через 1–2 недели): дата \_\_\_\_\_ вывод совпал ☐ уточнён ☐

## Приложения 7–12

### Приложение 7. Форма предварительного заказа (журнал заказа)

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

Журнал отделения. Вечерний показ. Итог — на кухню до часа, который ставит дом.

Дата подачи: \_\_\_\_\_ Меню на (дата): \_\_\_\_\_

| Позиция | Вариант А (заказов) | Вариант Б (заказов) | Стандартный (заказов) | Итого порций |
|---------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| Первое  |                     |                     |                       |              |
| Второе  |                     |                     |                       |              |
| Салат   |                     |                     |                       |              |
| Напиток |                     |                     |                       |              |

Особые порции по картам (текстура, диета): \_\_\_\_\_

Итоги передал: \_\_\_\_\_ Принял на кухне: \_\_\_\_\_ Время: \_\_\_\_\_

Ежемесячно итоги суммируются → статистика выбора для пересчёта меню и списаний (разделы 21, 29).

### Приложение 8. Журнал срывов выбора

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

Когда заявленный выбор не выдали. Ведёт кухня или линия.

| Дата | Приём пищи | Позиция | Что случилось (закончилось / не привезли / не приготовили) | Сколько не хватило | Чем заменили | Подпись |
|------|------------|---------|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------|
|      |            |         |                                                            |                    |              |         |

Разбор на еженедельной планёрке. Три срыва одной позиции — пересчитать объёмы или сменить пару (раздел 21).

### Приложение 9. Журнал отказов от еды

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

В отделении. Пишут каждый отказ от еды — не от одного блюда, а от приёма целиком или большей его части.

| Дата | Житель (код) | Приём пищи | Сколько съедено | Обстоятельства (настроение, слова жителя, контекст) | Что предложено взамен | Принял замену? | Кому сообщено | Подпись |
|------|--------------|------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|---------|
|      |              |            |                 |                                                     |                       |                |               |         |

**Правило эскалации (рамкой в журнале):** три отказа подряд у одного жителя — врач в тот же день. Отказ с бредовой мотивировкой («отравлено») — врач при первом эпизоде.

### Приложение 10. Алгоритм при отказе от блюда

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

Отказ от конкретного блюда, не от еды вообще.

- 1. Спокойно принять.** «А кто теперь будет доедать» — реплика запрещена.
- 2. Предложить замену** из того, что есть: второй вариант линии или стандартная замена (хлеб, кисломолочное, фрукты по сезону — перечень утверждён заранее).
- 3. Записать** в журнал заказа/замен: житель, блюдо, замена.
- 4. При повторении** (тот же житель, то же блюдо, 3 раза) — в карту предпочтений: «не ест \_\_ (наблюдение)».
- 5. Если отказ захватывает** большую часть приёма — к приложению 11.

Запрещено: давить уговорами, ставить условия («съешь — получишь»), наказывать отказом любой формой.

### Приложение 11. Алгоритм при отказе от еды

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

- 1. Первый отказ.** Если житель говорит — спокойно спросить почему. Предложить замену и формат: другое время, другое место, помощь. Запись в журнал отказов.
- 2. Второй отказ подряд.** Старшая смены идёт сама. Не болен ли (жалобы, температура по показаниям), не конфликт ли за столом, не сменилось ли что-то в режиме. Запись.

3. **Третий отказ подряд → врач в тот же день.** Не завтра. Не «на обходе послезавтра». В день третьего отказа.
4. **Особые сигналы — врач при первом эпизоде:** бредовая мотивировка («отравлено»), боль при глотании, рвота или резкая слабость рядом.
5. **До решения врача:** питьё и лёгкие форматы (кисломолочное, суп). Наблюдать. Не давить. Взвешивание — по назначению.
6. **Категорически запрещено:** принудительное кормление в любой форме, шантаж едой, публичное давление.

Все шаги — в журнале отказов (приложение 9).

## Приложение 12. Алгоритм при риске аспирации

*Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптация.*

**Профилактика (ежедневно):** - жители из списка дисфагического риска едят в поле зрения обученной смены; минимум два обученных человека на посту в часы приёма пищи; - текстура строго по назначению (IDDSI); проверка вилкой перед выдачей; - поза: вертикально, 90°, после еды 30 минут без укладывания; - темп: паузы, без спешки; напиток между глотками по назначению.

**При поперхивании (лёгкий эпизод, житель справился сам):** 1. Остановить еду. Дать откашляться. Стоящего по спине не хлопать: работает кашель. 2. Записать эпизод. Сообщить старшей смены. 3. Повтор за неделю → врач вне очереди: пересмотр текстуры.

**При тяжёлом эпизоде (не может кашлять, синюшность, потеря сознания):** 1. Медперсонал и врач — сразу. Нет эффекта — скорая (103/112). 2. Приём Геймлиха — только обученным сотрудником. 3. После эпизода — врачебный осмотр в тот же день, даже если всё обошлось (риск отсроченной пневмонии). 4. Протокол разбора инцидента (приложение 34) — за 3 дня.

Документы: список риска и текстуры — приложение 21 (медицинский контур); основания — раздел 10 доклада.

## Приложения 13–18

### Приложение 13. Алгоритм при быстром заглатывании

*Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптация.*

1. **Распознать:** ест заметно быстрее остальных, не прожёвывает, набирает полный рот, были поперхивания.
2. **Сервировка без назначения врача:** порция меньше + добавка; куски мельче (это сервировка, не смена текстуры); напиток под рукой; стол — в числе первых (снимает мотив «успеть»).
3. **Наблюдение:** место в поле зрения смены; поперхивания — в форму наблюдения.
4. **Эскалация:** любое поперхивание с кашлем — врач вне очереди (скрининг дисфагии; текстура по IDDSI — при подтверждении).
5. **Запрещено:** «ешь медленнее» как единственная мера; отбор еды темпом; самовольный перевод на пюре.
6. **Документы:** форма наблюдения, запись врача; при назначении — обновить карту.

### Приложение 14. Алгоритм при пикацизме

*Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптация.*

Пикацизм — поедание несъедобного: бумага, ткань, земля, предметы.

1. **Среда — сначала.** Осмотреть зону жителя и столовую. Убрать мелкое, острое, токсичное. Моющие — только под замком.
2. **Наблюдение.** Усиленный контроль в часы еды и после. Писать: что, когда, где.
3. **Замещение.** Безопасные жевательные альтернативы — по согласованию с врачом. Регулярные перекусы снижают «поисковое» поведение у части жителей.
4. **Врач.** Сообщить при первом выявленном эпизоде: нужна клиническая оценка (дефицитные состояния, терапия, поведенческий план).
5. **Инцидент** (проглочен опасный предмет): наблюдать за состоянием, врач сразу; боль, рвота, задержка стула — скорая. Протокол разбора (приложение 34).
6. **Документы:** записи наблюдения, назначения врача, протокол осмотра среды (раз в неделю, подпись старшей смены).

### Приложение 15. Алгоритм при конфликте за столом

*Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптация.*

1. **Прервать эскалацию, не наказывая едой.** Спокойный голос. Развести за разные столы. Еда обоих — целиком.

2. **Пострадавшему** (отобрали, толкнули) — порцию восстановить, приём закончить спокойно.
3. **Запись в день события:** участники, что произошло, меры.
4. **Разбор на планёрке.** Рассадка, конкретная пара, дефицит любимых позиций, гиперфагия одного из участников — у каждой причины своё решение (кейс 7).
5. **Повтор одной пары** — постоянная рассадка (документ отделения). Врач — о пищевом поведении инициатора.
6. **Запрещено:** лишать еды или десерта как наказание; выносить из столовой без еды; отчитывать при всех.

## Приложение 16. Алгоритм при пищевом инциденте

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

Пищевой инцидент: массовое недомогание, подозрение на отравление, посторонний предмет в блюде, нарушение температуры с выдачей.

1. **Остановить выдачу** подозрительной позиции сразу. Остатки и суточную пробу сохранить — не выбрасывать.
2. **Медицина.** Осмотреть пострадавших. Массовый характер — врач. Тяжёлые симптомы — скорая.
3. **Факты, не версии.** Что готовилось, когда, из чего. Писать по горячим следам, не согласовывая рассказы.
4. **Уведомления** по правилам дома и закона: руководитель, учредитель; при признаках инфекции — по установленному порядку.
5. **Протокол разбора** (приложение 34) за 3 дня: причина, виновное звено, корректирующее действие, срок, ответственный.
6. **Запрещено:** уничтожать остатки и пробы; «тихо» снимать позицию без записей; искать виноватого до фактов.

## Приложение 17. Матрица ролей RACI по питанию

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

R — исполняет, A — отвечает за результат, C — консультируется, I — информируется. Заполнять под свою структуру. Ниже — базовая конфигурация.

| Процесс                         | Директор | Зав. производством | Врач | Старшая смены | Сиделка | Бухгалтерия | Совет жителей |
|---------------------------------|----------|--------------------|------|---------------|---------|-------------|---------------|
| Положение о питании             | A        | C                  | C    | I             | I       | I           | C             |
| Меню с вариантами               | A        | R                  | C    | I             | I       | I           | C             |
| Показ меню, сбор выбора         | I        | I                  | I    | A             | R       | —           | I             |
| Лекарственно-пищевая таблица    | I        | I                  | A/R  | C             | I       | —           | —             |
| Список дисфагического риска     | I        | I                  | A    | R             | R       | —           | —             |
| Журналы (заказ, замены, отказы) | I        | C                  | I    | A             | R       | I           | —             |
| Списание продуктов              | A        | C                  | —    | I             | —       | R           | —             |
| Закупки, претензии              | A        | C                  | —    | —             | —       | R           | —             |
| Совет жителей                   | I        | C                  | C    | C             | —       | —           | A/R           |
| Панель чисел, отчёт учредителю  | A/R      | C                  | C    | C             | —       | C           | I             |

Утверждено приказом № \_\_\_\_ от \_\_\_\_

## Приложение 18. Чек-лист директора (ежемесячный)

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

1. Обошёл столовую в часы основного приёма пищи лично — ☐
2. Просмотрел журналы: заказ, замены, отказы, срывы — записи ведутся, не «копеечные» — ☐
3. Панель чисел месяца собрана; отклонения объяснены письменно — ☐
4. Совет жителей заседал; протокол есть; по решениям есть движение — ☐

5. Жалобы по питанию разобраны в срок; системные выводы сделаны — ☐
6. Переписка с учредителем актуальна (запросы без ответа повторены) — ☐
7. Инструктажи новых сотрудников по питанию проведены — ☐
8. Один случайный разговор с жителем о еде состоялся; запись в дневник обхода — ☐

Подпись: \_\_\_\_\_ Дата: \_\_\_\_\_

## Приложения 19–24

### Приложение 19. Чек-лист пищеблока (ежедневный)

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

1. Санитарный журнал дня ведётся; температурный режим линии зафиксирован — ☐
2. Суточные пробы отобраны по каждому приёму пищи, включая вариативные позиции — ☐
3. Вариативные позиции промаркированы (бирки: название, вариант) — ☐
4. Текстуры по назначениям проверены (тест вилкой) перед выдачей — ☐
5. Итоги заказа получены от отделений в срок; объёмы соответствуют — ☐
6. Особые порции (диеты, текстуры) приготовлены и промаркированы отдельно — ☐
7. Отходы взвешены/зафиксированы (в период замера) — ☐
8. Лекарственно-пищевая таблица на видном месте; новые назначения доведены — ☐

Зав. производством: \_\_\_\_\_

### Приложение 20. Чек-лист отделения (ежедневный, часы приёмов пищи)

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

1. Визуальное меню дня показано жителям; выбор зафиксирован в присутствии жителей — ☐
2. На посту в часы еды — не менее двух человек, обученных приёмам безопасного кормления — ☐
3. Жители из списка дисфагического риска — в поле зрения; поза 90° соблюдена — ☐
4. Отложенные порции для спящих/отсутствующих оформлены по правилам — ☐
5. Отказы и замены записаны в день события — ☐
6. Конфликтов без записи не осталось — ☐
7. Помощь распределена по приоритету риска; никто из нуждающихся не остался без помощи — ☐

Старшая смены: \_\_\_\_\_

### Приложение 21. Чек-лист медицинского контура

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации. Документы контура подписывает врач.

#### А. Лекарственно-пищевая таблица (вкладыш, обновляется при смене назначений)

| Правило                    | Действие для кухни и смены                                                            | Класс уверенности                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Клозапин + кофеин          | Кофе/чай для получающих клозапин — по согласованию с врачом; кофеин не отменять резко | высокий (усиление концентраций клозапина; синдром отмены) |
| Литий + соль               | Не менять солёность резко; солёные «загрузки» и бессолевые недели исключены           | высокий                                                   |
| ИМАО + тирамин             | Перечень ограничений у врача; выдержанные сыры, копчёности — по списку                | высокий                                                   |
| Грейпфрут + ряд препаратов | Грейпфрут и сок из меню получающих карбамазепин и др. — исключены                     | высокий для карбамазепина                                 |
| Алкоголь/энергетики        | Исключены полностью; передачи проверяются                                             | высокий                                                   |

**Б. Список дисфагического риска:** житель (код) — признак — текстура по IDDSI — дата назначения — подпись врача.

**В. Ежемесячно:** список риска пересмотрен ☐; таблица актуальна ☐; журнал отказов просмотрен, меры приняты ☐; метаболический мониторинг (вес, глюкоза, липиды по назначениям) в графике ☐.

Врач: \_\_\_\_\_



## Приложение 22. Чек-лист закупок

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

1. Спецификация допускает парные позиции и закупку по статистике выбора — ☐
2. Правило взаимозаменяемости при срыве поставки прописано (нутриентные эквиваленты) — ☐
3. Ответственный за приёмку и претензии назначен; акты недопоставки оформляются — ☐
4. Статистика срывов поставок ведётся и учитывается при следующей закупке — ☐
5. При аутсорсинге в контракт включены: вариативность, текстуры, документирование замен, доступ к журналам — ☐
6. Закупка сверена с меню-циклом и картами (диеты, текстуры) — ☐
7. Признаки картельного поведения (одинаковые цены, поочерёдные победы) — основание для обращения в ФАС; ответственный знает порядок — ☐

## Приложение 23. Чек-лист бухгалтерского учёта

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

1. Применяемая учётная форма подтверждена учредителем (с учётом поэтапного перехода на электронные формы) — ☐
2. Ежедневные итоги журнала заказа поступают в бухгалтерию по установленной форме — ☐
3. Списание парных продуктов идёт по фактической пропорции выдачи (методика согласована) — ☐
4. Разница «склад — выдача — списание» объяснима за любой день месяца — ☐
5. Отложенные порции и замены отражены в выдаче — ☐
6. Сырьевая строка (руб./житель/день) посчитана за месяц и передана директору — ☐

Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_

## Приложение 24. Чек-лист проверки реальности выбора

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации. Проводится еженедельно в пилотной точке, далее ежемесячно.

1. Спросить пятерых случайных жителей: «Что вы вчера выбирали?» — ответили соответственно журналу: \_\_\_ из 5
2. Журнал заказа заполнен тем же днём, что и показ меню (проверка по почерку/времени — без парадоксов «заполнено заранее»): ☐
3. Оба варианта физически были на линии (опрос смены + журнал срывов): ☐
4. Доля «стандартных» (невывбравших) не растёт необъяснимо третью неделю подряд: ☐
5. Замены выдавались реально (спросить двоих, кому меняли блюдо): ☐
6. Жители знают, что выбирать можно (опрос): \_\_\_ из 5

**Оценка:** 6/6 — выбор реален; 4–5 — точечные сбои, разбор на планёрке; ≤3 — вариативность фиктивна, диагностика по разделу 21 и кейсу 12.

Провёл: \_\_\_\_\_ Дата: \_\_\_\_\_

## Приложения 25–30

### Приложение 25. Форма семидневного замера отходов

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

До пилота и на 80–90-й день. Обычная неделя, не праздник. Кухонные весы, конец каждого приёма. Тарелочные остатки и кухонные — раздельно.

| День | Приём пищи | Тарелочные остатки, кг | Кухонные остатки, кг | Число порций | Остаток на порцию, г | Примечание |
|------|------------|------------------------|----------------------|--------------|----------------------|------------|
| 1    | завтрак    |                        |                      |              |                      |            |
| 1    | обед       |                        |                      |              |                      |            |
| 1    | ужин       |                        |                      |              |                      |            |

Итоги недели: средний остаток на порцию \_\_\_ г; топ-3 блюда по остаткам \_\_\_\_\_; сравнение с замером «до» (при повторном замере): \_\_\_ %.

Честность замера. Меню недели не «улучшать». Сменам не объявлять проверку — исказят поведение. Праздник, похороны, обострение — в примечание, не вычёркивать молча.

## Приложение 26. Форма учёта трудозатрат на кормление

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

Три типичных дня. Каждый приём. Секундомер. Поведение смены не трогать.

| День/приём | Число жителей, нуждающихся в помощи | Число помогающих | Время приёма пищи, мин | Суммарные минуты помощи | Минут помощи на жителя | Кто не получил помощь вовремя |
|------------|-------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|
|            |                                     |                  |                        |                         |                        |                               |

Дефицит: потребность (жители × нормативные минуты) – имеющиеся минуты = дефицит в минутах. Дальше — в ставки: делить на продолжительность рабочего времени. Это основание письма учредителю (приложение 33).

## Приложение 27. Форма отчёта о 90-дневном пилоте

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

1. Паспорт пилота: точка, даты, модель (M1–M5), ответственные. 2. Панель чисел «до/после» (12 показателей):

| Показатель                         | До | После | Что это значит (одна фраза) |
|------------------------------------|----|-------|-----------------------------|
| Доля выбирающих, %                 |    |       |                             |
| Отходы на порцию, г                |    |       |                             |
| Время раздачи, мин                 |    |       |                             |
| Отказы от еды, эпизодов/нед        |    |       |                             |
| Замены, эпизодов/нед               |    |       |                             |
| Срывы выбора, эпизодов/мес         |    |       |                             |
| Жалобы жителей/родственников       |    |       |                             |
| Трудозатраты линии, мин/приём      |    |       |                             |
| Сырьевая строка, руб./житель/день  |    |       |                             |
| Доля знающих о выборе, %           |    |       |                             |
| Эпизоды дисфагического риска       |    |       |                             |
| Удовлетворённость (анкета, б. 1–5) |    |       |                             |

3. Позиция совета жителей (протокол прилагается): расширить / сохранить / свернуть. 4. Решение директора: одно из трёх, с обоснованием. 5. Приложения: журналы, замеры, инциденты и их разбор.

## Приложение 28. Проект приказа о пилоте вариативного питания

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

ПРИКАЗ № \_\_\_\_ от «» 20\_\_ г. «О проведении пилотного проекта по организации вариативного питания»

1. Провести с «» по «» (90 дней) пилотный проект в отделении № : выбор из двух вариантов вторых блюд на обед, дней в неделю, с гарантией стандартного варианта.
2. Ответственные: руководитель пилота — ; кухня — ; отделение — ; медицинский контур — ; сведение данных — \_\_\_\_.
3. До старта: провести замеры по приложениям 25–26; опрос предпочтений; инструктаж смен; уведомить учредителя.
4. Вести журналы по приложениям 7–9 с первого дня.
5. Критерии успеха: \_\_\_\_ (доля выбирающих, отходы, отсутствие роста отказов). Критерии остановки: рост отказов; санитарные нарушения; противопоказания врача.
6. «» (дата) — заслушать итоги; решение о расширении/закреплении/свёртывании оформить приказом.

Директор \_\_\_\_\_ /подпись/

## Приложение 29. Проект положения о вариативном питании

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

Разделы и формулировки:

1. **Общие положения.** Цель: права жителей (ст. 37, 43 закона № 3185-1) — через организованный выбор в питании. Положение стоит на действующих нормах (СанПиН 2.3/2.4.3590-20; рекомендованные нормы — приказ Минтруда № 520н, статус в регионе — \_\_\_\_).
2. **Перечень вариативных позиций** и режим (дни, приёмы пищи).
3. **Гарантия стандартного варианта:** «житель, не сделавший выбор, получает полноценный стандартный вариант; выбор — право, а не обязанность».

4. **Порядок показа меню и фиксации выбора** (визуальное меню, формы, сроки передачи заказа).
5. **Замены и отказы:** порядок, журналы, запрет использования еды как поощрения/наказания, запрет принудительного кормления.
6. **Связь с назначениями врача:** конфликт «выбор против назначения» решает врач в день обращения; диетические столы имеют собственные пары эквивалентов.
7. **Роли и ответственность** (по матрице, приложение 17).
8. **Контроль:** проверки реальности выбора (приложение 24), панель чисел, отчётность учредителю.
9. **Совет жителей** — со ссылкой на положение (приложение 30).

## Приложение 30. Положение о пищевом совете жителей

*Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.*

1. **Состав:** 5–9 человек — жители (квота по отделениям; интересы недееспособных представляют выбранные ими лица или члены совета), сиделка, повар; врач — с правом совещательного голоса. Срок — 1 год, ротация — половина состава.
2. **Полномочия:** обсуждение меню до утверждения; дегустации новых позиций; сбор и ранжирование пожеланий; ответ администрации на пожелания — до 14 дней.
3. **Ритм:** заседание ежемесячно; кворум — половина состава; протокол ведётся и хранится \_\_\_ лет.
4. **Права совета:** запрашивать меню, журналы срывов, панель чисел; выносить предложения директору; инициировать дегустации.
5. **Границы:** совет не подменяет врача и не отменяет санитарные требования. Если позиция администрации расходится с зафиксированными предпочтениями жителя — приоритет у предпочтений, пока они не противоречат назначениям врача.
6. **Форма протокола:** дата, состав, вопросы, решения, сроки, ответственные.

## Приложения 31–36

### Приложение 31. Памятка персоналу «Питание и выбор: десять правил»

*Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации. Формат — один лист А4, вывешивается на посту.*

1. Еда — право, а не награда. Никогда не используйте еду как поощрение или наказание.
2. Показывайте меню каждому, каждый день, в его формате (речь, карточки, жест).
3. «Стандартный вариант» — нормальный итог, а не отказ от выбора.
4. Отказ от блюда — предложите замену и запишите. Без комментариев вслух.
5. Три отказа от еды подряд — врач сегодня. «Отравлено» — врач при первом.
6. Текстура — как в карте. Проверка вилкой — минута, риск аспирации — жизнь.
7. Кто ест с помощью — ест в своём темпе. Конвейер недопустим.
8. Записывайте в день события: замены, отказы, конфликты, срывы.
9. Не знаете — спросите старшую смену. Не решайте врачебные вопросы сами.
10. Житель за столом — хозяин своей тарелки. Ваша работа — чтобы выбор был реальным.

### Приложение 32. Памятка родственникам

*Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.*

**Что мы делаем.** В нашем доме жители выбирают из предложенных вариантов. Выбор пишем. Замены гарантированы. Стандартный вариант есть всегда.

**Как вы можете помочь.** Скажите, что близкий любит и чего не ест — войдёт в пищевую карту. Привычное время еды, любимая посуда, ритуалы — тоже. Приходите на дни открытых дверей и дегустации совета жителей.

**Что важно знать.** Ограничения в питании ставит только врач. Считаете, что близкому нужно ограничение, — напишите заявление, врач рассмотрит. Устной просьбой запретов не вводим: право на еду, которую человек любит, — его право.

**Куда обращаться.** Вопросы о еде — старшая смена отделения. Предложения — совет жителей. Жалобы — директор (срок ответа \_\_\_ дней). Передачи принимаются \_\_\_ (ограничения по санитарным правилам — на стенде).

### Приложение 33. Форма сообщения учредителю о дефиците ресурсов

*Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.*

Генеральному директору/начальнику \_\_\_\_\_ от директора \_\_\_\_\_

**1. Дефицит:** (ставки / оборудование / площади — конкретно, количественно: «3,0 ставки сиделок по расчёту из замера, приложение 26»). **2. Методика расчёта:** замер от \_\_\_\_ (даты), форма прилагается. **3. Последствия бездействия:** (фактическое: «12 жителей группы помощи получают менее \_\_\_\_ минут помощи за приём пищи; двое систематически не доедают»). **4. Что сделано без ресурсов:** (перечень мер нулевой стоимости и их эффект). **5. Сценарии:** минимальный (\_\_\_\_ ставки → эффект), полный (→), стоимость каждого. **6. Просьба:** рассмотреть до (дата); при отказе — просим письменного подтверждения для учёта в плане работы.

Приложения: формы замеров, расчёты. Директор \_\_\_\_\_ /подпись/

### Приложение 34. Протокол разбора пищевого инцидента

*Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации. Срок составления — 3 дня с инцидента.*

**1. Что произошло:** дата, время, место, участники, хронология — по записям, без согласования версий. **2. Класс инцидента:** аспирация / конфликт / массовое недомогание / посторонний предмет / проглатывание несъедобного / иное. **3. Немедленные меры:** что сделано, кем, когда; врач (время вызова, осмотра). **4. Причина:** звено цепочки (продукт / технология / текстура / раскладка / наблюдение / среда) — с обоснованием. **5. Факторы среды:** что в доме позволило инциденту. Не «человеческий фактор» как стоп-слово — условия: смена в одиночку, карта не обновлена и т.п. **6. Корректирующие действия:** действие — ответственный — срок — проверка исполнения. **7. Уведомления:** кто и когда проинформирован по установленному порядку. **8. Вывод для системы:** одна строка — что меняется в регламентах.

Составил: \_\_\_\_\_ Утвердил: директор \_\_\_\_\_

### Приложение 35. Форма управленческого дашборда (квартальная панель)

*Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации. Один лист на квартал.*

| №  | Показатель                          | Квартал | Предыдущий | Тренд | Комментарий |
|----|-------------------------------------|---------|------------|-------|-------------|
| 1  | Доля выбирающих жителей, %          |         |            |       |             |
| 2  | Отходы на порцию, г                 |         |            |       |             |
| 3  | Отказы от еды, эпизодов             |         |            |       |             |
| 4  | Замены по отказам, эпизодов         |         |            |       |             |
| 5  | Срывы выбора, эпизодов              |         |            |       |             |
| 6  | Сырьевая строка, руб./житель/день   |         |            |       |             |
| 7  | Трудозатраты линии, мин/приём       |         |            |       |             |
| 8  | Жалобы по питанию                   |         |            |       |             |
| 9  | Инциденты (по классам)              |         |            |       |             |
| 10 | Жителей с актуальными картами, %    |         |            |       |             |
| 11 | Заседания совета жителей состоялись |         |            |       |             |
| 12 | Анкета удовлетворённости, б. 1–5    |         |            |       |             |

Три вывода квартала (по одному предложению): \_\_\_\_\_

### Приложение 36. Анкета жителей в доступном формате

*Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации. Проводится раз в квартал; заполняется со слов жителя или самостоятельно; для невербальных жителей — не проводится (их канал — наблюдение, приложение 6).*

1. Еда вам в целом нравится? (улыбающийся / нейтральный / грустный смайл — обвести)
2. Что из еды вам нравится больше всего? \_\_\_\_\_
3. Что бы вы убрали из меню? \_\_\_\_\_
4. Удаётся ли выбрать то, что хочется? всегда / иногда / никогда
5. Достаточно ли еды? да / хотелось бы больше / слишком много
6. Удобно ли есть в столовой (шум, место, время)? да / что мешает: \_\_\_\_\_
7. Одно пожелание повару: \_\_\_\_\_

Обработка: итоги — в панель (показатель 12) и на совет жителей. По пунктам 3 и 7 администрация отвечает совету за 14 дней.

## Правила применения приложений

Все 38 форм — единый комплект: наблюдение питает карты, карты — меню и закупки, журналы — панель, панель — отчёты учредителю. Порядок — по дорожной карте (раздел 36): сначала замеры (25–26) и карты (2–3, 6, 37), затем журналы (7–9) и алгоритмы (10–16), затем управленческий слой (17–24, 27–35) и памятка жителю (38). Дисклеймер о локальном статусе остаётся на каждой форме после адаптации — пока форма не утверждена локальным актом дома.

## Приложения 37–38

### Приложение 37. Пищевой паспорт при поступлении (проект формы)

*Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Заполняется при поступлении совместно с жителем, а при невозможности — с опекуном/семьёй; обновляется при изменении состояния и не реже раза в год. Владелец — старшая медсестра; копия полей — на кухне и посту.*

| Блок                     | Что фиксируется                                                                                                                        | Кто заполняет                           |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Предпочтения             | Любимые и нелюбимые блюда; привычный ритм дня; как предпочитает есть (ложка/вилка, помощь, тарелка-разделитель)                        | Житель + семья; каналы воли — раздел 15 |
| Ограничения по убеждению | Религиозные/культурные (халяль, пост, вегетарианство); аллергии и непереносимости (в т.ч. целиакия, лактоза) — со слов и по документам | Житель/семья + врач                     |
| Глотание                 | Шесть признаков дисфагии (да/нет); при сомнении — GUSS/EAT-10 с записью балла                                                          | Медсестра                               |
| Полость рта              | Свои зубы/протезы; «болит ли жевать»; сухость во рту; дата последнего осмотра стоматологом                                             | Медсестра                               |
| Лекарства × еда          | Препараты из таблицы раздела 11 (клозапин, литий, ИМАО, карбамазепин и др.); согласовано с врачом                                      | Врач                                    |
| Вес и статус питания     | Вес при поступлении; рост; динамика (триггеры 5/7,5/10 % — раздел 26); аппетит по шкале 1–5                                            | Медсестра                               |
| Питьевой режим           | Обычный объём; при загущённых напитках — уровень IDDSI и фактический объём за сутки                                                    | Медсестра + кухня                       |
| Стул                     | Регулярность (для группы антихолинергической нагрузки — контроль трёх суток)                                                           | Пост                                    |

*Правило формы: каждая строка заполнена или помечена «данных нет». Пустых строк нет. Паспорт не заменяет медицинскую документацию: он собирает на одном листе то, что иначе размазано по пяти журналам.*

### Приложение 38. Памятка для жителей «Моя еда — мой выбор» (доступный формат, easy read)

*Проект локальной формы в технике easy read: короткие фразы, одна мысль на строку, картинка к каждой мысли. Лист А4, двусторонняя печать: в столовой и при поступлении в руки. Соответствует Accessible Information Standard (Англия): информация — в формате, который человек может понять<sup>113</sup>. Пиктограммы — под контингент дома. Фотографии своих блюд и своей столовой работают лучше абстрактных значков.*

**Лист 1. Моя еда — мой выбор** (вывешивается в столовой, вручается при поступлении)

1. Каждый день вам показывают меню. Меню — это список еды.
2. Вы можете сказать: «Хочу это». Вы можете сказать: «Не хочу это».
3. Если вы не говорите — вам покажут две тарелки. Вы покажете пальцем.
4. Вы не останетесь голодным. Всегда будет другой вариант.
5. Если вы едите в комнате — вам тоже принесут два варианта. Покажите, какой хотите.
6. Если еда мешает глотать — скажите персоналу. Вам помогут.
7. Если болит жевать — скажите персоналу. Вас посмотрит врач.
8. Вы можете пить воду, когда хотите. Просите пить.
9. Есть еда, которую вы не едите по вере? Скажите — мы учтём.
10. Ваше мнение важно. Совет жителей обсуждает еду.
11. Если что-то не так с едой — вы можете пожаловаться. Это ваше право.



**Лист 2. Сегодня обед — рабочий лист выбора** (лежит на раздаче и на посту постельных; заполняется на приём, не «навсегда»)

Сегодня: \_\_\_\_\_ (завтрак / обед / ужин). Дата: \_\_\_\_\_

Покажите пальцем или положите метку.

|                     | Вариант А                | Вариант Б                | Не хочу ни то ни другое                  |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
| Картинка / название | _____                    | _____                    | Принесут третий вариант по таблице замен |
| Мой выбор           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                 |

Если вы ничего не отметили — вам принесут обычный вариант. Это нормально. Выбирать не обязательно.

Кто спросил: \_\_\_\_\_ Кто принял заказ: \_\_\_\_\_

*Обратная сторона листа 1: «Куда пожаловаться» — имя и кабинет ответственного, ящик для записок совета жителей, телефон доверия учредителя. Лист 2 не хранит диагноз и не вывешивается в коридоре с фамилиями — это заказ на приём (раздел 17.6).*

## Приложения 39–42

### Приложение 39. Чек-лист перехода на СанПиН 2.3/2.4.4282–26 (с 01.09.2026)

*Проект локальной формы. Чек-лист перехода. СанПиН 2.3/2.4.4282–26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» утверждён постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 02.06.2026 № 18 (зарег. в Минюсте 02.06.2026 № 86854), действует с 01.09.2026 до 01.09.2032; СанПиН 2.3/2.4.3590–20 с этой даты утрачивает силу<sup>9</sup>. Дата семинара (25–27.08.2026) попадает в переходный период: документы дома готовятся к перепривязке. Пункты ниже сверены с текстом 4282–26 по официальной публикации.*

| Требование                                                                                                                                                                                                                                                                   | Где в СанПиН 4282–26                                                                                                                                      | Действие в учреждении                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Питание в стационарном соцобслуживании: не менее 3 раз в день, в т.ч. диетическое (лечебное) по медицинским показаниям                                                                                                                                                       | п. 56 подп. 11                                                                                                                                            | Перепривязать положение о питании; проверить формулировки меню                      |
| Суточные пробы при использовании готовых блюд из предприятий общественного питания (аутсорсинг)                                                                                                                                                                              | п. 56 подп. 12; отбор по подп. 4 (каждое блюдо отдельно; холодные закуски/первые/гарниры/напитки — не менее 100 г; хранение не менее 48 ч при +2...+6 °С) | Помещение приёма готовой продукции; назначенный ответственный; инструкция по пробам |
| Бракераж готовой продукции, журнал бракеража                                                                                                                                                                                                                                 | п. 56 подп. 13; образцы журналов — приложения 4 и 5                                                                                                       | Новые формы журналов; обучение завпроизводством                                     |
| Кейтеринг: внутренний порядок, прослеживаемость, разграничение ответственности; вскрытие упаковок и порционирование — в выделенном помещении/зоне                                                                                                                            | раздел VI (п. 51–55)                                                                                                                                      | Строка в договоре с поставщиком; проверка выполнения при приёмке                    |
| Питьевой режим: вода по обязательным требованиям; фонтанчики (чаша — ежедневная обработка), кулеры (мойка ≥1 раза в 7 дней, дезинфекция ≥1 раза в 3 месяца), кипячёная вода (кипячение ≥5 минут, смена ≥1 раза в 3 часа, график смены); посуда из расчёта списочного состава | п. 62                                                                                                                                                     | Проверить кулеры и графики; ведомость питьевого режима (приложение 40)              |
| Температура горячих жидких и иных блюд, холодных супов, напитков при выдаче — по технологическим документам                                                                                                                                                                  | п. 50                                                                                                                                                     | Термометры на линии; сверка с технологическими картами                              |
| Требования распространяются на привлекаемые предприятия питания                                                                                                                                                                                                              | п. 56 подп. 14                                                                                                                                            | Пункт в договоре аутсорсинга (раздел 42)                                            |

**Порядок действий.** До 25.08.2026 — сверить положение о питании и чек-листы пищеблока с обоими СанПиН (3590–20 действует до 01.09.2026). С 01.09.2026 — перепривязать журналы и формы на пункты 4282–26, обновить памятку персоналу пищеблока, уведомить учредителя одной страницей: что меняется, что остаётся. Модель выбора при переходе не меняется: ни одна редакция не ограничивает число вариантов (раздел 18).

### Приложение 40. Питьевой режим: форма учёта и санитарные требования

*Проект локальной формы. Правовая рамка — п. 62 СанПиН 2.3/2.4.4282–26 (с 01.09.2026; до этого — те же требования СанПиН 2.3/2.4.3590–20): питьевой режим обязателен в организациях социального обслуживания; вода — по обязательным требованиям (глава III СанПиН 1.2.3685–21; глава IV СанПиН 2.1.3684–21; ТР ЕАЭС 044/2017)<sup>9</sup>.*

*Клинический смысл: низкое потребление жидкости — частый и недооценённый дефицит у пожилых<sup>114</sup>. Рекомендации по гидратации в гериатрии — в руководстве ESPEN и в клинических рекомендациях для учреждений долговременного ухода<sup>115,116</sup>.*

**Ведомость «Выпито за сутки»** (по отделению, группа риска — лежачие, жители на загущённых напитках, жаркий период):

| Житель | Утро (стакан/мл) | День | Вечер | Ночь | Итого | Примечание* |
|--------|------------------|------|-------|------|-------|-------------|
|        |                  |      |       |      |       |             |

\*Примечание — индикаторы дегидратации: тёмная моча, сухость языка, сонливость вне режима, снижение тургора кожи; любой из них — запись и сообщение врачу. Важно: по данным обзора, клинические признаки малоинформативны для диагностики обезвоживания — надёжен только объективный метод (осмоляльность сыворотки)<sup>114</sup>; постовые признаки — повод к эскалации, а не диагноз.

**Правила:** единица учёта — «стакан» (200 мл) или маркированная посуда; норма-ориентир для взрослых без ограничений — не менее 1,6 л/сутки для женщин и 2,0 л/сутки для мужчин (рекомендация ESPEN по гидратации в гериатрии; индивидуально, при сердечной, почечной патологии и иных ограничениях — только по назначению врача)<sup>115</sup>; чайная пауза между приёмами пищи как «шестое пищевое событие» (раздел 10.7); у жителей на загущённых напитках — фактический объём выпитого (загущение снижает потребление — раздел 10.7). *Маркировка: объёмные ориентиры — не норматив; ограничение питьевого режима — только врачебное назначение.*

## Приложение 41. Детские учреждения (ДЦИ): что переносится, что нет

*Проект локальной формы. Маркер для руководителей детских домов-интернатов и смешанных организаций. Семинар и рекомендации доклада — про взрослых, пока учредитель отдельно не поручил детский контур. Ниже — границы переноса модели выбора, не педиатрическое руководство.*

| Блок                  | Переносится                                                                                                                      | Не переносится / требует адаптации                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вариативность и выбор | Принцип «не менее двух вариантов», визуальное меню, наблюдение за невербальным выбором (раздел 15), IDDSI и текстуры (раздел 10) | Согласие родителей/законных представителей; возрастные форматы меню и порций; педиатрический контур вместо терапевтического                                                                                                                                       |
| Нормы питания         | —                                                                                                                                | Детские наборы приказа Минтруда 520н (граммы на ребёнка) <sup>29</sup> ; среднесуточные наборы и массы порций для детей — приложения к СанПиН 4282-26 <sup>9</sup>                                                                                                |
| Санитарные требования | Суточные пробы, бракераж, температурный контроль                                                                                 | Раздел VIII СанПиН 4282-26 (детские коллективы): свои перечни недопустимой продукции, режимы, порции, диетическое питание детей — п. 60 <sup>9</sup> ; общие требования к детским организациям — СП 2.4.3648-20 (пост. ГГСВ РФ от 28.09.2020 № 28) <sup>117</sup> |
| Правовая рамка        | Учёт мнения и предпочтений (раздел 15–16)                                                                                        | Дети — особая рамка: законные представители, органы опеки, возраст согласия; режимы дееспособности раздела 16 не применяются                                                                                                                                      |

## Приложение 42. Калькулятор стоимости вариативности (инструкция)

*Проект локальной формы. Сопровождает файл «Калькулятор\_стоимости\_вариативности.xlsx». Четыре листа. Лист 1 «Пары блюд»: норма закладки (г/порцию) × закупочная цена (руб./кг) = стоимость порции для каждого варианта пары; разница — на порцию и в месяц. Лист 2 «Отходы»: масса тарелочных остатков × число порций × цена сырья = строка «выброшенных денег» (методика — приложение 25). Лист 3 «Сценарии отходов»: снижение отходов на 10/20/30 % — гипотеза; подтверждается только повторным замером через 90 дней (раздел 29). Лист 4 «Два сценария»: (1) собственный пищеблок, пара эквивалентов внутри нормы; (2) аутсорсинг, две позиции в ТЗ вместо монопозиции. Цифры на листах 1–2 — учебные заглушки, не себестоимость конкретного дома и не экономика Серафимовского. Жёлтые ячейки — ввод. Маркировка: калькулятор считает гипотезу, а не доказывает её. Формула доклада «замер до и после» обязательна.*

## Приложения 43–44

### Приложение 43. Спецификация вариативности для контракта аутсорсинга (форма восьми строк)

*Проект локальной формы к разделу 42. Согласовать с контрактной службой до публикации закупки. Приложение к контракту вместе с меню-циклом и раскладкой. Восемь строк раздела 42.3 — в заполняемый шаблон. Распечатка А4 — на стол директора, не только в PDF доклада.*

| № | Строка контракта        | Формулировка для спецификации (адаптировать)                                                                                                                           | Основание                                                                                                        |
|---|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Перечень позиций        | Группы взаимозаменяемых позиций (например, «крупы гарнирные: гречневая, рисовая, пшённая»), а не монопозиции                                                           | Разделы 19, 42.3                                                                                                 |
| 2 | Пропорции               | Пропорции вариантов внутри группы — по статистике выбора учреждения; корректировка раз в квартал без изменения предмета контракта                                      | Раздел 21                                                                                                        |
| 3 | Гарантия выбора         | На приёмах пищи с заявленной вариативностью — не менее двух вариантов основных позиций; срыв выбора фиксируется поставщиком в журнале замен и не считается исполнением | Раздел 42.3                                                                                                      |
| 4 | Замены при недопоставке | Эквивалент из той же группы по согласованию с учреждением, двусторонний акт в сутки замены                                                                             | Раздел 19                                                                                                        |
| 5 | Качество текстур        | Характеристики полуфабрикатов, значимые для текстур (помол, консистенция), — в спецификации качества; дисфагические позиции — отдельным пунктом                        | Раздел 10                                                                                                        |
| 6 | Приёмка и пробы         | Ответственный от учреждения, место и процедура суточных проб                                                                                                           | СанПиН 2.3/2.4.4282-26, п. 56 подп. 12 (с 01.09.2026); до этой даты — п. 7.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 <sup>9</sup> |
| 7 | Состав и нормы          | Меню-цикл с раскладкой и массой порций — приложение к контракту; соответствие нормам питания                                                                           | Приказ Минтруда № 520н <sup>29</sup>                                                                             |
| 8 | Отчётность              | Ежемесячно: доля выбора по позициям, остатки по блюдам, журнал замен — данные для панели чисел учреждения                                                              | Раздел 22                                                                                                        |

**Негативный список — в ТЗ отдельной строкой.** Поставщику нельзя отдать: отбор суточных проб; бракераж приёмки готовой продукции как акт учреждения; список дисфагического риска и текстурные назначения; маршрут эскалации отказа от еды. Фотофиксация приёмки — линия, маркировка, термометр. Лица жителей на кадр не попадают (раздел 17.6).

*Дисклеймер: проект формы, не нормативный документ; требует адаптации под 44-ФЗ/223-ФЗ и позицию контрактной службы учредителя<sup>108</sup>.*

#### Приложение 44. Письмо учредителю о пилоте вариативности при аутсорсинге (шаблон)

*Проект локальной формы. Письмо на одну страницу. Цель — санкция учредителя: строки выбора в спецификацию у действующего поставщика (при изменении) или в новую закупку. Отправлять за 30+ дней до срока планирования закупки.*

Уважаемый \_\_\_\_\_!

Государственное учреждение «\_\_\_\_\_» (стационарная форма социального обслуживания, \_\_\_\_ мест) просит согласовать включение в спецификацию закупки услуг питания следующих позиций: (1) группы взаимозаменяемых позиций вместо монопозиций; (2) гарантия не менее двух вариантов основных блюд на приёмах пищи с заявленной вариативностью с фиксацией срыва выбора поставщиком; (3) процедура замен при недопоставке из той же группы; (4) ежемесячная отчётность поставщика о доле выбора и остатках.

Обоснование. Право не ограничивает число вариантов блюд (СанПиН<sup>9</sup>; нормы питания — рекомендуемые<sup>29</sup>). Выбор при своей кухне и при аутсорсинге совпадает по содержанию: журналы, замеры, гарантия стандартного варианта. Различается место фиксации — контракт.

По сырьевой строке пары эквивалентов, как правило, сопоставимы. Меняются спецификация и отчётность. Это не обещание «пилот без затрат»: обучение смены, маркировка, весы, иногда посуда и ставки — отдельные строки. Понадобятся — напомним следующим письмом с расчётом, а не спрячем за «финансирование не запрашиваем».

Просим согласовать до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (срок планирования закупки на 20\_\_ год).

Приложения: форма восьми строк (приложение 43); панель чисел учреждения за последний квартал; проект графика перехода.

С уважением, \_\_\_\_\_

## Приложение 45. План Б: питание при закрытии столовой

Проект локальной формы. Одностраничный бланк к разделу 18.11. Подписывается до вспышки, не утром закрытия. Не заменяет санитарные предписания по конкретному карантину.

**Когда включается.** Закрытие столовой, карантин отделения, ОРИ, невыход кухни / срыв аутсорсера.

| Блок                                       | Что заранее                                                                                                                                                              | Кто владелец          | Отметка                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Выбор в комнате                            | Два варианта основных позиций на подносе (не вторая линия в коридоре); стандартный вариант всегда есть                                                                   | Старшая смены + кухня | <input type="checkbox"/> |
| Заказ                                      | Лист у поста или визуальное меню на двери; журнал замен ведётся усиленно                                                                                                 | Пост                  | <input type="checkbox"/> |
| Температура                                | Горячее доходит до комнаты по технологическим документам (п. 50 СанПиН 4282-26) <sup>9</sup> : мармит → коридор → палата — замер на последней выдаче, не только на линии | Завпроизводством      | <input type="checkbox"/> |
| Питьё                                      | График тёплого питья; ведомость приложения 40                                                                                                                            | Пост                  | <input type="checkbox"/> |
| Посуда                                     | Запас одноразовой / раздельной по карантинному контуру                                                                                                                   | Завхоз                | <input type="checkbox"/> |
| Холодный буфет                             | Перечень (хлеб, кисломолочное, фрукты по правилам буфета раздела 18.4), не «что осталось в холодильнике»                                                                 | Кухня                 | <input type="checkbox"/> |
| Если не вышла кухня / не приехал аутсорсер | Кто готовит или кто принимает аварийную поставку; чей телефон в 7:00; что выдаём в первый приём без горячего цеха                                                        | Директор / зам        | <input type="checkbox"/> |
| Смена                                      | График раздачи по отделениям с запасными руками; нагрузка не «обнаруживается в 8 утра»                                                                                   | Зам. по АХЧ           | <input type="checkbox"/> |

Витаминация и любые ограничения рациона при ОРИ — только по назначению врача (раздел 4.3). Выбор не отменяем: меняется форма подачи.

Подпись руководителя: \_\_\_\_\_ дата: \_\_\_\_\_ следующий пересмотр: не реже раза в год или после каждой вспышки.

## Часть IV. Одностраничные инфографики (для печати)

Шесть одностраничных А4 уже лежат в каталоге листовок раздатки и на стол не дублируются здесь:

- лестница вариативности;
- «Моя еда — мой выбор» (easy read);
- план Б: питание при закрытии столовой;
- таблица замен;
- что сделать в понедельник;
- шесть измерений стола.

Печатать из 04\_листовки/. Викторина зала — 05\_викторина/.

## Указатель сносок

Номер сноски — порядок первого упоминания. Полные записи с URL — раздел 44.

1 M-dysph\_prev · 2 S015 · 3 S016 · 4 S017 · 5 S030 · 6 S018 · 7 S004 · 8 S011 · 9 S003 · 10 S012 · 11 S008 · 12 S021 · 13 M-pillinger · 14 M-mortality · 15 M-cloz\_hagg · 16 M-lithium · 17 M-maoi\_nhs · 18 M-carb\_gf · 19 S032 · 20 S033 · 21 S022 · 22 S019 · 23 I-ontario · 24 M-dysph\_rev · 25 M-

cloz\_case · 26 I-gc1 · 27 M-mortality2 · 28 I-dge\_betr · 29 S002 · 30 I-lvnat · 31 I-dge · 32 I-fin\_nnc · 33 M-nijs · 34 I-aus6 · 35 I-cfr · 36 I-bda · 37 I-ghouse · 38 I-at\_qs · 39 I-cqc14 · 40 M-resolve · 41 M-dysph\_dd · 42 M-iddsi2017 · 43 M-iddsi\_wu · 44 I-aus\_iddsi · 45 M-dehydr\_steele · 46 M-dehydr\_li ·

47 M-guss\_trapl · 48 M-eat10 · 49 M-oral\_yoneyama · 50 M-oral\_muller · 51 M-dental\_porter · 52 M-cloz\_wd · 53 M-lithium\_sp · 54 M-maoi\_guide · 55 M-maoi\_hist · 56 I-dcbp · 57 M-comf\_oralfeed · 58 M-comf\_jnha · 59 M-crwg · 60 M-fepwg · 61 M-metmon · 62 M-lifestyle · 63 M-teasdale · 64 M-must\_bapen ·

**65** M-constip\_ep · **66** M-constip\_nhs · **67** M-micro\_psyс · **68** M-micro\_vitd · **69** M-micro\_b12 · **70** M-montessori · **71** I-orebro · **72** S001 · **73** S024 · **74** S009 · **75** S013 · **76** S014 · **77** I-crpd28 · **78** S028 · **79** S029 · **80** I-pioneer · **81** I-eden · **82** I-tallg · **83** S010 · **84** S005 · **85** S020 · **86** S035 · **87** I-bda\_res · **88** M-pm\_rev · **89** M-pm\_rct · **90** I-hugo · **91** I-fct · **92** I-ftag · **93** I-fin2020 · **94** I-sunrise · **95** I-jp2005 · **96** I-jpcov · **97** I-jp2021 · **98** I-jperia · **99** I-jpdiet · **100** M-sup\_hous · **101** I-ont\_fao · **102** I-torstar · **103** I-anfp · **104** I-snn · **105** I-m3mmar · **106** S006 · **107** S025 · **108** S023 · **109** S034 · **110** S031 · **111** I-nhs2016 · **112** M-ebt · **113** I-easyread · **114** M-hydr\_low · **115** M-hydr\_esp · **116** M-hydr\_palt · **117** S027